

中医自古有一「中医不传之秘在于量」之言，临床常用的中药饮片一般不会超过两三百味，而所治疗的范围却几乎囊括内、外、妇、儿科等各科疾病。有限的药物之所以可以发挥无限的作用，除了组方配伍的变化外，最根本的秘密就在于剂量。一位中医名家甚至这样形容剂量与疗效之间的关系：「药量者，犹良将持胜敌之器，关羽之佩月刀，神行者之千斤锤也。」「中医不传之秘在于量」之言，临床常用的中药饮片

中医不传之秘在于量

寻找中药重剂取效的秘诀

陈云志 刘俊 主编



人民军医

本书以临床实用性为原则，汇集了
医临床家大剂量用药的经验，
病症的独特用药体会。所录
医临床工作者临证用药有较
富，实用性强，适于广大中医临床工作者、中医院校师
生阅读参考。

策划编辑 王显刚
编辑邮箱 pmmpzhongyi@163.com
封面设计



销售分类 中 医

ISBN 978-7-5091-7177-6



9 787509 171776 >

定价：25.00元

中医不传之秘在于量

ZHONGYI BUCHUANZHIMI ZAIYU LIANG

——寻找中药重剂取效的秘诀

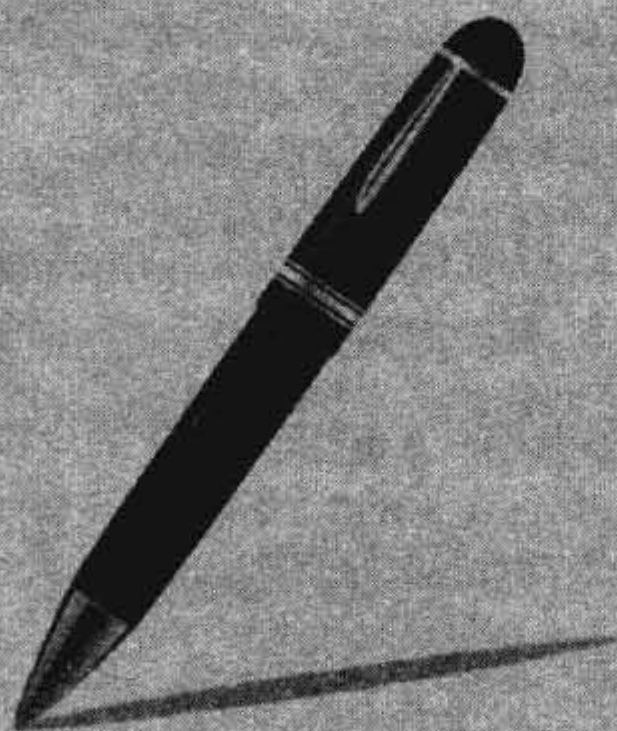
主 编 陈云志 刘 俊

副主编 郑 超 邓叔华 黎伟成

编 委 (以姓氏笔画为序)

邓叔华 刘 俊 杜中华 陈云志

侯公瑾 曹丕钢 温 维 黎伟成



人民军医出版社
PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

图书在版编目(CIP)数据

中医不传之秘在于量：寻找中药重剂取效的秘诀/陈云志,刘俊主编. —北京：人民军医出版社,2014.3

ISBN 978-7-5091-7177-6

I. ①中… II. ①陈…②刘… III. ①中药学—临床药学—经验 IV. ①R285.6

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2013)第 271426 号

策划编辑：王显刚 文字编辑：荣 堃 李 昆 责任审读：陈晓平

出版发行：人民军医出版社

经销：新华书店

通信地址：北京市 100036 信箱 188 分箱

邮编：100036

质量反馈电话：(010)51927290；(010)51927283

邮购电话：(010)51927252

策划编辑电话：(010)51927300—8707

网址：www.pmmp.com.cn

印、装：北京国马印刷厂

开本：710mm×1010mm 1/32

印张：11 字数：188 千字

版、印次：2014 年 3 月第 1 版第 2 次印刷

印数：4001—7000

定价：25.00 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书，凡有缺、倒、脱页者，本社负责调换



前言

中医自古有“中医不传之秘在于量”之言，临床常用的中药饮片一般不会超过两三百味，而所治疗的范围却几乎囊括内、外、妇、儿科等各科疾病。有限的药物之所以可以发挥无限的作用，除了组方配伍的变化外，最根本的秘密就在于剂量。一位中医名家甚至这样形容剂量与疗效之间的关系：“药量者，犹良将持胜敌之器，关羽之偃月刀，孙行者之千斤棒也。”

我有幸在湖南省中医药年会上聆听北京名中医仝小林教授的讲座。仝小林指出，医生们超常规剂量应用中药饮片的根本原因在于对疗效的追求，即重剂可起沉疴。例如，他在临床中发现，在治疗糖尿病时，黄连每日 10g 的常规剂量根本是“泥牛入海”。他创新性地加大黄连的用量，有的甚至加大到每日 45g、90g、120g，可迅速降低血糖，改善症状。“火神派”医生以擅用大剂量附子而闻名，对于这味常规剂量为 3~15g 的中药，吴佩衡、范中林、唐步祺、卢崇汉、李可等中医名家一般出手最少 30g 或 60g，急危重症则用至 100g、200g，甚至 500g，这些名家的宝贵经验值得我们探讨和学习。

中医四大经典之一的《伤寒论》，被视为中医治疗急危重症和疑难病的典范。书中所载的 113 首方剂，被后世尊为“经方”。有些专家指出，正是由于经方剂量传承的扑朔迷离，在一定程度上导致了当今中药临床剂量多端的乱象。1981 年，东汉大司农铜权被考古发现，东汉的 1 两应该是约 15.6g。如果按照这一折算方法，《伤寒论》中炙甘草汤的生地黄用量 1 斤，约折合为现在的 250g，大大超过了常规用量。

戴复庵在《证治要诀》中提到：“药病须要适当，假使病大而汤小，则邪气少屈，而药力已乏，欲不复治，其可得乎？犹以一杯水救一车薪，竟不得灭，是谓不及。”《简明医彙》说：“凡治法用药有奇险骇俗者，只要见得病真，便可施用，不必顾忌。”当然，我们在临床上并不是一味追求大剂量用药，但是很多名老中医在自己长期的临床实践中，在中医药理论的指导下，有意或者无意中总结出了一

些大剂量用药取得良好疗效的经验，这些经验值得我们去学习和借鉴，以便提高自己的临床水平。

《此事难知》指出：“初治之道，法当峻猛；中治之道，宽猛相济；末治之道，法当宽缓。”轻剂宽缓，霸药峻猛，轻霸结合，宽猛相济。明·张景岳曾说：“治病用药，本贵精专，尤宜勇敢……但用一味为君，二三味为佐使，大剂进之，多多益善。夫用多之道何在？在乎必赖其力，而料无患者，即放胆用之。”这些经验是可以作为我们临床参考的，也是提高中医临床疗效的一条重要途径。

本书遴选了近现代中医临床家运用大剂量中药治病的诸多经验，这些经验乃是建立在该老中医几十年使用心得的基础上，对其适应证、有效及中毒剂量、药后反应等有着成熟的经验，更可能有因地、因时、因人而异的因素在内，非有真知卓识者不能臻此，所以请读者切勿盲目模仿，无实际经验者宜慎用。对此经验，应师其法而不用其量，用量多少应视病症具体而定，不能丢掉中医辨证论治的精髓，切勿偏执某人之经验而死守其用量。尤其是患者或家属更要在有经验的专业医师指导下使用，绝对禁止盲目抄用。

在此，也谨对文献资料的原著作者和中医临床家致以衷心的感谢！正是由于他们对学术经验的整理、总结，才使后学者得以继承、学习，使中医得以发展、进步。

编 者

2013年6月22日



目 录

第一章 解表药	1
重用麻黄经验	1
重用防风经验	4
重用细辛经验	5
重用牛蒡子经验	9
重用蝉蜕经验	10
重用柴胡经验	11
重用葛根经验	12
重用升麻经验	13
第二章 清热药	15
重用石膏经验	15
重用天花粉经验	26
重用栀子经验	26
重用黄连经验	27
重用苦参经验	28
重用连翘经验	29
重用蒲公英经验	30
重用败酱草经验	33
重用土茯苓经验	34



重用白花蛇舌草经验..... 39

重用马齿苋经验..... 41

重用鸦胆子经验..... 41

重用生地黄经验..... 43

重用玄参经验..... 44

重用牡丹皮经验..... 45

重用水牛角经验..... 46

重用青蒿经验..... 48

重用地骨皮经验..... 48

重用白薇经验..... 50

第三章 祛风湿、泻下药..... 51

重用川乌经验..... 51

重用防己经验..... 53

重用豨薟草经验..... 54

重用鹿衔草经验..... 55

重用大黄经验..... 56

重用牵牛子经验..... 63

重用甘遂经验..... 64

第四章 化湿利湿药..... 66

重用苍术经验..... 66

重用厚朴经验..... 69

重用薏苡仁经验..... 70

重用泽泻经验..... 71

重用滑石经验..... 73

重用石韦经验..... 74

重用茵陈经验..... 75



重用金钱草经验.....	76
第五章 温里行气、消食驱虫药	78
重用附子经验.....	78
重用陈皮经验.....	81
重用川楝子经验.....	82
重用枳壳经验.....	83
重用山楂经验.....	84
重用麦芽经验.....	85
重用莱菔子经验.....	87
重用南瓜子经验.....	89
第六章 止血、活血化瘀药	91
重用槐花经验.....	91
重用白茅根经验.....	92
重用茜草经验.....	93
重用蒲黄经验.....	94
重用仙鹤草经验.....	97
重用川芎经验.....	100
重用郁金经验.....	102
重用益母草经验.....	103
重用鸡血藤经验.....	105
重用莪术经验.....	108
重用水蛭经验.....	110
第七章 化痰止咳平喘药	112
重用半夏经验.....	112
重用天南星经验.....	116
重用竹沥经验.....	118



重用皂角刺经验.....	119
重用葶苈子经验.....	120
第八章 安神平肝潜阳、息风止痉开窍药.....	123
重用酸枣仁经验.....	123
重用夜交藤经验.....	124
重用龙骨经验.....	126
重用赭石经验.....	128
重用蜈蚣经验.....	130
重用全蝎经验.....	134
重用蟾蜍经验.....	135
第九章 补虚、收涩、攻毒杀虫止痒药.....	136
重用黄芪经验.....	136
重用白术经验.....	140
重用甘草经验.....	145
重用熟地黄经验.....	146
重用白芍经验.....	149
重用乌梅经验.....	154
重用桑螵蛸经验.....	155
重用金樱子经验.....	156
重用海螵蛸经验.....	156
重用硫黄经验.....	157
重用狼毒经验.....	159
参考文献.....	161

第一章 解表药

重用麻黄经验

麻黄最早载于《神农本草经》，其性温，味辛、苦；归肺、膀胱经；其基本功效有发汗解表、止咳平喘、利尿退肿。多用于风寒感冒，咳嗽气喘，风水水肿。临床常用量为 2~9g。

孟德玉重用麻黄治喘

襄阳名医孟德玉对于喘证有独到治疗经验。孟氏谓喘证属临床常见疾患，分为虚、实两证。仲景治喘之方多为实证而设，宣肺平喘乃为常法，临床以其方加减用之，并非均有奇效。考其个中究竟，酌其用量，屡试于临床，悟方中麻黄用量不足乃是疗效之关键。以下就实喘须重用麻黄述及理由如下。

1. 喘为急证，药必重投 实喘发病多急，必投重剂方可遏止病情。麻黄为治喘要药，仲景治喘方中均以麻黄为君药，理当重用。

2. 麻黄辛散，其性轻扬 麻黄乃为嫩枝，非根果之属，只可轻煎，但味辛性温，煎煮时必先升散，此其一损；既是轻煎，则煎煮时间较短，出汁必少，此其二损。因此入方量虽大，但入口并不多。并非追求超大剂量，只求效应。

3. 仲景之法，求证于实 仲景治喘用麻黄之量多 2~4 两，约合当今 30g 以上，选此量绝非偶然，定是长期实践的结果。小青龙汤中麻黄为 3 两，麻杏甘石汤中麻黄为 4 两，均比目前用量为大，仲景以为常法。寒饮犯肺或热邪闭肺，均致肺气壅塞，气逆而喘。喘之发，则如沸腾之水，又如疾风劲雨，须猛力扼止，急折其势，方能使病情逆转。麻黄辛苦温，入肺经，为肺系专药，力专而迅猛，推为君药最是恰当，并能引诸药上行于肺。麻黄轻举辛散，符合《内经》“其在上者，轻而扬之”之理论，使肺内之邪气从上而宣散，则肺气得以平降，喘息得止。

4. 药性猛烈，及其所长 麻黄之性猛烈，正是药用所在，对于正常人即使少



量的麻黄也不适用，而对于病人则以其偏治其偏，药性过于温和反不能救人于急。中药毒性数砒霜为最猛，但对证仍有用之。西医目前用于解痉平喘的氨茶碱等药均是烈性药，且治疗量与中毒量非常接近，即使小剂量也不能保证不会发生毒副作用，但为了取得疗效，尽快缓解临床症状，仍归入常用药，用之恰当则喘息立平，如不对症则毒性立现。中药麻黄虽猛，但尚不如此，因麻黄不等于麻黄碱，不属高纯度提炼药，用药之准还须依中医辨证，终不失为临床治喘之要药。

孟氏认为实喘重在宣肺，而宣肺还须重用麻黄。临证时，若治喘疗效不佳，或可推敲麻黄是否足量。既然是治急症之药，理应中病即止，不可因其有效而大量久服。

沈年洪重用麻黄治慢性咳嗽

慢性咳嗽有很多种类，沈氏所讲慢性咳嗽仅指以咳嗽为主要症状，X线胸部检查无明显病变或仅有支气管炎病变，而把肺部肿瘤、肺结核和其他系统的疾病排除在外的慢性咳嗽。沈氏在工作中诊治的一些慢性咳嗽患者先期在其他医院西医内科诊治过，都用过了几种抗生素治疗，且用量较大。沈氏遇到此种情况很少再用抗生素，而是注重应用中医药治疗。在十几年的探索、借鉴、积累中，逐渐形成了在重用麻黄的基础上结合辨证论治的方法，自拟了麻精汤治疗慢性咳嗽，获得了比较理想的效果。基本方：炙麻黄 10~30g，黄精 20~50g，生黄芪 20g，生白术 20g，杏仁 10g，生白芍 10g，炙甘草 10g，鱼腥草 10g，麦冬 10g，南沙参 20g，浙贝母 10g，全蝎 5g，全当归 10g，枸杞子 20g，肉苁蓉 20g，桔梗 10g，法半夏 10g。热象明显者加黄芩 10g，以清热化痰止咳；寒象明显者加桂枝 10g，以温肺通经止咳。笔者临床门诊中所遇见的慢性咳嗽患者热象明显的很少，大多数是寒热不明显或显寒象者。

沈氏在南京中医学院学《中药学》时，老师说麻黄常用量在 3~5g，夏季一般不用，有“夏用香薷，冬用麻黄”之说。沈氏在刚刚开始行医时，也一直使用常规小剂量（3~5g）。有一次在门诊接待了一位来自四川的打工青年，要求转抄一张治疗咳嗽的中医方，该青年说四川当地咳嗽一般就用此方治疗，而且效果比较好。沈氏看了此方用药，方中麻黄用量 15g，其他用药与苏南农村没有多大区别。以后就试着在加大麻黄用量的基础上结合辨证论治，自拟了麻精汤来治疗慢性咳嗽，效果确实比较好。麻黄用量从 10g 渐增至 20g 以上，最多用至 30g，并没有出现明显的副作用。以大剂量的麻黄宣肺止咳的同时，辨证结合黄精、黄芪、白术、白芍、甘草、麦冬、南沙参益气养阴；杏仁、法半夏、浙



贝母、桔梗止咳化痰；枸杞子、肉苁蓉补肾；当归、全蝎活血通络；鱼腥草清热解毒，寒温并用以制麻黄之辛温。全方共奏宣肺止咳、益气养阴、补肾化痰之功，用于治疗肺气上逆日久而致气阴亏损、肾虚血瘀、虚实夹杂的慢性咳嗽，可达良效。

曾治一男性患者，13岁，中学生。2002年10月15日因咳嗽2月余来诊。自诉2个月前开始咳嗽，低热。诊为支气管炎，用抗生素治疗，热退，但咳嗽持续至今，夜间和劳累汗出后咳嗽加重。刻下：咳嗽，有少量白黏痰，舌淡红，苔薄，脉细，查体温正常。X线胸透示：肺部未见明显异常，诊为慢性咳嗽。证属肺气久逆，气阴亏虚。治拟宣肺止咳，益气养阴。用麻精汤治疗：炙麻黄20g，黄精50g，生黄芪20g，生白术20g，枸杞子20g，肉苁蓉20g，杏仁10g，生白芍10g，炙甘草10g，鱼腥草10g，麦冬10g，南沙参20g，浙贝母10g，全当归10g，桔梗10g，法半夏10g，全蝎5g。5剂，水煎服，每天2次，并嘱适当进行一些体育锻炼，晚上早点休息，避免劳累和受凉，饮食清淡一些。5剂后，患者咳嗽减轻，再服10剂，共服15剂，咳嗽止而病愈。

王国三重用麻黄经验

河北名老中医王国三对麻黄这味药的临床应用有深刻而独到的认识，应用甚为广泛。

1. 痹证 在外感六淫邪气中，寒邪、湿邪为阴邪，麻黄能通达太阳经气，故能散风寒之邪气，王氏认为一般用量应大，一般用量10~20g。

如治王某，女，46岁。主因感受寒湿而致腰痛及双下肢疼痛，难以行走，转腰不能，舌质淡红，苔白，脉沉。前医给予口服温阳通络方7剂无效。王老考虑此证为寒湿痹阻，经络不通。方予麻黄15g，熟附子10g，白芍12g，党参20g，炙甘草8g，川牛膝10g。水煎服，5剂。服完3剂，病告痊愈。

2. 遗尿症 麻黄通利九窍，宣利肺小便，如配伍益智丸、桑螵蛸等，可治遗尿症，比单纯应用缩泉丸疗效更佳。

如治张某，男，12岁，每晚尿床1~2次，深睡不醒，有时强行唤起让其排尿，却自言不尿，入睡后不久便尿床，曾先后多次口服桑螵蛸散和进行针灸治疗未取效果。王老看过患者，处方如下：麻黄6g，益智仁10g，乌药8g，山药6g，桂枝8g，白芍8g，龙骨、牡蛎各15g。连服10剂而愈。

王氏认为：不论老年小便失禁还是小儿遗尿，虚证居多，大多是肾气不充，皆以补肾固摄为主。加用麻黄入肺与膀胱经，其性辛温，能通阳化气，升提阳气，而助气化，有固摄膀胱的作用。麻黄能宣肺通气，通调水道，膀胱气化得以恢复，



开阖有度，遗尿自止。正如张景岳所云：“小儿虽利于肾，而肾上连于肺，若肺气无权，则肾水终不能摄，故治水必先治气，治肾必先治肺。”

3. 泄泻 王氏认为本病是阳气下陷，水液不能固摄所致。对病久而阳虚不升者，甚为切当。

如治李某，女，26岁，每日于清晨4~6时腹痛，泄泻，已5年余。饮食正常，无畏寒肢冷症状，多次应用温补脾肾、收涩止泻等药无效。查舌质淡红、苔薄白，脉缓。王老给予处方：麻黄8g，党参8g，白术10g，茯苓15g，薏苡仁5g，防风10g，炙甘草8g，水煎分服。1剂后泄泻反剧，但腹痛减轻。此麻黄疏通气机后阳升阴降所致，正是《伤寒论》所云：“虽暴烦下利，日数十余行，必自止，腐秽当去故也。”7剂后，患者痊愈。

重用防风经验

防风最早载于《神农本草经》，其性微温，味辛、甘；归肺、肝、脾经；其基本功效有祛风解表、祛风湿、止痛。多用于外感表证、风湿痹痛、皮肤瘙痒及透疹、息风止痉等，临床常用量为4.5~9g。

刘强重用防风治耳鸣

天津名医刘强临床重用防风治疗耳鸣，每用多获佳效。刘氏认为耳鸣之作，多责之于肝肾，因肝经循行于耳，肾开窍于耳。故治耳病多以清肝泻火或滋阴补肾。耳鸣虽为肝肾之病，但因脾虚而浊阴上逆蒙蔽清窍而致者亦属多见。刘氏认为其治用防风乃为理想之品，因防风味甘，入足厥阴肝经，燥己土而泄湿，达乙木而息风。故防风实为治疗浊阴上逆、蒙蔽耳窍所致耳病之妙品。刘氏临证多重用防风（30~40g）治耳鸣，其效甚捷。

如治一刘姓男子，年30余岁。患耳鸣近3月余，无有休止。经西医检查，诊断为神经性耳鸣，服西药培他定、谷维素，并注射B族维生素及ATP等药未能缓解。后延中医诊治。初以龙胆泻肝汤不效，继用杞菊地黄汤治疗月余罔效。刘氏应邀为其诊治。患者除诉其耳鸣隆隆不休以外，尚有头部昏沉且重如裹，时眩晕泛恶，胸胁满闷，食少，便溏，舌质胖淡苔白，脉沉弦滑。证属浊阴上逆蒙蔽清窍，刘氏初以苓桂术甘汤2剂，其眩晕、泛恶略除，但耳鸣不减。后刘氏在前方基础上加防风30g，患者服药1剂耳鸣减轻，2剂后耳鸣



及诸症皆除。

黄融琪重用防风治胃下垂

福建名医黄融琪主任医师在其经验方“益气防风汤”中重用防风（20~30g）治疗胃下垂，每获良效。其基础方为：炒防风、黄芪各 20~30g，人参、白术、炒当归各 10g，升麻、柴胡各 4.5g。

如治孙某，女，32岁，2001年9月13日初诊。患者胃下垂病史3年，消瘦乏力、体重肢困、食纳减少、胸脘胀闷不适，进食后即产生腹下坠的感觉，平时做弯腰动作时感觉疼痛，久医乏效。就诊前，于我院行X线检查提示：胃小弯角切迹低于髂嵴连线水平以下13cm。拟诊为重度胃下垂。诊得舌质暗淡少苔，舌底脉络色暗，略有迂曲。辨证为气虚血瘀，中气下陷。治宜益气升阳佐以活血行瘀。处方：炒防风30g，黄芪30g，人参10g，白术10g，炒当归10g，莪术6g，桃仁6g，升麻4.5g，柴胡4.5g。6剂，水煎服。二诊：服药后纳增，胸脘胀闷不适减轻。续前方再服7剂。三诊：诸症明显好转，弯腰自如，不疼痛。此后，以前方加减治疗共20天，复查X线提示：胃小弯切迹于髂嵴连线下2cm，为轻度胃下垂。宗原旨巩固治疗20天，嘱患者加强腹肌锻炼。疗程结束后，复查X线胃位置已回归正常，患者饮食正常，精神体力明显好转。

防风不仅能加强机体免疫功能，增强体力，同时尚有加强并协调胃肠道运动的作用。黄老的临证经验表明，重用防风治疗胃下垂，对改善胃动力效果显著，如按常规量使用，则难以获效。

重用细辛经验

细辛最早载于《神农本草经》，其性温，味辛，有小毒；归肺、心、肾经；其基本功效有发散风寒、止痛、通鼻窍、温肺止咳。多用于风寒表证、风湿痹痛、咳喘、鼻塞、鼻渊等，临床常用量为1~3g。

张鸣鹤重用细辛治痹证

张鸣鹤老中医治疗痹证善用细辛。张氏认为，细辛为驱寒胜湿之良药，且有较好的止痛作用，适用于风寒痹证，但与寒凉药配伍亦可用于寒热错杂的痹证。细辛用量要大，不能拘泥于“细辛不过钱”的陈规，古人所定这一戒律只是指服用粉剂不能过1钱之量，并非指服用汤剂。张氏认为，如欲发挥细辛的有效作用，

细辛必须过钱，他常用的剂量少则 6g，多则达 20g，从未发现任何不良反应，只要认证确切，就应大胆使用。

罗少锋重用细辛治痛症

罗氏体会，临床只要辨证准确，适当选方用药，细辛较大剂量（10~20g），每每能使剧痛缓解，沉痾顿起。

如治李某，女，61 岁，于 1998 年 1 月 5 日初诊。有咳嗽、哮喘病史 20 年，近 2 年来伴发心悸、气促、浮肿等症，加剧 2 个月。西医诊为肺源性心脏病，用强心、利尿和抗炎治疗未见明显好转。察患者面色晄白，全身浮肿，咳喘倚息，胸闷心悸，四肢厥冷，烦躁不安，小便清长，大便溏薄，口唇发绀，舌淡，苔白，脉沉细数。证属真阳不足，治宜回阳救逆。处方：细辛、炮附子、干姜各 15g，茯苓、人参、白芍、炙甘草、五味子各 10g，嘱其浓煎半小时顿服，连服 2 剂，汗止阳回，四肢转温，咳喘减轻。继予真武汤合葶苈大枣泻肺汤 10 剂调理，以巩固疗效。

肺心病后期多属心阳虚衰，极易产生阳气外越、阴阳离决的严重后果。“有阳则生，无阳则死”，故果断而较大剂量地使用峻温回阳的细辛、附子，往往力挽危亡于顷刻。临床上遇肺源性心脏病、风湿性心脏病心力衰竭等属心阳虚衰类型的患者，只要辨证准确，均可予较大剂量的细辛、附子回阳救逆，确可收效。

又如治刘某，女，42 岁。1995 年以来经常头两侧颞部胀痛，两耳有闭塞感，近几个月来每受风寒即发，屡治少效，于 1997 年 3 月 25 日来院就诊。经颅超声检查：示脑血管痉挛，诊为血管神经性头痛。注射氢化麦角碱等无效。见患者痛连眉梢，头不能举，夜不能寝，舌淡，苔薄白，脉濡细。诊为风寒入脑，脉络痹阻。治以祛风散寒，通络和营。处方：细辛、白芷各 15g，蝉蜕、葛根、钩藤、白芍、川芎各 10g，甘草 5g，水煎 30 分钟，连服 4 剂，头痛减，两耳闭塞感消失。继进 4 剂，头痛消失，且能伸举，入睡安静。转用天麻丸调理，诸症亦平。随访 1 年未见复发。

从以上病例不难看出，细辛不过“钱”之说，恐指散剂而言，并非包括煎剂。近几年来大剂量使用细辛，除个别患者出现口干咽燥外，从未发生过严重毒副作用。罗氏体会，较大剂量使用细辛，在顽固的寒湿痹痛、头痛、腹痛及危急阳虚病人中，往往能力挽沉痾。较大剂量的细辛用于临床，只要注意两点，其毒性及副作用完全可避免。一是久煎（指煎药半小时以上）；二是注意配伍，如可配芍药、甘草。罗氏体会白芍滋阴之品可中和细辛之辛烈，配甘草可调和诸药而解百毒。



王自立重用细辛治顽痹

甘肃名老中医王自立承家传之经验，并结合自己 40 余年的临床实践，对细辛的应用有独到的认识。王氏常常运用大剂量细辛治疗痹证，剂量均在 15~40g，最大量曾达 60g。少数人有轻微舌麻、咽干，但不影响继续治疗，多数人无明显不适或毒副反应，对伴有明显疼痛的风寒湿痹，采用大剂量的细辛，配伍于王氏自创的羌防通痹汤中，具有显著的止痛效果。细辛所含毒性多由挥发油所致，考虑可能在细辛煎煮过程中，由于其所含挥发油的散逸而降低了毒副反应。故每用细辛时必嘱患者久煎。但细辛入散剂吞服时当慎用，最大不超过 3g，以防中毒。

如治王某，女，34 岁，1998 年 10 月就诊。患者四肢关节疼痛数年，以小关节为甚，曾服消炎痛、阿司匹林等无明显疗效。每逢受寒或气候变化时，四肢关节疼痛难忍，近年来日渐加重，伴有肢体麻木、恶寒之症。舌体胖，质淡，苔白，脉沉迟。实验室检查：抗“O” 833，血沉 34mm/h，类风湿因子阳性。诊断：类风湿关节炎。该患者证属风寒并重，流着经络，痹阻不通。治以疏风散寒，宣痹通络。方用王师自创的羌防通痹汤：羌活 10g，防风 10g，白术 30g，细辛 15g，川芎 10g，牛膝 30g，制附片 6g，豨莶草 30g。水煎分服，每日 2 次，1 日 1 剂。方中细辛量自 15g 起逐渐加大，最后用至 40g。附子量自 6g 起，逐渐加至 20g。以后诸药略有加减，但细辛、附子不变。患者连续服用 3 个月后，麻木消失，关节疼痛明显减轻，疼痛发作次数减少。服药过程中查心电图、肝肾功能均无异常。3 个月后复查抗“O”、血沉、类风湿因子均恢复正常。嘱其继续服药 1 个月以巩固疗效。随访 2 年，无反复，疼痛消失。

又如治赵某，男，42 岁，1999 年 5 月 12 日就诊。患者四肢关节疼痛 3 月余，以双膝关节为著，经中西药物治疗效果欠佳。今来就诊，症见：恶寒肢冷，关节疼痛，下肢尤甚，疼痛时活动受限，行走不便，但局部无红肿之象。舌质淡、舌体胖，脉沉细。查血沉 45mm/h。诊断：风湿性关节炎。中医诊断：痹证（痛痹）。该患者病因为风寒湿三邪痹阻经脉而成，经有“风寒湿三气杂至合而为痹”，正此之谓也。治法：温通经脉，祛风除湿。方用黄芪桂枝五物汤加附片、细辛、豨莶草、牛膝治之。方中细辛由 20g 逐渐加至 30g，服药 1 个月，疼痛若失。随访 1 年，疼痛再未发作。

附：关于细辛剂量问题

细辛是临床常用中药，且如上述有诸多功效，但是其毒性剂量一直是限制临床使用和疗效的关键所在。下面就有关细辛毒性及剂量问题略谈管见。



细辛首载于《神农本草经》，书中没有注明细辛的用药剂量。而最早论述细辛剂量的本草著作是宋·陈承的《本草别说》，书中记载“细辛若单用末，不可过半钱匕，多即气闷塞不通者死”。所谓“半钱匕”相当于今之1g。明·李时珍《本草纲目》在传承的基础上不断发扬光大，书中记载，细辛“若单用末，不可过一钱，多则气闷塞不通者死”。李时珍将《本草别说》“半钱匕”提升到一钱，“一钱”相当于今之3g。其间，尽管历代不少医药学家对陈、李之说提出了质疑，甚至持反对意见，但“细辛不过钱”仍然得到了普遍的认同而被传承下来。诚如近代著名医家张锡纯在《医学衷中参西录·例言》中所说：“细辛有服不过钱之说，后世医者，恒多非之，不知其说原不可废。”其主要的原因是细辛为“味辛兼能麻口之药……盖麻口者，即能麻肺，肺麻则其呼吸即停矣”。提示细辛有呼吸毒性作用。

正是由于往昔“细辛不过钱”之说，特别是国家药典和《中药学》教材中，均将剂量规定在1~3g，这就使临床应用受到较大限制。尽管近年来重剂细辛的临床应用取得捷效及挽救沉疴的报道屡见不鲜，但在临床仍存在着需要解决和亟待明确的问题。

其实，“细辛不过钱”之说是一种误传，从以上论述不难看出，无论是《本草别说》还是《本草纲目》，都是针对“单用末”的散剂型而言。然而，在长期师徒口耳相传及传抄过程中，竟将“单用末”这个重要前提无端删去，以致后学者对之都未加重视。实际上剂型与剂量的关系问题是中医学历来都很重视的内容。陈承、李时珍所定的量并不包括汤剂。因此，在复方汤剂中，“1钱”并非是不可逾越的。“细辛不过钱”之说，应亟待予以更正。

即使从古方来看，细辛的用量就远远超过“1钱”。先于陈承的汉代张仲景，在《伤寒论》《金匱要略》中，细辛用量一般在2~3两。如麻黄附子细辛汤中用细辛2两，小青龙汤中用细辛3两。根据目前古今度量换算制的研究结果，可有3种折算方法：一是1两折合15.6g；一是1两折合为13.92g；一是1两折合为3g。然而，无论怎样折算，古方细辛之用量均超过“1钱”之限。尤其是前两种折算量，实可谓超大剂量。晚于陈承的清代陈士铎，在《石室秘录·完治法》中，分别用细辛5钱和1两，治疗头痛。综上述可见古圣今贤之共识。

近年来大剂量细辛用于临床，入汤剂时，20g以上者屡见不鲜，有重用30~40g者，更有超大剂量达90g，河北刘沛然老中医则以善用、单剂量使用细辛而闻名，并且多后下使用，非但未发生不良反应，反而取得良效。

关于细辛的有效安全量问题，从收集到的资料看，认为入汤剂时，10g左右



为比较安全有效量，对于一些特殊疾病如寒痹疼痛等可酌情加大剂量。大剂量细辛临床应用，可以说古有根、今有据。

纵观其用药经验，归纳为四点。①寒证选用：绝大多数情况下，用于寒证，若有热证用细辛时，须与寒凉药同用，而且药量要轻。②汤剂煎服：一般应煎煮 15~30 分钟，亦有主张久煎达 40 分钟者。③注意配伍使用：以辨证为依据，宜伍以酸寒或咸寒之品。有报告伍用白芍、甘草为宜，白芍滋阴以和细辛之辛烈，甘草“调和诸药而解百毒”。④小量渐增：此法符合有毒药物疗病的传统服药方法。

重用牛蒡子经验

牛蒡子最早载于《名医别录》。其性寒，味苦、辛；归肺、胃经；其基本功效有疏散风热、利咽透疹、解毒消肿。多用于风热感冒、温病初起、麻疹不透、风疹瘙痒、痈肿疮毒、丹毒、疔腮喉痹等，临床常用量为 6~12g。

李晓三重用牛蒡子治周围性面神经麻痹

李氏重用牛蒡子治疗周围性面神经麻痹为临床偶得。曾有一面神经麻痹患者，用牵正散加味治疗，服药 5 剂效果不满意。但患者又感到咽部疼痛，遂于原方中加用牛蒡子 25g，本意用牛蒡子解毒利咽，服药 5 剂，出现了意想不到的效果，咽部疼痛不但消失，而且面神经麻痹的症状也有明显好转，继服原方 10 剂告愈。从而体验出牛蒡子有治疗面神经麻痹的功效。从此，每遇到面神经麻痹患者。在方中都重用牛蒡子，每每取得较好的效果。

李氏临床中采用牵正散加味，重用牛蒡子治疗（白附子 6g，全蝎 10g，僵蚕 10g，防风 10g，钩藤 20g，牛蒡子 25g），临床证实，疗效显著。

如治王某，女，38 岁，农民，于 1995 年 8 月 12 日初诊。患者午睡被电风扇吹后，觉右侧面部麻木，次日，口眼喎斜，鼓腮漏气，嗽口时漏水，口角活动受限，右眼睑不能闭合，流泪。检查：前额纹消失，鼻唇沟平坦，眼裂 3mm，人中沟歪向左侧，舌质淡红、苔薄白，脉象浮弦。证属风寒客络，经络闭塞，治宜温散风寒，通络牵正。处方：白附子 6g，全蝎 10g，僵蚕 10g，防风 10g，钩藤 20g，牛蒡子 25g。每日 1 剂，水煎 2 次服。共服药 18 剂告愈。



重用蝉蜕经验

蝉蜕最早载于《神农本草经》。其性寒，味甘；归肺、肝经；其基本功效有疏散风热、利咽开音、透疹、明目退翳、息风止痉。多用于解表散热、开音、止咳平喘、皮肤疾病、祛风止痉等，临床常用量为3~10g。

刘弼臣重用蝉蜕治破伤风

著名中医儿科专家刘弼臣教授治疗破伤风，每每配伍大剂量的蝉蜕于辨证方中，临床收效甚佳。

如治董某，男，48岁。痉证7天，因皮靴误伤右眼上睑，伤口约0.2cm×0.2cm，自用羊畜粪和泥土覆盖以止血，旋即颜面浮肿。经某医院诊治，内服消炎片和外敷药后肿消、伤口结痂。3天后自觉牙关发紧，颈项强硬，治之不效，病情日趋严重。刻下唇口发紧，项强，面肌抽搐，呈苦笑状，瞳孔缩小，对光反应消失，口角不时抽动，大便数日未行，苔色薄白，脉弦而数。辨证为风毒内蕴，经络脉遂受阻，营卫壅滞，气血不运，肝风内动，以致口噤发痉，颈项强直，形成破伤风证，势颇危险，治拟祛风镇痉。玉真散（白芷6g，生南星6g，天麻6g，羌活6g，防风6g，白附子30g，共研细末）20g，每服5g，日3次，开水调服。

二诊：药后病情无大变化，今晨因帮助翻身，抽搐大作，喉中痰鸣，呼吸一度窒塞，经抢救后仍持续出现痉挛不已，证情至危，再拟祛风定痉、解毒开窍治之，以尽人事。麝香玉真散6g炙烤人工创口3小时。

三诊：炙烤后抽搐仍继续工作，但不甚重，甚至呈昏迷，牙关紧闭，不时齟齿，口角流涎，身热气促，体温38℃（腋温），喉中痰鸣，大便秘结，此为风毒稽留经脉，营卫仍然失宣，故筋脉拘急；邪毒化热伤津，肠道失润，故便结不行，亟当清化邪热，解毒止痉，兼通腑实治之。荆芥10g，净蝉蜕30g，全蝎10g，蜈蚣3条，防风10g，天南星10g，钩藤15g，白芷10g，生石膏50g（先下），天麻10g，羚羊角15g（先煎），金银花30g，连翘20g，生大黄10g（后下），木通10g，玄明粉10g（冲服），水煎后，鼻饲法灌服。麝香玉真散6g，炙烤。

四诊：炙烤后稍出微汗，大便未行，抽搐仍未停止，痰鸣稍已，证情仍然危急，再拟前方增减治之。荆芥10g，净蝉蜕30g，全蝎10g，蜈蚣3条，防风10g，天南星10g，钩藤15g，生石膏60g（先下），天麻10g，羚羊角15g（先煎），金

银花 30g, 连翘 25g, 生大黄 12g (后下), 木通 10g, 玄明粉 10g (冲), 瓜蒌 25g。水煎服, 鼻饲法灌服。

五诊: 药后汗出较多, 身热下降, 大便已通, 小便亦利, 抽搐显减, 偶有面肌抽动, 神志呈半清醒状态, 有时能够理解问话, 痰多黏稠, 不能咳出, 前方既效, 无再更张。以养阴清热善后而愈。

刘氏认为, 内服玉真散、炙烤麝香玉真散, 对破伤风有较好的疗效。蝉蜕是一味治疗破伤风有效的药物, 但用量须大, 可以 30~60g, 单用可增至 120g, 这些是治疗破伤风的基本有效方药, 临床可推广运用。

重用柴胡经验

柴胡最早载于《神农本草经》, 其性微寒, 味辛、苦; 归肺、脾、肝经; 其基本功效有解表退热, 疏肝解郁, 升举阳气。多用于透表泄热、和解少阳、诸疟寒热证、肝胆湿热证等, 临床常用量为 3~9g。

张琪重用柴胡治发热

国医大师张琪教授认为, 透邪是治疗发热的基本方法, 而透邪的关键是柴胡的使用, 世人多有“柴胡性燥劫肝阴”之说, 因此治疗热病时常避而不用。而张氏治疗发热时, 使用次数最多者莫过于柴胡。张氏认为, 柴胡具有疏解肝胆、畅利三焦的作用, 为利枢机之剂; 柴胡虽能疏解邪气, 能开气分之结, 但不能清气分之热, 故常配伍黄芩协之以清热, 热甚者加用生石膏。张氏使用以柴胡为主的小柴胡汤化裁治疗发热, 凡临床表现发热恶寒、苔白、脉浮数者, 皆可用之, 不必局限于往来寒热者, 并重用柴胡, 剂量一般在 20g 以上。通过大量的病例观察, 不仅未见劫阴助热之弊, 且屡用屡效, 足见柴胡为退热之良药。

李文瑞重用柴胡治发热

北京名医李文瑞教授善于重用柴胡治疗发热, 临床一般用量 3~10g, 重用 15~60g, 最大用至 120g。李氏认为柴胡具有发汗清热、散表和里之功, 与解热、抗菌、抗病毒等现代药理作用相合。重剂用于发热性疾病, 方可获效。常在小柴胡汤、柴葛解肌汤、银翘散、补中益气等方中重用。临床主要用于原因不明发热, 以及感冒、肝炎、血液病、肿瘤、体虚等所致发热。一般服药 2~5 天, 多则 2 周, 即可热平。药量随热降而逐渐减量, 未见明显毒副反应。



如治一42岁女患者。因发热10天，经多种检查未见异常，予抗菌、抗结核治疗月余未效，遂请师会诊。症见口苦咽干，胸胁满闷，寒热往来，纳呆食少，形体消瘦，二便如常，舌淡红，苔薄黄，脉弦而数。证属邪客少阳。遂予小柴胡汤加减，重用柴胡60g。服7剂后，热大减。守方柴胡减至30g，再续7剂后，热退病愈。

重用葛根经验

葛根最早载于《神农本草经》，其性凉，味辛、甘；归肺、脾、胃经；其基本功效有解肌退热，透疹，生津止渴，升阳止泻。多用于发表解肌、风湿痹痛、升阳止泻、消渴等，临床常用量为9~15g。

朱良春重用葛根治颈椎增生

国医大师朱良春教授在其著作《朱良春用药经验》中谓葛根“以益肾壮督治其本”，治疗颈椎骨质增生，必用葛根30~45g，认为葛根能“疗骨痹，解痉通脉”。

李忠悦重用葛根治热痹

李氏临床治疗热痹，多伍用葛根，对急性热痹者，常应用葛根60g，每每获效。如治刘某，男，38岁，因右足肿痛伴发热3天，于2000年9月10日来诊。查体：面色红，手足心热，右足踝关节、足背至第一跖趾关节肿胀，足背至第一跖趾关节皮肤色红，触之灼热、疼痛，行走不便，口干，舌质红，苔黄腻，脉弦细。实验室检查：血白细胞 $9.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞0.71，淋巴细胞0.29，血沉54mm/h；血尿酸 $435 \mu\text{mol/L}$ ，双肾B超显示：左侧肾盏及上段输尿管多个结石。西医诊断：痛风性关节炎。中医诊断：热痹。治宜清热通络，祛风胜湿，方药：生葛根50g，黄柏10g，苍术10g，薏苡仁30g，川牛膝10g，忍冬藤15g，秦艽15g，防己12g，生甘草6g。服4剂后红肿热痛明显减轻；再服5剂，症状消失能行走；以原方加五加皮15g，服10剂。1年后随访未发。

李氏每遇急性风湿热痹证的患者，均在辨证施治的基础方中加入并重用葛根60g，每能获较好疗效。现代药理研究表明，葛根内含葛根黄酮和大豆黄酮等有效成分，葛根黄酮可增加脑血流量和冠状动脉血流量，降低血管阻力，增加对体内尿酸的排泄；大豆黄酮具有解热、解痉作用。另外，还能减少嘌呤合成，使尿酸生成减少，使体内嘌呤的合成和分解速度处于相对稳定的状态。



重用升麻经验

升麻最早载于《神农本草经》。其性微寒，味微甘、辛；归肺、脾、胃、大肠经；其基本功效有疏散退热、透疹、清热解毒、升举阳气。多用于外感表证、麻疹不透、齿痛口疮、咽喉肿痛、温毒发斑等，临床常用量为3~9g。

方药中重用升麻治慢性迁延性肝炎

著名老中医方药中先生生平擅用升麻葛根汤治疗慢性迁延性肝炎，升麻15~45g，葛根、赤芍各30g，甘草6g。本方系《阎氏小儿方论》方，原治麻疹未发，或发而不透。升麻甘辛微寒，前人多用以透泄疹毒，清解阳明热毒，或升阳举陷。方氏取其解毒之义，用于慢性肝炎，毒热内蕴，血瘀津耗，肝功能损害较重，转氨酶较高者，常其他对证方合用。

方氏认为升麻解诸毒，效验颇良。临床上可以定性为“毒”病的情况大致可归纳为二种：其一可定性为火病而系暴发者，如具有传染性的温毒、时疫之类疾病皆属其范畴之内；其二因误食药物或有毒物所致疾病。这两种情况均可在辨证论治的基础上，使用大剂量的升麻。10余年来，方氏曾重点对病毒性肝炎患者及其他药物中毒患者在辨证论治的同时，重用升麻进行治疗。其剂量一般均在30g，多时曾用到45g，效果很好，无一例有不良反应。

据方氏介绍，曾在10年前治疗郭姓女化验员。肝功能严重损害，谷丙转氨酶在500U左右，经用升麻葛根汤为主，重用升麻（45g）治疗3个月后，肝功能恢复正常，服药期间无任何不良反应出现，以后即全日工作，迄今疗效巩固。此后方氏常用此方重用升麻，配合加味一贯煎、加味黄精汤等治疗本病活动期，谷丙转氨酶持续增高波动较大者，均获良效。一般服用20剂左右，谷丙转氨酶即开始下降。提出大剂量升麻对肝炎病毒或有一定的拮抗作用，值得进一步研究。

李逸民重用升麻治子宫脱垂

北京名老中医李逸民擅用升麻治疗子宫脱垂。李氏认为，升麻气味甘苦平，微寒无毒，去皮色青，形如鸡骨者良。在临床应用上始见于《伤寒论》，至金元时期，李东垣对于升麻的使用范围之广、疗效之妙，给后世医家治疗虚劳内伤、中气下陷诸证树立了典范，其代表方剂就是补中益气汤。

李氏临证治疗子宫脱垂时，就是以补中益气汤为主方。在初期治疗升麻只用



1.5g，大部分病人疗效都不显著。后由 1.5g 逐渐加至 15g 始效。似乎有离经叛道之嫌，然余又何尝不小心从事？审视《药性》，升麻被列入寒性；察看《神农本草经》，升麻气味甘苦平，微寒无毒，质轻而宣，能发越脾气而上升。如中阳不振、谷气下流之妇科带证，升麻用 1~3g 一般可以奏效。子宫脱垂是虚劳内伤、脾肺气虚之重证，药量过轻如杯水车薪，不济于事。参、芪、甘草是补脾肺气虚之圣药，如不借升麻升举之势，子宫下垂如何上提？

李春贵重用升麻解药毒

李氏临床治疗由于药物引起的中毒患者，在辨证论治的同时，重用升麻，效果很好，其用量在 30~40g。如温某，女，22 岁，学生。主诉 1 年前因发热、咳嗽在某院诊断为肺结核，用卡那霉素、链霉素、PAS 等治疗 1 月余，出现耳堵、耳聋、恶心、嘴唇发麻、视物模糊等症状，终止抗结核治疗，但停药后症状未好转。半年前诊断为前庭功能丧失、链霉素中毒性耳聋。经用西药治疗 1 个月，耳聋未见改善，中医以补肾之剂配合针灸治疗近 3 个月，亦未见明显进步。细察其证，除两耳失聪外，并时见轻微的头晕耳鸣，舌苔薄白，脉弦缓。综合脉证分析，肝虽开窍于耳，心亦开窍于耳，突然耳聋，心气闭塞也，脉弦缓者，肝虚也，治宜补肝之精，益心之阴，开心之窍。处方：升麻 35g，鳖甲 30g，龙骨 30g，远志 15g，石菖蒲 20g。服药 4 剂后，两耳已有听觉，且头晕症状减轻，耳鸣有所好转，效不更方，加减进退 20 余剂，听力恢复。后嘱其用散剂，每服 5g 以善后。

李氏体会，升麻为疏散风热药，发汗力较弱，故在小剂量应用时，无伤阴耗液之弊；大剂量应用，应注意阴虚火旺及喘满气逆者慎用。

第二章 清热药

重用石膏经验

石膏最早载于《神农本草经》，其性大寒，味辛、甘、苦；归肺、胃经；其基本功效有清热泻火（清气分实热，清肺胃实热），煅后外用收湿敛疮。多用于温热病气分实热证、清肺平喘、胃热积滞等，临床常用量为 15~60g。

张琪重用石膏治急性热病

国医大师张琪教授善用重剂生石膏治疗急性热病。张氏认为石膏为治疗急性热病的有效药物，但石膏须用生者，更须大剂量方效。张氏学习前贤用石膏之经验，结合自己的临床实践，以生石膏为主与他药配伍，治疗各类发热性疾病，常随手奏效，其退热之功，直胜过犀角、羚羊角等名贵药品。

1. 治疗温热型流行性感冒 包括冬温和春温，临床主要表现为壮热头痛，微恶寒，口渴，舌尖红，苔白，少津，脉象浮数。因风为阳邪，风邪夹温，不同于风寒，初起即壮热头痛、口渴脉浮数、舌尖赤等。治疗此症，银翘散、桑菊饮效皆不显，张氏常用生石膏 50g，加葛根、连翘各 15~20g，一般药后得汗而热退，即所谓“体若燔炭，汗出而散”。

刘某，男，34 岁，1981 年 12 月 18 日初诊。发病 2 日，壮热头痛，口渴，肢节酸楚，微恶寒无汗，舌尖赤，苔白少津，脉浮数，体温 39.8℃。用羚翘丸等无效，病属冬温，宜清热解表。处方：生石膏 30g，薄荷 15g，连翘 25g，葛根 20g，金银花 30g，甘草 15g，玄参 15g，天花粉 20g，服药 3 剂，周身汗出热除而愈。

2. 治疗外寒里热之重感冒 此症在黑龙江省冬、春两季较为多见，临床表现为发热恶寒，肢节酸痛难忍，头痛，口干渴，兼有呕恶、舌苔白干、脉浮滑带数。此为外感寒邪内蕴伏热，宜疏解表邪，加生石膏以清内热。处方：柴胡 25g，桂枝 15g，黄芩 15g，白芍 15g，半夏 15g，生石膏 75g，甘草 10g。



此方仿柴胡桂枝汤意，加石膏以清里热；服药后汗出，诸症悉解。张氏以此方治愈外寒内热之重感冒甚多，往往一剂知、二剂已。甄权谓：“石膏治伤寒头痛如裂，壮热皮如火燥和葱茶煎。”据临床观察与柴胡、桂枝合用得汗出则热退，头痛、肢节酸痛俱除，胜过葱茶远矣。本方除了治疗外寒内热之新感外，亦治外邪入里之伏邪。此伏邪非温病之伏邪，乃寒邪入里潜伏与内热互结，患者常长期发热，时起时伏，发作时则先寒后热，甚至有终年累月不解者。此方用柴胡、桂枝疏解外入之伏邪，使之透表外出；生石膏以清内热，则顽固不解之发热可以解除。

于某，女，37岁，工人，1981年1月29日初诊。发热2月余，上午体温39.5~40℃，持续至夜半热始退，翌日复如是，经本市各医院会诊无结果。余审其发热之前先恶寒，随之即热，自汗，肢节痛，恶心，耳鸣稍聋，便秘，舌苔白干，脉象弦滑。曾经用抗生素、氨基比林等，体温一时下降旋又上升，持续2月余不退，病人体质日见衰弱，筹思良久，应按伏邪施治，辨证属三阳合病，宜解肌和解清热法。处方：柴胡30g，黄芩15g，半夏15g，桂枝15g，生石膏75g，白芍15g，党参20g，生姜10g，大枣3个，甘草10g，水煎服。

2月2日复诊：服上方3剂，热减大半，虽届时仍有热，但体温在37.5~38.0℃，全身已不痛，耳仍小鸣，纳差，苔白渐化，脉弦滑中略有缓象。此乃伏邪渐透病有转机，继用前方连服3剂，热除而愈。类似病例颇多，可参阅柴胡汤类方证治及其运用。

3. 治疗暑温 《金匱要略》谓之喝。“太阳中热者，喝是也。汗出恶寒，身热而渴，白虎加人参汤主之。”此为感受暑热之邪所出现之证候，以汗出、发热、烦渴为主证。叶天士谓“夏暑发自阳明”即指此类，必以白虎加人参汤主治。生石膏常用至200~400g。张元素谓石膏为治“中暑潮热”之要药，信而有征。

邱某，男，30岁，农民，1967年7月2日就诊。当时余在兰西县巡回医疗中遇此病人。神昏壮热，体温40.1℃，面赤唇干，舌焦，大汗出，大渴，心烦气促，头痛，脉洪大有力。此为暑热伤气，热炽津伤，宜清热益气生津。处方：生石膏200g，党参25g，知母20g，甘草10g。服2剂，体温降至35.8℃，神志清，脉滑，诸症悉退。

临床体会：凡热病见洪滑脉象，唇红，舌红，苔白稍粗涩，口略渴，恶寒不甚重者，即可放胆应用生石膏，不必拘泥于阳明经证之具备与否。若有轻微恶寒，恶风表证，也不必顾忌，可加解表药。临床观察凡内热盛而兼有表证者，解表药与石膏合用，常获汗出热解之效。若热病重如《伤寒论》所载谵语、遗尿、脉滑



而厥的真热假寒证时，必须投以大剂白虎汤。1 剂不效，可以二三剂连服，隔 4 小时 1 次。张氏治疗高热不退多采用连续服药法，使药能胜病多获良效。曾遇一病人，初起发热恶寒，继则不恶寒，壮热口渴。经中西医治疗，迁延不愈。后来身不热，但昏不知人，手足厥冷，脉伏不出，举家恐慌，邀余会诊。见其唇干舌绛，苔燥，面色如蒙尘垢，此乃热深厥亦深之真热假寒证，投以大剂白虎汤合生脉饮，隔 4 小时服药 1 次，连服 2 剂，手足转温，脉亦出，唇舌起疱，势如火燎，为热邪外透之佳兆，病人神志转清醒，遂治而愈。

4. 治疗大叶性肺炎及各类肺炎 此病属中医学“温热病”“肺热喘咳”的范畴。凡遇咳嗽喘促、壮热无汗或自汗、舌干脉滑数或浮数等症，《伤寒论》中的麻杏石甘汤是很有效的方剂。本人经验，本方药量比重颇为重要，石膏用量需大于麻黄 10 倍左右，服药后往往热退喘平。麻黄为宣肺定喘之要药，但性温与肺热不宜，必须配合生石膏清热。如生石膏量小，则达不到清热透邪之目的。近人蒲辅周谓石膏闭遏邪气，蒲氏所指是湿温之类。温热炽盛，非石膏莫救。

孙某，男，7 岁，1978 年 11 月 5 日初诊。该患得病 7 日，初起发热恶寒，后壮热无汗，体温 39.7°C 。听诊右肺有散在湿性啰音。X 线片示右肺呈高密度阴影，白细胞总数 $19100/\text{mm}^3$ ，中性粒细胞 75%，诊断为大叶性肺炎，继发脓胸。用青霉素、链霉素、红霉素、氨苄西林治疗 15 天，未见明显好转，体温最高 40.3°C ，邀本人会诊。当时见咳声嘶哑，痰稠黏不易咳出，舌尖红，发热无汗，脉浮数。辨证为寒邪入肺，肺气郁闭，蕴而化热，又挟饮邪。治宜宣肺清热逐饮，投以麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤。处方：麻黄 75g，生石膏 75g，杏仁 15g，甘草 75g，葶苈子 15g，白芥子 75g，桔梗 10g，生姜 5g，大枣 3 个。服药 3 剂后汗出热退，痰易咳出，咳喘大减，体温降至 38.5°C 左右。继服前方 3 剂，体温下降至 37.5°C 。鼻窍已不煽动，但仍喘促胸痛，便秘。此属痰浊壅肺不能肃降，上方加瓜蒌 15g，大黄 3g，半夏 10g，以利肺泄痰浊。服 3 剂，大便通，诸症悉退。经 X 线检查，右肺阴影已消失，继用滋阴润肺之剂，以善其后。

本案符合《医宗金鉴》喘症门马脾风，症见胸高气壅，肺胀喘满，两胁抬动，鼻翼煽动，便秘，神气闷乱。盖因寒邪闭肺经，郁而化热，肺气不通。初治以宣肺清热，继以利下痰涎，先升后降，诸症悉平。麻杏石甘汤重在宣肺清热，麻黄、杏仁宣开肺气，石膏清热。麻黄与石膏合用，其作用不在发汗解表，重在宣肺泄热。故《伤寒论》谓“汗出而喘，无大热者”可用此方。余临床体验，凡急性支气管炎、大叶性肺炎属邪热与痰浊阻于肺经，肺气郁闭者，皆可应用。

5. 治疗猩红热（即烂喉痧） 此为热入营血之证。余昔年治此病甚多，见舌



质虽红，但有白苔，壮热，头痛，恶心呕吐，颈部腋下有痧疹出现，属气血两燔者，投以生石膏 100g，蝉蜕 10g，连翘 20g，金银花 25g，牡丹皮 15g，生地黄 15g，紫草 10g，服 3 剂后，可使热降疹退病愈。

猩红热后续发血尿者，张氏亦用生石膏加生地黄、牡丹皮、大小蓟、白茅根等清热凉血之剂，收效甚速，可见用生石膏不必拘泥于温病学家的热在气分之说。

6. 流行性乙型脑炎及森林脑炎 症见壮热，神昏谵语，口噤面垢，背反张，项强直，口渴，脉洪数，舌苔黄干或见四肢痉挛，抽搐不已，角弓反张，两目上视，口唇青紫，口燥咽干，脉沉伏不出，舌苔如霜。此即“壮火食气”“阳毒伏匿”之证，可投以生石膏 100~200g，玄参 25g，蜈蚣 2 条，全蝎 10g，金银花 50g，葛根 25g，煎后徐徐温服送下，此类病人多不能服药，可用鼻饲法。流行性乙型脑炎在我省较为罕见，森林脑炎则多见。张氏遇此病常用大剂生石膏配合上述药物治疗，效果显著。如见便秘、腹硬满、舌黄燥，可用大承气汤，重用大黄、芒硝，加用生石膏 150~200g，大便通，燥屎得下，病情即见转机。此为阳明经腑合治之法。

陈某，38 岁，男，伐木工人。1961 年 9 月 15 日在哈尔滨某医院住院确诊为“森林脑炎”，邀余会诊。病人高热 39.8~40℃，神志昏愤，狂叫，面垢，目赤项强，角弓反张，舌绛苔燥，手足抽搐，厥冷，躁动不宁，二便闭结，脉沉数有力，此为暑湿暑厥重症，热邪结于阳明，因其如狂乃热入血分，瘀血内结，上犯神明，宜大剂桃仁承气汤下瘀血，重加生石膏清气分之热。处方：桃仁 50g，大黄 50g，芒硝 50g（冲），甘草 20g，生石膏 200g。服 2 剂，二便遂通，下燥屎及红灰污水样便甚多，热大减，狂叫谵语亦止，手足转温，已不躁动。又用生石膏 100g，大黄 25g，桃仁 25g，枳实 15g，川厚朴 15g，芒硝 20g（冲），玄参 25g，生地黄 25g，甘草 15g。继服上方 3 剂后，神志转清，眼珠转动自如，脉见沉弦，舌红转润苔已薄，继以清热解毒养阴之剂调治而愈。

本案属暑厥、暑风之重症。又符合《金匱要略》“腹满口禁，卧不着席，脚挛急，必齮齿”之痉病重症。故于桃仁承气汤中加生石膏以清热生津，获效甚捷。

7. 治疗温毒发斑 高热面赤，狂躁谵语，全身斑疹密集或斑烂点紫，脉洪大，舌艳红、苔黄燥，或舌卷焦黑如烟薰。此为热毒入于营血，用清瘟败毒饮，重用生石膏加紫草等，以清热凉血解毒。

杨某，女，11 岁，学生，1982 年 1 月 8 日初诊。患儿罹淋巴肉瘤 3 年余，经北京某医院用长春新碱、环磷酰胺及肾上腺皮质激素维持，病情一直稳定。因其弟出水痘感染，于 1981 年 12 月 31 日上下肢出现少数红色皮疹，翌日发热，斑疹



逐渐增多，体温达 39℃。经哈尔滨某医院儿科确诊为水痘，用青霉素、链霉素热不降，体温仍在 39~39.8℃，斑疹继续外出不止，入某院儿科传染病房治疗，又用氨苄西林、维生素 C，体温依然不下，斑疹仍继出不止，乃邀余会诊。患儿壮热，头面、眼睑、躯干、四肢以及手指足趾、前后阴部、鼻腔、咽喉斑疹密集，色赤，或丘形融合成片，几乎无健康皮肤，眼不能睁，声音嘶哑，咽峡部周围红赤，小便色黄赤如浓茶，大便微干，脉滑数，舌红无苔少津，神志清，无谵语。血常规：血红蛋白 100g/L，红细胞 333 万/mm³，白细胞 4300/mm³，多核细胞 62%，淋巴细胞 36%，单核细胞 2%。诊断：温毒发斑。辨证温毒之邪郁于阳明。治法：清热凉血，解毒化斑。处方：大青叶 15g，板蓝根 20g，金银花 30g，连翘 20g，玄参 20g，生地黄 20g，麦冬 15g，牡丹皮 15g，甘草 10g，赤芍 15g，黄芩 10g，生石膏 70g，水煎服。嘱其隔 5 小时服药 1 次。服药 2 剂后，体温一度下降至 37.4℃，4 小时后又上升到 39℃，但其颜面水疱疹干枯，再无皮疹出现，大便泻，日 3~4 次，色污黄。嘱继服上方 2 剂，服药后体温降至 37.4℃，但下午又上升到 38.4℃，此乃热毒从大肠外出之佳兆，继用下方：大青叶 15g，金银花 30g，板蓝根 20g，连翘 20g，玄参 20g，牡丹皮 15g，生石膏 50g，黄芩 15g，天花粉 15g，麦冬 15g，山豆根 20g，生地黄 20g，栀子 10g。又用 2 剂体温下降至 35.7℃不再上升，患儿全身皮疹逐渐干枯脱落，能进食，大便日行 1 次，检查肝脾，肝肋下 10cm，脾可触及边缘。血红蛋白 60g/L，红细胞 240 万/mm³，白细胞 3600/mm³，分叶不详。温毒已解，防宿疾复发，以养血凉血之剂调之。处方：当归 20g，生地黄 20g，川芎 15g，白芍 20g，牡丹皮 15g，地骨皮 15g，玉竹 15g，玄参 15g，连翘 20g。服上方 6 剂，血红蛋白 85g/L，红细胞 280 万/mm³，白细胞 5800/mm³，皮疹大部分消退，精神、食欲正常，以上方增减善后，血常规终于恢复正常。

本案在水痘高峰时高热不退，病情极为危笃，重用生石膏达 70g，采取连续服药法，以期药能胜病，足证生石膏是清热解毒之良药。

8. 麻疹、麻疹并发肺炎 初期为风邪所郁者，用升麻葛根汤加味主治。若疹出色红紫或黑、高热喘咳、烦躁不宁、脉洪数或滑数，急宜清热透表，用生石膏 100g，紫草、升麻、葛根、牡丹皮各 5~10g。张氏以此方治愈麻毒陷肺者甚多，用之及时，无不获效。此病期必须用大剂量生石膏方可挽救，喘甚可加麻黄，痰多酌加葶苈子、桑白皮等。

9. 治产后发热 产后在一般情况下忌用寒凉之药，但产后确有实热，生石膏亦在所不忌。《金匱要略》有竹皮大丸，治妇人“乳中（产乳期）虚，烦乱呕逆，安中益气”……方中白薇与石膏合伍，可退热除烦，通乳定乱；竹茹与石膏同用，

善治胃中实热上逆之呕吐，张锡纯曾盛赞此方之功效。余在1981年6月治一少妇产后发热，投以生石膏为主的方剂而热退。

薛某，女，28岁，1981年6月4日初诊。产后20余天，左乳房红肿、硬胀、乳汁不下，发热。西医诊为乳腺炎，先后用青霉素、链霉素、红霉素，其热不下，体温在 $38.4\sim 39.2^{\circ}\text{C}$ 已2周余。病家甚为恐惧，邀余往诊。察其脉滑数有力，左乳房肿胀，乳汁不通，稍有焮赤，舌红苔燥。此是胃中实热不解，宜用清热解毒、通乳之剂。处方：瓜蒌20g，漏芦20g，生石膏50g，牡丹皮15g，赤芍15g，柴胡20g，黄芩15g，蒲公英60g，刘寄奴15g。服前方3剂右乳房胀见消，体温下降至 37.5°C ，继用前方加连翘30g，又服5剂，乳房肿全消，乳汁已通，体温 36.2°C ，病愈。

再如产褥热高热口渴、头痛、神昏谵语、便结尿黄、脉象洪数、舌苔黄燥，属阳明温病，亦必须重用生石膏，辅以党参以益气。余遇此症为顾产后血虚常用白虎人参汤加当归20g养血，每奏良效。

10. 治肺感染 脉见洪滑、大便干燥、咳嗽、咳痰稠黏、有时带血、口渴喜冷饮、胸痛、舌苔黄燥者，此属胃腑实热，肺受火灼，用白虎汤加黄芩以清肺胃之热，效果颇佳。曾治一例支气管扩张合并肺感染病人咳血不止，黄痰稠黏，用生石膏50g加用凉血止血之剂痰转稀薄，咳血止，发热退病乃获愈。

11. 治疗支气管炎、肺气肿合并感染 症见咳嗽痰稠或咳黄痰，身热恶寒，肢节酸痛。此证为表寒里饮夹热，宜小青龙加石膏汤治疗颇效。

刘某，女，63岁，病人素患慢性支气管炎，肺气肿。入冬以来，气候突变，感冒咳嗽加重，喘息不得卧，身热，体温 38.7°C ，恶寒，肢节酸痛，痰稠黏不易咳出，气短，干呕欲吐，脉象浮滑带数，舌质红苔白腻。处方：麻黄75g，生石膏50g，干姜10g，桂枝10g，白芍15g，甘草75g，半夏15g，细辛5g，五味子10g。服药2剂，身热恶寒皆除，咳喘减轻大半，痰变稀薄，继以前方增损而安。

12. 泌尿系感染 症见高热不退，有时用抗生素类热亦不退。张氏用八正散加石膏，发热及尿路刺激症状可迅速消除，临床治疗此类疾病甚多。

李某，女，37岁，工人，1981年1月29日。发热10余日不解，尿频，尿急，小便赤涩痛，周身肢节及腰酸痛，体温 39.2°C 。尿检白细胞满视野，脓细胞(++)，红细胞15~20个，蛋白(+)。脉象滑数，舌干赤。西医诊断：急性肾盂肾炎。由于青霉素过敏，用红霉素、氯霉素热不下，高热10余日不退，病人甚恐惧，邀余往诊，诊为热淋。用清热解毒、利水通淋法。处方：生石膏75g，瞿麦75g，篇蓄20g，车前子15g(布包)，木通15g，大黄5g，滑石20g，焦栀子15g，白茅根50g，



金银花 50g，甘草 10g，水煎服。上方连服 6 剂，发热退，体温下降至 36.2℃，诸症悉除，尿检白细胞 1~2，脓细胞（-），红细胞 2~3，蛋白（+），舌润脉缓。继以清热解毒之剂，连服 3 剂而愈。

13. 治口疮、齿龈溃烂、牙痛、唇舌溃疡顽固不愈 此乃足阳明胃经积热循经上犯所致，不能只着重于局部的治疗，必须重用生石膏以清阳明之热。张氏遇此症常用李东垣之清胃散重加石膏，取效甚捷。

近治一患者于某，唇舌及牙龈溃疡糜烂，用中西药罔效，时退时起，反复不愈。经一年多的治疗不能根除。某医院谓有恶性变之虞，病人甚为忧虑，诊脉滑而有力，唇赤干，舌红少津，边缘有溃疡。处方：生地黄 25g，川黄连 10g，牡丹皮 15g，当归 15g，升麻 10g，生石膏 75g，板蓝根 20g，连翘 25g，金银花 30g。上方连服 20 余剂，口腔溃疡痊愈，不再复发。此方即清胃散重加生石膏，以清阳明之积热，又加板蓝根、银、翘清热解毒，积年沉痾得以向愈。

14. 急性风湿热、关节炎、类风湿关节炎 急性风湿之发热，亦是顽固难治之症。《素问·四时刺逆从论》谓之热痹，病机为热邪痹阻关节，或内有蕴热，复感风寒湿邪与热邪搏结而起。临床表现关节红肿热痛，伴有发热口渴、脉数、舌苔燥等证。《金匱要略》有桂枝芍药知母汤，《千金要方》有犀角散等，治疗此类痹证疗效多不满意。张氏常用生石膏 50~70g，防己、秦艽、穿山龙、地龙、伸筋草、牡丹皮等以清热、祛风、活络，疗效颇佳。

1981 年曾治杜某，女，27 岁，发热 1 年余不退，关节肿痛，脉数舌燥，久治无效。张氏用上方，稍有增减，服药近百剂，发热已退，关节肿痛全消，病情获得完全缓解，足证石膏为治疗急性风湿发热之良药。

刘弼臣重用石膏治小儿热病

著名中医儿科专家刘弼臣教授治疗小儿温病发热，擅于重用石膏取效，虽年幼岁小，重剂亦未见不良反应，而退热之效甚佳。

如治平某，男，15 岁，1963 年 5 月 20 日初诊。发热持续不退，腋温 40℃，精神萎靡不振，咳嗽不爽，大便溏泄，每日二三次，小便黄而不利，曾在某医院诊为传染性单核细胞增多症，单用抗生素后不效。化验血常规：白细胞 $74 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 48%，淋巴细胞 30%，单核细胞 22%。咽喉红赤，舌苔白腻，舌质红赤，脉数不清。证系风温上受，肺胃失宣，治以清气解热，宗白虎汤加味。生石膏 25g（先煎），肥知母 5g，生粉草 2g，粳米 6g（包），桑叶 6g，连翘 6g，黄芩 5g，薄荷 3g，淡竹叶 3g，鲜芦根 30g。另：至圣宝元丹 4 粒，早、晚各 1 粒。

二诊：服清气解热之品 2 剂后，身热已平，汗出津津，大便仍然溏泄，小便



较利，精神略振，微有咳嗽，苔白脉微数，化验血常规：单核细胞已降至正常，再拟原方损治之。生石膏 25g（先煎），知母 5g，六一散 10g（包），南沙参 5g，橘红 3g，橘络 15g，杏仁、薏苡仁各 10g，炙枇杷叶 5g，焦三仙各 15g，灯心草 3 尺。另：至圣宝元丹 4 粒，早、晚各 1 粒。

刘氏认为，考历代名医，善用石膏者，除张仲景外，明有缪仲淳，清有顾松园、余师愚、王孟英，皆以善治温热名。凡治阳明实热之证，无不重用石膏以收工。证之临床，周岁小儿，应用石膏 25~30g，看似骇然，但服至二三剂后，往往热势豁然，诸症亦解。

陈国恩重用石膏经验

通化市名老中医陈国恩在用药方面，师古不泥，尝谓：“服药本为补偏救弊，有是病则投是药，切勿为古人所囿。”某年隆冬，陈氏治一头痛患者，头痛欲裂，呻吟不已，3 日未眠，时时以拳击头，昏昏欲仆，舌红焦干，六脉洪数，曾服芎芷石膏汤数剂不愈。陈氏诊毕，只将方中石膏改为 150g，服药 2 剂头痛若失。陈氏云：“冬不用石膏，夏不用麻黄，彼言其常，此治其变，认准证即放胆用药又何虑之有？只能考虑季节因素，酌用量而已，切勿为其所限。”

夏小军重用石膏经验

甘肃名医夏小军教授在儿科临证时常重用石膏为主药，治疗时行温疫、痰热壅肺、胃热炽盛所引起的诸多病证，每获良效。

1. 时行温疫 谷某，男，5 岁，1998 年 2 月 1 日初诊。左侧耳下腮部漫肿疼痛 4 天，壮热口渴，咀嚼不便，咽红，舌红、苔薄黄，脉浮数、诊为风温在表之痄腮，治以疏风清热、散结消肿，方用银翘散加味。处方：生石膏（先煎）60g，金银花、连翘各 15g，芦根 9g，桔梗、白僵蚕、竹叶、陈皮、荆芥、牛蒡子、薄荷（后下）各 6g，甘草 3g。水煎服，每日 1 剂。服 3 剂后身热退，肿痛渐消，守原方更进 3 剂痊愈。

按语：本例患儿，虽邪在肺卫，尚未入里，但因小儿发病容易，传变迅速，故在辛凉平剂中加用生石膏一味，表里双解，防止传变。白僵蚕既能散结消肿，又能平息肝风，防止邪热暴张而化火动风；陈皮理气和胃，防止苦寒过极损伤胃气，故获全功。

2. 痰热壅肺 梁某，男，8 岁，1999 年 11 月 7 日初诊。发热 7 天，汗出，胸腹满闷，纳呆，咳嗽声浊，喉间痰鸣，痰黄黏稠，口渴欲饮，舌红、苔黄腻，脉滑数。证属痰热壅肺。治以清热化痰、降气平喘，方用麻杏石甘汤加味。处方：生石膏（先煎）60g，黄芩 9g，炙麻黄、苦杏仁、半夏、川贝母各 6g，甘草 3g。



水煎服，每天1剂。服3剂后身热退，咳喘减，原方去黄芩，生石膏减为30g，加沙参、麦冬各9g，再进6剂痊愈。

按语：麻黄性温，原为发汗解表之药；石膏辛寒，擅清阳明气分之热。两药相伍，则麻黄并不解表发汗，而主要是宣肺定喘；石膏配麻黄则不在于清泄阳明，而在于清肺中邪热，且石膏重用于麻黄，以监制麻黄辛温之性，而为辛凉之用，故汗出者不忌麻黄，无大热者不远石膏。加黄芩、川贝母、半夏以清泻肺热、化痰止咳，且在邪去大半之时及时养阴清肺，以防正伤。药中病机，疾病乃愈。

3. 胃热炽盛 李某，女，6岁，1999年6月9日初诊。间断鼻衄1月余，加重3天，流血量多，血色殷红，伴低热，口渴思饮，大便干燥，小便短赤，舌红、苔黄，脉细数。证属胃热炽盛之鼻衄，治以清热泻火，凉血止血。方用清胃汤加减。处方：生石膏（先煎）60g，白茅根、生地黄各15g，茜草、牡丹皮、牛膝各10g，黄芩6g，黄连、生大黄（后下）、甘草各3g。2剂后鼻衄止，大便软，原方去大黄，生石膏减为30g，再进5剂而愈。

按语：石膏性寒质重，外能解肌肤之热，内能清肺胃之火，因此用量宜大，宜生用，且宜久煎。但苦寒过极，易伤胃气，加之小儿脏气清灵，随拨随应，故在鼻衄止后清热泻火当须有节，中病即止，不可过剂。清胃汤去升麻加牛膝以引血下行，上病下取；生大黄泻热通便，白茅根、茜草凉血止血。诸药合用，胃热得除，鼻衄乃止。

任鸿义重用石膏治发热

任氏多年来，临床重用生石膏治疗外感初期热在气分之发热，尤其对一些用抗生素和解热药不效的发热患者，可收到良好的效果。

如治患者，男，44岁。发热恶寒，下午为甚，曾连用3天头孢类抗生素和解热药，效果不佳。现症：体温39.6℃，头痛身痛，口干口渴，咽喉肿痛，纳差欲呕，苔白少津，脉洪大有力。证属表证未解，里热炽盛。治拟解表邪，清里热。药取：生石膏200g，知母10g，荆芥10g，防风10g，白芷10g，柴胡10g，地骨皮10g，桑白皮10g，鱼腥草15g，葛根30g，山豆根15g，甘草6g。2剂，每日1剂，少量多次热服。药后病情好转，体温降为38℃，头痛身痛，咽喉肿痛减轻，自感神疲乏力，乃热病耗气伤津。前方加人参15g，芦根15g，续服2剂，体温降为37.5℃，精神好转，饮食增加。再服2剂，体温恢复为36℃，诸症消除。

生石膏性味辛甘寒，辛能解肌，甘可缓热，寒则泻火，尤长于清泄气分实热。临床证明，退高热小剂量效果不理想，大剂量才能奏效。外感病发热初期，症见大热、大烦渴、大汗出、脉洪大乃可使用。而临床实际上只要是邪在气分的实热

证，不必“四症具悉”即可使用，因现在的发热病人，大都用过抗生素或解热药，因而不汗出者，也有不烦渴者，只要在辨证的前提下，重剂量（200g）早用生石膏，不但退热快，而且可缩短病程，收事半功倍之效。因其无毒性，退高热时成人用量在200g左右，未见出现不良反应。近人张锡纯《医学衷中参西录》中有“愚用石膏以治外感实热，轻症亦至两许（30g），若实热炽盛，又恒重用至四五两或七八两（120~200g）”，对生石膏治疗热病的用量早有研究，启示我们只要辨证无误，卫气营血心中明了，即可重剂大胆使用。生石膏应以热服为宜，因《内经》有“治热以寒，温以行之”之旨，提醒我们热服才能更好地发挥其治疗的效果。

尚学瑞重用石膏治急性热病

尚氏受《疫疹一得》及《医学衷中参西录》等书启迪，重用生石膏（50g以上）为主药，治疗多种属于中医急性热病的患者，取得显著效果。

1. 治疗暑温 暑温为夏季感受暑热病邪所引起的急性热病，初发多表现为壮热汗出，口渴面赤，或微恶寒，唇红，舌红苔黄或燥，脉洪滑而数；重者可出现脱、闭、动风、动血等危候。遇此证，尚氏常放胆用生石膏150~300g，对初发病属气分者收效快捷，对病人营血患者也常随证加用。

如治王某，男，35岁，农民。1987年8月6日求诊。中午冒暑劳作昏倒在地，诊见神志模糊，壮热，体温达40℃，面赤唇干，大汗出，心烦气促，头痛口渴，舌苔焦燥，脉洪大而数。此为“中暑”，暑热内炽，气津两伤，故治疗宜清暑泄热，益气生津。急处白虎加人参汤，重用生石膏。处方：生石膏200g（先下），党参25g，知母20g，甘草10g。急煎频服，1日1剂。服3剂，患者体温降至36.8℃，神清气爽，诸症悉除。

2. 治疗春、冬季流感 春冬季流感出现高热、头痛、口渴等症者，尚氏常重用生石膏50g左右，加葛根、连翘各15~25g，随症加味，一般服药后高热诸症可得汗而解，正所谓“体若燔炭，汗出而散”。

如治黄某，男，23岁。1990年3月17日就诊。2天来壮热头痛，体温波动在39~39.8℃，伴口渴，肢节酸楚，微恶寒，无汗。曾服解热镇痛药、抗生素及中药银翘解毒丸无效。诊其舌脉，舌尖赤，苔白少津，脉浮数。证属“风温”，邪袭肺卫，伤及津液，治宜清热解表，泄热生津。处方：生石膏50g（先下），葛根20g，连翘25g，薄荷15g，金银花30g，甘草15g，玄参15g，天花粉15g。服药1剂，周身汗出，热退；续服2剂而愈。

3. 治疗肺部感染 肺部感染包括西医之“大叶性肺炎”“支原体肺炎”“支

气管炎”及“支气管扩张并发感染”等病。对症见壮热无汗或自汗，咳嗽喘促，痰黏稠，舌干，脉浮数或滑数，属于邪热与痰浊阻肺、肺气郁闭者，一般以麻杏石甘汤加减（重用生石膏，且量大于麻黄 10 倍左右）或以白虎汤化裁，效果确卓。

如治周某，男，18 岁，1996 年 12 月 6 日初诊。患者初病时恶寒发热，咳嗽，按“感冒”治之，但发热时轻时重，后出现高热无汗，气喘，经 X 线、实验室等检查，诊断为“大叶性肺炎”，但用抗生素治疗 5 天未能控制病情，体温最高达 40℃，试用中药。时症壮热无汗，体温 39.5℃，咳嗽，咳声嘶哑，痰黏稠难咳，胸痛，喘促烦躁，便干尿赤，舌尖红，脉滑数。予麻杏石甘汤合葶苈大枣泻肺汤加味，以宣肺清热化痰。处方：生石膏 75g（先下），麻黄 8g，杏仁 10g，葶苈子 10g，白芥子 8g，桔梗 10g，甘草 8g，生姜 5g，大枣 5 枚。服用 3 剂后，体温降至 38.5℃左右，痰易咳出，咳嗽气喘减轻。继服 3 剂，体温基本正常，但仍气喘，胸痛，便结。上方加瓜蒌 15g，大黄 5g，半夏 9g，减石膏量至 50g，麻黄至 5g。续服 3 剂，症除体虚，X 线、实验室复查结果均正常。改用滋阴润肺之剂以善其后。

4. 治疗急性乳腺炎及产褥热 急性乳腺炎和产褥热均为妇人产后易发之患，凡以高热为主症，舌苔黄燥，脉洪数、滑数或弦数者，笔者均重用生石膏为主药，而不避其寒。前者自拟“清热通乳汤”，后者用白虎加人参汤配当归等化裁。

如治邢某，女，26 岁。1997 年 7 月 12 日就诊。产后 20 天，发热不退，体温在 38.5~39.5℃，右侧乳房红肿热痛，乳汁不下。西医诊为“急性乳腺炎”，用青霉素、红霉素等效果不佳。舌红苔燥，脉滑数有力。治宜清热解毒，消肿通乳，用清热通乳汤。生石膏 50g（先下），牡丹皮 15g，赤芍 15g，柴胡 15g，黄芩 15g，蒲公英 40g，瓜蒌 20g，漏芦 20g，刘寄奴 10g。3 剂后，局部症状减轻，体温降至 37.5℃，加连翘 30g，继服。又 5 剂，乳房红肿热痛全消，乳汁通畅，体温正常。

5. 治疗泌尿系感染 凡泌尿系感染出现高热不退，辨证属中医“热淋”范畴者，尚氏每重用生石膏加入随证方中而取效。

如治黄某，男，42 岁，农民。患慢性肾炎 7 年，经治疗病情稳定，尿蛋白（++）。1999 年 8 月 5 日就诊。近日突然高热（39℃以上），伴尿频，尿急，尿痛。用西药无效。刻诊：体温 39.2℃，口苦，腰痛，小腹拘急，尿色黄赤浑浊，便秘。舌红，苔干黄，脉洪数，辨为火热壅盛、下注膀胱之热淋。治宜清热解毒，利湿通淋。用八正散加生石膏化裁。处方：生石膏 50g（先下），金银花 30g，瞿麦 20g，



滑石 20g，篇蓄 12g，车前子 20g（包），大黄 10g，甘草梢 10g。急煎 1 剂，嘱 6 小时服药 1 次。用药 2 剂，小便通利，体温 37.5℃。又常规服药 3 剂，诸症消退。后改用知柏地黄丸等药调理，病情稳定，尿蛋白（+），余无其他不适。

重用天花粉经验

天花粉又名瓜蒌根，最早载于《神农本草经》，其性微寒，味甘、微苦；归肺、胃经；其基本功效有清热泻火，生津止渴，润燥化痰。多用于温病气分热甚、热病烦渴、肺热燥咳、消渴证等，临床常用量为 10~15g。

余跃平重用天花粉治异位妊娠

余氏采用自拟活血抗孕汤治疗异位妊娠。药物组成：天花粉 45g，赤芍 15g，桃仁 15g，丹参 15g，三棱 15g，莪术 15g，蜈蚣（研粉冲服）3 条，蒲黄（包煎）20g，益母草 45g，紫草 15g，川芎 15g。水煎服，每日 1 剂。连续服至血 B-HCG 降至正常。治疗初期，每隔 3 天查 1 次血 B-HCG，如 B-HCG 下降 $\geq 15\%$ ，则改为每周 1 次，直至正常为止。治疗前后做 B 超检查和肝肾功能检查。治疗输卵管妊娠 30 例，取得较好疗效。

现代药理学研究表明，天花粉有致流产和抗早孕作用。其原理是天花粉蛋白能迅速引起胎盘的滋养层细胞变性坏死，坏死细胞的崩解碎片充斥在绒毛间隙，导致血循环障碍，然后加速绒毛组织退化坏死，造成胎儿死亡。同时，内源前列腺素的合成和子宫积液增加，使子宫收缩增强，造成流产。天花粉蛋白是一种植物蛋白，具有较强的抗原性，容易发生过敏反应，临床常与抗过敏药同用。天花粉饮片的常用量为 10~15g。余氏根据临床经验，在自拟活血抗孕方中重用天花粉 45g 治疗输卵管妊娠 30 例，取得较好效果。

重用栀子经验

栀子最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦；归肺、心、肝、胃经；其基本功效有泻火除烦，清热利湿，凉血解毒。焦栀子凉血止血。多用于温热病热甚烦



躁不安、湿热黄疸、湿热淋证、心肝胃脏腑实热证等，临床常用量为 5~10g。

赵荣胜重用栀子治痛经

安徽省名中医赵荣胜教授治顽固性痛经（子宫内膜异位症、膜样痛经）时，每于方中加栀子一味，多获良效。栀子既是清热利湿之佳品，又是解郁化瘀止痛之良药。如《伤寒论》中用栀子豉汤治“心中结痛”，丹栀逍遥散解肝经火郁，民间治跌打挫伤肿痛常用生栀子末调鸡蛋清外敷等。赵氏发前人之意，乃移治痛经，多年应用效佳。每随栀子用量增大而效果更佳。对寒凝血瘀者，与姜、桂配伍，恒用 30~50g。如治乔某，30 岁。患痛经 4 年，进行性加剧，遇寒尤甚。近年来，每次行经须卧床休息，痛甚则恶心呕吐，汗出肢冷。月经周期正常，持续 4 天，量偏多，色紫黑，有血块。平时畏寒，少腹坠胀，大便质稀，苔薄白，脉沉弦。进行 B 超检查提示：左侧巧克力囊肿（5cm×5cm×5cm）。西医诊断为子宫内膜异位症。结婚 3 年未孕，其丈夫精液检查正常。赵氏予以少腹逐瘀汤加栀子 40g，令其每周服 3~5 剂，经期，每日 1 剂。患者连服 50 余剂，痛经基本消失。后受孕，顺产一女婴。

重用黄连经验

黄连最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦；归心、胃、大肠、肝经；其基本功效有清热燥湿、泻火解毒。多用于胃肠湿热泻泄、大肠湿热痢疾、湿热痞满、心经热盛诸症、热毒痈疽疔疖等。临床常用量为 2~5g。

全小林重用黄连治消渴

黄连善清胃火而可用治胃火炽盛、消谷善饥之消渴证，常配麦冬用，如《普济方》治消渴丸；或配黄柏用，以增强泻火之力，如《圣济总录》黄柏丸；若配生地黄，可用治肾阴不足、心胃火旺之消渴，如《外台秘要》黄连丸。现代中医名家全小林教授以重剂黄连（30g 以上）治疗糖尿病取得良好效果。对于重剂黄连败胃的预防，在其复方中加用干姜或生姜，防止其苦寒伤脾胃。

张瑞重用黄连治阵发性室上性心动过速

张氏在临床中发现部分阵发性室上性心动过速的患者，常伴有心经热证，根据文献报道，尝试重用清心热、降心火的黄连治疗本病，并根据兼证，依辨证论治精神，灵活配伍其他药物。以黄连 20~25g 为主药，随兼证加减。若症见心悸、



面赤口渴、心烦易怒、舌质红、脉数等，属心火上炎者，可伍以栀子、黄芩、麦冬、玄参等；若症见心悸不宁、手足心热、口燥咽干、眩晕耳鸣、舌质红少苔、脉细数等，宜酌情配伍养阴安神之品，如二冬、地黄、当归、酸枣仁、柏子仁等；若热兼有痰证，见胸闷烦躁、惊而易发、口干苦、舌质红苔黄腻、脉弦滑等，可再配二陈、竹茹、远志、贝母、胆南星等祛痰之剂，疗效显著。

如治赵某，女，22岁，大学生，1999年10月8日就诊。患阵发性室上性心动过速1年余，平均1个月发作1次，每次持续数分钟。每遇学习紧张及情绪激动则发作趋频，严重时1个月数发，持续时间亦长，发作时心电图示180次/分。心烦易怒，夜寐不宁，口干喜饮，舌边尖红，苔少，脉细数。辨为心火上炎，扰乱心神。治宜清心安神。方用安神丸化裁：黄连25g，麦冬10g，栀子12g，酸枣仁15g，水煎服，1日1剂。服药2个月，阵发性室上性心动过速发作1次，持续时间有所缩短，其心火上炎之证亦减。以上方药物比例，嘱其配丸药长服，每日2服，每服6~8g，温开水送下，并尽量避免烦劳及情绪激动。

重用苦参经验

苦参最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦；归肝、胆、胃、大肠、膀胱经；其基本功效有清热燥湿，泻火解毒，杀虫，利尿。多用于湿热泻痢、湿热黄疸、湿热小便不利、湿热带下、阴肿阴痒、湿疹湿疮、皮肤瘙痒、疥癣等。临床常用量为5~10g。

苏进光重用苦参治室性早搏

苦参治疗室性早搏早有报道，但单味苦参远不如结合辨证用药疗效更好。苏氏重用苦参结合辨证用药治疗室性早搏疗效显著，以此体会到中医辨证用药结合专病用药疗效更佳，亦体现了中医辨证施治之特点。

如治张某，男性，21岁，学生。患者于2006年7月初中毕业后，因情志不遂而失眠多梦，久则出现心慌心跳，食欲减退、消瘦，逐渐发展至心悸、汗出、怕光、手颤，不能坚持农业劳动。曾先后去省、地、县级医院就诊，进行了有关的检查，如心电图、心脏扫描、脑CT、T₃、T₄、TSH等，除心电图示多发性室性早搏外，其他未见异常。曾以心肌炎、心脏神经官能症等给予中西药治疗，但未见明显疗效，特别是心悸、汗出，不但不减反而加重。患者又恐自己是心脏病，

到处求医就诊，曾服抗室性早搏的慢心律、乙胺碘呋酮、安定等仍未见效。2007年2月来诊，症见形体消瘦，易激动，说话时口唇、四肢发颤，自述心慌乱，失眠，自汗，舌质红苔黄，脉细而结代。心电图示多发多源性室性早搏。回顾患者病史，初中毕业后未能升学深造而忧思失眠，继则心悸心跳。病患属忧思过度心脾所伤，久治不愈而出现心脾两虚之证，应益气健脾，宁心安神。查前治疗已给予归脾汤、炙甘草汤等方，疗效未显，故不能再蹈前医覆辙，重用苦参合归脾汤加减：苦参 50g，常山 10g，酸枣仁 20g，白术 10g，茯神 15g，陈皮 12g，木香 10g，沙参 12g，五味子 10g，生龙骨、生牡蛎各 30g，珍珠母 30g，大枣 5 枚，炙甘草 10g。每日 1 剂，水煎取汁 300ml，早晚分服。服上方 5 剂后自觉心悸心跳、自汗、手颤明显减轻，查心电图室性早搏亦较以前减少。效不更方，上方加合欢花 15g，夜交藤 15g，5 剂，照前服用。再来复诊时，心悸、心跳、自汗、手颤基本消失，唯不能耐劳，易激动，心电图示正常心电图，室性早搏消失，为巩固疗效，又服 5 剂，诸症皆除。

苏氏认为室性早搏临床多以心气、心血虚为本，阳亢悸动为标，常以生脉饮、炙甘草汤、归脾汤等益气养心复脉治疗，但疗效并不显著。单味苦参由于用量大，苦参败胃的副作用也很明显，久服患者常不易坚持，故临床重用苦参治疗室性早搏，再结合辨证用药，既提高了疗效，减轻了苦参的副作用，又发挥了中医辨证施治之优势。

重用连翘经验

连翘最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦，微辛；归肺、心、小肠经；其基本功效有清热解毒，消痈散结，疏散风热。多用于痈肿疮毒、咽喉肿痛、瘰疬痰核、风热外感、温病初起等。临床常用量为 6~15g。

李文瑞重用连翘治血淋

名老中医李文瑞临床应用连翘一般用量 3~15g，重用 20~45g，最大用至 60g。李氏认为连翘具有清血分结热、通淋之功，与抗菌、抑菌、利尿等现代药理作用相符。重剂用于血淋，多与重剂白茅根配伍，相得益彰，清热散结而不伤阴，凉血止血而不留瘀，常加入二至丸、八正散等方中重用。临床主要用于原因不明之血尿、肾炎、肾盂肾炎、泌尿系感染等。



如治一男性 21 岁患者。因患急性肾炎年余而休学，尿常规检查红细胞 10~30 个/HP，已持续月余。症见神疲乏力，腰膝酸软，纳可便调，舌质红，苔薄黄，脉弦有滑象。证属热结血分，迫血下行。投予连翘 35g，白茅根 30g。服 5 剂后，尿中红细胞 3~8 个/HP。上方再进 10 剂后，尿常规正常，症状缓解。继以六味地黄丸巩固疗效，之后随访未复发。

重用蒲公英经验

蒲公英最早载于《名医别录》，其性寒，味苦、辛；归心、肝经；其基本功效有清热解毒，消肿散结，利湿通淋。多用于乳痛、肠痈、疔疮、疖肿、痈肿不散、肝火上炎之目赤肿痛、虫蛇咬伤等。临床常用量为 9~15g。

孙一民重用蒲公英治白血病

我国著名中医血液病专家孙一民教授治疗白血病以善重用中药鲜品出名，治愈了诸多当今血液系统之疑难病症。

如治杨某，男，23 岁，农民。患者曾于 1974 年 4 月经地、市医院确诊为急性淋巴细胞型白血病，5 月 13 日转北京某医院治疗。住院 10 个多月，于 1975 年 3 月 23 日出院。出院时诊断为“急淋缓解期”。出院后继续用乐疾宁、甲氨蝶呤、环磷酰胺、白花蛇舌草、狗舌草等中西药治疗。1975 年 4 月 13 日来我处就诊。当时患者鼻腔、齿龈出血，齿龈瘀紫肿胀，口唇发绀，面部发暄、面色㿠白，精神萎靡，说话声音低弱，行走无力。自述：烦躁，手足心热，汗出，口咽干，恶心，纳食不佳，遗精，小便黄，睡眠不宁。舌质红，舌苔黄，脉细数。根据上证乃系阴虚内热，血热妄行。治法：以养阴清热、凉血解毒为法。选方：犀角地黄汤加减。生地黄 12g，牡丹皮 9g，杭白芍 15g，藕节、荷叶各 9g，石斛、麦冬各 12g，山栀子 9g，连翘 15g，白茅根 30g，建曲 9g，竹茹 6g，牡蛎 24g，大蓟、小蓟、扁豆花各 9g。每日 1 剂，水煎服。

4 月 25 日二诊：上方连服 10 剂后，病情略有减轻，齿龈、鼻衄暂止，饮食渐增，恶心减轻。仍烦躁，手心热，汗出，口咽干，遗精。按上方意，加量、调整：生地黄 15g，牡丹皮 9g，杭白芍 15g，小蓟 24g，藕节、荷叶各 9g，石斛 15g，麦冬 12g，山栀子 9g，连翘 18g，白茅根 30g，竹叶 9g，竹茹 6g，陈皮 9g，牡蛎、浮小麦各 30g。每日 1 剂，水煎服。后又在上方基础上加减化裁。

11月28日复诊：上方加减服20余剂后，因连续感冒，发热，阴液受伤，内热仍炽，现在又见齿龈出血，口唇干裂，加重养阴清热、凉血解毒剂量。方用：生地黄、小蓟各30g，白茅根60g，玄参30g，石斛、麦冬各15g，知母12g，连翘15g，山栀子、荷叶各9g，藕节15g，甘草3g，天花粉15g，金银花、蒲公英各30g。每日1剂。

在上方基础上，随证加减，服至1976年6月9日，经数月治疗，症状虽有好转，但患者内热及衄血仍时有反复，考虑是否某些药有副作用，服后助长了内热。针对这一情况，我们尚得患者同意，停用其他药物，并根据前段在治疗中临床观察，每用大剂量鲜药如鲜生地、鲜小蓟、鲜蒲公英、鲜白茅根等，效果比较好。因之，每日只以4味鲜药加大剂量服用。处方：鲜公英、鲜小蓟各500g，鲜生地250g，鲜白茅根250g，切碎、洗净，每日煎1剂当茶饮。

上方鲜药服10余剂后，齿龈出血即止，遗精亦愈，阴液渐复，内热渐清，口咽干减，饮食增加，精神好转。到1977年5月15日为止，共服上方158剂，患者精神很好，无出血，无发热，无明显贫血（血红蛋白80%），肝脾不大，周身淋巴结不肿大，神经反射正常，齿龈瘀紫肿胀消失，日吃主食约1斤半，已能从事重体力劳动。

在辨证论治处方用药的基础上，孙氏选用了鲜药，在治疗过程中，孙氏选用了四味鲜药作为治疗的主药。因为鲜药含有自然汁，其养阴清热等作用比干药好。如梨有清肺润肺的作用，鲜梨含有大量自然汁，所以吃鲜梨比梨干的作用好得多。张锡纯认为：“小蓟能清血分之热，此血热之妄行，单用小蓟根数两煎汤，或榨取其自然汁开水冲服效佳。茅根善清虚热而不伤脾胃，为涵养真阴之佳品。”鲜生地长于清热凉血，生地黄的提取物有促进血液凝固而起止血作用；蒲公英有清热解毒的作用。可见鲜药的自然汁中所含有效成分较干药高。这可能与在干燥过程中丧失某些有效成分有关。所以我们选了鲜生地等四味药作为主药，终于取得了良好效果。

关于用药剂量：本例患者从诊断到治疗，从选方到用药，都以极谨慎的态度来对待，但患者内热出血却时有反复。问题在什么地方呢，考虑患者齿龈瘀紫肿胀，似为血分热毒较甚，内伏较深，轻者齿龈出血，重时很可能腐溃化脓。前一段治疗，虽药证相符，奈热毒根深蒂固，病重药轻，犹如“杯水车薪”，疗效不大。随在不影响胃纳的情况下，逐渐加大了剂量，最后加至每日量达1500g，经长期服用，终于取得比较满意的疗效。孙氏认为对这例患者的治疗，最后加大了药量，是提高疗效的一个重要因素。这对我们今后在治疗某一特殊病例疗

效不明显时，是认为病不易治呢，还是剂量没用到位呢，这确实是值得进一步探讨的问题。

又如治牛某，女，52岁，营业员。患者从1979年开始感觉低热，乏力，纳呆，五心烦热。1980年春节前，又感左下肢关节疼痛，同时发现左腹部有一肿块，因身体逐渐消瘦、乏力加重而停止工作。1980年4月1日在地区肿瘤医院检查：超声波提示：脾脏最大厚度9cm，肋下7.5~9cm；左上腹部有一肿块，最大直径9cm，肿块区波型为微小低波。周围血常规：白细胞 $153.6 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞61%，淋巴细胞7%，嗜碱性粒细胞7%，嗜酸性粒细胞5%，幼稚细胞20%，血红蛋白10g%。4月4日骨髓穿刺检查意见：慢性粒细胞型白血病。予以化疗：口服白血宁1周，后又改服马利兰，效果不佳，病情未得到控制，白细胞计数继续增高。4月11日血检：白细胞 $258 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞39%，淋巴细胞2%，嗜碱性粒细胞2%，嗜酸性粒细胞2%，杆状核细胞2%，早幼粒细胞4%，中幼粒细胞22%，晚幼粒细胞23%，晚幼嗜酸粒细胞3%，原始粒细胞1%。于1980年4月17日来院就诊。主症：低热，五心烦热，齿龈瘀紫肿胀，关节疼痛，腹中痞块，纳呆，神疲乏力，舌质嫩、尖红、中心有裂纹，苔白，脉细微数。心肺无异常，肝未触及，脾大肋下约9cm，左腹部触及一可移动性肿块，约9cm×5cm，质软，无压痛。西医诊断：慢性粒细胞型白血病。中医辨证：阴虚内热，热毒蕴伏血分。患者低热，五心烦热，舌红、有裂纹，脉细数等症，系阴虚内热所致。血分热毒壅盛，则发生白细胞恶性增生，进而出现脾大，腹部痞块，关节疼痛，齿龈瘀紫肿胀等浸润现象。治拟滋阴清热、凉血解毒为法，停止其他一切治疗。处方：鲜蒲公英、鲜小蓟各250g，鲜生地60g，每日1剂，水煎服。

5月19日血检：白细胞 $10.2 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞5%，淋巴细胞44%，嗜酸性粒细胞1%，血红蛋白145%，血小板 $116 \times 10^9/L$ 。处方：①鲜生地100g，鲜小蓟40g，鲜蒲公英400g，每日1剂，水煎服。②建曲9g，谷芽、麦芽各15g，焦内金9g，佩兰9g，云茯神15g，白芍12g，甘草3g。3剂，水煎，另服。

7月14日复查：未见异常，服下方继续观察。处方：鲜生地250g，鲜小蓟500g，隔日1剂，水煎服。8月6日骨髓穿刺检查：基本缓解。

按语：临床治疗白血病，多以化疗为主，但药物副作用对身体损害较大，往往邪正同衰，病情易反复。孙氏通过长期临床实践，发现用大剂量凉血解毒、甘寒养阴的鲜中药来治疗，既祛邪又扶正，可达邪去正复之目的，与其他治疗白血病的药物比较，不仅疗效显著，且没有什么副作用。



重用败酱草经验

败酱草最早载于《神农本草经》。其性微寒，味苦、辛；归肝、胃、大肠经；其基本功效有清热解毒，消痈排脓，祛瘀止痛。多用于肠痈、肺痈、痈肿疮毒、产后瘀阻腹痛等。临床常用量为 6~15g。

邵冬珊重用败酱草制酸

邵氏临床体会，败酱草为一制胃酸良药。泛酸或吐酸为临床常见症状，脾胃肠病证中或以其为主症，或为胃痛、胁痛、呕吐之兼症。夫酸者，肝木之性也，吐酸多与肝胃相关，且有寒热之别，《证治汇补·吞酸》云：“大凡积滞中焦，久郁成热，则本从火化，因而作酸者，酸之热也；若客寒犯胃，顷刻成酸，本无郁热，因寒所化者，酸之寒也。”但吐酸总以热证多见。故无论病之寒热，凡有吐酸症者，皆随方加用败酱草，常用量 15g，效不显者，可用至 20~30g。湿热郁滞于中，随气上逆，则吞酸作矣。败酱草用于湿热之证，此其制酸之理也。

骆洪道重用败酱草治鼻窦炎

骆氏在治疗盆腔炎过程中，重用败酱草，意外地治愈一妇女患了多年的鼻窦炎。受此启发，以苍耳子散加重败酱草用量治疗鼻窦炎，其效甚佳。

如治傅某，女，19 岁。2002 年 3 月 22 日初诊。患者于 3 个多月前因外感引发鼻窦炎。鼻塞流涕，涕浓稠色黄。曾在某医院耳鼻喉科诊治，检查：鼻黏膜充血，中鼻甲稍肥大，鼻腔底有脓性分泌物。诊断为鼻窦炎。用阿莫灵胶囊和鼻窦炎口服液治疗 10 余天，鼻涕由浓转淡，鼻塞也略有好转。家长怕长服抗生素有副作用而停药。不料 1 周后鼻塞、涕浓复旧。刻诊：鼻涕黄黏量多、鼻塞，并偶见咳嗽，口干，小便黄，大便干，舌略红、苔微黄，脉滑略数。中医诊断：鼻渊。辨证：肺胃郁热熏鼻。治以清热解毒，利湿排脓，消肿散结。方用苍耳子散合败酱草加减。药用：败酱草 60g，苍耳子 12g，辛夷 10g，白芷 10g，黄芩 10g，冬瓜子 20g，生薏苡仁 20g，穿山甲 6g，蜈蚣 2 条，桑白皮 15g，生甘草 3g，7 剂，每日 1 剂，水煎分 2 次服。服药后，鼻涕量大减，质转稀，色转淡，鼻塞基本好转。原方减黄芩加生黄芪 20g。继服 7 剂而康复。

现代药理研究表明，败酱草对金黄色葡萄球菌有较强的抑制作用。大肠经与肺经互为表里，故重用败酱草治疗鼻窦炎，药症合拍，可提高疗效，缩短疗程。



王希臣重用败酱草治妇科炎症

王氏在辨证论治的基础上重用败酱草治疗女性生殖系统炎症（外阴炎、阴道炎、子宫颈炎、盆腔炎等），疗效甚佳。

如治王某，17岁。20天前月经后外阴磨破，近3日溃破面迅速加大，外阴肿胀，疼痛难忍，行动受阻。妇检：小阴唇内侧均有2cm×2cm溃破面，右上达阴蒂，左下达阴唇系带，边界清，被覆脓苔，伴发热，心烦，夜不能寐。两脉弦数，舌质红、苔黄厚腻，为湿热型外阴溃疡。处方：败酱草60g，丹参30g，赤芍10g，川楝子15g，乳香、没药各10g，每日1剂，药渣放入盆内煮沸外洗。3天感舒适，5日后妇检已愈。

又如治赵某，48岁。有慢性盆腔炎史。近日下腹部疼痛加重、拒按，寒战，恶心，心烦不眠，口渴咽干，大便燥，小便黄，脉洪滑，舌质红、舌心黑、苔黄腻。为热入营分。妇检：阴道畅，内见少量褐色血液，宫颈轻度糜烂，B超示：子宫体境界不清，双侧附件肿大与子宫粘连（6.8cm×5.6cm），后穹窿穿刺有脓流出，印象：盆腔脓肿。处方：败酱草90g，黄芪15g，穿山甲15g，薏苡仁30g，丹参30g，桃仁20g，乳香、没药各10g，金银花15g，川楝子15g，每日1剂。前后加减共服30剂而愈，随访未复发。

王氏在实践诊疗中每遇女性生殖系统炎症患者都重用败酱草一药，收到较好的效果。并且败酱草的用量超过常规用量甚多，未发现不良反应。

熊新年重用败酱草治前列腺增生症

熊氏在临床中发现该药对前列腺增生症有很好的治疗作用，遂在相应的方剂中加入大剂量败酱草（30g以上），收到良好的疗效。熊氏认为，前列腺增生症多因年迈体弱，气血亏虚，肾阳衰惫，瘀血败精瘀阻膀胱日久致腺体增生，州都气化失司。本病渐有年轻化趋势。治当补益肾阳、祛瘀通浊为要。《本草正义》谓败酱草：“此草有陈腐气，故以败酱得名。能清热泄结，利水消肿，破瘀排脓。”故在治疗前列腺增生症时，重用败酱草，取其腥臭陈腐直趋下焦，入肝经达阴器，能破瘀消肿，能通浊祛败精，去故生新而窍道畅利。

重用土茯苓经验

土茯苓最早载于《滇南本草》，其性微寒，味淡、甘；归肝、膀胱、胃经；其



基本功效有清热解毒，祛湿。多用于杨梅毒疮、肢体拘挛、痈肿疮毒、瘰癧、痹证等。临床常用量为 15~60g。

余国俊重用土茯苓治头痛

四川名医余国俊先生善于重用土茯苓治疗头痛。如治杨某，女，38 岁。右侧头痛反复发作 8 年，1~2 个月发作 1 次，发时痛如锥刺，前额、眼眶胀痛，右侧面部发红，伴呕吐稀涎。服麦角胺、卡马西平可以缓解。笔者接诊时，察其舌质暗红，边尖有瘀点，苔薄黄，脉弦略数。考虑为气郁痰滞络阻，用清·陈士铎《辨证奇闻》所载散偏汤加减，服 3 剂头痛渐止。1996 年 5 月 8 日头痛复发如前，用上方加土茯苓。处方：土茯苓 120g，川芎 30g，白芍 30g，柴胡 10g，白芥子 10g，炙远志 6g，白芷 6g，葛根 30g，生甘草 6g。服 1 剂止痛。迄今 3 年余，头痛发作间隔时间延长，4~6 个月发作 1 次，症状逐渐减轻。每次发作均用土茯苓 120g 水煎服，均 1 剂止痛。

又如治张某，女，17 岁，1997 年 4 月 20 日出诊。头痛 3 年多，每因受凉、生气而发作，剧时满头胀痛伴恶心，平时则绵绵隐痛。常服扑炎通、去痛片等，止痛效果越来越差。患者 12 岁时曾做过心脏瓣膜手术，体质差，情怀悒郁。察其舌质偏淡、苔薄白，脉弦细。予土茯苓 120g，装入保温瓶中开水泡 2 小时，代茶顿饮之。服药后，当晚头痛大减。遂每日泡服 120g，3 天后头痛消失。

土茯苓首载于《本草纲目》，未言其治头痛，尔后的中医学著作亦未言其治头痛。若此解毒清热、健脾除湿之药，重用 120g 何以能止痛？重温清·徐灵胎关于“药性专长”的一段妙论：“凡药性有专长，此在可解不可解之间，虽圣人亦必试验而后知之。如菟丝子之主面黧黑，亦其一端也。以其辛散耶？则辛散之药甚多，以其滑泽耶？则滑泽之药亦甚多，何以他药皆不能去，而菟丝能之？”徐氏由此而推论药性之专长曰：“但显其形质气味者，可以推测而知，而深藏于性中者，不可以常理求之……药中如此者极多，可以类推。”故临证者除了熟悉药物的四气五味、升降浮沉、归经及常规用法之外，还应掌握药物的特殊专长与优势，便于出奇兵而奏厥功。

朱良春重用土茯苓治痛风

对于现代医学之痛风亦有佳效，国医大师朱良春认为，“此乃嘌呤代谢紊乱所引起，中医认为系湿浊瘀阻、停着经隧而致骨节肿痛、时流脂膏之证，应予搜剔湿热蕴毒，故取土茯苓健胃、祛风湿之功。脾胃健则营卫从，风湿去则筋骨利。”朱氏治疗此证，恒以土茯苓为主药，配用萆薢加强清热化湿之效，屡有效验。但用量需 30~60g。

时慧君重用土茯苓治痛风性关节炎

时氏根据痛风性关节炎的发病规律，临证施以大剂量土茯苓（30～60g）为主药治疗，一般3～5剂即可控制关节红肿热痛。急性期以土茯苓50～60g，配伍蚕沙、忍冬藤、红花、川牛膝、萆薢、泽兰、赤芍、牡丹皮、延胡索、地龙；慢性期则以土茯苓30g，配伍生黄芪、白术、桑寄生、独活、忍冬藤、防己、薏苡仁、萆薢、川牛膝等。例如蒋某，男，45岁。因突发右第一跖趾关节红肿热痛2天，于1999年8月11日就诊。既往无慢性关节痛病史，血尿酸608mmol/L，诊为痛风性关节炎。投以急性期方1剂后症状减轻，2剂后痛大减，5剂后右跖趾关节红肿消退，改服慢性期方10剂后复查血尿酸已降至342.6mmol/L。

时氏认为，痛风主因是“内毒”——体内尿酸产生过多，而土茯苓性平，味甘淡，入胃、肝经，具利湿、解毒、利关节之功效，切合痛风病机，故而以土茯苓为主药组方治疗痛风症效果颇佳。

任继学重用土茯苓治蛋白尿

国医大师任继学教授常重用土茯苓解毒除湿，治疗肾风蛋白尿。正虚外感是肾风病成之因，湿浊毒邪则是肾风病成之机。《本草正义》谓土茯苓“利湿去热，能入络，搜剔湿热之蕴毒”。任氏认为，土茯苓为治湿毒要药，归经脾、肾，能通经透络，解毒除湿，它既能渗利湿浊之邪，又能正化湿浊而使之归清，湿渗浊清毒解，精微固藏，尿蛋白自可消除。土茯苓“败毒祛邪，不伤元气”（《本草秘录》），《救荒本草》云其可以代粮，故长期大剂量服用无明显毒副反应。任氏治肾风常重用土茯苓至200g为君药。《本草备要》谓土茯苓“有赤白二种，白者良”，慎不可用代用品，否则损胃。

如治陈某，女，38岁。于2003年2月16日初诊。腰酸痛4个月而就诊。4个月前，“重感冒”后出现腰酸痛，在当地医院诊为“急性肾小球肾炎”，经中西医结合治疗未见明显好转。诊见：劳累后腰酸痛，下肢酸软无力，口中黏腻，晨起恶心，咽红，舌红、苔白腻，脉沉缓无力。查尿常规：隐血（++），蛋白（+）；肾功能及肾脏B超检查正常。西医诊断：急性肾小球肾炎；中医诊断：急性肾风。辨证为湿浊化热，治宜渗湿化浊，清热解毒，佐以益肾。药用土茯苓100g，爵床、山茱萸、血草、绵黄芪各20g，姜竹茹、白豆蔻、杜仲炭、马勃、枸杞子各15g，鲜白茅根60g，桔梗10g。服1个月后尿蛋白消失，再随证加减，治疗4个月后尿隐血消失，病愈。

李庭喜重用土茯苓经验

李氏在临床上放胆重用土茯苓，辨证配方治疗多种疾病，取得显著效果。

1. 治疗偏头痛 某女，36岁，教师。1998年3月10日来诊。自诉左侧头痛反复发作7年余，1~2个月发作1次，发则头如锥刺，前额、眼眶胀痛，左面部发红，伴有恶心、呕吐稀涎。每服麦角胺、卡马西平而缓解，深以为苦。现症又发，求中医治疗。察其舌质暗红，边尖有瘀点，苔薄黄，脉弦略数。脉证合参，用《辨证奇闻》之散偏汤加减：川芎、白芍各30g，白芷、柴胡、白芥子各10g，葛根30g，细辛、生甘草各6g。服6剂头痛止。5月12日，患者头痛复发，李氏忆及有资料载重用土茯苓止头痛，遂于上方加土茯苓120g。服1剂，头痛即止。又续5剂。此后头痛仍间有发作，李氏尝试独用土茯苓120g煎服，亦可1剂止痛。迄今为止，患者头痛发作间隔时间延长，4~6个月发作1次，症状明显减轻。且每发辄自取土茯苓120g煎服，均1次止痛。

按语：偏头痛是临床多发而难治之症。本例患者病史长，结合舌脉，属痰浊郁滞，血瘀络阻，重用土茯苓以除湿涤痰，通络止痛，切中病机，故可获效。必要时配川芎、白芷、葛根、细辛以活血温通，引经升阳；配白芍、甘草缓急止痛；配白芥子以除顽痰。诸药合用，对多种病程较长的头痛、偏头痛有确切疗效。

2. 治疗农药中毒后遗症 某女，26岁，农民。1997年5月18日初诊。患者1个月前因家庭矛盾，服农药甲胺磷约30ml，不久出现昏迷、抽搐、二便失禁等中毒症状。经住院抢救，症状消失出院。近20天来，患者渐觉足趾、足背麻木，并逐渐加重，双下肢乏力。半月前在某医院诊为“末梢神经炎”，治疗10天余未效。刻诊：身重面黄，双下肢麻木、痿软无力，胸脘痞满，不思饮食，小便短黄，舌质红、苔黄腻，脉濡数。辨为痿证，方宗四妙丸加味，重用土茯苓。方药：土茯苓60g，苍术、独活、陈皮各10g，黄柏12g，怀牛膝、薏苡仁、川芎各15g，甘草6g。服药5剂，患者症状略有改善。又5剂，肢体麻木明显减轻，下肢较前有力。上方继服15剂，疾病痊愈。1997年12月随访，患者可正常参加体力劳动，肢体痿软未复发。

按语：农药中毒后遗症多发于中毒量大、中毒时久和素体虚弱患者。本证属余毒留恋，湿热阻滞气机，上扰神明，流注下肢经络，气血郁滞，肢体失养。方中重用土茯苓以加强利湿解毒，与诸药共奏清热化湿、解毒活血通络之功，故可较快改善症状，缩短疗程。

3. 治疗心律失常 某男，56岁，干部。1999年10月20日初诊。患痛风20年，久医乏效。10天前又出现心悸、气短，曾遍服中西药。半年前心悸加剧，辗转本地多家医院治疗无效，住我院，确诊为房颤、痛风、肾功能不全。但叠进中西药效差。刻诊：心悸，胸部憋闷，气短乏力，稍动则气不接续，入夜时常憋醒，



大汗淋漓，醒后难以入睡，周身多处关节红肿热痛，有结节，活动受限，稍有恶心，下肢轻度浮肿，二便尚可。舌质淡有紫斑，苔薄，后根腻，脉结代。测心率 230 次/分，时有间歇。处方：土茯苓 60g，人参 15g（另兑），麦冬 12g，五味子 9g，丹参 18g，葛根 30g，山楂 30g，泽泻 12g，苏梗 12g，香附 15g，炒酸枣仁 20g，牡蛎 20g，川牛膝 15g，甘草 5g，苦参 12g，7 剂，水煎服。10 月 27 日复诊：服上方后，心悸气短减轻，入夜可安睡 5 小时左右，肢体关节疼痛略减，舌脉同前。上方继进 20 剂。11 月 16 日三诊：心悸、气短、入夜憋闷消失，肢体关节红肿疼痛缓解，脉已转平，80 余次/分，偶有间歇。嘱其每月服 5 剂，以巩固疗效。6 个月后随访，心悸、肢体关节红肿未作。

按语：心律失常属中医“心悸”范畴，多责之于痰浊、湿郁、热毒和瘀血内扰或气血两亏，心脉失养。本例患者病程长，心之气阴俱虚，兼湿浊瘀血阻滞，重用土茯苓可利湿化浊通脉，并能健脾益气，配生脉饮及活血理气、利湿安心之品，标本兼治，故能收功。

4. 治疗睾丸炎 某男，19 岁，学生。1999 年 06 月 20 日来诊。突发右侧睾丸肿大如鸡蛋，局部红肿灼痛，疼痛难忍，行走不便，夜不能寐，并伴寒热等全身不适，经西药抗炎治疗，效果不显。查体：体温 39.9℃，右侧睾丸肿大如鸡蛋，灼热触痛。白细胞 $11.0 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.68。诊为急性睾丸炎。舌红，苔薄黄而腻，脉疾数。处方：土茯苓 50g，橘核、荔枝核、川楝子各 15g，昆布、海藻各 20g，赤芍 12g，广木香、小茴香、延胡索（醋炒）各 10g，陈茶叶约 30g。水煎 2 次，混合取汁 600ml，分 2 次服，1 天 1 剂。服 5 剂，患者症状明显好转，睾丸肿胀已减，疼痛基本消失，稍有触痛，行走活动无不适感。守方 3 剂而痊愈。

按语：睾丸炎属中医“子痛”“疝痛”范畴，多为厥阴经脉失调，湿毒蕴结积聚，气血壅滞，经络阻隔所致。本例患者年轻新发，湿热毒邪炽盛，故重用土茯苓清热解毒，利湿通络，又配理气活血软坚等药，从而迅速取效。

王荣港重用土茯苓治疗牙龈肿痛

天津名医王荣港以土茯苓为主药，治疗牙龈肿痛数十例，均收良效。

如治张某，男，52 岁。患牙周炎 1 年余，经常牙龈肿痛，伴出血。惧冷、酸、热、硬食物。其牙龈中度萎缩，伴红肿，齿衄，口臭，纳呆，大便不爽，小溲短赤，舌红苔白略腻，脉滑略数。证属中焦湿热，治以清热解毒祛湿。处方：土茯苓 60g，薏苡仁 20g，生石膏 15g（先煎），黄连、黄芩、苍术、川牛膝、栀子、荷叶各 10g，升麻 1g。连服 3 剂诸症大减，又服 5 剂即愈。嘱其用土茯苓 100g 煎



汁 500ml 备用，每日刷牙后用 15ml 药汁兑入 50ml 凉开水中含嗽。随访 1 年未复发。

王氏认为，牙龈肿痛多为胃中湿热所致，缠绵难愈。土茯苓清热解毒，除湿通络之功，为上述诸药所不及，故在治疗牙龈肿痛时于方中重用土茯苓可获事半功倍之效果。

重用白花蛇舌草经验

白花蛇舌草最早载于《广西中药志》。其性寒，味微苦、甘；归胃、小肠、大肠经；其基本功效有清热解毒消痈，利湿通淋。多用于痈肿疮毒、咽喉肿痛、毒蛇咬伤、热淋涩痛等。临床常用量为 15~30g。

黄时浩重用白花蛇舌草治慢性非特异性溃疡性结肠炎

黄氏根据现代药理研究认为，白花蛇舌草能刺激网状内皮细胞的增生，增强网状细胞及白细胞的吞噬能力，有抗菌消炎的作用，故临床常以白花蛇舌草为主，配槐花、金银花、黄连清热解毒；大黄、当归尾、红花、赤芍凉血活血、祛瘀消肿，保留灌肠，治疗慢性非特异性溃疡性结肠炎，多获良效。加之灌肠可直中病所，作用于病变部位，改善局部血液循环，消除水肿及炎症，改变肠黏膜的病理状态。白花蛇舌草干鲜品均可入药，鲜药要加量，方可有效。

如治刘某，男，42 岁。反复大便不规律 2 年，腹泻与便秘交替出现，大便混有白色黏液，伴有左下腹部阵发性疼痛，时有腹胀肠鸣，矢气则舒，常疲倦乏力，纤维肠镜检查：直肠、乙状结肠黏膜充血水肿，黏膜下血管模糊欠清，诊断为慢性非特异性溃疡性结肠炎，多方治疗无效。舌淡、舌黄厚腻，脉弦。处方：白花蛇舌草 100g，槐花 15g，大黄 10g，金银花 15g，黄连 10g，当归尾 10g，红花 10g，赤芍 10g。上药加水 1000ml，煎至 150ml，每晚睡前保留灌肠 1 次，嘱忌吃油腻燥热食品，多吃蔬菜瓜果，反复灌肠 30 余天，大便成形，无黏液，每日一行，左下腹痛症状消失。随访 2 年未复发。

倪寄兰重用白花蛇舌草经验

北京名老中医倪寄兰在临床上注意将白花蛇舌草与其他药物配合使用，用于各科疾病收到良好的疗效。配龙葵可以增强清热利咽的作用，能治疗咽炎；配鱼腥草可以增强清肃肺金、止咳化痰的作用，用以治疗急性支气管炎；配桑白皮有清泻肺热、化痰平喘的作用，可以治疗肺炎；配金钱草能清肝利胆、渗利湿邪，

治疗胆囊炎；配垂盆草有清肝解毒、利湿化浊之效，用以治疗急性肝炎，效果良好；配石韦能清利膀胱湿热，常常用以治疗泌尿系感染；配葎草有清热利湿化浊的作用，常用于治疗肾小球肾炎；配牡丹皮、玄明粉可以清热凉血，通腑泻下，能治疗急性阑尾炎；配萆薢、莪术能清热利湿，活血消肿，可以治疗急性前列腺炎；配漏芦、穿山甲能清热解毒，活血止痛，治疗急性乳腺炎；配穿破石、薏苡仁可清热利湿，散瘀止痛，用以治疗盆腔炎；配草河车、芙蓉叶能清热解毒，散瘀凉血，多用于治疗急性淋巴管炎；配蝉蜕、苦参以清利湿热，散风止痒，用以治疗各种痒疹；配生石膏、知母清热解毒，生津止渴，共奏退热之功；配芦根、葛根能清热解毒，疏风解表，可以治疗病毒性感冒；配急性子、威灵仙能清热解毒，抗癌利膈，用以治疗食管癌；配砂仁、蜈蚣能解毒抗癌、行气止痛，可治疗胃痛；配鳖甲、水红花子有解毒抗癌、软坚散结之功，可以治疗肝癌；配紫苏子、地龙能解毒抗癌，降逆平喘，可以治疗肺癌；配薏苡仁、白蔹以解毒抗癌、渗湿散结，临床用以治疗宫颈癌；配黄药子、山慈菇能清热解毒，散结消瘰，可以治疗甲状腺肿瘤。

倪氏认为，白花蛇舌草味甘，性淡凉，能清热解毒，活血利尿，不仅有抗菌作用，还能抗病毒及抗癌等。由于配伍不同，作用各异，疗效也大相径庭。此药用量宜大，一般用 30~60g，药量太小则疗效不佳。

宫润珍重用白花蛇舌草治盆腔炎

宫氏在临床上取其清热解毒作用，单味或稍佐他药，治疗盆腔炎效果颇著。常用的方法是：症状轻、病程短者，单味大剂量水煎服，每日剂量在 50~75g，连用 15 天；稍重者加蒲公英 25~50g，泽兰 15~25g，每日 1 剂，水煎服，15 天为 1 个疗程，必要时停药 1 周，再用 1 个疗程；症状重、病程长者，以白花蛇舌草为主药，根据辨证情况，按照君臣佐使选药组方，亦可同时配用西药替硝唑、左氧氟沙星，或口服，或静脉滴注，此法屡验屡效，优于单用西药治疗。

如治刘某，女，32 岁。小腹坠胀，疼痛 1 月余，伴腰骶部酸痛，中等量黄带，心烦多梦，饮食及二便尚可，舌尖红、苔白微黄腻，脉弦滑。B 超提示子宫直肠窝处可见 16mm×23mm 的液暗区。西医诊断为盆腔炎，中医诊断带下症（湿热内蕴型），治疗用白花蛇舌草 75g，蒲公英 30g，泽兰 25g，知母 15g，黄柏 15g，每日 1 剂，水煎服。连用 15 天，腹痛、腰骶部酸痛逐渐缓解。20 天后复查 B 超未见异常。改用白花蛇舌草 50g，单味水煎服，间断服药 1 个月。半年后随访，未见复发。



重用马齿苋经验

马齿苋最早载于《本草经集注》。其性寒，味酸；归肝、大肠经；其基本功效有清热解毒，凉血止痢。多用于热毒血痢、热毒疮疡、崩漏、便血等。临床常用量为 9~15g。

陈树森重用马齿苋治带状疱疹

上海名老中医陈树森先生创带状疱疹方马齿苋膏。药物以新鲜马齿苋 100g。制法和用法：将新采的鲜马齿苋洗净、切碎，捣成糊状涂敷患处，日换 1~2 次。如已破溃用野菊花煎汤洗净后再敷药。适应证：带状疱疹灼热疼痛或化脓者。随证加减：如已破溃者加黄连粉 10g 同敷。马齿苋具有清热解毒、凉血消肿之功，对热毒疮疡内服、外敷均佳，故用以治疗本病亦有良效。

如治韩某，男，37 岁。1987 年 11 月 15 日就诊。患者因重症肝炎用激素治疗 34 天，左臂及大腿外侧出现成群的斑丘疹及米粒大小之疱疹，呈带状分布，基底部发红，剧痛难忍，诊断为带状疱疹。乃停激素予本方外敷，每日 1 次，当日疼痛明显减轻。2 日后疼痛消失，疱疹变瘪。5 日斑丘疹消退，疱疹结痂而愈。

王豪亦重用马齿苋治消渴

王氏用马齿苋 100g，水煎 2 次，早晚分服，每日 1 剂，治疗糖尿病 7 例，效果较好，对起病不久和未曾服用过西药的患者疗效显著。一般服药 1~2 周尿糖即可转阴，如坚持服药 1 个月以上，血糖也可望恢复正常。马齿苋对阴虚燥热型患者效果最佳，而对阴阳两虚或久病不愈者疗效欠佳。

重用鸦胆子经验

鸦胆子最早载于《本草纲目拾遗》。其性寒，味苦；归肝、大肠经；其基本功效有清热解毒，止痢，截疟，腐蚀赘疣。多用于痢疾、疟疾、腐蚀赘疣等。临床常用量为 0.5~2g。



李静重用鸦胆子治痔疮

当代名医李静受张锡纯先生的影响，擅用鸦胆子治疗热毒诸证。李氏自己10多年前患外痔，疼痛难忍，外科医生手术治之。后每遇酒喝多时复发。思之不能再手术了，用消炎药内服、外用或可治愈。隔年夏突发外痔，大如鸽蛋，站不可，坐亦不可，痛不可忍。思之鸦胆子乃解毒妙品，且其曾因血脂高间断服过数月，乃自服鸦胆子胶囊，每服30粒，日服3次，次日即感疼痛大减，续服至3日外痔全消。此为李老自知之经过。此前亦曾用过此方，唯未敢用此大量。今自服之，一日服至90粒鸦胆子，服至3日痔全消，实出意料之外。但体虚之人万不可用此大量也。

又治一朋友朱某之婶母，医院诊为舌癌3个月，疼痛而致饭食减少来求治。视其舌边有花生米粒大溃疡如菜花状，因其体质尚可，且朋友诉其家庭困难，住院放疗、化疗治不起，询之有无偏方、单方治之。用鸦胆子胶囊，每服10粒，日6次，每三餐饭前、饭后服之。同时加服三七粉每日10g，服半月疼痛止，服1个月溃疡面愈合而愈，又服半月至今未发。

另有陈某，男。患痔出血，近月来出血量多来求治。与其服鸦胆子每服30粒装入胶囊内，日3次，3日即大效，1周血全止。

李氏认为，鸦胆子苦寒，清热解毒，活血止痛，灭原虫，蚀腐肉，脱赘疣。治热毒下痢脓血、里急后重等。因其有毒，故外用为多。前贤张锡纯曰：“鸦胆子，为凉血解毒之要药。善治热性赤痢，二便因热下血，最能清血分之热及肠中热，防腐生肌，诚有捷效……治梅毒及花柳毒淋皆有效验。捣烂醋调敷疗毒，效验异常，洵良药也。”

鸦胆子乃苦参之种子，古人将鸦胆子去皮，用益元散为衣，名曰菩提丹，治二便下血入神，赞其有神灵之功也。其善清血热，而性非寒凉。善化瘀滞，而力非开破，有祛邪之能，兼有补正之功。前人有诗赞鸦胆子云：“一粒苦参一粒金，天生瑞草起痾沉，从今觅得活人药，九转神丹何用寻。”

故在临床上，凡遇有毒热之证，每思用鸦胆子治之，且与三七配伍用之。一解毒其性偏凉，一解毒则性平。临证视其毒热重则鸦胆子重用之，其热不重则三七重之。唯其有毒，则方能攻毒，毒去毒消则毒自无。但若体虚之人，始服时需从小量开始，贵在灵活运用也。



重用生地黄经验

生地黄最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦、甘；归肝、心、肾、胃经；其基本功效有清热凉血，止血，养阴生津。多用于温热病热入营血证、阴虚咳嗽、心阴虚证、阴亏便秘、吐血、衄血、便血等。临床常用量 10~15g。

朱仁康重用生地黄治皮肤疾患

我国著名中医皮外科专家朱仁康治皮肤病惯用生地黄，药量既大（多在 30g 以上），使用范围亦广，常为同道所瞩目。朱氏因考虑到疮疡皮肤病血热所致者颇多，故喜用生地黄作为凉血清热的主药。临床上凡遇血热证者，除重用生地黄外，常与牡丹皮、赤芍二药配伍，收效颇为满意。

在临床上常见因某些药物而引起的药疹，周身泛起弥漫性大片红斑，中医称为中药毒。此系内中药毒，毒入营血，血热沸腾，外走肌腠所致。朱老常用自拟的皮炎汤（生地黄、牡丹皮、赤芍、知母、生石膏、金银花，连翘、竹叶、生甘草）治之，多能应手而愈。另外，由于心经有火、血热生风引起的皮肤瘙痒症、皮肤划痕症等病，每以《医宗金鉴》消风散化裁治之，但常加大生地黄的用量，以增强凉血清热作用，往往能收到满意的疗效。

姜春华重用生地黄治痹证

著名中医学家姜春华教授善运用补肾为主治疗各种痹证，并结合科研试验研究，自创地乌蠲痹汤治疗风、寒、湿、热痹均有佳效。方中大剂量生地黄为君，生地黄具有滋阴通络、凉血清营、补益肝肾之功，《神农本草经》曰其“逐血痹”“除寒热积聚”“除痹”。姜氏用生地黄治疗顽痹一般用量在 60~90g，最多可用至 150g。其用意有三：第一，生地黄甘寒，入肝、肾经，可滋阴养血，补肝益肾，得酸平之怀牛膝、辛温之五加皮协助，共同发挥补益肝肾、扶助正气的作用。第二，风寒湿三痹中寒痹和湿痹均需辛温或燥烈之品方可消除，然辛温燥烈之品无不有伤阴耗血之弊。方中川乌、蚕沙、威灵仙、独活便是此类药物，得大剂量之生地黄，可缓和它们的燥烈之性，双向调节，取利去弊。第三，根据《神农本草经》记载，地黄有除痹作用，生者尤良，风寒湿三痹中行痹需以散风为主，佐以驱寒利湿，但古有“治风先治血，风行血自灭”的理论，更需参以补血之剂，血不足者痹着不行，生地黄补血养血，补养充足，自然流



通洋溢而痹行矣。该方以生地黄为君，组方严谨，配伍精当，用于临床确有良效。

如治杨某，男，46岁。3年多来腰痛如折，右腿冷痛，肿胀麻木，屈伸不利，艰于行走，得温则减，遇寒则甚，气候交变尤易发作。化验：抗“O”750U，血沉15mm/h，诊断为风湿性关节炎。平素恶寒怯冷，口淡不渴，舌苔白而厚腻，脉象按之沉细。证属寒湿入络，凝滞经脉，闭阻营卫。治拟温经散寒，活血镇痛。药用制附子9g，桂枝9g，生地黄50g，威灵仙15g，晚蚕沙30g，秦艽9g，蕲蛇9g，当归9g，赤芍9g。7剂药后，关节疼痛、麻木、发冷好转。守上方加黄芪30g，乳香、没药各6g，再进14剂，病人下肢活动自如，后用上法调治月余而愈，随访1年未发。

重用玄参经验

玄参最早载于《神农本草经》。其性寒，味苦、甘、咸；归心、肺、胃、肾经；其基本功效有清热凉血，滋阴，解毒。多用于温邪入营、内陷心包、温毒发斑、热病伤阴、津伤便秘、骨蒸劳嗽、目赤咽痛、瘰疬、白喉、痈肿疮毒等。临床常用量为10~15g。

沈大友重用玄参治急性血栓性静脉炎

沈氏以四妙勇安汤为基本方，重用玄参，辨证论治，治疗急性血栓性静脉炎，疗效显著。如治李某，女，33岁，剖宫产术后8天，突然自觉左下肢疼痛。走路不便，更衣时发现左下肢明显增粗肿胀、发热。立即到县医院检查。诊断：左下肢静脉炎血栓形成。症见：面色微红，口苦唇干，舌尖红，苔腻，脉弦大。检查左下肢皮肤微红硬，明显肿胀，触及股四头肌、腓肠肌疼痛。辨证：本病系妇科手术后长期卧床，以致下肢气血运行不畅，气滞血瘀。瘀血阻于脉络，脉络滞塞不通，营血回流受阻，水津外溢，聚而为湿。给予清热利湿、活血化瘀、通络止痛。处方：玄参90g，丹参30g，黄芪15g，人参18g，川芎12g，水蛭12g，黄连12g，金银花30g，当归60g，甘草9g。每日1剂，早晚分服。每日均取上方药渣湿热敷。平卧患肢抬高30°，治疗15天诸症皆消而痊愈。

白伟重用玄参治慢性干燥性鼻炎

白氏在慢性干燥性鼻炎使用中药治疗，在常规使用宣通鼻窍药物时，重用玄

参可以获得较好的疗效。白氏认为，玄参能够肃清枢机，调节火热燥邪，是治疗慢性干燥性鼻炎的良药。

如治一男性患者，45岁，具有慢性鼻炎史，平时发作时自己使用滴鼻净滴鼻治疗。2010年12月发作使用后效果不明显，鼻窥镜检查为干燥性鼻炎，西药治疗效果不显，前来中医治疗。患者自我感觉鼻部干燥，有异物感，交替性鼻塞，时轻时重，遇寒加重，头部微胀不适。现鼻黏膜及鼻甲肿胀，色淡，大便每天1次，略显干燥，小便少，无汗，口渴欲饮，舌淡，苔薄白，脉缓。中医诊断为寒燥伤阴所致之鼻炎。治以养阴润肺，通鼻窍。处方：玄参30g，黄芩9g，藿香9g，白芷9g，辛夷花9g，金银花12g，桔梗5g，甘草3g。3剂。每天1剂，水煎服，分2次服用。嘱忌食辛辣、油腻、生冷食物。二诊：患者感觉鼻部异物感明显减少，鼻塞减轻，干燥感略有好转，大便每天1次，不显干燥。处方：上方玄参增加至50g，余不变。5剂。每天1剂，水煎服，分2次服用。三诊：鼻部干燥感明显好转。上方连服15剂，上述不适症状消失，随访无复发。

重用牡丹皮经验

牡丹皮最早载于《神农本草经》。其性微寒，味苦、辛；归心、肝、肾经；其基本功效有清热凉血，活血散瘀，清虚热。多用于温毒发斑、血热吐衄、温病伤阴、阴虚发热、夜热早凉、无汗骨蒸等。临床常用量为6~12g。

李文瑞重用牡丹皮治经验

名老中医李文瑞临床应用牡丹皮一般用量为6~12g，重用25~60g，最大用至90g。李氏认为牡丹皮凉血、散瘀、止痒，与解热、抑菌、降低血管通透性等现代药理作用相合。血热所致之病症，重用方可获佳效，常在二至丸、归参丸、犀角地黄汤等方中重用。临床主要用于血小板减少症、血液病之发热、皮肤病等，服后无腹痛、腹泻等不良反应。

如治一男性35岁患者。全身皮肤发疹，色红有环状，身热痒甚，遇冷则缓，口干苦，纳食尚可，大便秘结。舌淡红，苔白黄，脉细滑。证属邪客血分，迫于肌肤。投予归参丸加牡丹皮45g，升麻10g，土茯苓25g，甘草3g等。服7剂后皮疹减轻。再进7剂后，痊愈。



重用水牛角经验

水牛角最早载于《名医别录》，其性寒，味苦、咸；归心、胃、肝经；其基本功效有清热凉血，泻火解毒，定惊。多用于温热病热入营血证、血热妄行斑疹、吐衄、痈肿疮疡、咽喉肿痛、皮肤瘙痒、缠腰火丹、肝火上炎之眼患等。临床常用量 15~30g。

冯先波重用水牛角治缠腰火丹

缠腰火丹相当于现代医学的带状疱疹，因其好发于两胁肋，为肝经循行之处，所以多用龙胆泻肝汤治疗清泻肝火，但是临床有效、有不效者。贵阳名老中医冯先波先生用犀角地黄汤易犀角为水牛角合龙胆泻肝汤治疗该证，疼痛迅速缓解。冯氏根据《黄帝内经》言“诸痛痒疮，皆属于心”，又此处为胆经循行之处，故治疗该证当以泻肝火、凉心血为主，若只用龙胆泻肝汤则只能清泻肝火而不能泻心火，故需合用水牛角地黄汤。方中水牛角粉凉心、泻肝火、清营血之热合于一身，诸药合用，共奏凉心平肝之效，故临床疗效甚佳。而取效的关键是水牛角的剂量，冯氏运用一般用量为 30~50g，少则乏效。

江尔逊重用水牛角治药物性皮炎

四川经方大家江尔逊曾治一患者，男，65 岁，患者因痛风发作，服西药别嘌醇 7 天后，头身瘙痒；继服 10 多天后，瘙痒加重，皮肤发红、浮肿、干燥、腰以上尤甚，而急诊入院。西医诊断：全身性剥脱性皮炎（别嘌醇过敏）。经某医院专家会诊，主用进口高效激素甲泼尼龙针，配合抗生素、维生素等静滴及对症治疗半个月，症状无改善。又配服中药消风散加减数剂，大小便不畅。更医用大剂八正散加减，服 2 剂大小便皆闭，神志不清。家属接到病危通知后焦急万分，急来邀诊。刻诊：面部、全身皮肤发红漫肿，瘙痒无度，多处大面积脱皮，腹胀按之如鼓，大小便俱闭已 3 天，神志时清时昧，舌体肿大，舌色衬紫，苔灰黄厚少津，脉大无力。综合病史与治疗史，考虑为湿热久羁，深入营血，耗血动血，伤阴损肾。本应凉血散血，养阴滋肾，奈何大小便皆闭，危在顷刻，急当育阴利水，宣肺通便。用猪苓汤加味：阿胶 20g（烔化），猪苓 15g，茯苓 15g，泽泻 30g，滑石 30g，杏仁 15g，桔梗 6g，枇杷叶 30g，车前子 30g（包煎），虎杖 30g，炒莱菔子 30g。2 剂，浓汤频喂。西药治疗不变。



二诊：当晚 6 时许开始频喂，翌日凌晨 2 时自行解小便 1 次，下午 6 时许大便亦通，神志清，转危为安！改用犀角（水牛角代）地黄汤加味，大清深入营血分之毒热：鲜水牛角（先煎 2 小时）50g，生地黄 30g，牡丹皮 15g，赤芍 30g，紫草 30g，墨旱莲 30g，益母草 30g，仙鹤草 30g。若效不著，可将水牛角加至 200g。

三诊：上方连服 5 剂，病无进退。因撤减激素过快，病情反弹，全身大面积脱皮，瘙痒难忍，烦躁不安。遂将方中水牛角加至 200g（文火炖 2 小时，滤取 100ml，分 3 次兑入药液中），并逐渐恢复激素用量。又服 5 剂，全身大面积脱皮得到控制，皮肤发红、瘙痒显著减轻。上方徐服至 20 剂，全身皮肤终于恢复正常。唯颜面虚浮，气短乏力，夜梦纷纭，纳差，大便稀，口干不欲饮，舌质淡紫，苔薄白，脉弦弱。此脾虚气陷，纳运不及。改投升陷汤合参苓白术散加减。服 8 剂后诸症减轻，眠食转佳。2 年后随访：出院后曾遵医嘱服用泼尼松 3 个月。曾经几次全面复查，不仅心肝肾等内脏功能正常，骨密度亦正常，体健无恙。

江氏恪守此法，以大剂犀角（水牛角代）地黄汤为主，重加紫草、仙鹤草、墨旱莲等解毒凉血止血之品。其中鲜水牛角每剂用至 200g 方才显效，足证其营血分热毒之深重。水牛角，近贤有称之为“灵异草”者，服之能令心主复辟，精神内守，魂魄安定，而收“移精变气”之功。据长期临床观察，过敏性疾病的病因相当复杂，但有一条是不容忽视的，精神失内守、魂魄不安定之人，容易发生过敏性疾病。既然如此，水牛角抗过敏之功便可意会了。

救治本例的主要方药，江氏后来又验证过一次：某男，36 岁，身体壮实。因宿患痛风，几年来断断续续服用别嘌醇，疗效尚可。唯偶尔皮肤瘙痒，便停药，并口服抗过敏药物，未尝贻害。1999 年春节前，连续服用别嘌醇半月，致头面、全身发红，剧烈瘙痒，脱皮，乃急诊入院。西医亦诊断为全身性剥脱性皮炎。西药治疗同本例高某，其时高某尚未出院，乐为之介绍，患者即来室商治。因有高某案之治验，急予大剂量犀角（水牛角代）地黄汤加味，水牛角用 200g。连服 12 剂，全身瘙痒逐渐减轻乃至消失，皮肤发红亦大减，脱皮得到控制。因家贫要求出院，出院后遵医嘱服用泼尼松，续服上方至 30 剂，一切病症完全消失，至今安然无恙。足见水牛角在血热型皮肤疾患中的治疗价值。



重用青蒿经验

青蒿最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦、辛；归肝、胆、肾经；其基本功效有清透虚热，凉血除蒸，解暑，截疟。多用于阴虚发热、劳热骨蒸、温邪伤阴、夜热早凉、肝胆湿热证、疟疾寒热等。临床常用量为 6~12g。

何克炽重用青蒿治疟疾

已故四川名中医何克炽采用大剂量青蒿配小柴胡汤加味治疗疟疾病，临床疗效满意。基本用药为：青蒿 50~80g，柴胡 10~20g，黄芩 10~20g，法半夏 10~20g，人参 15~20g，甘草 10g，石膏 60~100g，知母 15~20g，莲米 10~30g。加减：发热症状重可加秦艽 15~20g，白薇 15~30g；寒战、壮热症状重可加炙首乌 10~15g，草果 10~15g，槟榔 10~20g。

如治陈某，男，35 岁。1997 年 8 月初诊日期。因到中缅边境务工，被当地蚊虫叮咬后，晨 5 时左右先寒战，继壮热，体温均在 39℃ 以上，伴心、胸、胃部疼痛 10 月余；经当地西医、草医治疗，现晨 5 时仍寒战、壮热，继大汗出。刻诊：精神欠佳，神志清楚，面色青黄少华，舌红，苔厚黄，脉弦数。老师据临床特征，诊为疟疾，继以下方治疗：青蒿 80g，柴胡 20g，黄芩 12g，法半夏 12g，人参 15g，甘草 10g，秦艽 20g，白薇 25g，制首乌 10g，知母 20g，石膏 60g，莲米 20g。水煎频服，每次 200ml，1 日 1 剂。服上方后病愈。

重用地骨皮经验

地骨皮最早载于《神农本草经》，其性寒，味微苦、甘；归肝、肺、肾经；其基本功效有清虚热，凉血，清肺降火。多用于阴虚发热、骨蒸盗汗、肺热咳喘、血热出血证、消渴证、虚火牙痛等。临床常用量为 9~15g。

刘绍勋重用地骨皮治肺癆

辽宁名老中医刘绍勋认为，地骨皮甘淡而不膩，淡凉而不寒，滋肾阴而清肝火，走肌表而降肺热，故适用一切阴虚火旺之证。刘氏有两点体会：其一，临证

应用地骨皮，与清热养阴之品合理配伍，十分重要。例如，清肃肺热，须与生石膏、滑石配伍；退骨蒸劳热，应与青蒿、女贞子之类合用；补益正气，方中加入沙参、麦冬、五味子等，疗效尤其显著。10年前，治一女性患者，患重症肺癆，咳嗽痰血，骨蒸潮热，盗汗气快，身体虚弱。曾大量用抗癆药、抗生素未效，遂服中药百合固金汤、紫菀汤等，疗效亦不明显。刘氏经手治疗后，参其脉症，拟用秦艽扶羸汤、清骨散加减化裁，方中加入女贞子、五味子、青蒿、麦冬等养阴解肌之品，重用地骨皮 50g，仅服 10 余剂，诸症悉减，后又坚持服药半年余，身体逐渐康复，至今宿疾未犯。其二，用足药量是取得良好疗效的关键。刘氏认为，古今某些医方中，对于地骨皮的用量似乎略嫌不足，这对发挥其药效很有影响。一般书上的常用量，是在 15~30g。刘氏认为地骨皮的基本用量不能少于 50g，否则疗效较差。10 年前，刘氏遇一女性患者，系癆瘵病，西医诊断肺结核进展期，有活动病灶，长期低热不退因对抗生素过敏，故找中医治疗。该患系中学教师，略知医学常识，因身体瘦弱，思想负担很重。参其脉症，拟投秦艽扶羸汤，方中以地骨皮为君，每剂剂量为 50g，经治 3 月有余，低热完全消退，体质大见恢复，拍片病变钙化吸收，心情愉快，上班工作。

上述两例，均属阴虚火旺，水不制火，阴阳失调，肺金被刑所致。方中重用地骨皮，意在滋阴降火，收敛虚浮之阳，俾令阴平阳秘，故收功效。按照惯例，治疗肺癆，似乎方中必用百部之类，刘氏认为不必尽然。癆之为病，一般而论，初期病情进展，多属阴虚火旺，迁延日久，或者体质虚弱，才会出现阳虚之证或是阴阳俱虚并见。以刘氏之见，治疗肺癆，初期严密控制病情进展实属关键，而滋阴降火之法应为其基本治则。地骨皮抑菌作用较强，百部却仅能润肺化痰治咳而已，前者确胜后者一筹。由此看来，在滋阴降火的方药中，地骨皮应是不可缺少之品。

刘氏曾治愈 10 余例典型肺癆患者，通过对地骨皮的药效观察，遵循“异病同治”的原则，临床中又做了新的尝试。例如长期低热不退是病症中的一大难题，病因复杂，病状多乖，治疗中难度较大，特别是某些体征不够典型，仅有长期低热不退的患者，治疗中就更不是轻而易举的了。那么，按照中医的辨证施治之法，某些长期低热难愈的患者能否治愈呢？刘氏认为，凡是大病初愈或因外感传里化热未愈等，由于气阴两伤，造成低热缠绵者；凡经透视、化验等西医检查没有器质性病变，而午后或夜间必现潮热症状者；病因待查或被称为功能性低热者……都可以重用地骨皮，用滋阴降火之法进行治疗，效果还是比较理想的。刘氏曾治一张姓中年妇女，自述患低热已 1 月余，早晨和上午身凉无恙，至中午自觉周身不适，骨节酸楚，午后则身疲乏力，五心烦热，夜间盗汗，醒后汗止，午后和夜



间体温在 $37.4\sim 37.6^{\circ}\text{C}$ 之间，次日上午则热自消退。曾去某医院经透视、化验等全面检查，未发现器质性疾病。按中医辨证，此乃属于阴虚火旺之象，拟用秦艽鳖甲散合清骨散加减化裁，重用地骨皮 50g，方中加入沙参、生石膏、滑石等养阴、清热、解肌之品，服药 10 余剂，体温基本恢复正常。继服 20 余剂，热退身安，诸症悉平。又治一吴姓女患者，22 岁，未婚。该患月经期长，经量多，夹有瘀块，小腹隐隐作痛。每次月经须 10 余日方净，月经来潮时，颜面潮红，头晕耳鸣，手足灼热，热甚有时须用冷水浸浴，或有心中烦忧之感。每次月经来潮期间，身有微热，体温波动在 $37.3\sim 37.5^{\circ}\text{C}$ 。此患已有 1 年多，患者甚为苦恼。此乃阴虚内热、血室被扰所致。拟用滋阴降火、逐瘀生新、凉血止血之品，重用地骨皮 50g，治疗 3 月有余，症状渐减，直至全愈。

近年来，刘氏经治此类疾病，不下百余例，均以重用地骨皮取效。

重用白薇经验

白薇最早载于《神农本草经》。其性寒，味苦、咸；归胃、肝经；其基本功效有清虚热，清热凉血，利尿通淋，解毒疗疮。多用于阴虚发热、产后虚热、热淋、血淋、疮痈肿毒、毒蛇咬伤、咽喉肿痛等。临床常用量为 4.5~9g。

田霞重用白薇治男性更年期综合征

田氏在临床中重用白薇，配合其他药物治疗男性更年期综合征多例，取得满意效果。如治谭某，49 岁。主诉：疲劳，工作能力下降，注意力不集中，性功能减退，失眠，便秘，骨骼关节疼痛，心悸等。经泌尿外科男科中心确诊为“男性更年期综合征”。查患者形体消瘦，头晕目眩，潮热盗汗，五心烦热，舌红苔薄腻，脉弦细。处方：白薇 30g，百合 15g，熟地黄 15g，枸杞子 10g，栀子 10g，郁金 10g。用药 15 剂后自觉症状明显减轻，加酸枣仁 10g，继服。嘱饮食清淡，调畅情志，又 15 日后症状基本消失。

田氏在临床上对更年期综合征的治疗，一是补肾，二是调肝，尤其喜用白薇。白薇是一味清血热的药物，同时入肝、肾二经，长于清解，能透邪外达，又能清泄肺热，有利尿作用，适用于骨蒸潮热、低热不退等症。长期大量服用无明显毒副作用，与其他药物配伍，具有补而不滞不燥、滋而不腻不凉之优点，使虚得补，燥得润，而诸症自除。

第三章 祛风湿、泻下药

重用川乌经验

川乌最早载于《神农本草经》，其性热，味辛、苦；归心、肾、肝、脾经；其基本功效有祛风湿，散寒，止痛。多用于风寒湿痹、手术麻醉、心腹冷痛、寒疝疼痛、跌打损伤等。临床常用量为 1.5~3g。

李可重用川乌治寒痹

当代民间著名中医学大家李可每遇危险重危症，使用毒剧中药救治，多获起死回生之效。疑难痼疾用之则立见转机，累起沉疴。其中使用最多的是附子，一生累计超过 5 吨。川乌次之，亦在 3 吨以上，经治人次万名以上，无一例中毒。如何驾驭药中猛将，使之听从调遣，治病救亡而不伤害人体？奥秘在《伤寒杂病论》中已有揭示。仲景在 1700 多年前，已取得了临床应用乌附剂的成功经验：①凡乌、附类方（附子汤除外），炙甘草为乌、附之 2 倍，甘草善解百毒，甘缓以制其辛燥；②蜜制川乌，蜜为百花之精华，芳香甘醇凉润，善解百毒，并制其燥烈；③余药另煎，取汁与蜜再煎，中和毒性，使乌头之毒性降到最低点，而治疗效能不变。按上法应用川乌安全稳妥。为确保万无一失，李氏从 20 世纪 60 年代起，又加 3 条措施：

1. 凡用乌头剂，必加 2 倍量之炙甘草，蜂蜜 100g，黑小豆、防风各 30g。凡用附子超过 30g 时，不论原方有无，皆加炙甘草 60g，即可有效监制。从古今各家本草论证得知：炙甘草扶正解百毒，杀乌、附毒。蜂蜜，补中润燥，止痛解毒。治肺燥咳嗽，肠燥便秘，胃脘热痛，鼻渊口疮，汤火烫伤，解乌头、附子毒。黑小豆，活血利水，祛风解毒，治水肿胀满，风毒脚气，黄疸水肿，风痹筋挛，产后风痉，口噤，痈肿疮毒，解药毒。《本草纲目》：“煮汁，解砒石、甘遂、大雄、附子百药之毒。”防风，发表去风，胜湿止痛。治风寒外感，头痛目眩，项强，风寒湿痹，骨节酸痛，四肢挛急，破伤风。《本草求原》：“解乌头、芫花、野菌诸毒。”

《本经集注》：“杀附子毒。”

2. 凡剂量超过 30g 时，乌头剂加冷水 2500ml，文火煮取 500ml，日分 3 次服，煎煮时间 3 小时左右，可有效破坏乌头碱之剧毒。附子剂用于慢性心力衰竭，加冷水 1500ml，文火煮取 500ml，日分 2~3 次服。

3. 余凡用乌头剂，必亲临病家，亲为示范煎药。病人服药后，必守护观察，详询服后唇舌感觉。待病人安然无事，方才离去。

有以上三条保证，又在配伍上、煎药方法上做了改进，采取全药加蜜同煎、久煎法，既保证疗效，又做到安全稳妥，万无一失。1965 年曾参与川乌中毒濒危 2 例的抢救，以生大黄、防风、黑小豆、甘草各 30g，蜂蜜 150g，煎汤送服生绿豆粉 30g，均在 40 分钟内救活。由此也可反证，使用新定乌头汤绝无中毒之虞。

如治高某，51 岁。患者于 1941 年护送抗大学员赴延安时。路经山西宁武县之摩天岭，严冬大雪封山，雪深没膝，冻死 7 人，冻掉手指足趾多人。本人虽幸得肢体完好，但已受严重冻伤。1966 年发现双下肢冷痛，多次住院治疗无效，发展至 1976 年病情恶化。在 5 所大医院住院 7 个月，确诊为脑动脉硬化、心肌下壁梗死、双下肢血栓闭塞性脉管炎。后又赴某医院接受下肢放血疗法，10 余日无效，建议高位截肢。绝望之下，患者于 1976 年 9 月 7 日求治于余。诊见双下肢膝以下冰冷，左侧尤重，足趾青紫，电击样剧痛日夜不休，左上下肢麻木。胸部憋胀刺痛，发作时以硝酸甘油片维持。脉沉细迟微，双足背动脉消失。面色苍白晦暗，畏寒神倦。此证由寒邪深伏血分，痹阻血脉，已成真心痛及脱疽重症。且病经 30 年之久，已成沉寒痼冷顽症，非大辛大热温通十二经表里内外之乌头、附子猛将不能胜任。遂拟当归四逆加吴茱萸生姜汤合乌头汤，加虫类入络搜剔，麝香辟秽通窍，合而为大辛大热、开冰解冻、益气破瘀、通络定痛之剂：生黄芪 240g，附子、当归各 60g，川乌、丹参、黑小豆、川牛膝、防风各 30g，麻黄、桂枝、细辛、赤芍、桃仁各 15g，油桂 10g，吴茱萸 20g（开水冲洗 7 次）。另用麝香 1g，炮甲珠 5g，生水蛭 3g，全蝎 3g，蜈蚣 2 条，研粉分冲。蜂蜜 150g，鲜生姜 40g，大枣 20 枚。加冷水 500ml，文火煮取 500ml，兑入黄酒 500ml，日 3 夜 1 服，4 剂。服 1 剂，当夜安然入睡。又连服 3 剂，诸症均退。原左足大趾内侧之溃疡亦收口愈合，心绞痛及下肢电击样剧痛亦消失。后患者注射毛冬青针 15 盒，遂痊愈。追访未见复发。



重用防己经验

防己最早载于《神农本草经》。其性寒，味苦、辛；归肝、肾、膀胱经；其基本功效有祛风湿，止痛，清热利水。多用于风湿痹证、水肿、小便不利、脚气、湿疹疮毒等。临床常用量 4.5~9g。

王国三重用防己治肝硬化腹水

河北名老中医王国三善于应用汉防己治疗水肿以及肝硬化腹水。如治王某，男，54岁。患乙型肝炎、肝硬化腹水，在某医院住院治疗，西医给予利尿、补充蛋白等支持疗法，疗效不佳，症状时好时坏。于6月27日王氏处就医，刻下：患者消瘦，语言低微，行动困难，腹胀如鼓，脐突，阴囊肿胀，舌质淡红、苔略腻，脉沉缓。辨证为肝肾阴亏，脾虚水湿内停。处以：西洋参粉 6g，苍术 30g，怀牛膝 30g，川牛膝 30g，冬瓜皮 24g，墨旱莲 30g，车前子 30g（包煎），焦三仙各 9g，鸡内金 18g，汉防己 40g。7剂。二诊：7月6日。患者双下肢水肿减轻，阴囊处水肿减轻，仍腹胀、脐突，王老认为药已见效，继用前方。汉防己加至 60g，7剂。三诊：7月13日。患者双下肢水肿已消退，阴囊已无水肿，腹胀减轻，脐仍突起，前方加葶苈子 24g，继用 7剂。

王氏认为：肝硬化腹水，中医病因病机为肝肾阴虚，气滞血瘀，脾虚失运。此急症理应攻逐水邪，应用峻猛之药，如十枣汤、舟车丸之类，此类药虽可解一时之快，但易出现如上消化道出血之类坏证，应缓缓图功。王老在几十年临床过程中应用此方（消水汤），重用汉防己，治愈肝硬化腹水患者无数。

张从善重用防己治水肿

张氏擅用防己治疗特发性水肿。张老认为，特发性水肿因原因未明，西药治疗颇感棘手。张氏根据本病多见于女性更年期前后，或与月经周期有关，且多伴有腰膝无力、两尺脉沉弱等症，认为属肾虚者多。自拟二仙防己黄芪汤：汉防己 24g，仙茅 15g，淫羊藿 15g，黄芪 15g，白术 10g，党参 10g，何首乌 10g，车前子（包煎）10g，炒酸枣仁 10g，炒山楂 10g。本方是在仲景防己黄芪汤的基础上加减组成，而重用二仙温肾助阳，重用防己利水消肿。有资料报道汉防己小剂量利尿，大剂量则作用相反。张氏认为汉防己善走下行，长于除湿，通窍，利道，重用之，利尿作用慢而持久。临床上重用治特发性水肿多例，效果堪称满意，并



对功能性水肿、肾炎水肿亦有一定疗效。

重用豨薟草经验

豨薟草最早载于《新修本草》，其性寒，味辛、苦；归心、肝经；其基本功效有祛风湿，舒筋活络，清热解毒。多用于风湿痹痛、中风半身不遂、风疹、湿疮、疮痈、湿热黄疸等。临床常用量为 9~12g。

朱良春重用豨薟草治肝炎

国医大师朱良春教授善于重用豨薟草治疗肝炎，朱氏认为慢性肝炎活动期，乃由湿热疫毒蕴结肝胆、肝郁气滞、脾胃运化失健而致。治疗一般采用清热利湿和疏肝运脾的大法。凡迭治不愈者，多与血瘀有关，故有“久病多瘀”之说。朱氏常于辨证用药的基础上，重用豨薟草等，临床恒获比较满意的效果。根据实践体会，豨薟草用于急性黄疸型肝炎与慢性肝炎活动期，对改善临床症状，降低黄疸指数、转氨酶及各项絮状试验，有显著而稳定的效果。

豨薟草用治肝炎，甚少论及。由于其性味苦入肝、脾、肾三经，《中国医学大辞典》更明确指出它“秉少阳升发之气，能升能降，祛风湿，活血化瘀”。是则本品不仅能祛风除湿，还有清热活血、补虚安中、调节肝胆功能之效。移治肝炎，宜其获效。因为既然病邪为湿热，其基本病理变化为湿热蕴结，肝郁气滞，脾运失健，血瘀凝结，重用本品是符合辨治原则的，是治疗黄疸比较理想的药物之一。

如治徐某，女，43 岁。患慢性肝炎已久，肝功能反复不正常，经常发热，口干而苦，脘腹痞闷，肝区胀痛，纳差，苔薄，舌质红，边衬紫，脉弦细。反复给予疏肝理气、健脾培中或养益肝阴、清化湿热之剂，病情时剧时缓，迁延不愈。目前因发热，乃又神疲，食欲显减，身目黄染。肝功能检查：黄疸指数 51U，胆红素 55mg%，锌浊 18U，麝浊 18U，谷丙转氨酶 284U。疫毒伤肝，湿热稽留，蕴阻脾胃则运化无权，熏蒸肝胆则疏泄失常，缠绵反复，诸象迭起。此次因外邪引动宿疾，病情加剧，经治发热已除，湿热疫毒之邪，缠稽不解。“久病多瘀”，除清化湿热、调理脾胃肝胆外，应着重活血化瘀，以去其瘀结所在。处方：豨薟草 45g，田基黄 30g，丹参 18g，芒硝 3g（分冲），石见穿 30g，生麦芽 30g，麸炒枳壳 8g，糯稻根 30g，生甘草 45g。10 剂。药服 10 剂后，黄疸消退，症状缓解，食欲增加。又自服 10 剂，病情明显好转。肝功复查：黄疸指数 10U，锌浊 12U，



麝浊 10.7U，谷丙转氨酶 72U。一般情况均好，基本稳定，继续调理巩固。随访，已早恢复工作。

又南通市传染病院一女性患者陈某，患慢性肝炎，反复出现黄疸，不思饮食，神疲乏力，肝功能反复不正常，苔腻舌质暗红，脉弦细，迭经中西药物治疗，收效不著。邀约会诊，给予以豨莶草为主的汤药服之，病情有所缓解。1周后复诊，一般情况良好，黄疸已渐消退，腻苔趋化，纳食亦增。又守方续服，病情逐趋稳定（保肝之西药仍同时并用）。

朱氏运用豨莶草治疗黄疸型肝炎，屡屡应手。朱氏认为，黄疸型肝炎多系湿热搏于血分所致，若迁移时日，瘀热胶结难解，一般利湿退黄之剂殊难中的，必须凉血活血、解毒护肝始为合拍。凡黄疸缠绵不退，湿热疫毒稽留，朱氏每从血分取法，以豨莶草 30~45g 配合丹参、田基黄、石见穿等，多能应验。

杨小清重用豨莶草美容消斑

杨氏根据面色无华，晦滞不润，甚则出现瘀斑、痤疮等，多缘于心肝血虚、阴虚血燥、热毒湿盛所致的机制，以豨莶草为主药，配生地黄、麦冬、赤芍、牡丹皮、天花粉等治之，每获良效。

如治陈某，女，28岁，1997年7月12日诊。患者3年前面部开始出现暗黑色瘀斑，甚觉不雅，选用多种美容护肤用品外搽，并屡服维生素E及补肾类中药治疗不瘥。近2年来更因痤疮频发令瘀斑加重，伴夜寐欠佳、梦多。舌质偏红，尖有瘀点、苔薄白，脉沉细略数。证属阴虚血燥，瘀热互结。处方：豨莶草 20g，生地黄 15g，麦冬 15g，赤芍 15g，牡丹皮 12g，天花粉 12g。每日1剂，水煎服。服药1个月后，睡眠正常，痤疮大为减少，瘀斑亦渐消退。为巩固疗效，嘱其之后2个月内于经期前再服上药10剂。半年后随访，面泽斑消。

《本草纲目》谓豨莶草“治肝肾风气……风湿诸疮”。《景岳全书》立豨莶丸治疗白驳风。因此，杨氏认为豨莶草能祛斑除疮，养血华色，在临证组方时重用豨莶草美容消斑，获得较满意的疗效。

重用鹿衔草经验

鹿衔草最早载于《滇南本草》。其性温，味甘、苦；归肝、肾经；其基本功效有祛风湿，强筋骨，止血。多用于风湿痹证、月经过多、崩漏、咯血、外伤出血



等。临床常用量为 10~15g。

洪鼎侨重用鹿衔草治喉痹

洪氏根据鹿衔草水煎剂对金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎球菌等有抑制作用，用于治疗慢性咽炎。临床体会应用鹿衔草治疗本病，临床需用量达 15~30g，方可有满意疗效。如治曾某，男，32 岁，1999 年 8 月 15 日初诊。患者慢性咽炎史 5~6 年，近日因旅途疲劳而致病情加重，自觉咽部干燥不适，咽痒，异物感明显，咽部可见滤泡增生，呈暗红色，舌红，苔微黄，脉弦细。以鹿衔草合养阴清肺汤加减：鹿衔草 20g，生地黄 12g，麦冬 9g，玄参 12g，川贝母 5g，西青果 12g，木蝴蝶 5g，杜牛膝 15g，生甘草 5g。7 剂后症状明显减轻，再加减服药 3 周而愈。

重用大黄经验

大黄最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦；归脾、胃、肝、心、大肠经；其基本功效有泻下攻积，泻火解毒，凉血止血，活血祛瘀，清泻湿热。多用于积滞便秘、血热吐衄、目赤咽肿、热毒疮疡、烧烫伤、湿热痢疾、黄疸、淋证等。临床常用量为 5~15g。

李翰卿应用大黄治便秘

名老中医李翰卿认为，大黄在攻下通便方面有三个作用：寒、湿、燥，即是说大黄对实热、湿热的便秘比较适宜。西大黄的泻下通便、泻火作用较川大黄强，而燥湿作用较川大黄弱；酒大黄、熟大黄的泻下作用较生大黄弱，而善清头部之火热；水煎在半小时以下者泻下作用强，40 分钟以上者泻下作用较弱；用量大时泻下作用强，小剂量时泻下作用较弱；配合行气、润燥软坚药时泻下作用强，不配伍泻下作用弱；属于津液不足或者血虚便秘者，常在应用大黄的第一剂后，大便即通，其后不久大便又趋秘结，此时若再反复应用大黄，其泻下作用则日渐下降，甚或使便秘更加严重，这是由于大黄虽多能攻下，但却伤津伤血所致。此时必须配合增液润便或养血润便之品方可使大便得通；气虚或阳虚的便秘者，因大黄苦寒攻伐，大伤元气，不但不能使大便通畅，而且常常是便秘更甚；对于寒实便秘者，虽用大黄 3g，亦可使大便泻下 1~3 次，并在泻下之前往往兼有腹痛，而湿热结滞的便秘，最少 9g，甚或用 15~30g 才有效。对于逐瘀破血，由于大黄



逐瘀破血力量大，所以在妊娠期间一定要慎用，否则容易发生堕胎。

王少华应用大黄治血证

王少华老中医认为，血证者，尤其是大量的咯血、吐血、便血等，轻则耗气伤血，重则发生血脱而危及生命。如能及时制止出血，则危重急症自可出险入夷。王氏体会，这一止血重任非大黄莫属。《血证论·吐血》云：“止血之法虽多，而总莫先于降气……而大黄一味，既是气药，又是血药，止血而不留瘀，尤为妙药。”此说诚是。大黄性专沉降，对于齿鼻耳目诸衄等表现于上部的疾病，辄以酒炒后用，借酒性之上升，驱瘀热以下。治面部诸衄，还可配升麻上行，与大黄共成高屋建瓴之势，且可发挥升麻的散火毒、解火郁之功。用量方面，考虑到大黄具悍利之性，有将军之称，利在速战速决，因而治火热内灼、阳络受损而血外溢的吐衄疾病，在发病之初，患者证实体实，用大黄之目的在于大泻血热，祛瘀生新，因而用量宜大（10~15g）；若妇人经漏既久，崩中或吐衄反复发作，证虽实而体已虚者，大黄用量宜小（3~6g），借以化瘀磨积，缓图奏功。

叶景华重用大黄治急症

上海市名老中医叶景华临床上常将大黄用于急腹症、慢性肾炎和急慢性肾衰竭、感染性疾病、高热而大便秘结者及作为活血化瘀的主药。多年来应用经验有以下几点：

1. 大黄是急重症的要药，使用得当，疗效卓著。

2. 要达到通腑目的，必须用生大黄后入。热结盛者剂量要大，可用15~20g，并与玄明粉同用。若仍未通便者，可用大黄煎汤，或用粉剂加温开水作保留灌肠。大便多者可用制大黄。单味大黄需长期服用者，可将其研成粉，装入胶囊或制成片吞服。每个病人对大黄反应不一，特别对年老病人，应从小剂量开始，避免因用量过大而致泻下不止。

3. 传统认为大黄是攻逐之品，过用要伤正气，但临床观察，有大黄适应证而长期应用者，未见因此而出现正气亏虚情况。如有一部分慢性肾衰竭病人，连续应用大黄1~2年，未发现不良反应。部分病例原来有正虚情况，随着病情好转而正气渐恢复。

曾治一患者，男，55岁，工人。1991年2月21日来院诊治。患者慢性肾炎已12年。近数月来头晕乏力，腰酸，有时腹胀不适，纳可，大便每日1次，小便尚多，面色灰滞，舌苔黄腻，脉较细而弦。血压24/13kPa，尿化验蛋白（+），红细胞10~15/HP，血肌酐503μmol/L，尿素氮23.6mmol/L，肌酐清除率12.6%，血红蛋白96g/L。以中医药治疗为主。用黄柏10g，知母10g，生大黄15g（后入），



王不留行 30g, 土茯苓 30g, 徐长卿 30g, 枳实 10g, 大腹子皮各 10g, 皂角刺 30g, 厚朴 6g。坚持长期服药。平时除用小剂量降压药及氧化淀粉外, 未用其他治疗。

1992 年 3 月 5 日复查: 肌酐 $468\mu\text{mol/L}$, 尿素氮 13.11mmol/L , 肌酐清除率 19.9%。一般情况较好, 血压 18/12kPa。继续服上方治疗。1993 年 10 月 15 日再复查: 血肌酐 $646\mu\text{mol/L}$, 尿素氮 18.4mmol/L , 肌酐清除率 11.5%。继续上法治疗, 有外感时先以治标, 外感症状解除后再原方治疗。1994 年 6 月 20 日复查血肌酐 $794\mu\text{mol/L}$, 尿素氮 18.3mmol/L , 肌酐清除率 9.6%, 血红蛋白 100g/L 。一般情况尚可, 血压在正常范围内, 原有症状时减时甚, 有新的感染后症状加剧。仍以原方加减治疗。1995 年上半年维持原来情况, 至下半年起未能坚持服上方而至他处就医, 杂药乱投, 情况日趋恶化。1996 年 2 月来诊治时, 患者卧床不起, 恶心呕吐, 下肢浮肿, 小便量少, 复查血肌酐升至 $2019\mu\text{mol/L}$, 而行血液透析治疗。

按语: 患者于 1991 年来诊治时已是尿毒症, 以大黄为主的中药治疗持续 4 年余, 肾衰竭情况一度较稳定, 虽后来又有所发展, 但是进展比较缓慢。肌酐从 $503\mu\text{mol/L}$ 进展至尿毒症终末期, 历时 4 年多, 说明中医药对延缓肾衰竭的进展是有效的。在这 4 年多时间里服用大黄未中断过, 每日剂量少则 10g, 多则 20g, 未见有不良反应, 血红蛋白亦变化不大。

郑家本重用大黄经验

名老中医郑家本善于重用大黄治疗急重疾患。如对急黄病证, 无论便秘与否, 均予大黄, 排除毒素, 先发制病, 提高了抢救成活率。曾抢救王某, 吐血不止, 头痛如劈, 烦躁欲死(上消化道急性大出血伴高血压危象), 单用生大黄 30g 煎服, 服后 2 小时, 泻下黑色粪水半面盆, 顿时血止, 险象解除。又如诊治刘某湿温病(肠伤寒)患儿, 高热 6 天, 神昏谵语, 大便不爽, 苔黄厚腻, 脉滑数。经中西医诊治, 体温(41°C 以上)不降。前医均恐“下之则洞泄”或“下后肠易穿孔”, 未敢泻下, 郑氏根据“治者不可畏而不用”, 在前医所拟的菖蒲郁金汤内加酒大黄 9g, 意在“釜底抽薪”。药后 3 小时, 患儿泻出果酱状大便, 量甚多, 顿时热退神清。“大黄之力虽猛, 然有病则病当之。”对儿科“肺胃热炽”的高热证候, 郑氏常在拟方中配以大黄, 疗效显著提高, 均未见有引邪深入之弊。对癫狂属实火者, 常首用生大黄 30~60g, 荡涤痰热, 当大便日行 5 次以上时, 狂乱可止, 再随证治之, 每取良效。在治尿毒症、急腹症、败血脓毒症等急性病证时, 大黄更有用武之地, “夺关斩将”, 屡建奇功。或云: 大黄仅有“推墙倒壁”“将军”之能, 而无“深谋远虑”“军师”之策。吾曰: 否。如甲寅年春, 治柳某臌胀(肝硬化腹水), 宗“虚因实而难复, 实以虚而益猖”之旨, 在辨证处方中, 连续使用酒大黄 1 年



有余，每日 6g，计总量 3000g 以上，患者之肝功及蛋白定量均恢复正常，基本治愈。随访 8 年，未见其因长期服大黄而产生后遗症，现仍能参加体力劳动。可见“有病则病当之，恒用多用亦不妨”。

杜书学重用大黄治黄疸

杜氏治疗黄疸病证，无论其属何因之疸，悉在辨证前提下，在基本方中重用大黄、车前子，二者相使为用，常是仅进数剂，而疸退病缓。大黄清泻肝胆湿热，利胆退黄，非他药所能比拟，故为历代贤医习用，畏其泻峻猛，观其用量不过十一二克，虽能愈黄，常是数剂尽服，苛疾方起，而若刻求收效甚速，则又非直折退黄之大量，不能胜任其职。故杜氏每遇黄疸病证，必重用大黄，每每用至 30 余克。大黄本为苦寒直折之品，若重剂投之，安能不致泻下无度？故而又伍以车前子，以其淡渗之性分利，“黄家所得，从湿得之。”湿邪，从前阴而泻，且以实大便，大黄借以重用，以其俾得深入退黄，而不致泻下无度。

如治梁某，男，8 岁。3 天前发热，食欲不振，呕吐，小便黄，面色微黄，巩膜黄。舌苔黄腻。脉弦滑数。化验肝功：黄疸指数 45U，谷丙转氨酶 650U，麝香草酚浊度 14U。证属湿热蒸肝胆，治宜清肝利胆退黄。处方：茵陈 15g，栀子 10g，大黄 20g，车前子 20g，板蓝根 15g，肝炎草 10g，炒白术 10g，藿香 10g，柴胡 10g，甘草 10g。服药 2 剂，热退呕平，大便日 2 次，上方减藿香、柴胡，加神曲、郁金续服 4 剂。化验肝功，黄疸指数正常，余好转。治宜标本兼顾，大黄、车前子减量，加太子参、砂仁、郁金增损治疗，前后服药 12 剂，肝功化验正常，而病告痊愈。

又如治毕某，男，36 岁。患黄疸型肝炎月余，曾服大剂量清热解毒之品，效果不佳。症见少气里急，脘腹胀闷，不欲饮食，舌苔白腻，脉滑而虚。近期肝功化验：黄疸指数 16U，谷丙转氨酶 350U，麝香草酚浊度 10U。证为过用苦寒，邪气未除，胃阳已伤，治以标本兼顾。方以黄芪建中汤合茵陈蒿汤，加车前子 30g，大黄 30g，板蓝根 30g，炒白术 15g，郁金 15g，服药 10 余剂，黄疸指数正常。后观其脉证，随证加减，调治月余，肝功正常。

是以黄疸病治疗，临证实须细求其因，进而在辨证立法用药基础上，必增用二药，无论老少，皆可放胆用之，然临证尤须审证精确。二药实属攻伐之品，若体虚正衰者，又当标本兼治，以防犯虚虚之戒也。

陈天资重用大黄经验

陈氏在临床上使用之量，远远超过中药教材规定剂量。

1. 治疗急性阑尾炎 治疗急性阑尾炎，早期常用大黄牡丹汤加减。酌加白花



蛇舌草、黄芩、赤芍、葛根等，生大黄每剂用量为 30~50g，每日 1~2 剂。患者如能排便数次，症状逐渐好转。生大黄的用量每次改为 15~20g，每日 1 剂，或中药改为增液承气汤加减，生大黄用量酌减。

2. 治疗急性胰腺炎 陈氏所经治的急性胰腺炎，基本上为水肿型。临床上使用大柴胡汤加减，酌加延胡索、川楝子、虎杖等，生大黄每剂的用量一般为 40~50g，每日 1~2 剂，若患者发热、腹痛等症状减轻，大便次数增多，则生大黄每天的用量可减至 15~30g。

3. 治疗不完全性肠梗阻 治疗不完全性肠梗阻，均用大承气汤加味。由于不完全性肠梗阻其热结胃肠、腑气不通尤甚，故生大黄之量尤重。一般每剂用量为 50~60g，每日 2~3 剂，半数以上患者的每日用量为 100~180g。若患者大便已通，腹痛、腹胀、发热等症已改善，生大黄每日之用量可减至 10~30g。若大便每日 10 余次，可加大补液量，生大黄可暂停使用。

4. 治疗胆囊炎、胆石症 治疗急性胆囊炎、胆石症，常用大柴胡汤合四金汤加减，生大黄每剂用量为 50~60g，每日 1~2 剂，一般病人每日用量为 2 剂，多数患者每日生大黄的数量为 100~120g，个别患者每日用 3 剂，或加用生大黄 50g 捣碎开水研服。若患者大便次数较多，腹痛发热、黄疸等症减轻，生大黄每日之量可减至 20~30g。

5. 治疗老年习惯性便秘 老年习惯性便秘，一般用养阴润下之法治疗，若此法治疗效果不佳，腹痛腹胀明显，可用载水行舟之法，使大便迅速排出，则用增液承气汤加味，生大黄每剂量为 20~30g，每日 1 剂。此法一般均能攻下大便，大便通畅后，则停用生大黄。

6. 外用灌肠 外用生大黄灌肠，一般多用于不完全性肠梗阻或尿毒症早期，每剂生大黄用量为 50~80g，每日 1~2 剂。此法有时亦用于习惯性便秘。

陈氏认为，在临床上重用生大黄，并不等于滥用生大黄，使用时首先要明确疾病诊断，分清其寒热虚实，辨别其轻重缓急，了解其体质强弱，掌握其病情之变化，不可一概强攻，更不可胡乱投药，以重泻为快。根据陈氏临床经验，一般而言，病人其符合阳明腑实者，不怕其泻，最怕不泻，若泻下数次之后，腑气则通，邪热则解，病情会逐渐好转，反之病情会逐渐加重。当然，患者若泄泻次数频繁，泻量过多，会迅速伤阴耗气。此时应及时补液，尤其应合理补钾，内服与静脉滴注配合，以纠正水电解质失衡。

李春和重用大黄经验

李氏临证以大剂量运用大黄著称乡里。对狂证、跌损、痈疖、瘟疫、妇女不



孕、痛经、月经不调及小儿惊风、胎毒等症，多以重剂大黄为主，常取得快速而良好疗效。

案1 郭某，男，40岁，农民。平素健康，初因卖鱼被人打伤，8个月前复因邻里纠纷，被人欺侮。肝郁气愤交加，卒然发狂，呼号怒骂，亲疏不辨，打人毁物，不思食眠，面红目赤，声宏气粗，脉滑数大，舌质绛，苔黄燥。诊为肝郁气滞，痰火交争，上闭清窍。方用：大黄 240g（另包后入），枳实、厚朴、石菖蒲各 12g。加水 600ml，先煎后三味 1 小时，最后 20 分钟下大黄。家人强其连服 2 剂，服后腹痛便泻十数次，泻下黏液及黄褐色大便。泻后乏力蜷卧，无力狂奔，神志间有清时，脉趋和缓。上方减大黄为 150g，继服 2 剂后，觉腹空欲食，每次进流质碗许，神志渐趋正常，病情逐日康复。至今 10 年未复发。

按语：“诸躁狂越，皆属于火”，痰火并走于上，蒙闭清窍，发为斯症。泻肝热、倒痰火，非重剂大黄不足为治。《本经疏证》云：“烦惊、胸满、谵语，非大黄不为功。”或即此意。

案2 赵某，女，26岁，纺织工人。婚姻坎坷，家庭失睦，郁闷已久，半年前生气后神志异常，性情暴躁，继而呼叫怒骂，登高而歌，弃衣而走。曾在省内外精神病医院施冬眠、镇静及激素疗法，未根治。其脉弦滑，舌质红，苔黄腻。诊为肝郁气结、痰火上闭清窍。方用：大黄 150g（另包后入），枳实、厚朴各 12g。后二味加水 600ml，煎 1 小时，后 20 分钟加入大黄。服后腹痛作泻，呕恶难受，折腾一夜，至黎明病势已缓，困倦乏力，闭目而卧，鼾睡达 10 小时，醒后神志转清，给服稀粥。如此 4 剂，不再发狂，症见倦卧乏力，短言少语，嘱家人好生调护，1 周后下床，至今 15 年未再复发。

按语：青壮年肝郁及脾、痰火闭塞清窍者，以重剂大黄调理肝气、清热祛痰，强下痰火，其势如破竹，一过不留，这是其他疏肝清热祛痰方药如逍遥散、越鞠丸、安宫牛黄丸等力所不及的。以上二例狂证，均仅服 4 剂药即愈，都已超过 10 年未复发。

案3 郑某，女，26岁，农民。无器质性疾病，婚后 4 年未孕，月经 40~50 天一行，经前及经期腹痛、腰酸沉，经色紫暗，夹带血块，平时白带多，腥臭、烦躁，耳鸣，口苦，眠差多梦，脉弦数，舌质红暗，苔黄而腻。诊为气血郁滞，痰热瘀阻。方用：大黄 140g（另包后入），牡丹皮 12g，生桃仁、生五灵脂、生蒲黄、血竭各 10g，木香、黄芩各 12g，黄酒、米醋各 60ml 为引。加水 800ml，先煎诸药 1 小时，最后 20 分钟加入大黄，滤出药液 400ml。二煎加水 300ml，煎半小时滤出，两煎药液合并共 600ml。先服药引各 40ml，再服药液 400ml，待 2 小



时后，服尽余药引和药液。服药后腹痛、下坠，呕恶欲吐，泻下黏浓便 20 余次。如是连服 5 剂（隔天 1 剂），心烦眠差、口苦等症悉减，脉缓和，舌质、舌苔渐转正常。但仍不见经来，2 个月后又出现嗜酸、呕恶等妊娠反应，足月生一健康男婴。

按语：婚久不孕，畏于社会流言，肝脾不和，气滞及血，胞宫瘀阻，冲任失调，经乱失孕。取重剂大黄，急行快下，破瘀血血闭，除肝郁痰阻，酒醋二引，辛酸散敛，促气血畅行，气血既通，青壮男女，焉有不孕之理。

案 4 冯某，女，36 岁，农民。婚后连生二女，因无男孩，家庭不和，常忧郁不解，渐致月信后延，经色紫暗，经量殊少。经前腹痛身困，眩晕体重，胸胁胀满，脉弦而滑，舌质紫暗，诊为肝郁气滞、瘀阻胞宫。方用：大黄 90g（另包后入），柴胡 15g，当归 20g，川芎、木香、延胡索、牡丹皮、桃仁各 12g，先煎余药，后加大黄，一、二煎合并共取汁 600ml，第一次服 400ml，第二次服完余药。服后有腹痛、欲吐、腹泻反应，给热米粥以养胃，连服 6 剂，痛经消失，经期正常，经色亦佳。

按语：由气滞而血瘀，由瘀而胞宫痹阻，致痛经、经期后延。重剂大黄破除瘀血，散癥瘕、积聚，疏理肝气，瘀散气行，其病必除。

案 5 李某，男，40 岁，农民。建房时不慎跌下，胸腹满闷，周身刺痛，伤处青紫，呼吸气短，呕恶欲吐，舌质暗，脉细涩，诊为跌仆损伤，瘀血内阻。方用：大黄 150g，当归尾 30g，桃仁、红花、木香、茜草各 12g。加水 500ml，大黄后入，取汁 250ml，童便 50ml 为引，一并服下，服后泻下黑褐色便数次，诸症渐消，勿需余药。

按语：跌仆损伤治用活血化瘀之剂，乃医家常识。但何种方药最优？则大有探讨必要。大黄既下瘀血、血闭，又善清热解毒，还能理气散结，促进气血运行，推陈致新，恰合跌损之血瘀、热闭、气滞之病机，故一剂而愈。

李氏体会，化瘀血、疏肝郁、清火热、解毒邪，唯大黄之效最捷，凡阳、实、热证，重剂大黄，用之勿虞。

重剂大黄是速效药，特别对气滞血瘀所致狂证、气血瘀闭胞宫致不孕症，痛经、月经不调症、毒热炽盛之肿痛、疥疮、瘟毒症以及跌损、小儿惊风、衄血等，用重剂大黄，最多五七剂即可治愈，这是其他方药所不及的。《本草正义》云“迅速善走，直达下焦无坚不破，有犁庭扫穴之功……迅如走丸，一过不留。”给大黄的速效作了恰切比喻。

根据祖传和李氏个人经验，治疗年轻力盛的狂证，每剂用量 150g 以上，多者达 240g；对青壮年妇女不孕、痛经、月经不调和跌仆损伤症，每剂用量 90~150g；



痈疮、疔肿、瘟毒，每剂用量 50~100g；小儿惊风、胎毒、衄血等，每剂用 5~15g。虽然李氏的用量高于常规用量 2~10 倍，但从临证 40 年来，尚未见一例因重用大黄而致病情加重或致伤残事故，反而屡收良效。张锡纯《医学衷中参西录·大黄解》载：治一少妇“赤身卧帐中，其背肿热，若一缕着身，即觉热不能忍”“用大黄十斤，煎汤十碗。放量饮之，数日饮尽，竟霍然全愈”。如此用量，较之量大几倍，并无严重后果，反而治愈奇症。李氏体会：凡中青年病人，属实、热证，是大黄适应证，可放胆用之。

大剂量大黄，服药后约 2 小时，即开始腹痛，继而腹泻，泻下黏液及褐黑色便，伴有恶心、呕吐。初服药此反应较剧，服三四剂后则反应逐渐减弱至消失。吐、泻、腹痛后，大多数患者呈虚弱倦卧状。对此反应，勿需特殊处理，宜向病家说明，以米粥或流质饮食饮之，卧床静养。若病人服后吐药，可将下次药提前服用。

年轻而体弱患者，若无心肝肾等慢性病，可酌情减量，对素体阳虚、体弱、老人、心肝肾肺慢性病者忌用。阴证、虚寒证禁用。

李氏经验认为：大黄不加芒硝，泻而不伤，于病有益。加芒硝则泻而伤人，因此，大黄禁与芒硝为伍。

重用牵牛子经验

牵牛子最早载于《名医别录》。其性寒，味苦，有毒；归胃、大肠、肺、肾、膀胱经；其基本功效有逐水退肿，利尿，去积。多用于水肿、腹胀、痰饮喘咳、虫积腹痛等。临床常用量为 9~15g。

刘绍勋重用牵牛子治实滞

近年来，牵牛在临床中应用比较广泛。在肾炎、尿毒症水肿、肝硬化腹水等危笃疾病中，牵牛每每大显身手，疗效堪称满意。辽宁名老中医刘绍勋认为，无论中焦湿热壅滞之症或是食积滞留之候。皆可用牵牛攻之、逐之、消之。治疗这类疾病，刘氏主张用熟牵牛。此药经过炮制，一可减其毒性，二可缓其燥烈，三可去其辛辣刺激之味。总之，凡有实滞之象者均可用之，基本剂量为 15g，体质强壮者可用至 30g，不必诚惶诚恐。几年来，刘氏按上述剂量治疗一些患者，并未出现意外情况。



1972年国庆节前夕，刘氏家母因过食膏粱厚味，当夜脘腹剧痛，辗转反侧，痛苦万分，经吞服开胸顺气丸1包暂缓症状。次日仍胃痛胁痛不已，噎腐厌食，腹部胀满，尿道涩痛，溲中带血，舌质绛，苔黄腻，口渴思饮，脉象弦滑有力，一派食积停聚、湿热蕴结之象。家母当年已是82岁高龄，病情发展如此迅猛，阖家惊骇。经反复思量，如投鸡内金、三仙等消导之品，恐怕病重药轻，贻误病机。考虑再三，遂与消食和胃之品中，加入熟牵牛20g，仅服1剂，症状大减，继服1剂，病趋稳定，遂停服汤剂，仅以米粥调理而告痊愈。

又如治李某，男性，现年20岁。6年前因颜面及四肢水肿，腹部胀满如鼓向刘氏求医。经某医院诊断为肾炎合并尿毒症，住院治疗月余未效。观其脉症，已属湿热蕴毒，传入脏腑，气血衰微之候。拟用扶正与祛邪兼并之法，在清热解毒、通关利湿、扶正益气之品中，重用熟牵牛30g。该患服药2小时许，排尿一小水桶（约有1000ml），诸症豁然轻减，后经继续治疗，方药随证加减，竟获痊愈。

以上两例说明，临床中应用牵牛，必须辨证准确，药症相符，要胆大心细，当机立断，只有药达病所，牵牛才会兀见殊功。

重用甘遂经验

甘遂最早载于《神农本草经》，其性寒，味辛、苦；归肺、肾、大肠经；其基本功效有泻水逐饮，消肿散结。多用于水肿、臌胀、胸胁停饮、便秘、风痰癫痫等。临床常用量为入丸、散服，每次0.5~1g。

张琪重用甘遂治腹水

国医大师张琪教授善用甘遂配大黄治疗水血互结之证。张氏认为：水蓄可以导致血行阻滞，血瘀亦可影响水液分布运行。“水阻则血不行，血不利则为水”，水与血影响，相互瘀结，如水蛊、血蛊相当于肝硬化之腹水，肝脾大，腹壁静脉曲张等腹部膨隆，见青紫筋脉，全身或手足有红缕赤痕（蜘蛛痣），大便色黑，小便赤，或见吐血、衄血等，治宜活血化瘀，健脾利湿。此时若单纯祛瘀，则因蓄水不除，压迫脉道，使血行阻滞，终致瘀血难消，单纯逐水则会因瘀血障碍，津液敷布及排泄受阻，使水瘀互阻而加重。故两者必兼施，方能达到瘀水并除之目的。宗“留者攻之”“去苑陈莖”，创祛瘀逐水之法。《金匱要略》有大黄甘遂汤为攻瘀逐水之代表方剂。大黄破瘀，甘遂逐水，为瘀水并除之要药。张氏以此二药



合用治疗肝硬化腹水颇效。如治疗脾大型肝硬化高度腹水处以甘遂 10g, 大黄 15g, 海藻 30g, 牵牛子 40g, 白术 20g, 茯苓 30g, 桃仁 15g, 党参 20g。方中大黄与甘遂合用, 合参、术等消补兼施, 初服尿微增, 连服小便渐增, 大便日行 2~3 次, 所下皆清水。腹胀见松, 连服 20 剂, 小便一昼夜增至 3000ml, 腹水全消, 基本缓解, 随访此病人已上班 2 年, 情况良好。

甘遂为峻猛逐水之品, 但因其难溶于水, 故临床上多作丸散剂服用, 用于丸散剂, 往往 1~2g 即可令腹痛腹泻。张氏煎服, 其峻猛之力较丸散剂为稍逊, 但用量 10g 亦非常人能处之。故临床应该辨证准确, 方可运用。临床运用时可先小剂量运用, 如患者可以耐受则逐渐加量, 以防过量带来副作用。

第四章 化湿利湿药

重用苍术经验

苍术最早载于《神农本草经》，其性温，味辛、苦；归脾、胃、肝、肺经；其基本功效有燥湿健脾，祛风湿，解表。多用于风湿痹痛、风寒外感表证、泄泻、妇女带下等。临床常用量为 5~10g。

顾文忠重用苍术治顽固性湿证

顾氏在临证中遇顽固性寒湿证、湿热证及风寒湿证，应用苍术常规剂量组方治疗难以祛除湿邪时，将其重用至 50g，每获佳效。

如治陆某，男，48 岁，1996 年 2 月 5 日初诊。患者近 3 个月来经常晨起时腹泻，曾服四神丸、补脾益肠丸、氟哌酸、止泻宁等治疗 2 月余，疗效不佳。刻诊：身体较瘦，形寒肢冷，面色苍白，食欲不振，头重身困，全身乏力，腰膝酸软，口中“毛糙”不适。每日晨起即发生腹泻 2 次，早餐后腹泻 1~2 次。粪便为糊状，夹杂较多黏液。每次泻前在左中下腹部有轻微疼痛。舌质淡，苔白厚腻，脉细滑。粪便镜检：有黏液及少量白细胞，隐血（-），血沉正常。乙状结肠镜检见乙状结肠痉挛，黏液增多。证属脾肾阳虚，寒湿内盛，治宜温肾暖脾，散寒祛湿。处方：炒苍术、炒党参各 30g，茯苓、焦六曲各 20g，木香、台乌药、补骨脂、炒白术、肉豆蔻各 15g，炮附子、淡干姜、炙甘草各 10g。服上方 7 剂后，患者晨起腹泻减少为 1 次，早餐后仍腹泻 1~2 次，头重身困不减。舌苔依然白厚腻，未见丝毫减退。遂将上方中炒苍术量增至 50g。再进 7 剂。至 2 月 20 日来诊时，见患者面色转红润，精神较爽，诉头重身困、畏寒肢冷消失，口中已无“毛糙”感，腹泻已止，大便成形，舌质淡红，苔为正常薄白苔，脉缓。病告痊愈。为巩固疗效，给服附桂理中丸 2 周收功。随访 1 年余，未见复发。

又如治施某，男，42 岁，1997 年 7 月 3 日初诊。患者近半年多来常感下腰部不适，伴有尿频、尿急，尿道口常有黄白色分泌物。曾在本市某医院男性专科医



治，给服氟嗟酸、阿奇霉素等治疗，效果不佳。刻诊：会阴部坠胀不适，排尿时尿道有灼热感，尿末及大便时尿道口滴出黄白色物，小便黄赤，大便干燥，伴头重身困，心中烦热，口干舌燥，腰背酸痛，性事减退。舌质红，苔黄厚腻，脉滑数。直肠指诊：前列腺稍大，触痛明显。前列腺液镜检：白细胞成堆，卵磷脂小体显著减少。证属精室湿热，治宜清利湿热。处方：炒苍术、生薏苡仁、瓦松、石韦、红藤、败酱草、金银花、石斛各 30g，苦参、桑寄生、六一散（包煎）各 20g，焦黄柏、牛膝、生栀子、龙胆草、王不留行、木香各 15g。连服 7 剂后，尿道灼热感减轻，尿道口分泌物略减，但头重身困依然，舌苔仍黄厚腻，无消退迹象。故于前方中将炒苍术重用至 50g，再服 7 剂。于 7 月 18 日来诊时，诉头重身困减轻，尿道灼热感消失，尿道口分泌物大减，舌苔已变薄，成黄白相兼，药已显效，遂将上述重用苍术方再进 7 剂。于 7 月 26 日来诊时，患者神清爽朗，诉诸症全消，诊视舌苔已为正常薄白苔。为巩固疗效，予三妙丸及龙胆泻肝丸续服 2 周。随访 1 年余，未见复发。

顾氏居住地处东海之滨，常年除秋季外，空气湿度较大，故民病多湿证。苍术为当地中医常用药物，常规剂量为 15~30g。一般较重的湿证，如苍术用至 30g，大多可取效。但对某些顽固性湿证，常需重用至 50g 或以上才能显效，然苍术重用不当，亦有导致汗多及伤阴动血之虞，据笔者经验，重用苍术安全有效必须注意以下 5 个指征或条件：①舌苔必须是白厚腻、黄厚腻或灰黑厚腻者；②平素无出汗或出汗少者；③无阴虚、血燥、津枯表现者；④消化道无活动性溃疡及其他出血表现者；⑤经常规剂量苍术治疗后湿邪不除者。

李国荣重用苍术治婴儿腹泻

李氏用其老师马莲湘教授一成方，名小儿止泻散，由苍术、羌活、车前子、生熟大黄、制川乌、甘草等组成，治婴儿泄泻有效率达 86.4%。方中重用苍术，由此思及前人有“泄泻之本无不由于脾胃”“湿多成五泄”之说，可见泄泻主脏在脾，主因为湿，方悟出燥湿健脾的苍术实为止泻要药。遂以苍术为主组方，试用于无发热的婴儿泄泻，效如桴鼓。一般 1 剂见效，3 剂多能明显好转。医家病家皆欣然。

李氏也曾试用于有热腹泻，却往往泻虽减而热益炽。患儿脱苔，烦躁明显。这一方面证明苍术确有止泻作用，另一方面也说明该药苦温辛燥，用于热泻有伤阴之虑。李氏调整苍术剂量，并与生石膏为伍，即仿白虎加苍术汤之意，方收泻止热退之效。从此以后，凡遇婴儿泄泻均以苍术为主组方，方中苍术用量相对较大，石榴皮等涩肠药物反而少用。婴儿泄泻年龄多在 2 岁以下，1 岁以内者占半



数。苍术每剂用 10~12g。初时曾用苍术 6g，临床无效。后改为 10g，始效。对脾虚明显或年龄较小的（如 3~4 个月婴儿），用苍白术各 6g。成人泄泻亦可用苍术，用量须更大。曾治一同事母亲，泄泻两三个月不愈，晨起即泻，苔厚腻。观前医用四神丸、参苓白术散、鸡鸣散等加减无效，李氏用苍术 30g 组方而愈。

苍术止泻不是涩肠而是燥湿，因而可突破某些止泻涩肠药的限用规则，临床运用更加灵活。如苍术和泻下药同用，就有异曲同工之妙。

李新发重用苍术配麻黄治湿热阳痿

李氏在治疗湿热阳痿中重用苍术、麻黄、每获奇效。

如治张某，40 岁，某公司经理。1993 年 5 月 19 日就诊。患者素嗜烟酒，膏粱厚味，公务繁忙，起居无常，遂发阳痿，举而不坚 1 年。曾自购市售多种“壮阳药”一一品尝，非但无效，已致阳痿不举 1 个月，伴见阴囊潮湿，口苦，口舌生疮，溲黄便干，夜寐不安，身重乏力，舌质红，舌苔白腻，脉弦数。既往健康，形体丰腴。证属肝经湿热，气机阻滞，下焦失于宣泄，宗筋弛纵而痿。处方：龙胆草 15g，栀子 10g，黄芩 10g，当归 10g，生大黄 10g，车前子 15g，泽泻 15g，柴胡 20g，甘草 5g。7 剂，水煎每日 1 剂，2 次口服。嘱忌烟酒，饮食宜清淡，慎起居，调情志。复诊口苦、便干、口舌生疮悉退，余症亦然。上方去大黄加苍术 45g，麻黄 15g。7 剂，煎服宜忌同前。10 个月后患者精神欣快报告，服药后小便频多，清长多沫，随之阴汗止，阴部欲动，服至第 5 剂成功合房一次。身轻有力，相继房事正常。

又如治薛某，46 岁，工人，1993 年 7 月 16 日就诊。素嗜辛辣烟酒 20 余年，每餐不食辛辣味或饮酒则食欲全无。于 3 年前酗酒渐发阴茎举而不坚，曾服中药近百剂，几经易医未愈。1 个月前闻听羊肉大补，于是每日以氍羊肉佐餐，非但未效，且病日甚，一有欲念，阴茎尚未举，而其精自泄，苦不堪言，伴见臀部多汗，龟头时有白垢，纳少，小便黄，困倦身重，舌体胖大，苔白厚少津，脉濡滑。证属脾胃湿热，由辛辣厚味，损伤脾胃，湿热阻滞脉络，致气血不能充养宗筋，复用补阳，相火愈盛，精愈不固，而致阳痿、早泄。处方：苍术 45g，麻黄 15g，薏苡仁 20g，滑石 15g（包煎），厚朴 10g，杏仁 10g，白豆蔻 10g，半夏 10g，通草 10g，竹叶 10g。水煎每日 1 剂，2 次口服。嘱忌烟酒、辛辣厚味，饮食清淡。7 日后复诊，自述药后小便明显增多，日前有欲念，阴茎已能举但不坚，未发早泄。臀部已无汗，食欲渐增，脉觉有力。前方加女贞子 10g，墨旱莲 10g。续服 14 剂告愈。

《中医治病绝招》载：“苍术三倍于麻黄利尿。”李氏依此经验，用于治疗湿



热阳痿，以冀其利尿通阳，果然获效。苍术治上、中、下三部之湿主药，麻黄利水，如此用量配伍，苍术泄水开郁，走而不守，抑麻黄泻肺舒散之功，二药协同，功专走下，利水湿，泄湿浊，使湿从小便而出。故药后小便增多而汗不出，使湿化热亦化，湿热去则阴气自通，以达命门火得以用事。

熊棠庆重用苍术治顽固水肿

熊氏重用苍术治疗顽固性水肿乃为临证偶得。1991年6月4日收治一“扩张型心肌病并心功能Ⅳ级、重度心衰、心律失常”的男性病人，年近花甲，发病11天。症见：心悸气喘，动辄尤甚，咳嗽倚息不能平卧，全身浮肿，小便短少。证为肺脾气虚，痰湿内阻。经西药强心利尿，中药益气健脾理气、泻肺利水消肿等综合治疗1周后，心功能转为代偿期，心力衰竭纠正，心悸、气喘、咳嗽缓解，膝以上浮肿消退，唯有下肢浮肿不能除。用上法停用强心药，继续治疗4天后，下肢浮肿仍如故。思之患者已有该病史5年余，经治疗仅下肢水肿不除，虑为原证未变，但重心为脾阳衰惫。根据许公岩名老中医治湿当以“温运利化”之经验，非大剂苍术莫属。于是撤去所用西药，在原中药处方中加苍术18g，服3剂后，居然浮肿逐渐消退，继服5剂浮肿消失出院。为何使用益气健脾理气、泻肺利水消肿合西药利尿剂，肿反不见消退，而在中药原法的基础上重用苍术燥湿健脾，其利尿消肿作用减轻，肿却自消？《玉楸药解》有云：苍术“燥土利水，泄饮消痰”。又曰：“白术守而不走，苍术走而不守，故白术善补，苍术善行。其消食纳谷，止呕住泄亦同白术，而泄水开郁，苍术独长。”此为重用苍术妙处之一。其二，泻肺利水、消肿之品及西药利尿剂，皆为寒凉剂，虽有益气健脾理气药物，亦不能抵御其克伐阳气之弊。重用苍术脾阳得以助，阳足则脾得以运，水肿能有不消之理乎！

此后，熊氏凡治疗心性水肿，属脾阳不足加苍术与干姜同用；肺脾气虚，调输运化失职、湿饮内停者，与麻黄相使合用，且用量应3~4倍于麻黄；心阳不振与桂枝相伍；肾阳虚损配合附片；湿痰瘀阻调配田七、葶苈子，用量均在15~20g之间。自1991年以来共观察百例病人，解除了水肿不消之苦，均获满意疗效。但水肿之热甚者切不可妄用。

重用厚朴经验

厚朴最早载于《神农本草经》。其性温，味苦、辛；归脾、胃、肺、大肠经；



其基本功效有燥湿，行气，平喘。多用于湿阻中焦、脘腹胀满、食积气滞、腹胀便秘、痰饮喘咳等。临床常用量为 3~10g。

李文瑞重用厚朴治腹胀

著名中医学家李文瑞临床常重用厚朴，一般用量 3~10g，重用 25~50g，最大用至 80g。李氏认为厚朴有理气除胀、增强肠蠕动之功，与兴奋肠管的现代药理作用相符。用于腹胀较甚者，重剂方可获效。常在厚朴三物汤、枳术丸、厚朴七物汤等方中重用。临床主要用于帕金森症、腹部手术后、胃肠功能紊乱等。服药期间未见明显不良反应。如治一男性 80 岁患者，患帕金森症住院。经西药治疗肢体抖动等症状明显减轻，唯腹胀便难如故，遂邀李氏会诊。症见腹胀如鼓，便软而难解，纳呆食少，舌淡红，苔薄白，脉弦细。证属气运失司，浊气不降，遂拟厚朴三物合枳术丸，重用厚朴至 80g，加莱菔子 10~15g，服 3 剂后略减，治疗月余症状缓解。

彭景星重用厚朴治肠梗阻

湖北名医彭景星善于重用厚朴治疗肠梗阻。肠梗阻通常用大承气汤加味治疗，彭氏体验方中厚朴应重用，一般 30g，身体壮实者可用至 60g。因本病主要是肠腑气机不通，厚朴味苦、辛，能降能行，为导气宽肠要药，但需重用方能奏效。

曾治马某，女，34 岁。化脓性阑尾炎术后，腹痛、腹胀，大便 7 天不行，腹透可见扩张的肠腔及液平，诊断为粘连性肠梗阻。先拟以方，药用：大黄 15g，厚朴 15g，枳实 15g，芒硝（冲服）10g，大腹皮 15g，炒莱菔子 15g。服药 3 剂，症状不见改善。遂邀彭氏会诊，仅将方中厚朴增至 40g，服药 1 剂，大便通畅，腹痛消失。

重用薏苡仁经验

薏苡仁最早载于《神农本草经》，其性微寒，味甘、淡；归脾、胃、肺、大肠经；其基本功效有利水渗湿，健脾止泻，除痹，清热排脓。多用于水肿、小便不利、脚气、脾虚泄泻、湿痹拘挛、石淋等。临床常用量为 9~30g。

张董晓重用薏苡仁治乳头溢液

张氏临床重用薏苡仁治疗乳头溢液，效果满意。如治一女性患者，29 岁。素体虚弱，产后 1 年，哺乳 6 个月，现已回乳 6 个月。仍有双乳多个乳孔溢乳，不



经挤压而出，经前症状尤重，与月经有一定相关性。伴乏力，精神倦怠，食欲差。患者形体较瘦，面色淡白，语声低微，舌体胖大边有齿痕，舌质淡红苔薄白，脉细。因患者不愿服用中药汤剂，嘱以薏苡仁 60g，每日 1 次煎服。2 周后患者溢乳症状明显好转。因彼时为月经后，为排除月经因素对乳头溢液的影响，嘱患者继续服药 2 周，至经前复查。再次复查时患者左乳已无溢液，右乳溢液量亦较前明显减少，且经挤压才可见乳头溢液。遂嘱患者原法继续用药 1 个月。复诊时已无乳头溢液。后又以此法治疗乳头溢液多例，包括产后乳汁自涌、流产后双乳溢液、停止哺乳后仍有乳汁自行等病症，多获良效。

重用泽泻经验

泽泻最早载于《神农本草经》，其性寒，味甘、淡；归肾、膀胱经；其基本功效有利水渗湿，泻热。多用于水肿、小便不利、泄泻、带下证等。临床常用量为 5~10g。

胡建华重用泽泻治内耳性眩晕

名老中医胡建华善用泽泻汤治疗内耳性眩晕，认为泽泻用量以 30g 左右为宜。如病情日久，恐其入络，亦可加用丹参等活血化瘀之品，一则祛瘀以通络，二则活血以助利水，一举两得。

黄煌重用泽泻治眩晕

江苏省名老中医、南京中医药大学黄煌教授亦善用泽泻治疗眩晕证。黄氏认为泽泻主治冒眩而口渴、小便不利，其人面色多黄黯，肌肉松软，体形肥胖，动则气短，其舌体多偏大、质淡红。针对这样的体质与表现，可重用泽泻至 60g，量大力宏，利水力强，可明显改善患者头晕头痛诸症。

汪建勋重用泽泻治眩晕

银川市名医汪建勋教授临证强调抓住眩晕之“天旋地转”临床特征，因此侧重从痰论治，重用泽泻，多获良效。

如治邱某，男，72 岁。2007 年 11 月 6 日初诊。主诉：眩晕时作多年，加重 2 周，严重时伴天旋地转不敢睁眼，心慌气短，行走不稳，乏力，汗出，睡眠一般，大小便尚调，苔白腻，脉弦滑。汪师辨证为痰浊中阻，治以渗湿祛痰，化浊定眩。方以泽泻汤加减，处方为：泽泻 60g，白术、茯苓各 20g，半夏、竹茹、陈



皮、天麻（先煎）、菊花各 10g，车前子（包煎）30g，胆南星 6g。3 剂，水煎服。

11 月 30 日：诉药后眩晕明显减轻，余症均减，唯觉头顶沉重感，苔白腻渐化，脉细弦。汪氏认为效不更方，故在原方基础上加八月札、香附各 10g 以行气，有助于痰湿利化，并加丹参 15g、葛根 12g 以活血化瘀，以防久病入络，气血瘀滞，又予 3 剂，煎服法同前。

12 月 5 日：诉诸症著减，精神转佳，纳可，大小便调，脉细弦，仍效不更方，继上方 3 剂以巩固疗效。

汪氏强调，化痰祛饮平眩晕，所能收效之关键在于重用泽泻，此方取《金匮要略》泽泻汤治支饮冒眩之意。仲景曰：“心下有支饮，其人苦冒眩，泽泻汤主之。”

“泽泻汤”以渗湿利水之征象为主药，配以健脾制水之白术，旨在去除水湿，使痰饮无由此生，使眩晕无由以作，泽泻用量在 60g 左右，白术 20g，此外半夏、竹茹、天南星有较好的化痰降浊作用，故临床常选用。如病情日久，恐其入络，亦可加用丹参等活血化瘀之品，一则祛痰以通络，二则活血以利水，一举二得。

马宝东重用泽泻治痛风

马氏善用泽泻治疗现代医学之痛风。马氏认为，痛风的治疗上应“急则清泄浊毒，利湿化瘀”。泽泻因其清热利湿、利关节之功效，故重用 50g 为君药，辅以萆薢、苍术、黄柏等加强清热利湿泻浊之功，临床收效明显。

屠庆年重用泽泻治眼底出血

临床上各种原因引起的眼底出血很常见，且多起病突然，常于短时间内视力急剧下降，甚至失明，属中医暴盲范畴，常用治法为凉血止血。名老中医屠庆年治疗此病常在辨证的基础上加用泽泻，可取得更好的疗效。《本草蒙筌》所言：“泽泻……暴服亦能明目，其义何也，盖泻伏水，去留垢，故明目。”从西医的角度分析，急性出血期渗出水肿较明显，患者多诉眼部胀痛不适，选用泽泻“邪伏水，去留垢”，能取得较好的消肿效果。一般泽泻的用量在 20g 左右，最多可用 40g。

李慧重用泽泻治泄泻

李氏临床实践中，重用泽泻配伍治疗泄泻，获得较好疗效。

如治吴某，男，52 岁，1999 年 10 月 20 日就诊。患者 1 周前因受凉致鼻塞、流涕、打喷嚏，曾服用 VC 银翘片、感冒通等药物，效果不佳，且于 5 天前出现发热，体温最高达 39℃，腹泻，泻下急迫，大便水样，腹痛轻，查大便常规无异常，遂在单位卫生所用青霉素、丁胺卡那霉素，效不显。就诊时病人体温在 37.5～38.0℃浮动，仍腹泻，为水样便，无脓血，1 天 10 次左右，腹痛轻，纳呆，胸腹满闷，口渴，小便少，无双下肢浮肿，舌质红、苔黄腻，脉浮数。辨证：外感湿

热。药用：泽泻合葛根芩连汤加平胃散（泽泻 30g，葛根 15g，黄芩 12g，黄连 9g，苍术、厚朴、陈皮各 10g，甘草 6g），服 3 剂即瘥。

又如治范某，男，68 岁，于 2000 年 1 月 12 日因腹泻就诊。病人半月前因过食寒凉而引起泄泻，下腹部隐痛，大便时溏时泻，纳呆，稍进油腻则大便次数增多至 2~3 次，乏力，四肢倦怠，面色萎黄，喜热畏寒，苔薄白，脉濡弱。辨证：脾胃虚弱。药用：泽泻合参苓白术散加减（泽泻 30g，党参、山药、云茯苓各 15g，白术 10g，薏苡仁 20g，焦三仙各 6g，桔梗、砂仁、甘草各 6g）。病人服用 3 剂后，症状缓解。加服 5 剂，大便基本正常。嘱病人服香砂六君子丸以巩固疗效。半年后随访，未再复发。

李氏治疗本类患者时，深深感悟到配入大剂量泽泻，可以取得更好的疗效。《本草思辨录》认为，泽泻能起阴气，而召上冒之阳，治饮停眩冒，功胜茯苓；治水结而渴，惟泽泻其庶几耳！泽泻润下而兼渗，使水湿从小便而去，则泄利停。只是在应用时要注意中病即止，以免降泄太过，真阴潜耗，或也可以与补药合用。

重用滑石经验

滑石最早载于《神农本草经》，其性寒，味甘、淡；归膀胱、心、胃经；其基本功效有利尿通淋，清热解暑，外用收湿敛疮。多用于小便不利、暑湿，湿温、湿疮、湿疹、痱子、泄痢等。临床常用量为 10~20g。

刘绍勋重用滑石治外感

辽宁名老中医刘绍勋认为，滑石能解肌发汗，它发汗而不伤气阴，这一特点胜过羌活等药，因此在临床中，经常运用滑石治疗外感疾病。

刘氏认为，滑石所以能够“上开腠理而发表”，主要是滑利柔润、利窍淡渗的作用。滑石的滑润之特性，轻抚皮毛，柔润肌肤，使肌腠疏密得当，肺气得以宣畅，俾令体内濺濺汗出，进而驱邪外散。对于滑石的利窍淡渗作用，亦应做新的理解和探索。滑石利窍，并不局限于通利前后二阴，还具有开通“玄府”（即毛孔）的作用，这与其滑润之性是分不开的。外邪束表，毛孔闭塞，滑石能够发挥其滑利之专长解毛窍窘迫之围，为外邪遁逃打开门户。对滑石淡渗作用的认识，同样不可拘泥固有的观点，“滑石利六腑之涩结”，它能通利下焦膀胱及其他各腑，这只是一个方面。另一方面，因为滑石具有轻淡甘寒之性味，所以其药力最易渗透



肌腠之间，从而达到发汗、解肌、去邪的目的。至于发汗而不过汗，解肌而不伤气阴，是由于滑石的甘益气、补脾胃的作用，这是不难理解的。治疗外感，如果滑石与生石膏伍用，相得益彰，疗效更为突出。

近年来，无论治疗外感或是流感，刘氏在方中必用滑石，无不收效甚速。仔细玩味，无非外邪一从汗解，一从溲去使然。刘氏曾因外感发热，体温 38.4℃，自拟解表汤剂，方中重用滑石 30g，仅服 1 剂而告病愈，次日照常上班。看来，古人认为滑石“上开腠理而发表”，实为经验之谈，值得我们学习和实践。

重用石韦经验

石韦最早载于《神农本草经》，其性微寒，味甘、苦；归肺、膀胱经；其基本功效有利尿通淋，清肺止咳，凉血止血。多用于石淋、肺热咳喘、血热出血等。临床常用量为 6~12g。

李文瑞重用石韦治顽固性蛋白尿

名老中医李文瑞临床应用石韦一般用量 5~10g，重用 30~45g，最大用至 60g。李氏认为石韦具有利尿通淋、清热止血、消尿蛋白之功效。常在辨证方中重用。临床主要用于顽固性蛋白尿、肾炎、肾盂肾炎、泌尿系感染等。如治一女性 49 岁患者。患慢性肾炎，持续性蛋白尿 10 余年，均在 100~300mg/24h 以上。初诊时，咽干口渴，二便如常，双下肢微热，时或疼痛。舌淡红，苔薄白，脉细。尿蛋白为 300mg 以上/24h。证属湿热内蕴，迫及下焦。投予石韦 45g，白茅根 30g，茯苓、猪苓、葛根各 15g，鸡血藤 25g，甘草 3g。服 5 剂后，症减，尿蛋白 200mg/24h，遵原方石韦加至 50g。继服 1 个月，尿蛋白 <50mg/24h，多为阴性。

张志远重用石韦治结石

名医张志远亦善用石韦利尿排石，张氏以前对它的应用主要是取其利尿退肿之效，虽然亦不断以之治疗淋病，但大多局限在肾盂肾炎、膀胱炎、尿道炎方面，自马王堆帛书问世后，才开始单独试验石韦的确切疗效。治疗膀胱结石，张氏常每日用石韦 60g，水煎，4 小时 1 次，分 3 次服下，取得良好疗效。

张浩良重用石韦治咳喘

张氏认为石韦味苦沉降，入肺经，故可下气平喘。临床上每以次品为主，与玉泉散、瓜蒌、杏仁等治疗肺热咳喘；如肺经郁热咳喘则再加麻黄；如肺阴不足



者，则本品加北沙参、麦冬配伍；兼有气虚者，酌加人参、黄芪等。石韦止咳平喘，古已言之，现代科研亦证明其有祛痰止咳、下气定喘之功效，惟其性微寒，故用于肺热、肺燥者似为适宜，且其超出常用量倍数，方可建功，一般 5~10 岁者，可用 15~30g，成年人可用至 45~60g。至于寒饮伏肺者，似非所宜，或须适当配伍方可用之。

重用茵陈经验

茵陈最早载于《神农本草经》，其性微寒，味苦、辛；归肝、胆经；其基本功效有利湿退黄，清热解毒，疗疮。多用于黄疸、湿疮瘙痒、湿温、暑温、湿热带下等。临床常用量为 6~15g。

陈国恩重用茵陈治肝炎

通化市名老中医陈国恩认为，遣方用药，寒热虚实，辨证已明即应大胆用药。时感表邪宜轻量小剂，重症顽疾亦峻药攻坚，滋补药味可多，攻邪药量宜重。力求精兵简药，弹无虚发，这样既节约药物，又集中药力，且利于观察疗效，总结经验。陈氏每方药物多不超过 10 味，君药量重，多在 30~50g，并且注意效验价廉，很少使用缺货。如治疗急性黄疸型肝炎，自拟茵陈退黄汤：以茵陈 1250g，栀子 10g，大黄 10g，龙胆草 15g，红花 10g，白茅根 50g，柴胡 10g，茯苓 30g 组成。陈氏体会，茵陈为一年生草本植物，味苦性微寒，阳春三月，百草生发，山野村民常以茵陈嫩苗煮食代菜，味美适口，多食无碍。该药疗效确切，退黄迅速，非大剂量不可，成人每剂不少于 1000g，儿童不少于 300g。

曾治一李性男患，素体健康，1 周前食欲减少，恶心欲吐，困倦肢沉，面目色黄，伴胃脘不适，厌油腻，右胁隐痛，苔黄便燥，舌红苔黄而薄，脉弦数，口腔黏膜黄染，巩膜黄染，肝右肋下 2cm，质软，触痛。肝功化验：麝浊 7U，锌浊 14U，黄疸指数 25U，转氨酶 425U，碘反应 (+)，尿三胆 (+)，诊为湿重于热型黄疸，拟清热利湿退黄法。茵陈 1250g，栀子 15g，黄柏 10g，红花 10g，滑石 30g，木通 15g，龙胆草 10g，白茅根 100g，大腹皮 20g。水煎服。服药 16 剂，历时 18 天，肝功及黄疸指数均恢复正常，诸症悉愈出院。

甘聚珊重用茵陈治黄疸

陕西名老中医甘聚珊治疗肝病黄疸，每每重用茵陈，佐以丝瓜络。《温病条辨》



言：“湿之入于中焦，有风湿，有湿热，有自表传来，有水谷内蕴，有内外结合”，甘氏认为：病毒性肝炎之黄疸稽留不去者多是病久入络、湿聚气滞为患，唯使大剂苦寒之品，必致徒伤胃气，临床常用之茵陈系祛湿利胆之要药，表有湿者能微发其汗，里有湿者，可祛湿利尿，故表湿、里湿、寒湿、热湿皆可用，一般用 20g，多则 50~100g；丝瓜络可理气消瘀，疏通经络，二药相伍，可奏祛湿理气、通络之效。

重用金钱草经验

金钱草最早载于《本草纲目拾遗》，其性微寒，味甘、咸；归肝、胆、肾、膀胱经；其基本功效有利湿退黄，利尿通淋，解毒消肿。多用于湿热黄疸、石淋、热淋、肿疔疮、毒蛇咬伤等。临床常用量为 15~30g。

张琪重用金钱草治结石

国医大师张琪教授认为尿路结石治疗用清热利湿、涤石通淋法有一定效果。其机制是通过药物的利尿作用，增加尿流量，促进输尿管蠕动，有利于结石之排出。但据临床观察，这一治法的作用有一定限度。对结石停留于上尿路，特别是肾盂较高部位，体积较大者则效果不显。尤应重视的是，凡结石停留必使气血阻遏，而结石之排出又必赖气血之宣通以推动之。基于以上理论，张氏除用清利湿热之剂外，常伍以行气活血、软坚化积之品。一方面使气血畅通，另一方面使结石溶化，效果较好。不少病例结石年久固结不下，经用此法治疗，结石可以排出，有的病例出现结石溶解现象，化成小块随小便排出。自拟消坚排石汤，以重用金钱草为主药。处方：金钱草 50~75g，三棱 15g，莪术 15g，鸡内金 15g，丹参 20g，赤芍 15g，红花 15g，牡丹皮 15g，瞿麦 20g，篇蓄 20g，滑石 20g，车前子 15g，桃仁 15g，水煎服。

金钱草为治疗尿路结石之首选药。此药始见于《本草纲目拾遗》，谓：“性微寒祛风治湿热……治脑漏白浊热淋玉茎肿痛……”并未记载治砂石淋。近代始发现其有清热解毒、利尿排石、活血散瘀作用，故本方重用之为主药。张氏以此方治疗本病颇多，效果较为满意。

如治林某，男，48 岁，干部。1978 年 5 月 29 日初诊。自 1977 年冬，左侧肾区绞痛，发作痛甚剧，经 X 线摄片未显影，疑为栓塞。本年连续发作数次，入沈



阳某医院疑结石，来哈求治，脉沉，舌苔白，小便黄。处方：金钱草 50g，篇蓄 20g，瞿麦 20g，桃仁 15g，赤芍 20g，三棱 15g，丹参 20g，车前子 15g，木通 15g，莪术 15g，牡丹皮 15g，甘草 10g。服上方 6 剂，小便增多，尿出秫米大结石二块，痛大减。又经用上方 6 剂，小便排出泥沙样浑浊物，小便增多，疼痛未发作。于本年 6 月 26 日来本所医院住院治疗，连用上方 10 剂，又排出结石一块，如小豆粒大，尖端已酥，可能系药物所溶，排尿前小腹胀腰酸，结石排出后，症状即消失。又继服上方，连日来小便又排出泥沙样物质甚多。嗣后小便转清，疼痛未作，停药而愈。

第五章 温里行气、消食驱虫药

重用附子经验

附子最早载于《神农本草经》，其性大热，味辛、甘；归心、肾、脾经；其基本功效有回阳救逆，补火助阳，散寒止痛。多用于亡阳证、寒凝诸痛证、水肿等。临床常用量为 3~15g。

张子琳重用附子治亡阳证

山西名医张子琳在其经验集中论述，附子乃起死回生之品，但必须用之得当，吾父常以大量附子治病救人，剂量常在 30~60g，屡见奇效。尝说：“附子，要么不用，用则重用，量少则起相反作用。”何意？附子乃下焦药也，量少不能重坠下沉，反在上焦起火。另须注意者，附子煎剂宜冷服，取寒因寒用，反治之法。若热饮，易在上焦停留而产生不良反应，出现嘴麻、舌麻，继之浑身皆麻。但遇此亦无需惊慌，饮凉开水多能解之，或时过半日便自然缓解。附子之适用证是脉必沉迟，唇甲黑青，脉证相合，放胆使用，疗效可靠。

近代的中医名家如陈伯坛、刘民叔等，均很擅长遣用附子，认为其能救脱扶阳，每剂常 30~90g，最大量超过 200g，这可能与地处西南部环境、体质、气候、习俗有密切关系。另外，大剂量的运用在煎服方法上亦有讲究，一般先煎 2 小时以上，将所含毒性成分破坏，补火温里的作用并不随之而减弱，仍可发挥回阳的功效。

况时祥重用附子治重症肌无力

贵阳中医学院第二附属医院况时祥教授每每重用附子治疗重症肌无力获得良效。况氏尝言：附子味辛甘，性热，为疗阳虚之佳品。《本草汇言》曰：“附子，回阳气，散阴寒，逐冷痰，通关节之猛药也。”故阳虚证必用附子，辨证要点为精神不振，面色淡白，畏寒肢冷，腹痛喜暖，少气乏力，口淡不渴或渴喜热饮，大便溏薄，小便清长，舌淡嫩，脉微细或沉迟无力等，有一二症即可，不必悉具。



用量 10~50g，煎煮 1 小时以上，先武火后文火，既消减乌头碱之毒，又不减温阳之力。

李继昌重用附子治寒痹

附子作为散寒止痛药，临床一般用量为 3~15g，但对于顽固性阴寒痹证，云南名医李继昌则认为一般常规量不效，可用至 30~120g，先煎透（1 小时左右），疗效显著。

邹云翔重用附子治水肿

江苏著名肾病专家邹云翔教授认为，对脾肾阳虚、水湿泛滥所致的慢性肾阳水肿，治疗重在温补肾阳，方用附子理苓汤和济生肾气丸加减。其中附子、桂枝不可少，可重用附子。附子剂量可用至 30~60g，但需久煎 2.5 小时以上，去其毒性而存其温阳之效。

吴佩衡重用附子经验

云南名医吴佩衡教授以善用附子闻名，吴氏处方每剂附子辄用 60g，重则每剂 250~500g。对疑难重症，失治、误治病例，每起沉疴。

吴氏对血证的治疗，认为需熟记以下二诀，细心体会，弄通含义，则可应付裕如。其一曰：“失血都传止血方，生军六味作主张，甘寒一派算良法，并未逢人用附姜。”其二曰：“血水如潮本阳亏，阳虚阴盛敢僭为，人若识得升降意，宜苦宜辛二法持。”（原载清代郑钦安著《医法圆通》卷四）

一者言其常，治出血之法，如唐容川谓“泻心即是泻火，泻火即是止血”，葛可久创十灰散亦多清凉之药。所以泻火滋阴已成为治血证常法。一者言其变，郑氏原注云，宜苦者十之一二，宜辛者十之八九。此言未免过偏，但对用常法治疗无效的病例，宜按阴阳升降气血运行的道理，采用辛温药物，温阳止血，亦可立竿见影。如吴氏前治伤寒肠出血病例，附子每剂重用到 300~400g，而终于力挽狂澜，阳回血止而安。多年来，其学术传人用温阳止血法治疗葡萄胎术后疑恶变咯血、崩漏不止，取环后反复清宫不能止血，高血压并痔疮出血不止，以及呕血、便血、尿血、衄血等病例，辨证属阳虚者，均获满意效果。阳虚出血的辨证要点为血证而兼见面色淡白无华（或夹青色），少气懒言，声低息短，自汗食少，畏食酸冷，形寒初冷，手足厥逆，溺清便溏，口不渴或渴喜热饮，舌质淡或舌质夹青，舌苔白滑或白腻，脉象沉、迟、细、弱、弦、紧等。

温阳止血之药颇多，而附子大辛、大温，有毒，通行十二经，为温阳止血之要药。《神农本草经》载附子性能回阳救逆，散痼冷沉寒，除风湿痹痛，原非止血专药，乃用其温肾回阳而止血。临床使用此药，习惯于开水单独先煎透，以口尝



不麻为度。如此剂量即使每剂达 300~500g，亦无中毒情况，可以放心使用。

李文瑞重用附子治男子不育

名老中医李文瑞临床应用附子一般用量 3~10g，重用 15~25g，最大用至 35g。李氏认为附子大辛大热，温肾壮阳力强。达逐寒生精、化浊行水、宣痹止痛之功效。临证贴切，则需重用。但宜逐渐增量。重用时，更应延长煎煮时间，以去其大毒。常在天雄散、真武汤、桂枝加附子汤等方中重用。临床主要用于男子不育、甲状腺功能减退症、风湿性关节炎、类风湿关节炎等。如治一男性 32 岁患者。婚后 3 年未育，女方检查未见异常。行精液常规检查：精子活动度 >0.15 ，精子数 $>0.23 \times 10^9/L$ ，异常精子 0.15。自诉精液清稀，阴部微冷，余如常。舌淡红，苔薄白，脉细弦。证属肾阳不足，阴寒内盛。遂予天雄散加露蜂房，制附子首用 10g，服 7 剂后，无明显不适。之后逐渐加至 25g。连续守方服用 45 天后，复查精子数增至 $>0.68 \times 10^9/L$ ，异常精子 0.07，精子活动度 0.75。遵原方加减配成蜜丸以巩固疗效。1 个月后告知其爱人已怀孕。

白清佐重用附子经验

著名中医学家白清佐临证善用附子，每以重剂而获良效。白氏临证中，附子配任之法，约有如下数条：附子配鹿茸，补阳填精，阳痿滑泄者宜；附子伍肉桂，补火力强，以治阳衰肢厥；附子配干姜，温中调脾；得肉豆蔻温脾燥湿，涩肠止泻；附子配参、芪，大补中气，参、芪重用，其效尤著；附子配半夏，温中降逆，寒呕能已；附子配桂枝、白术，温经通络，善治寒湿痹痛；得延胡索、木香，温暖肝肾，治寒痛腹痛；附子配当归，温通血海，冲任虚寒，经水不调者宜；附子配腊茶，清热助阳，对于真寒假热、阴盛格阳之证，每奏奇功。

白氏用附子，特重两点：一曰认证，凡确属三阴寒证，阳气衰微，脾湿肾寒者，必用附子。二曰知附子之性，附子大辛大热，能破阴回阳，生者驱邪优胜，熟者补虚为佳。举凡阴寒弥盛，地气盖天，阳气竭绝之寒证，必用附子。盖附子气味雄厚，有斩关夺将之能，直入命门，盖火之原，使神机活跃，追复散失之元阳。此仲景急温之法，起死回生之妙术也。若不识此理，因循失治，阳气耗散，纯阴用事，死期已至，纵有神丹，亦弗能救，此非死之于病，乃医之咎也。当阳微欲绝，神去魂存之际，非唯用附子，且当用生者，而其量重在一两之上为宜。白氏临床常用附子，初用量小，继则量大，遇阴寒重症，附子之用量辄以两计，甚者用至三四两，并伍大剂姜桂，极见功效。

如治一寒厥。李某，会计。患伤寒，四肢厥逆，昏不识人。诸医皆谓邪入心包，热源厥深，投以辛凉苦寒之剂，非唯不效，且日益加重，其妻邀白老诊治。



观其面灰舌淡，牙齿清润，小溲白而失禁，四肢厥冷如冰，脉沉微欲绝，询知前医皆用寒凉之品，于是断为寒厥，群阴用事，汨没真阳，当用附子、姜、桂，温补命门，回阳救逆。遂急以生附子 60g，干姜、肉桂各 15g，甘草 9g，加水久煎，候温，缓缓服之。1 剂尚未知；2 剂则神识少清，四肢能动，阴邪开始溃退，于是易生附子为熟附子；又服 3 剂后，神清肢温。病势大减，继以温调脾胃之剂，调理月余而愈。

又如治一臌胀。胡某，太原某厂。高度浮肿，并伴发严重之胸水和腹水。身恶寒，四肢不温，大便溏，舌淡，脉沉细。诊为阳虚火衰，不得温运脾阳，湿渍太阴而成臌胀。治宜攻补兼施，标本同治。方用附子 45g，党参 30g，肉桂、桂枝各 15g，白术 24g，温补脾肾之阳，并以甘遂、槟榔、二丑、玄明粉为散剂，攻逐有形之水。服药后 6 日间，水泻 74 次，体重由 134 斤减为 102 斤，胸水、腹水全消。继用大剂补中益气汤加茯苓、泽泻之属，并吞服硫黄丸而愈。

重用陈皮经验

陈皮最早载于《神农本草经》，其性温，味辛、苦；归胃、肺、脾经；其基本功效有行气宽中，燥湿，化痰。多用于脾胃气滞证、呕吐、呃逆、湿痰、寒痰咳嗽、肝气郁滞证等。临床常用量为 3~9g。

王吴启重用陈皮治乳腺增生病

王氏擅用重剂陈皮治疗乳腺增生病，其自拟陈皮汤：陈皮 80g，夏枯草 30g，王不留行 30g，丝瓜络 30g，随证加减，治疗乳腺增生效果满意。吴氏认为，乳腺增生之患，气血易理，痰邪难除，故非重剂不能胜任。陈皮汤中王不留行活血通经，消肿止痛；夏枯草清肝热，散郁结；丝瓜络通络化痰消肿；尤其重用陈皮，既有健脾燥湿之功，以绝痰湿生化之源，更有理气散结，以消痰核之效，其性虽温，与夏枯草相伍，并无伤阴耗气之弊。

罗舜达重用陈皮治乳腺增生病

罗氏运用柴胡疏肝汤重用陈皮治疗乳腺增生病，表现为乳房胀痛或放射痛，女性随月经期变化，经前痛著，经后减轻，体检时可扪及单个或数个结节或带状包块，边界不清或部分清楚，活动不粘连。中医辨证属于肝郁痰凝者，症见心烦易怒、失眠多梦、情绪急躁、乳房胀痛、舌苔薄白、脉象弦滑。属于冲任失调者，



伴有月经不调，腰痛乏力，经量少而色淡，或闭经，舌苔淡红，脉弦细或沉细。方拟柴胡疏肝汤重用陈皮：陈皮 30g，柴胡 12g，川芎 10g，香附 10g，枳壳 6g，赤芍 10g，甘草 6g。属于肝郁痰凝者加郁金 10g，石菖蒲 10g，茯苓 15g；属于冲任失调者加当归 10g，续断 10g。3 剂为 1 疗程，一般 2~3 个疗程即可。

罗氏临床体会，柴胡疏肝汤有疏肝解郁、行气止痛等功用，把陈皮加大为每剂 30g 时，效果佳，一般 1 个疗程即可见效，是一个简单易行且有效的治疗方法。

周海平重用陈皮治痛泻

舟山市名老中医周海平主任中医师运用痛泻要方治疗肝郁脾虚痛泻症喜重用陈皮。肝郁脾虚痛泻症临床表现为：不明原因肠鸣腹痛，大便泄泻，泻必腹痛，舌苔薄白，脉弦缓。治宜疏肝健脾，缓急止痛。周氏拟痛泻要方加味方治之，基本方药物组成：陈皮 15~20g，白术、白芍、防风各 10g。每日 1 剂，5~7 天为 1 疗程。周氏认为：肝郁脾虚痛泻症主要病因为肝郁，肝失疏泄，而陈皮系理气药，具疏泄之功，且具醒脾之效，所以重用得以取效。然本品辛散苦燥，温能助热，舌红少津、内有实热者慎用。

如治刘某，男性，52 岁。2006 年 9 月 28 日初诊。患者自诉经常感觉到突然间不明原因大便泄泻，泻必腹痛，纳食欠香，反复发作，持续半年余，舌质淡、苔白腻，脉弦。治宜疏肝健脾祛湿。拟痛泻要方加味：陈皮 20g，焦白术、白芍、防风、藿香、佩兰各 10g。每日 1 剂，水煎服。5 剂。10 月 2 日二诊，痛泻减轻，纳差未已。上方去藿香、佩兰，加薏苡仁 24g，炒扁豆 15g。继服 5 剂。服后腹痛腹泻消失。随访 2 年，痛泻不再发作。

重用川楝子经验

川楝子最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦；归肝、胃、小肠经；其基本功效有行气止痛，疏肝泄热，驱虫，止痒。多用于脘腹、两胁胀痛、热淋、石淋、蛇串疮、疝气痛、睾丸偏坠痛、虫积腹痛等。临床常用量为 4.5~9g。

张琪重用川楝子治胃痛

国医大师张琪教授治疗胃脘痛属于肝气犯胃、胃失和降之证者，治以疏肝和胃为法。凡疏肝之药，不宜温燥，因肝为刚脏，即《内经》所谓“将军之官”。怒伤肝，肝郁化火，阳易亢，阴易亏。但滋阴药又碍脾，脾为土脏，喜燥恶湿，肝



气犯胃，每多化热伤阴，故用芍药以柔肝抑肝，平肝之阳以益肝之阴。肝气平则脾不受侮，《本草纲目》所谓“土中泻木”即指此而言。

川楝子又名金铃子，本草载入肝胃小肠经，性味苦寒。“泄肝止痛，治热厥心痛”。《中药学》谓：川楝子有毒，成人一次服 6~8 个即可引起头晕、呕吐、腹泻、呼吸困难、心跳、震颤、痉挛等症，而张氏在临证中以川楝子为主配合治疗肝气犯胃作痛，常重用至 30g（砸碎煎）。不仅未见有中毒反应，而且每获卓效。香附、陈皮疏肝和胃，白术健脾胃，合之为治疗肝胃不和之有效方剂。

重用枳壳经验

枳壳最早载于《神农本草经》。其性微寒，味辛、苦；归脾、胃、大肠经；其基本功效有破气消积，化痰除痞。多用于胃肠积滞、湿热泻痢、胸痹、结胸、气滞胸胁疼痛、内脏下垂等。临床常用量 3~9g。

关思友重用枳壳治胃下垂

河南安阳名医关思友治疗胃下垂属中气下陷者，每投以补中益气汤重加枳壳（枳实）、全蝎，临床运用体会，其疗效较单纯用补中益气汤为佳。

如治王某，女，55 岁，1999 年 10 月 14 日诊。自述两胁胀满、紧束已月余，就医时诊为肝气郁滞，曾服柴胡疏肝散合金铃子散加减数剂，鲜效，刻下：食欲不振，胃脘隐痛，两胁胀满、紧束，时轻时重，喜叹息，舌质淡紫，苔薄黄，脉沉无力。病因缘于 3 天前，婆媳争吵所致。审视脉证，脉与肝气郁滞不符，乃疑而细询，告曰：食后两胁胀满、紧束，站立时加重，平卧时症状若失。忽悟之，遂嘱 X 线钡剂透视，报告胃底位于两髂嵴连线下 5cm。于是辨证辨病结合，诊为肝郁脾虚，中气下陷，治宜补中益气，升阳举陷。书方：黄芪 30g，陈皮 12g，升麻 12g，柴胡 12g，党参 30g，甘草 12g，当归 24g，枳壳 18g，炒白术 25g，全蝎 5g（冲服）。3 剂，水煎服。二诊时，两胁紧束感减半，脘痛消失，药已中的，效不更方，上方略事加减，共服药 20 剂，症状消失，一如常人。复经 X 线钡剂透视，报告胃底位于两髂嵴连线下约 1cm。为巩固疗效，改服补中益气丸以资善后。

关氏认为，胃下垂投补中益气汤加枳壳或枳实、全蝎，疗效比单用补中益气汤好。据临床观察和文献报道，枳壳和全蝎对脏器弛缓有紧上固下的功能，但是用量是个关键，一般说来，枳壳须用 15g 以上，全蝎须用 5g 以上，全蝎研面冲服



较之入煎，药效宏专。

陈国恩重用枳壳经验

通化市名老中医陈国恩治疗胃下垂、子宫脱垂、脱肛等病，常于补中益气汤中加入大剂量枳壳，疗效满意。陈氏认为脏器下垂多中气不足，升提无力所致。中气虚则气机不畅，气滞中焦，愈积愈滞，升举愈难，重用枳壳宽中行气，气行满除，中气通畅，下垂自可上收，一般用量均在 50~100g，无任何不良反应。

靳锋重用枳壳治疗胃下垂

靳氏遵近代医家蒲辅周提出的“气以通为补，血以和为补”之旨，认为气血之性宜动不宜静，能助气宣通流动者即能补气，能助脾运化者亦能补脾。单纯补气是不够的，要使气行，气行则脾旺健运。所以在补中益气汤中加用枳壳并重用之，使中焦气机调畅，清升浊降，胃则自然复其本位。枳壳剂量 10~60g，突出一个“运”字，对胃脘胀满者、腹部胀满者，只要是脾虚不运使然，皆可在所选方中重用枳壳而收功。

如治李某，女，40 岁。患者胃脘间断性疼痛 5 年，加重 1 周。曾在外院做消化道钡透，提示胃下垂，十二指肠球部溃疡。患者常感胃脘胀满疼痛，呃逆，泛酸，服三九胃泰、香砂养胃、西咪替丁等药物后虽有缓解，但胀满难消，日益加重。入院时症见：胃脘胀满作痛，甚则掣背，尤以食后胀满为甚，呃逆，口干，泛酸，纳差，二便调，舌淡，苔白，脉弦细。查：精神较差，面色萎黄，形体消瘦，腹软，剑突下压痛。上消化道钡透示：胃下垂（胃小弯弧线在髂嵴连线以下 6cm），十二指肠球部溃疡。辨证为脾胃虚弱，中气不足，摄纳不力，升举无能。治宜：健脾益气，调气运脾，方用补中益气汤加味。黄芪 30g，党参 30g，白术 10g，升麻 3g，柴胡 3g，陈皮 10g，当归 10g，枳壳 45g，赭石 15g，甘草 6g，水煎分 2 次服。3 剂后患者即感胃痛明显减轻，胃脘坠胀若失，泛酸减轻，饮食增加。效不更法，继服 7 剂，呃逆、泛酸已止，上方去赭石加枳壳至 60g，继服半月，临床症状全部消失，精神和食纳好转。遂复查上消化道钡透提示胃体已上升 3.5cm。嘱其加强腹肌锻炼而出院。

重用山楂经验

山楂最早载于《神农本草经集注》，其性微温，味酸、甘；归肝、胃、脾经；



其基本功效有消食化积，活血化瘀。多用于饮食积滞、泻痢腹痛、疝气痛、瘀阻胸腹痛、痛经、产后瘀血腹痛、恶露不尽等。临床常用量为 10~15g。

刘绍勋重用山楂治高血压

辽宁名老中医刘绍勋认为，山楂含有大量维生素 C，能扩张血管，有明显的降压作用，并能治疗和预防冠心病。经过临床观察，认为剂量少于 30~50g，降压作用不甚显著，但如用量过大，反而会使患者胃酸增多，这又不利于某些脾胃虚弱的病人，因此应以 30~50g 为基本用量。

曾治杨某，女，63 岁。1974 年 3 月就诊。主诉患高血压病已有 2 年，曾坚持服用中西药，疗效仍不巩固。现有头晕、眼花、耳鸣、口苦、目眩等症状。血压 200/100mmHg。舌赤少苔，六脉弦数。此乃肝胆郁热、肝阳上亢所致。拟用清肝泄热、育阴潜阳法，佐以扩张血管药。方药：山楂 50g，沙参 30g，五味子 20g，麦冬 30g，牛膝 30g，钩藤 50g，生石膏 30g，黄芩 15g，蝉蜕 20g，全蝎 10g，夏枯草 20g，草决明 50g，益母草 50g，白茅根 50g，龙胆草 10g，菊花 20g，鳖甲 20g，龙牡各 60g。服药 2 剂，诸症俱减，嘱其继服原方 4 剂，血压降至 140~150/90~100mmHg。效不更方，该患又服原方 10 剂，头痛、眩晕、耳鸣等症基本消失，血压降至 140~150/90~98mmHg，病情已趋稳定。嘱其间断服药，以资巩固疗效。

刘氏运用清热降火法治疗高血压病，用的是自拟“平肝降压汤”。主要药物有山楂、草决明、夏枯草、钩藤、菊花、牛膝、沙参、赭石、麦冬、五味子、生石膏等。此方不是治疗各种类型高血压病的通用方剂，仅对肝阳上亢型的高血压症有较好的效果。在刘氏经治的百余例高血压患者中，属于肝阳上亢者，绝大多数疗效较好，本方即以重用山楂为君药而收功。

重用麦芽经验

麦芽最早载于《药性论》，其性平，味甘；归肝、胃、脾经；其基本功效有消食健胃，回乳消胀。多用于食积停滞、断乳、乳房胀痛、疏肝解郁等。临床常用量为 10~15g。

陈树森重用麦芽断乳

上海名老中医陈树森创回乳方断乳，方以炒麦芽 50~100g，每天 1 剂，煎汤



日3次分服，或去皮研细末，每服15g，日3~4次，开水调服。连服6~7天。适应于产后不哺乳或断乳，乳房发胀者。乳房胀痛者加柴胡10g，青皮10g，红肿者加蒲公英30g；同时外用芒硝适量装纱布袋中敷局部则更好。

麦芽本为消麦面食积之药，用以回乳起始于元《丹溪心法》，清《医宗金鉴》谓：“无儿食乳欲断，炒麦芽汤频服宜。”用本方回乳安全有效，无任何副作用。

如治尤某某，女，28岁。1985年10月18日就诊。产后2个月，因乳腺发炎泌乳不畅，乳房胀痛，不能继续哺乳。乃予本方服之，连服4天后，乳房松软，胀痛大减，1周后泌乳停止，胀痛全消。

李历城重用麦芽断乳

山东名老中医李历城擅用炒麦芽回乳。论炒麦芽治回乳，早在《丹溪纂要方》《薛立斋医案》中有记载，一直沿用至今，为断乳之良药。然临证中，其效果全然不一。有的得心应手，效如桴鼓；有的如泥牛入海，全无消息。李氏临证摸索，认为其中存在一个药量和煎制法问题。炒麦芽断乳，取效快的关键在于用量要大，煎制法为：取生麦芽180g，微火炒黄（注意一定要即时炒，即时用），置砂锅中，加水1000ml，煎至500ml（先文火后武火，煎煮时间需20~30分钟），滤出头汁，复加水800ml，煎至400ml，将两次煎的药物兑在一起，分2次温服，服后令微汗出。近年来，李氏治疗百余人，均为2剂服完，即告痊愈。

朱良春重用麦芽疏肝

国医大师朱良春亦指出：大麦芽又为疏肝妙药。但疏肝之药，率皆辛温香燥升散，故只可暂用，不可久用，宜用小量，不宜大量。尤其是肝病日久，肝阴不足，又兼肝郁气滞者，不疏肝则无以行滞，疏肝则香燥之药难免伤阴，昔魏玉璜有见于此，而拟一贯煎一方，于甘润之中加川楝子一味，川楝子虽能泻肝行气，细究之犹不免苦寒伤中之弊。唯大麦芽疏肝而无温燥劫阴之弊，虽久用、重用亦无碍，而且味甘入脾，其性微温，不仅不败胃，而且能助胃进食，大得“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”之妙。朱老治慢性肝炎，肝阴不足，症见爪甲少华，口燥咽干，烘热肢软，纳谷不馨，食后胀闷不适，大便干结，两胁胀痛，舌红、苔少，脉细数者，亦常用一贯煎加减，多以生麦芽易川楝子，药如枸杞子、北沙参、麦冬、何首乌、木瓜、蒲公英、生麦芽、生地黄、黄精、鸡血藤等。如肝火炽盛之目赤、烦躁不安、胁肋胀痛，当用川楝子以泻肝止痛者，亦必加大量生麦芽以为辅佐。生麦芽用量以每剂30g为宜。



重用莱菔子经验

莱菔子最早载于《日华子本草》。其性平，味辛、甘；归脾、胃、肺经；其基本功效有消食行气，降气化痰。多用于食积气滞证、催吐痰食、咳喘痰多、胸闷食少、降气通便等。临床常用量为 6~10g。

江尔逊重用莱菔子经验

四川经方大家江尔逊教授善于重用莱菔子，如治疗便秘、不寐、癰肿等病症，均奏良效。临床使用莱菔子，应严格区分炒用与生用，因两者之功效迥然有别。

1. 炒莱菔子重用：降气通便，豁痰宁神

(1) 降气通便：江氏长期验证，炒莱菔子降气除胀之力类似枳实、厚朴，而降气通便之力则优于枳实、厚朴，故可用于各种实秘。因本品辛甘平，质润多脂，降气开郁而不伤阴，若加入辨证方药中，又可用于各种虚秘。如临床常见的习惯性便秘，多因脾阴不足，肠燥津亏。此证初服麻子仁丸有效，久服则效差甚至无效。乃因麻子仁丸中有大黄、厚朴之苦燥，久用之，伤阴化燥在所难免。江氏治此等虚秘，喜用《伤寒论》之芍药甘草汤，常用量为白芍 30~50g，生甘草、炙甘草各 5~10g，以大滋脾阴，再加草决明、肉苁蓉各 30g 润肠通便，疗效颇佳。但遇少数顽固性便秘用之乏效时，必暂加炒莱菔子 30~50g 降气开郁，奏效方速。

临床见有小儿便秘者，大便坚如羊矢，便时哭闹，又艰于服汤药。治此者，可将莱菔子炒熟，捣细。1~3 岁，每服 3g；4~7 岁，每服 5g。开水调成糊状，兑少许白糖，每餐前顿服，3~4 日即见效。

(2) 豁痰宁神：不寐一症，病因病机多端，而以痰热扰心为常见。治此症一般用黄连温胆汤加味，疗效可靠。但若连服数剂不见起色者，可能是痰甚且顽。元代医学家朱丹溪说：“莱菔子治痰，有冲墙倒壁之功。”故可中加莱菔子豁痰以宁神。如白某，女，37 岁，失眠 1 年余，常服朱砂安神丸、天王补心丹等中成药，仍难入眠，每隔几夜，必服西药安定片才能勉强浅睡三四个小时。平时头晕胸闷，舌红苔黄腻，脉滑稍数。笔者用黄连温胆汤加胆南星、天竺黄、石菖蒲、远志等 4 剂，仍无显效。乃加炒莱菔子 30g，又服 4 剂，睡眠明显改善，效不更方，再加炒酸枣仁 10g（轧细吞服），续服 18 剂，睡眠质量进一步改善，丢掉安定片。



2. 生菜菹子内服催吐痰食，外用解毒消肿

(1) 催吐痰食：《日华子本草》称莱菹子“水研服，吐风痰”。但用水研服，很不方便，水煎服可否？江氏无病时曾尝试用生菜菹子 30g，捣破，水煎 40 分钟，滤取药液约 200ml，顿服。服后约半小时，便觉头晕，胃脘不适，呕恶欲吐。而后笔者催吐风痰或宿食，便单用生菜菹子一味，水煎顿服。

如治陆某，男，66 岁。宿患慢性支气管炎，因外感诱发，气喘痰鸣。已服小青龙汤加味数剂，外感已除，仍咳嗽气急，喉如曳锯，胸膈满闷，苔白厚腻，脉滑数，予生菜菹子 50g，捣破，文火煮沸 1 小时，滤取药约 200ml，顿服。服后约半小时，呃呃连声，频频咳吐黏涎，移时达半痰盂。咳喘痰鸣、胸膈满闷随之大减。转予香砂六君子汤合三子养亲汤，连服 6 剂，渐渐康复。

又曾治张某，男，16 岁，因吃汤圆及干鱼片过多，胃脘满闷，噎腐呕恶，头晕目眩，西医授以“饥饿疗法”，已两餐未食。又服多酶片、山楂丸等亦不效。予生菜菹子 50g，煎服法如前，服后不及 1 小时，便频频呕吐，并泻下酸臭粪便，胃脘顿觉轻松，转以七味白术散善后。

然而当今有的药房备用的莱菹子，竟有生与熟不分者。而其始作俑者，或为近代名医张锡纯先生。张氏认为莱菹子“无论或生或炒，皆能顺气开郁，消胀除满”。笔者曾数次试验：于辨证方药中加生菜菹子 15g，脾胃虚弱者服后多有恶心欲吐之感。可见张氏不分生熟混用之说，不足为训。

(2) 解毒消肿：《日华子本草》谓莱菹子“同醋研，消肿毒”。江氏亦曾验证之。一学生，男，18 岁，左腋下忽生一疔，皮色不变，肿痛灼热，西医诊为“腋下淋巴结炎”，肌注青霉素，外敷鱼石脂，3 日乏效，患者左上肢活动受限，夜间灼痛难寐。予生菜菹子 300g，捣极细，用适量食醋调成糊状，摊在塑料薄膜上（厚约 0.5cm），敷于患处，外敷纱布，再用胶布固定，一日一换；同时内服柴胡清肝散合五味消毒饮。敷药当晚疼痛灼热大减，连敷 4 天，疔肿全消。又曾用食醋调生菜菹子细末，外敷产后乳痈（急性乳腺炎），效亦佳良。

马山重用莱菹子治高血压

马氏临床应用莱菹子治疗高血压病，常获较好疗效。单纯性高血压病，取菊花 10g，泽泻 30g，丹参 30g，莱菹子 30~40g，钩藤 15g。水煎服，一般 7~15 剂即可见效。高血压合并冠心病患者，在辨证基础上加莱菹子 30g。女性因病过早切除子宫或摘除卵巢，内分泌失调，有部分病人可致高血压，重者可引起中风脑出血，预后不好。这类高血压病人，中西药降压效果均不理想。马氏在调补肾阴肾阳基础上加莱菹子治疗，获得很好的降压效果。



消化系统、呼吸系统疾病伴有高血压者，莱菔子为必用之药。因本药除有降压作用外，还可消积化食，除痞满，止咳化痰。如慢性浅表性胃炎或萎缩性胃炎伴有高血压者，在辨证治疗时加莱菔子，可消食化积，理肠止泻，降血压；哮喘病伴有高血压加莱菔子，降肺气，理大肠，止咳平喘，降血压，均起到双重治疗作用。

马氏认为，高血压患者保持大便通畅很重要。便秘病人胸腔、腹腔压力升高，全身紧张，烦躁不安，加重血压升高，这时服降压药疗效甚微，常诱发冠心病、脑血管病发作。大便通畅，全身放松，适当配合降压药物的治疗，常获较好疗效。故用莱菔子调理肠胃功能，排气通便，同时有良好的降血压作用。降血压常用量为 30g，重者 40~50g，未见不良反应。

重用南瓜子经验

南瓜子最早载于《现代实用中药学》。其性平，味甘；归胃、大肠经；其基本功效为驱绦虫。多用于绦虫病、前列腺增生等，临床常用量为 30~120g。

孟景春重用南瓜子治前列腺增生

南京中医药大学孟景春教授用炒熟南瓜子治前列腺增生获良效。孟氏指出，南瓜子，是从菜场中购买的南瓜，取出子后去瓢，洗净晒干，炒熟后食用。它不是炒货店所售白色粒大的瓜子。服用方法：炒熟后，每天嚼服 100g，嚼服时一定要连壳吞下，吐壳则效果欠佳。连续服用 1 周后，即见效果。见效的标志即夜尿次数减少，小便时亦较通畅。服至 1 个月，症状明显改善，若进行 B 超检查，增生的前列腺可见缩小。连续服用，一般无不良反应。老年人若牙齿脱落，嚼服不方便，可加工磨成粉剂，然后分数次用开水送下。但每天一定要服满 100g，少则影响疗效。也有人将南瓜子炒熟后，装在瓶内随身带着，当零食吃。虽然服法不同，但服用量和带壳的食用法不能变。

刘弼臣重用南瓜子治绦虫病

刘氏临床上多采用南瓜子、槟榔合剂以治疗绦虫病，对绦虫有麻痹作用，是目前治疗绦虫病较好的方法，治愈率可达 90% 以上。用法：生南瓜子 100~200g，槟榔 100~200g，先将生南瓜子捣碎，早晨 1 次空腹服下，隔 1 小时后即服槟榔煎剂，约 2 个小时后即腹泻排虫，如无腹泻，可用泻药助泻。驱虫时应注意将头



部祛出，否则，未达到治疗目的。因此在服驱虫药后，当虫体排出时，应坐在温水盆中，使虫体自然排出，也不能用手牵拉以免折断。要仔细检查虫体，发现头节，才算治疗有效，否则，2周后再重复治疗。驱虫后必须健脾养胃，以助恢复。

吴子腾重用南瓜蒂治流产

吴氏对习惯性流产之治疗，首重补脾气、温肾阳，再用养血、滋阴、调气、柔肝之法随证治之。药物重用炙黄芪、菟丝子、川续断、杜仲、白术一类。并当用老南瓜蒂入药，取其益肾补气、壮胎元之力最著。每遇此证，常用老南瓜蒂30~60g，煎水代茶，予患者临产前几个月服之。可嘱病家事先收蓄，每治一个病人，常需数斤之多。曾治一30余岁的王姓妇，结婚10余年，已堕四胎，屡服补肾养血之品，往往至五六个月时而胎堕。适孕第五胎时延余诊治，其脉细软而尺迟，舌淡苔白燥。予炙黄芪30g，菟丝子、炒杜仲各20g，生地黄炭15g，白术8g，南瓜蒂60g。嘱自第3个月开始，每月服6剂，服至第7个月时停药，即用老南瓜蒂30g，每日煎水代茶。足月生一男婴。

第六章 止血、活血化瘀药

重用槐花经验

槐花最早载于《日华子本草》，其性微寒，味苦；归肝、大肠经；其基本功效有凉血止血，清肝泻火。多用于血热出血证、目赤、头痛、腹泻等。临床常用量为 10~15g。

孙文亮重用槐花治血栓性静脉炎

孙氏临床上在治疗血栓性静脉炎时，常重用槐花，取得满意效果。

如治张某，男，46 岁，2000 年 5 月 3 日初诊。主诉：双下肢反复出现硬条索状物 3 个月，伴针刺样疼痛，局部灼热，可自行缓解，遗留棕褐色色素沉着，无脱屑，无瘙痒，随后又在他处出现。此起彼伏，呈游走性。但不伴有关节痛，与天气变化无关。双下肢皮下浅静脉有多处呈条索状，长短不一，1~8cm 不等，稍微隆起，按之硬紧，且与皮肤粘连，颜色发红，皮温高，压痛明显。实验室检查：血常规正常，血沉 12mm/h。舌质红有瘀斑、苔薄黄，脉涩。西医诊断：血栓性浅静脉炎。中医诊断：恶脉。辨证为湿热蕴结，瘀阻脉络。治以清热解毒，活血通络，方选四妙勇安汤加味。处方：槐花 90g，金银花 30g，玄参 15g，当归 15g，生甘草 12g，全蝎 3g（研末冲服）。水煎服，每日 1 剂，连续服用 21 剂而痊愈。随访 2 年，未见复发。

又如治李某，女，38 岁，2001 年 9 月 19 日初诊。主诉左小腿肿胀、疼痛 5 天。检查：左小腿水肿，按之凹陷，有韧性，皮温略高，左小腿后侧压痛，直腿伸踝试验阳性，腓肠肌压迫试验阳性。多普勒超声检测：左小腿深静脉阻塞。既往健康，无心、肝、肾等疾患。刻诊：小便黄，大便干，舌质红、苔黄腻，脉弦数。西医诊断：左小腿血栓性深静脉炎。中医诊断：股肿。辨证：湿热下注。治以清热利湿，活血化瘀，方用槐花浮萍汤加减。药用：槐花 60g，浮萍 15g，黄芩 15g，茯苓 15g，红花 12g，白鲜皮 12g，牛膝 15g，车前草 15g，金银花 15g，甘



草 10g。每日 1 剂，水煎分早、晚 2 次服用。药进 5 剂，症状缓解，继服 3 剂，诸症消失，随访未复发。

孙氏临床体会，治疗血栓性静脉炎时，槐花宜大，方可取得速效，其用量一般在 30~120g。

重用白茅根经验

白茅根最早载于《神农本草经》，其性寒，味甘；归肺、肝、胃、膀胱经；其基本功效有凉血止血，清热利尿，清肺胃热。多用于血热出血证、胃热呕吐、肺热咳喘、水肿、热淋、黄疸等。临床常用量为 15~30g。

张锡纯重用白茅根治水肿

张锡纯在《医学衷中参西录》所载白茅根汤中对白茅根利水消肿有明确、具体的说明，他说：“治阳虚不能化阴，小便不利，或有湿热壅滞，以致小便不利，积成水肿，白茅根一斤，掘取鲜者，去净皮与节间小根，细切，将茅根用水四大碗，煮一沸，移其锅置炉旁，候十数分钟，视其茅根若不沉水底，再煮一沸，移其锅置炉旁，须臾视其根皆沉水底，其汤即成，去渣温服，多半杯，日服五六次，夜服二三次，使药力相继，周十二时，小便自利。”由此可见古人用白茅根治水肿病的经验。

陈国恩重用白茅根治肾炎

通化市名老中医陈国恩治疗急性肾炎，常治以越婢加术汤加白茅根、紫荆皮等，白茅根用量动辄 100~200g。陈氏云：“攻坚之战，宜重兵速克，以防疲其师。”白茅根甘能补胃，故虽寒而不碍胃，清热凉血，通络利尿，消肿迅速，贵在一味，常收斩将夺关之效。

杜雨茂重用白茅根治肾病

著名中医家杜雨茂教授善用白茅根治疗肾病。慢性肾炎水肿，主要出现小便不利和尿量减少，因此利尿是消除水肿的重要治疗途径之一。杜氏每遇小便短少、尿中带血，或镜检发现血尿者，无论有无水肿，均在本病的辨证方药中加入白茅根 30~45g，玉米须 30g，连续服用，多可收到清热凉血、利水消肿之良好效果。由于白茅根甘淡微寒，清热而不碍胃，止血而不留瘀，利尿消肿而不伤阴，故对慢性肾炎水肿伴血尿者用之最为对症，值得推广应用。根据杜氏经验，本品用量



不可太轻，一般应在 30g 以上，否则收效欠佳。

石景亮重用白茅根经验

著名中医学家石景亮认为：白茅根者，临床应用于急性肾炎，证型属于风热水肿、湿热或热毒水肿、血尿者一定要用之；肾病综合征属湿热阻塞者，放胆用之；对肾盂肾炎，无论急性肾炎或慢性肾炎均应使用白茅根。

此外，石氏亦善用白茅根治疗血证。石氏认为，白茅根味甘性寒，有清热、凉血、止血、利尿的功能。用白茅根的临床指征是：热证吐血、衄血、尿血；急性肾炎、慢性肾炎小便量少；急性传染性肝炎小便不利。临床多用其治疗热病烦渴、肺热咳嗽、胃热呕血、吐血、衄血、尿血、热淋、水肿、小便不利及黄疸等病症。白茅根无毒性作用，其用量一般在 15~30g，对体壮症重者，可用 60~100g。其治疗血小板减少性紫癜血热型者，自拟经验方茅根三花三草汤治疗，即以白茅根为主药。处方：鲜白茅根 60g，金银花 20g，槐花 20g，凌霄花 30g，茜草 30g，仙鹤草 30g，紫草 20g，生地黄炭 30g，桑白皮 20g，地骨皮 15g，冬瓜子 30g，麦芽 20g，大枣 30g，生姜 10g。临床使用每获良效。

重用茜草经验

茜草最早载于《神农本草经》，其性寒，味苦；归肝经；其基本功效有凉血化瘀，止血，通经。多用于出血证、血瘀经闭、跌打损伤、风湿痹痛、燥咳等。临床常用量为 10~15g。

郑书全重用茜草治过敏性荨麻疹

郑氏在用脱敏汤方（墨旱莲、紫草、茜草）治疗过敏性鼻炎的启示下，用其加味并重用茜草（20g）治疗过敏性荨麻疹获良效。郑氏临床体会：茜草味苦寒，入肝经，有凉血止血、活血化瘀之效。通常用于治疗各种血热出血及外伤出血，还用于血滞经闭、跌打损伤、痹证关节疼痛及瘀滞肿痛等证。由于在治疗荨麻疹过程中，重用茜草，意外提高了疗效。受此启发，后每遇过敏性荨麻疹，属热证、实证者，均重用茜草，收到较好效果。茜草用量超过常规用量，但未发现明显不良反应。

如治李某，女，17 岁，2002 年 5 月 12 日初诊。反复全身瘙痒，皮肤丘疹 3 月余。开始丘疹成小片、边缘红、大小不一、高出皮肤，每用手搔抓后，遍及全



身皮肤，甚则连及眼睑，夜间尤痒，心烦口干，月经提前3~5天，小便黄，大便干，舌质略红苔薄黄，脉弦数。每因情志不畅，嗜食辛辣，或气候阴雨潮湿而发病。经用抗组胺类药、钙片，时好时坏。辨证为血热生风，湿热蕴结。治宜凉血祛风，除湿止痒。药用紫草15g，墨旱莲15g，茜草20g，生地黄10g，白鲜皮10g，当归10g，桔梗6g，土茯苓15g，蝉蜕10g，僵蚕15g。连续水煎2次，煎成500ml左右药液，分4次服完，每日1剂。服药2剂后，皮肤瘙痒发疹略有好转，考虑为清热凉血力量不达。而茜草苦寒，入肝经，清热凉血且化瘀，故原方重用茜草50g，服2剂后皮肤瘙痒大减，再服2剂后症状消失。后用养阴柔肝方以善其后。半年后随访，风疹已完全痊愈，未再复发。

重用蒲黄经验

蒲黄最早载于《神农本草经》，其性平，味甘；归肝、心包经；其基本功效有止血，化瘀，利尿。多用于出血证、瘀血痛证、血淋尿血等。临床常用量为3~10g。

王馨斋重用蒲黄治眼科血证

绍兴名中医王馨斋，从事中医眼科50余年。重用蒲黄治疗眼科诸种血证，尤有心得。根据《神农本草经》记载，蒲黄生用性滑，行血消肿；炒黑性涩，功专止血。王氏主张生用，他认为眼内出血不同于其他部位出血，血止后可遗留与出血相类似的机化物，仍会影响视力，因此用药不仅要止其出血，而且要促其尽快吸收。蒲黄既能行瘀，又善止血，故使用于眼科诸种出血最为相宜。蒲黄炒黑之后性质变燥，久服伤阴化火，导致反复出血，大是不宜。至于剂量也很重要，王氏指出：“蒲黄一物，除其在眼科上独特的功能之外，更应靠医生善于运用，剂量不同，则功效大殊。同盟者更赖辨证正确，配伍得当，所谓知己知彼，才能百战不殆。”对于气滞夹瘀的眼科出血证，王氏常选蒲黄与理气药配伍，蒲黄的用量一般在20g左右。蒲黄不仅长于活血化瘀，而且尤善于通利血脉。临床上由于瘀血引起的眼底出血，可谓屡见不鲜。盖瘀血不去，新血断无生理，且阻于络脉，气亦不通。目失气血濡养，影响精明，此时活血化瘀、疏通血脉是治疗关键。王氏根据通因通用的原则，重用蒲黄50~60g，化瘀止血，寓通于涩。



廖佐芹重用蒲黄治血淋

廖氏初学中医时，外祖父恒谓：“生蒲黄治淋有奇效。”每不以为然，后见其每遇此类病证，无不用此，且屡收效验，遂铭记于心。1987年冬，其表弟刘某，突患尿淋。尿频急而痛，恶心腰痛，痛时向外生殖器放射，尿道内如针扎火燎，解尿时汗如黄豆大，尿红赤如洗肉水状。尿常规检查：红细胞（+++）。X线片示右输尿管下端有一黄豆大结石。廖氏猛然忆起外祖父的话。辄投以生蒲黄粉30g，用金钱草30g，鲜葱一大握，煎汤分3次送服。每次10g，连用2天。第3天早晨起床后，其感尿意紧迫，急就便盆，随着尿道内一阵撕裂样疼痛后，须臾竟解出结石2粒。其淋痛之疾，遂卒然而愈。

蔡小荪应用蒲黄的经验

上海著名中医学大家蔡小荪善用蒲黄活血化瘀调经。一般认为蒲黄生用性滑，行血消肿；炒黑性涩，功专止血。然蔡氏尤推重生蒲黄。认为炭剂是治疗月经过多的常用之品，在炮制方面必须存性，若成焦炭，难免折损药效。从临床实践来看，生蒲黄的止血作用胜于蒲黄炭。据动物实验报道：生蒲黄对不同动物的离体子宫平滑肌均有使其收缩的作用，因而具有较强的祛瘀止血功效。

蒲黄一药，用量宜灵活多变。处方时少则10g，多则可达60g。随症斟酌，可根据病情轻重缓急，使其恰到好处，一般化瘀止痛，经量少而不畅者用10~12g；经量中而带血块者用12~15g；量多如注，块下且大者30~60g。他指出：蒲黄一物而能多用，除其独特功能之外，实赖医者在临床上善于掌握运用！剂量轻重不同，则功效大殊。只有辨证正确，用量、配伍得当，庶可获得预期效果。

治痛经，蒲黄用量不必过重，用以化瘀祛实。女子经血虽以血为主，然其盈亏行止无不由乎气。若气血失调，运行不畅，即可造成不通则痛。然痛经一症又以气滞血瘀为多见。蒲黄一药专入血分，以清香之气兼行气血，气血顺行则冲任调达，瘀去痛解。辨治要点：经行不畅，腹痛拒按，下块后较舒为特征。临床常见于内膜异位、膜样痛经等。一般在经前3天预先服用，使瘀块不易形成而排出畅通，效果方显。过晚服用，则瘀血既成，难收预期功效。

如治一子宫内膜异位症患者，年龄47岁，曾育2胎，流产4次，末次月经9月7日。既往经期尚准，每行始则量少微黑，第4天起色鲜有块不大，少腹进行性剧痛，每翻滚难忍，甚则昏厥，常需急诊。妇检右侧卵巢囊肿，似乒乓球大小，子宫后穹窿有数个黄豆样结节。诊断为子宫内膜异位症。刻下乳房作胀，烦躁易怒，脉细弦，苔薄微腻，舌质紫暗。证属肝郁气滞，宿瘀内结。经期将临，姑先疏肝理气，化瘀散结定痛。处方：生蒲黄10g，五灵脂10g，丹参6g，川芎4.5g，



川牛膝 10g，制香附 10g，延胡索 10g，制没药 6g，血竭 3g，5 剂。药后 3 天经行，腹痛小瘥，经量较畅。原剧痛时需注止痛针剂并卧床休息，此次腹痛已能忍受且一天即缓。以后每月经前 3 天预服该方 5 剂，调治 4 个月，经痛逐月减轻而至消失，量变正常。B 超复查卵巢囊肿缩小，后穹窿结节消除。

又有少数子宫内膜异位症患者，经行腹痛剧烈，常伴有肛门跳痛，甚则大小便失禁症状。蔡师谓：此为子宫肌痉挛引及泌尿系统功能紊乱所致。以解痉搜剔，每获良效。

治血虚兼有瘀血阻滞胞宫之证，选用生蒲黄与阿胶珠配伍。蒲黄用量一般在 15~20g，阿胶 10g（烊冲）。临床常见产后恶露不绝，如排出过多，或逾期不止，色淡红、质稀，夹有小血块，为子宫复旧不全。生蒲黄除能缩宫止血，祛瘀生新，促使瘀血排出外，亦能止血定痛，对宫缩不良、腹痛阵阵的瘀血性恶露不绝等，有良好治疗作用。阿胶，甘平，入肺、肝、肾三经，具有补血止血之功效，对一切失血之症均可奏效。据现代药理研究，阿胶有加速血中红细胞及血红蛋白生长的作用。阿胶与生蒲黄相配，止血而不留瘀，补血而不滋腻，寓涩于养，动静结合，配伍巧妙，瘀去宫宁，血自归经，临床运用每能应手取效。

如治一位新产妇女，主诉产后 35 天恶露未净，日前出现血量增多，色淡红有小血块，小腹阵痛，头晕乏力，腰背酸楚，面色少华，血红蛋白 70g/L，脉细苔薄腻，质淡边有齿印。证属气血两亏，瘀阻胞宫。拟补血止血，祛瘀生新。方拟：生蒲黄（包煎）20g，阿胶珠（烊冲）10g，炒潞党参 12g，炒当归 10g，仙鹤草 10g，益母草 12g，川续断 10g，桑寄生 12g，2 剂。药后腹痛消失，下块较多，恶露显减未止，续服 2 剂净止。

蒲黄长于活血化瘀，尤善通利血脉，故有止血固崩之功。临床上由于瘀血引起的崩漏屡见不鲜。缘瘀滞未去，则新血不能归经，导致出血不止，或量多如注有块。本着通因通用的原则，常重用蒲黄。其用量可达 30~60g，化瘀止血，寓通于涩。

如治李某，曾生育 1 胎，人流 2 次。1994 年 6 月因卵巢囊肿做过剥离术，术后小腹隐痛。出院后 7 月 22 日月经来潮，淋漓不止。8 月 28 日经刮宫后血仅止 10 余日，又突然流血不止。量多如注，有块且大。刻下小腹疼痛拒按，块下时略瘥。心悸气短，自汗头晕，精神疲倦，舌边紫黯有齿印，苔薄白，脉沉细弦。证属气虚夹瘀，胞络受阻。治拟活血化瘀，佐以扶正之品。处方：生蒲黄（包煎）50g，花蕊石 20g，炒当归 10g，丹参 6g，熟大黄炭 10g，炒党参 15g，震灵丹（包煎）12g，炮姜炭 3g，血竭 3g，3 剂。9 月 25 日复诊，块下更多，腹痛胀消失。再拟上法 3 剂后血块消失，经血自止。3 个月后门诊随访，崩漏未见反复。



重用仙鹤草经验

仙鹤草最早载于《本草图经》，其性平，味苦、涩；归肝、心经；其基本功效有收敛止血，止痢，截疟，补虚。多用于出血证、腹泻、痢疾、疟疾寒热、敛津止汗等。临床常用量为 3~10g。

何任重用仙鹤草治癌性疼痛

国医大师何任教授对于癌症的疼痛常重用仙鹤草 30~120g，白英 15~30g，并与失笑散相伍进行治疗，收到了较好的疗效。一般认为仙鹤草是凉血止血药，白英是清热解毒药。何氏在临床实践中认为这两味不仅有清热解毒、凉血止血的功效，而且也有抗癌消肿止痛的作用。《闽东本草》《药材学》也载有仙鹤草、白英能活血祛风、止痛。失笑散则能活血祛瘀，散结止痛，配合使用，则能提高止痛的作用。

如治张某，男，64 岁，1996 年 1 月 8 日初诊。左肺癌未能手术，近 1 月来反复左胸及背部疼痛，并逐渐加重，气急，面浮，溲少，大便艰结，苔白腻，脉弦。以蠲痛为主，辅以清解。处方：仙鹤草 60g，白英 20g，生蒲草 9g，五灵脂 9g，全瓜蒌 15g，鱼腥草 30g，冬瓜子、皮各 30g，野葡萄根 15g。服上药 7 剂后，胸痛明显减轻，气急、面浮、溲少、便干等症也得到缓解。

郭辉雄重用仙鹤草治盗汗

郭氏用仙鹤草变通治盗汗而偶获良效，悟出偶然之中必具必然之理，于是在临床上凡遇盗汗者，常以仙鹤草为主药，用量 30~50g，根据临床证候不同，随症配伍。盗汗偏阴虚者，配生地黄、麦冬、当归、白芍、五味子、山茱萸、女贞子、墨旱莲等；兼虚火旺者，加黄柏、知母、玄参、地骨皮等；偏气虚者，配黄芪、党参、白术、茯苓、甘草等；湿热内蕴者，配茵陈、黄芩、黄连、栀子等；若临床证候不显，可仅以仙鹤草 30~50g，大枣 10 枚，煎水频饮即可。

如治曾某，男，35 岁。患盗汗已历半月，经用当归六黄汤、大补阴丸等治疗罔效。自诉寐则汗出，醒则觉汗湿衣襟，旋即汗已，深为所苦，伴咽干，心烦，二便尚调，舌苔薄黄质红，脉象沉细数。此盗汗之证，投常药无效，当变通其法。窃思仙鹤草功专止血，但血汗同源，既能止血，当亦能敛汗。且江南民间，常用仙鹤草与大枣煎服，认为可医脱力劳伤，作为补益之品。于是以仙鹤草为主而疏



一方：仙鹤草 30g，白芍 15g，甘草 6g，生地黄 12g，柏子仁 15g，麦冬 12g，茯苓 10g，大枣 10 枚。嘱服 3 剂，盗汗减少，继进 3 剂而盗汗已，诸恙悉除。

王国三重用仙鹤草治早搏

河北名老中医王国三对心病的治疗颇有造诣。临证之时，对室性早搏的治疗，每每用到仙鹤草，且用量极大，一般用到 40~120g，效果更佳。因此，在此基础上，自拟抗早搏冲剂，益气养阴、活血化瘀、复脉宁心，针对气虚血瘀型的心悸而设。经严格科研设计，观察 100 例，总有效率达 94%。并设心律平对照组 30 例，总有效率达 80%。

如治王某，女。于 10 年前因劳累而发心悸气短，憋气，当时急赴本地医院，经心电图诊断为心律失常，频发室性早搏。给予心律平 75mg，每日 3 次，症状有所好转，但停药即发，时发时止。近 1 周复因劳累而上症又作，口服前药不缓解，故求治于中医。现症：心悸，气短，伴周身乏力，纳可，二便调，舌质黯淡，苔薄白，脉促结。心电图提示：频发室早，呈二联律，偶发房早。中医诊断：心悸（心气虚损兼有血瘀）。西医诊断：心律失常。治宜益气养心，复脉安神。处方：仙鹤草 40g，党参 18g，当归 10g，白芍 10g，酸枣仁 30g，远志 10g，龙眼肉 10g，熟地黄 10g，砂仁 6g（后下），甘松 15g，炙甘草 24g，紫贝齿 40g，龙齿 40g，生龙牡各 30g（先煎），焦三仙各 9g，鸡内金 10g。14 剂，水煎服。每日 2 次。服药后症状略有好转，上方仙鹤草加到 60g，连服 21 剂，诸症好转，心电图恢复正常。

王氏认为仙鹤草之所以民间又称脱力草，肯定有一定的道理，于是悉心研究，在《现代实用中药》一书中有这样的记载：“为强壮性收敛止血剂，兼有强心作用，适用于肺病出血、肠出血、胃溃疡出血、子宫出血、齿科出血、痔血、肝脓肿等病。”受该文的启发，在治疗顽固性心悸时，加入仙鹤草，初期用到 30g，有一定的疗效，而且患者无不良反应，后又用到 40g，效果较明显，当用到 120g 时，效果更佳，才悟出其理。仙鹤草虽为收敛止血之品，实际上亦有明显的补益作用，故江南民间称此为脱力草，常用来补益强壮，消除疲劳。而其药性敛涩，所以能达到益心气、敛心神而复脉的功效。

李艳重用仙鹤草治化疗引起的骨髓抑制

李氏运用大剂量仙鹤草治疗化疗引起的骨髓抑制疗效显著。如治卢某，男，72 岁，2002 年 12 月 5 日初诊。1 年前患淋巴瘤，曾用表阿霉素、硫酸长春新碱、环磷酰胺、泼尼松、还原型谷胱甘肽等药，间隔 20 天化疗 1 次，连续化疗 6 次后，出现进行性贫血。CT 片示：腹膜后可见直径 0.3~1.0cm 淋巴结，脾大，超过 6 个肋单元。血常规检查示：白细胞 $1.42 \times 10^9/L$ ，红细胞 $2.28 \times 10^{12}/L$ ，血红蛋白



67g/L, 血小板 $44 \times 10^9/L$ 。骨髓细胞检查示: 骨髓细胞增生减低, 粒系增生减低, 各级均见, 形态未见明显异常, 红系 3 张涂片未查见, 淋巴细胞大致正常, 巨核细胞 3 张涂片查见 1 只颗粒期, 散在血小板可见。印象: 骨髓象增生减低, 诊断为骨髓抑制。住院治疗, 3 天输 1 次血, 疗效不佳。患者自愿服中药。诊见患者面色㿔白, 形体消瘦, 纳呆, 倦怠神疲, 齿龈肿痛, 时有衄血, 锁骨上淋巴结肿大, 左侧 $4.5\text{cm} \times 3\text{cm}$, 右侧 $4\text{cm} \times 5\text{cm}$, 质硬, 推之不移, 按之不痛, 舌淡苔薄白, 脉细弱无力。处方: 仙鹤草 60g, 菝葜 30g, 三棱 12g, 莪术 12g, 皂角刺 15g, 黄芪 30g, 白及 30g, 桂枝 10g, 甘草 10g, 苍术、白术各 15g, 党参 30g, 肿节风 15g。服药 10 剂后, 锁骨上肿块消失, 纳可, 仍感气短乏力, 隔 5 天输 1 次血。上方减皂角刺, 加黄精 12g, 鹿角胶 10g (烊化), 继服 10 剂, 诸症尚有好转, 隔 11 天输 1 次血。效不更方, 上方又服 10 剂, 复查血常规: 白细胞 $4.6 \times 10^9/L$, 红细胞 $3.2 \times 10^{12}/L$, 血红蛋白 71g/L, 血小板 $95 \times 10^9/L$ 。嘱其停止输血。调整处方如下: 仙鹤草 60g, 菝葜 30g, 三棱 12g, 莪术 12g, 黄芪 30g, 白芍 30g, 桂枝 10g, 甘草 10g, 苍术、白术各 15g, 党参 30g, 川芎 12g, 熟地黄 9g, 茯苓 15g, 陈皮 12g, 半夏 12g, 鹿角胶 10g (烊化)。继服 60 剂, 复查血常规及骨髓象皆正常, 除活动后仍感乏力外余症消失, 遂停药, 嘱其每月服上方 10 剂。随访 2 年, 患者健在。

现代药理研究也证实, 仙鹤草能使凝血时间缩短, 血小板计数增加, 并能增强细胞抵抗力。李氏后又用于多发性骨髓瘤及再生障碍性贫血, 亦获良效。

马帮义重用仙鹤草治痢疾

马氏临床中喜用鲜仙鹤草配伍鲜马齿苋, 治疗细菌性痢疾, 获满意疗效。用法: 鲜仙鹤草 100g, 鲜马齿苋 200g, 洗净, 入水 1000ml 煎煮, 煮沸后 5~10 分钟, 便可滤取药液频服。该用量为成人量, 儿童酌减。服药治疗期间, 忌食辛辣厚味刺激之物。

如治周某, 男, 26 岁。因腹痛、便脓血 2 天就诊。患者于 2 日前因食水果不慎而致腹痛, 里急后重, 便下黏液脓血, 每日 10 余次, 肛门灼热坠胀, 伴恶寒发热, 口苦, 口渴欲饮, 舌红、苔黄腻, 脉滑数。血常规报告: 白细胞 $13.8 \times 10^9/L$, 中性粒细胞 0.80。大便镜检: 白细胞 (+++), 红细胞 (++)。诊断: 急性细菌性痢疾。遂给予上法治疗。用药 1 天后, 诸症有所好转, 继用 5 天后, 诸症痊愈, 复查大便亦正常。

又如治陈某, 男, 6 岁。因腹痛、里急后重、便脓血 3 天就诊。患儿于 3 日前因食桑椹过量而出现腹痛, 呕吐, 大便清稀如水样, 继则里急后重, 便黏液脓

血，日 10 余次，遂就诊于某职工医院。血常规报告：白细胞 $14.1 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 0.85。大便镜检：脓细胞（+++），红细胞（+++），诊为急性细菌性痢疾，并给予氯霉素等药物口服治疗，因味苦难吞，患儿难以接受，故请中医诊治。刻诊：除见上述诸症外，兼见发热，口渴欲饮，舌红苔黄，脉数。遂给予上方剂量减半治疗。服药 2 日后，诸症明显缓解。继用 5 日后症状消失，复检大便亦正常。

现代药理研究证实，本品可收缩毛细血管，促进血液凝固，并且对痢疾杆菌、大肠埃希菌、铜绿假单胞菌等均有抑制作用。取大剂仙鹤草收敛固涩、止血止痢为主，再配伍重剂马齿苋则解毒止痢之力更宏，二者合用，对赤痢（血痢）效更佳。

重用川芎经验

川芎最早载于《神农本草经》，其性温，味辛；归肝、心经；其基本功效有活血行气，祛风止痛。多用于血瘀气滞痛证、头痛、风湿痹痛等。临床常用量为 3~9g。

张天嵩重用川芎治头痛

后世含川芎治疗头痛的方剂多而不可胜数，但在用量上却有分歧，多数医家认为以 3~10g 为宜。至清代陈士铎倡重用川芎，其所著《辨证录·头痛门》中治头痛正方六首，用川芎一两者有四，为后世效仿；但在《辨证录》眉批中指出“川芎能走散人真气，久服多服能令人暴亡，若用一两而服至十剂，恐汗出不收，似宜少用之”。张氏初读此书时，亦与此眉批意见相同，怀疑重用川芎之弊，但后来在临床中用其所载散偏汤及《医宗金鉴》之芎芷石膏汤化裁，重用川芎 30g，治疗偏头痛数十例，效果颇佳，一般药后明显痛减，也未出现不良反应。曾治一例重用川芎 30g，连服 18 剂，未出现“汗出不收、头晕”等不良反应。

张氏认为，用川芎的原则有三：

一辨病情：辨西医之病对临床用川芎有重要的参考作用，对于偏头痛、紧张性头痛、三叉神经痛、外伤后（脑水肿除外）、普通病毒性感染等所致头痛可大胆应用，正如程之田《医学心传》中所说“攻病如攻敌，用药如用兵；兵在精而不在多，药贵当而不忌峻”。对于脑出血、大面积脑栓塞、脑瘤等其他原因导致颅内高压引起的头痛则不宜应用。

二究配伍：考川芎的不良反应，多为单用久服所致，张氏常用川芎 30g、生



白芍 30g 作为治疗偏头痛的药对，并根据辨证再配伍其他药。风则加天麻、钩藤、防风等，分内外而选用；寒则加白芷、细辛等；火则加石膏、菊花、蔓荆子、龙胆草、黄芩等，分脏腑或经络而选用；湿则加羌活、防风；痰则加制半夏、茯苓、僵蚕；瘀则加全蝎、蜈蚣；虚则加党参、黄芪、白术、白芍、当归、熟地黄、桑寄生，分气血阴阳而选用。

三考用量：用量当细考病情之久暂与轻重。对于颅内高压引起的头痛不宜应用；对于发病急或头痛轻浅者，如外感头痛或鼻窦炎所致的头痛，不论其风寒、风热、风湿等，用量宜小，一般 6~9g 为宜，量大则有头晕不适之感；对于时作时止、发时头痛剧烈者，如中重度偏头痛，则宜重用，一般用量在 30g 以上，疼痛明显减轻或消失后，迅速减量，既巩固疗效，又不致不良反应出现，所谓“中病即止”。

王因仲重用川芎治顽固性头痛

王氏在临床实践中治疗头痛患者百余例，其中慢性顽固性头痛 10 余例，重用川芎，效果满意。如治一女性患者，45 岁。自述患头痛病 1 年半，曾多处求医诊治，时轻时重，头痛重时常服复方阿司匹林片以缓解痛苦，且有胃肠不适的不良反应。于 2007 年 11 月 14 日初诊。患者头痛喜裹，恶风畏寒，时有头痛头沉，痛甚连及项背，时有汗出，口不渴，舌淡红苔薄白，脉浮。血常规检查正常。X 线片检查未见异常。中医诊断为慢性顽固性头痛，辨证为风邪侵入脑络，营卫气血不和，治宜祛风散邪通络，调和营卫气血。方药：当归 10g，川芎 10g，桂枝 10g，炒白芍 10g，炙甘草 6g，荆芥 10g，防风 10g，羌活 10g，马蹄香 6g，白芷 10g，蜈蚣 2 条，生姜 10g，大枣 5 枚。7 剂，水煎 2 次，合并药液分 2 次服，每日 1 剂。

服药 7 剂后，自觉症状稍有减轻，痛时仍需服用复方阿司匹林片，于是，调整原方药量，重用川芎。处方为川芎 60g，当归 15g，桂枝 10g，炒白芍 10g，炙甘草 6g，荆芥 10g，防风 10g，生姜 10g，大枣 5 枚，羌活 10g，马蹄香 6g，白芷 10g，蜈蚣 2 条。7 剂。水煎服，每日 1 剂。服药 7 剂后，自觉头痛明显减轻，不服用复方阿司匹林也能忍受。重用川芎原方继用 7 剂，患者自述头痛诸症消失。为巩固疗效，后改用玉屏风散、四物汤合桂枝汤加减，连服 15 剂。至今随访，9 个月未再复发。

杨德义重用川芎治偏头痛

杨氏认为川芎辛香升散，能上行头面，既可搜风通络止痛，又能助清阳之气而利窍，对各种病因引起的头痛均有较好的疗效，是治疗头痛的要药。在临床实践中发现，川芎治疗偏头痛须用重剂才有显效，一般常用剂量为 30g，若效果不显可加



大剂量至 50g，对于剧痛不止者可增至 75~100g，取效后即减至常用量。药理学研究结果证实，大剂量川芎能明显降低偏头痛患者脑血流速度，具有较好的止痛作用。临证结合气血阴阳虚实和各种兼夹之证，辨证加减用药，不仅能增强川芎祛风止痛的作用，还可佐制川芎之辛香走窜耗气之弊。

重用郁金经验

郁金最早载于《药性论》，其性寒，味辛、苦；归肝、心、胆经；其基本功效有活血止痛，行气解郁，清心凉血，利胆退黄。多用于气滞血瘀之胸痛、胁痛、腹痛、吐血、衄血、倒经、尿血、血淋、湿热黄疸、胆石症等。临床常用量为 5~12g。

王荫卿重用郁金治腹水

内蒙古名老中医王荫卿对肝硬化腹水的治疗，多以重用郁金取效，并体会其用量需大，每用 30~60g，腹水方能很快消退。认为郁金为气中血药，疏肝解郁，有逐水消积之功，祛邪而不伤正。

如治刘某，男，52 岁。1962 年 8 月 5 日就诊。患者于 1961 年 12 月因肝硬化腹水住某医院治疗月余，腹水消退出院。复于 1962 年 7 月初又有腹水发生，再次住院治疗 20 余日，疗效不显，院方嘱其出院回家调养。出院时化验：血红蛋白 104g，白蛋白 18g，球蛋白 44g，脑絮 (+++)，麝浊 20U，麝絮 (++++)。症见形体消瘦，面色晦暗，腹胀如鼓，下肢凹陷性水肿，体倦无力，语言低微，食欲不振，小便短赤，大便溏，舌质红，苔白，脉沉细弦。证属肝郁脾虚，气滞血瘀，三焦气化不利。治以疏肝健脾，活血化瘀，行气逐水。拟逍遥散加减：柴胡 10g，当归 12g，赤芍 15g，白术 9g，云茯苓 20g，郁金 30g，牡蛎 30g，鳖甲 30g，车前子 30g（包煎），红花 6g。上方 3 剂后，无明显效果，且又增胁痛、鼻衄。仍以上方加白茅根 30g，藕节 30g，延胡索 9g。服 6 剂后，胁痛、鼻衄消失，小便量增多，腹水大减，纳食增加。仍以上方去白茅根、藕节、延胡索，又继服 20 剂，腹水尽消，下肢水肿消失，精神转佳。仍以原方去红花、车前子。守方治疗 4 个月，肝功化验正常，诸症悉除，其他无不适，已能参加劳动。随访数年未复发。



重用益母草经验

益母草最早载于《神农本草经》，其性微寒，味辛、苦；归心、肝、膀胱经；其基本功效有活血调经，利水消肿，清热解毒。多用于血滞经闭、痛经、经行不畅、产后恶露不尽、瘀滞腹痛、水肿、小便不利、跌打损伤、疮痈肿毒、皮肤瘾疹等。临床常用量为 10~30g。

朱良春重用益母草经验

国医大师朱良春教授善用益母草利水消肿。朱氏认为，用益母草利水消肿，必须用大剂量。曾验证：若每日用 30~45g 时，利尿作用尚不明显，用 60~120g 时（儿童酌减），始见佳效。鉴于其具有活血、利水之双重作用，故对于水血同病，或血瘀水阻所致之肿胀，堪称对之佳品。

1. 用于肝硬化腹水 肝硬化腹水与肝、脾、肾关系最为密切，乃气、血、水相因为患，其病位在肝，恒多“瘀积化水”之候。朱氏治疗腹大如鼓、腹壁青筋显露之臌胀，在辨证论治的前提下，恒以益母草 120g（煎汤代水煎药）加入辨证方药中，常可减缓胀势，消退腹水。

2. 用于急、慢性肾炎 急性肾炎多系外感风邪水湿或疮疡湿毒内攻等，致使肺、脾、肾三脏功能失调，水湿泛滥肌肤而成。益母草除能利水外，尚可清热解毒。《新修本草》载“能消恶毒疗肿、乳痈、丹游等毒”，不失为治疗急性肾炎之要药。常用处方：益母草 90g，泽兰叶、白槿花各 15g，生甘草 5g。风邪未罢，肺气不宜加生麻黄 5g；内热较甚加生大黄 5g，生黄柏 10g；气血虚弱加当归 10g，生黄芪 15g。至于慢性肾炎，则要从久病肾气亏虚，络脉瘀滞，以致气化不行，水湿潴留着眼，补肾、活血兼进，借以扩张肾血管、提高肾血流量和增强肾小管排泄功能。常在组方时选加益母草。

3. 用于其他原因之水肿 临床可见一种浮肿，尿常规检查无异常发现，一般肿势不剧，以面部和下肢较为明显，常伴见面色少华、头晕乏力等症状。朱氏认为，此种浮肿基于气血亏虚，肝脾失和。盖气虚则鼓荡无力，血涩运迟，络脉瘀滞，以致水湿留着。故此类浮肿乃虚中夹瘀之候也。朱氏习用生黄芪（30g）与益母草（60g）相伍，以扶正气、化瘀滞、行水湿，配合茯苓、白术健脾，当归、白芍养肝，天仙藤、木瓜舒筋化湿，收效较著。



另外，朱氏善重用益母草降压。益母草的降压作用已为现代药理实验所证实，但决非泛泛使用，它主要适用于肝阳偏亢之高血压症。朱氏指出：“益母草有显著的清肝降逆作用，对产后高血压症尤验，但用量必须增至 60g，药效始宏。”当肝阳肆虐，化风上扬，出现血压增高、头晕肢麻时，或久病夹有痰湿、瘀血，伴见面浮肢肿、身痛拘急者，均可适用。朱氏曾制“益母降压汤”，药用益母草 60g，杜仲 12g，桑寄生 20g，甘草 5g。头痛甚者加夏枯草、生白芍各 12g，钩藤 20g，生牡蛎 30g；阴伤较著者加女贞子 12g，川石斛、大生地各 15g。

张学文重用益母草经验

国医大师张学文教授善用益母草，张氏根据其所具有的活血利水双重作用，治疗脑水肿、小儿解颅，取得比较理想的效果。张氏临床常用于以下诸症。

1. 治痛经 治气滞血瘀引起的痛经，常与延胡索、当归、白芍、香附、川牛膝等补血养血、行气止痛药物组合成方。益母草剂量要大一些，一般常用 30g 左右，大多有明显效果。

2. 治产后病 如产后出血或恶露不绝，腹部胀痛，出血量少，或夹杂血块，由子宫收缩无力引起者，常配合当归、酒白芍、艾叶、川芎、焦山楂，偏寒者再加炮姜、台乌药等，效果较为理想。现在已经证实益母草可收缩子宫，显著增加子宫肌肉的收缩力和紧张性。对折伤内有瘀血者也可用，如《外台秘要》记载的益母草膏。

3. 治急性肾炎水肿、血尿 用益母草 30~60g，生品可以用量更大一些，单用或加入辨证方剂中用，甚为有效。常配伍猪苓、茯苓、连翘、白茅根、丹参、浮萍、桑白皮之类，现已为临床所常用。肾结石也可配伍冬葵子、石韦、鸡内金、海金沙等同用。

4. 治解颅 解颅多为西医之脑积水，病机多为水瘀互结证。益母草既可活血，又可利水，甚合其病机。常配伍当归、赤芍、红花、川芎、葛根、丹参、白茅根、泽泻、琥珀、茯苓、麝香、车前子、山楂等，用后效果明显，已有多例治验病案。

5. 治高血压 据报道，益母草水浸剂等对麻醉动物静脉注射有降压作用，其乙醇制剂对在位兔心有轻度兴奋作用，还有抗血栓形成和促进血栓溶解作用，故用于高血压病，既可以因其利尿作用而降低血容量，又可因其活血、溶栓、强心作用，改善外周血循环。凡高血压病头目眩晕、心慌心悸或有轻度浮肿者，用之有较好效果。常配伍平肝清肝之菊花、天麻、钩藤、石决明、白芍、牛膝、磁石等应用。

6. 治癥瘕积聚（如慢性附件炎、盆腔炎等） 取本品有活血祛瘀而性平可久



服以缓化慢消之特点，常配伍当归、丹参、三棱、赤芍、红花、牛膝、小茴香、台乌药等组方，但要久服方有效。

总之，益母草虽曰“益母”，但不止用于妇科，实则对内科水瘀互结之证疗效亦好。中医认为“血不利则为水”，而益母草既可活血消癥，又可利水消肿，两擅其长，对凡瘀血久留，水瘀互结之脑水肿、颅内压增高、急性肾炎、高血压等，均可以治疗。但此药作用平和而力弱，用量一般需大，30~90g 为成人常用量，治肾炎时干品可用至 90~120g，鲜品 180~240g，方有显效。

李凤祥重用益母草治功能性子宫出血

内蒙古名老中医李凤祥教授重用益母草治疗功能失调性子宫出血，疗效显著。

如治裴某，女，44 岁，1999 年 10 月 2 日初诊。患者于 1 年前未值经期，忽然出现阴道出血，量多，历久不去，经用激素治疗始去。从此，每次月经来潮，辄漏下淋漓，量多色紫，并见少腹胀痛，食纳呆滞，做妇科检查未见异常，在当地医院诊为“功能失调性子宫出血”。此次自 8 月 22 日月经来潮，迄今未止，经量时多时少，血色紫黑有块，余症如前。曾肌注缩宫素、黄体酮不效，亦曾服中药数剂，多以参芪等益气摄血，或以炭剂止血，亦无效。忆起李老一首歌诀：“功能出血无专方，多用归脾补血汤，不如四两益母草，归芍甘草佐木香”。遂疏方：益母草 120g，白芍 12g，当归 9g，木香 3g，甘草 6g，3 剂，水煎服，每日 1 剂，分 2 次服。服药 2 剂后经量明显减少，服完 3 剂后，血止。为巩固疗效又服 3 剂，以后每值月经来潮的前 1 周服药 6 剂。如是 3 个周期后，月经每隔 30~32 天来潮 1 次，经期 8 天，色淡，量适中，周身无不适。随访至 2000 年 12 月 20 日未复发。

《本草纲目》云：益母草能“活血化瘀，调经解毒，治胎漏产难……崩中漏下，”其功专入血分，行瘀血，生新血，行瘀血而新血不伤，养新血而瘀血不滞。现代药理研究证实，益母草有增强子宫收缩力的作用，其作用与脑垂体后叶素、麦角新碱相似。更有白芍伍当归，一张一弛，稳定子宫，少佐木香，疏肝开郁，和胃健脾，临床用于久漏不止，或反复发作，经年不愈者，屡用屡验。

重用鸡血藤经验

鸡血藤最早载于《本草纲目拾遗》，其性温，味微甘、苦；归肝、肾经；其基本功效有行血补血，调经，舒筋活络。多用于月经不调、痛经、闭经、风湿痹痛、



手足麻木、肢体瘫痪及血虚萎黄等。临床常用量为 9~15g。

杨光宁重用鸡血藤治重症肌无力

杨氏认为鸡血藤补血活血，守走兼备，并能舒筋活络。《本草纲目拾遗》谓其“治老人气血虚弱，手足麻木瘫痪等症”。故于补中益气汤加味中重用该品，意在活血化瘀改善微循环，促进经络组织间气血贯通，从而振奋神经肌肉的传递功能，治疗重症肌无力获得较好疗效。

如治由某，男，36 岁。1997 年 12 月在北京某医院行恶性胸腺瘤部分切除术，术后曾行化疗及放疗，并经中医药配合治疗，疗效尚稳定。2001 年 5 月出现四肢痿软、咀嚼无力、吞咽困难、喝水呛咳等症状，并逐渐发展至复视、言语不清、呼吸困难，无吞咽，靠鼻饲进食等危象，北京某医院诊断为：重症肌无力 4 型。经西医治疗 1 个半月后，除言语恢复，呼吸较前通畅外，其他症状无明显改善，以“重症肌无力 3 型”诊断出院。刻诊见面色萎黄，上睑下垂，语声低沉，鼻插饲管，舌淡紫边有齿痕、苔薄白，脉细弱。中医诊断：痿证，证属脾肾气虚型。治疗以健脾益气升阳、补肝肾益精血为法。处方：鸡血藤 50g，黄芪 30g，人参 10g，炒白术 15g，陈皮 10g，升麻 6g，柴胡 6g，当归 10g，杜仲 10g，巴戟天 10g，黄精 10g，枸杞子 10g，枳壳 15g，焦三仙各 10g，炙甘草 6g。每日 1 剂，水煎 2 次，早晚各 100ml 鼻饲灌服。服药 1 周后，患者自感身体较前有力，食欲增加，二便通畅。随症加减服药 20 天后，患者恢复吞咽功能，自行拔掉鼻饲管。继宗原法，辨证巩固治疗半年后，周身无力及复视症状消失，咀嚼吞咽正常，上睑下垂明显改善，生活已基本自理。

杨丁友重用鸡血藤治重症肌无力

中国人民解放军总医院杨丁友教授临床以鸡血藤 400~600g 水煎代茶饮治疗重症肌无力（痿证）多例，多在 3 个月内收明显疗效。曾治赵某，男，36 岁，农民，1997 年 8 月 6 日初诊。自诉肌力减弱 5 年，开始为四肢疲乏无力，逐渐加剧，曾在某医院住院检查、治疗，诊断为“重症肌无力”，经多种治疗未能控制病情。现肢体肌肉无力、酸胀而痛，尤以下肢为甚，且影响行走，上楼困难，舌淡苔白，脉沉细无力。诊断“痿证”，辨证为气虚血瘀、筋脉失养。予鸡血藤 500g 以文火水煎 2 次，第 1 次煎 50 分钟，第 2 次煎 30 分钟，2 次共滤出 2000~2500ml 药液，代茶频服。1 个月后自感体力改善，下肢肌力好转；继服 1 个月后，精神体力均明显好转，上楼困难明显减轻；继服至半年时，肌力基本恢复正常。后仍以鸡血藤 200g 水煎频服以巩固疗效。又继服治疗半年后，肌力恢复正常。随访至 2002 年，已能参加轻度劳动。



“痿证”日久多治以补肝肾、温肾阳为主，但由于鹿茸、海马等价格昂贵，长期服用难以坚持。鸡血藤性温、味苦微甘，《中药大辞典》言“活血舒筋，治腰膝酸软、麻木瘫痪，为强壮性之补血药”，且价廉而无副作用。临床观察，对中风后遗症之弛缓性瘫痪亦有增加肌力作用，但疗效更缓慢。

孙玉齐重用鸡血藤治便秘

孙氏继承家父经验，常用单味大剂量鸡血藤，治疗因阴血亏虚所致的肠燥便秘，临床收效颇佳。如治刘某，女，28岁。产后8月余，大便干结，排便不畅，3~4日一行。伴头晕眼花，手足发麻，腰脊酸痛，舌质淡，苔薄白，脉沉细。多次治疗，便秘只是一时取效，停药后如故。遂给予鸡血藤100g，水煎取汁早晚分服。3剂后，大便趋于正常，每日一行。改为鸡血藤60g，水煎服。连服20余剂，诸症消失，大便通畅。随访半年未复发。

鸡血藤温润，行补兼备。对便秘兼有筋骨麻木、风湿痹痛者及老人、妇女尤为适宜。其无攻下药苦寒伤胃、养血通便药甘润腻滞之弊。唯其用量需大，必以60g以上，方可收效。

赵云芝重用鸡血藤治不宁腿综合征

赵氏临床上重用本品治疗不宁腿综合征，取得较好疗效。如治李某，45岁。双小腿深部异常不适感2年，加重半年。患者2年前劳累后出现双小腿深部异常不适，酸胀麻木，经休息、按摩后渐缓解，此后每因劳累或受凉则发作。曾在外院查心电图、铬、血沉、类风湿因子等均正常，给予西比灵、复方丹参片、吲哚美辛（消炎痛）、谷维素等扩张血管、改善血供、活血化瘀药物治疗，效果不显。近半年来病情加重，双小腿酸胀麻木，甚则痛苦难言，患者终日坐卧不宁，伴心烦乏力，睡眠多梦，常于夜间起床行走活动以使症状减轻或缓解，月经后期量少，色紫暗有血块，舌质淡红、舌边尖有瘀点、舌苔薄白，脉弦细无力。证系阳气不足，脉络瘀滞，营卫不和，治以益气温阳，活血通络，方用黄芪桂枝五物汤加味：鸡血藤30g，黄芪30g，桂枝15g，白芍15g，怀牛膝15g，桃仁12g，红花12g，生姜3片，大枣5枚，水煎分2次服，每日1剂。服上方5剂后，患者体力增加，但腿部不适症状减轻不明显，上方鸡血藤改用50g，继服3剂，腿部不适症状明显减轻，心烦乏力瘥，睡眠好转。上方去桃仁、红花，继服3剂，症状消失。

不宁腿综合征，现代医学认为可能与腿部血液循环障碍导致组织代谢产物蓄积有关，但具体病因不甚明了，各项理化检查多无阳性发现，故治疗亦无特效药物。赵氏认为，本病多是由于阳气不足，脉络瘀滞，气血不畅所致，治疗



宜益气温阳，活血通络，方选黄芪桂枝五物汤加味。初诊鸡血藤用 30g 效不显，二诊重用鸡血藤至 50g，收效显著。鸡血藤性温，善补血活血，温通经脉，对阳虚脉络瘀滞之不宁腿综合征患者，在辨证的基础上重用本品治疗可收事半功倍之效。

张淑华重用鸡血藤治经期身痛

张氏每遇经行前后及经期身痛的患者，将经行身痛分为血虚、血瘀两型辨治。血虚以素体血虚，或大病久病后，以致气血两虚，经行时阴血下注胞中，气随血泄，气血愈显不足，筋脉失养，遂致身痛。血瘀以素有寒湿稽留经络、关节，血为寒湿凝滞，经潮时气血下注冲任，因寒凝血瘀，运行不畅，以致经行身痛。血虚型拟养血益气汤，以大剂量鸡血藤 30~60g 为主药，配以黄芪 30g，当归 20g，白芍 30g，山茱萸 10g。血瘀型拟养血祛风汤，以鸡血藤 30~60g 为主药，配以黄芪 30g，当归 20g，白术 15g，炙甘草 6g，桂枝 9g，独活 9g，川牛膝 10g，桑寄生 15g，薤白 10g，生姜 3 片。

如治李某，女，22 岁。因经行时四肢疼痛麻木，肢体软弱无力，阵发性加重，月经量少，于 2000 年 5 月 11 日初诊。既往无慢性关节炎病史。诊为经行身痛，血虚型。投以养血益气汤。服 3 剂后症状减轻，5 剂后症状完全消失。继服 3 剂以巩固疗效。

又如治王某，女，35 岁。因经行时腰膝关节疼痛，得热痛减，遇寒痛甚，经行量少色暗，有血块，于 2000 年 6 月 12 日初诊。此为经行身痛，血瘀型。投以养血祛风汤。服 3 剂后症状减轻，5 剂后症状完全消失。继服 3 剂以巩固疗效。

张氏重用鸡血藤加味治疗经行身痛 50 余例，均取得满意疗效。鸡血藤行血而舒筋活络，对肢体麻木、风湿痹痛等症，无论血虚、血瘀均可应用。其可与补血、活血及祛风通络的药物同用。

重用莪术经验

莪术最早载于《药性论》，其性温，味辛、苦；归肝、脾经；其基本功效有破血行气，消积止痛。多用于癥瘕积聚、经闭及心腹瘀痛、食积脘腹胀痛等。临床常用量为 3~15g。



刘绍勋重用莪术治胃病

辽宁名老中医刘绍勋曾治一胃病患者未效，后被他人治愈。索视其方，才知重用了莪术。查阅前人医籍，才恍然大悟。此后，在治疗胃疾时常常重用莪术为君。有些医者似乎忌讳莪术，即便治疗积聚之病，与三棱伍用，药量亦很轻微，惟恐伤正，其实，这种顾虑是不必要的。这个病例对刘氏启发很大，从此，刘氏在临床中格外重用莪术。

刘氏忆曾去外地学习，因不适应当地生活习惯，得了胃病，服保和丸之类中成药，未能将病根除，后来改服“烂积丸”，一举而奏效，因后者方中有莪术，疗效显著可想而知。又治一病人胃有实滞，虽经针灸治疗，胃痛减轻，但缠绵数日未愈。刘氏在治疗中把莪术列为君药，与消食和胃之品配伍，仅治数日而愈。

刘氏认为，治疗肝胃之病，如果经过准确辨证，因人、因病而异，方中适量加入莪术，无论缓解症状，还是调节脏腑功能，疗效甚为可观。几十年来，刘氏通过对数十例患者的疗效观察，深深体会到：莪术的临床应用价值是不能怀疑的，也是不可忽视的。一般地说：应用莪术的基本剂量是 7.5g，中等剂量是 10g，有时也用到 15g 或 20g，或者剂量再大一些，这要根据病情的轻重缓急和患者的体质强弱来决定。近几年来，有的地区和单位用莪术治疗癌症，取得一定效果。刘氏用莪术治疗肝炎、溃疡病，也用于治疗癌症。莪术的一个主要特点是通肝经聚血，解毒止痛。刘氏通过临床实践，认为莪术对胃癌疗效较好。胃癌早期用莪术，会增进饮食，增强体质，促使病情稳定；胃癌晚期用莪术，能够明显减轻疼痛，改善机体“中毒”症状。

刘氏对于莪术的理解主要有以下三点：其一，莪术虽为破气化瘀之品，但辛苦气温并不峻猛。莪术既然能够开胃化食，这就有助于脾胃功能的恢复。开胃化食，就意味着人的气血生化之源有了保障，就为人体正气的恢复创造了有利的条件。所谓“益气”，就是有益于正气的恢复和舒展。其二，莪术能“破气中之血”。气为血之帅，气行则血行，气滞则血瘀。所云“气中之血”，说明气之前导作用不利，血亦不能随之畅行，这是气滞不前，造成血液稽留的表现，亦即气滞血瘀。莪术攻逐的是滞气，消烁的是瘀血，敦促气血按照正常规律周而复始，也就起到了“益气”的作用。其三，莪术“治心腹诸痛”。经曰：“痛者不通，通者不痛”。所谓诸痛，不言而喻，即指各种类型的疼痛。肝胃之症，癥瘕积聚，诸如此类，均可导致心腹疼痛。莪术益气舒郁，其痛自缓。



重用水蛭经验

水蛭最早载于《神农本草经》，其性平，味咸、苦；归肝经；其基本功效有破血逐瘀，逐瘀消癥。多用于血瘀经闭、癥瘕积聚、跌打损伤、心腹疼痛、慢性咳嗽等。临床常用量为 1.5~3g。

吴天强重用水蛭治血管瘤

吴氏认为水蛭功能破血逐瘀，《神农本草经》云：“逐恶血、瘀血、月闭、破血癥积聚，无子，利水道。”张锡纯云：“破瘀血而不伤新血，专入血分而不损气分。”吴氏根据这些贤达之慧，对血管瘤患者用水蛭暴晒研成粉末装入 0 号胶囊（重约 1g），每服 4 粒，日服 2 次，结合患者体质，伍以补气养血之剂，每收全功。水蛭破血消癥，力猛有毒，为临证医家所忌，但一些药物的专门独效却不能尽致发挥。水蛭一味，吴老临床 20 余载运用，并未发现其有毒性作用。

张霆重用水蛭治真性红细胞增多症

张氏在辨证论治理论的指导下，根据其病因病机，重用水蛭治疗真性红细胞增多症，获得显效。

如治马某，女，45 岁，农民。3 个月前因头晕、头痛、关节胀痛就诊，实验室检查：血红蛋白 210g/L，红细胞 $8.9 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $4.1 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ ，血细胞比容 65%。骨髓穿刺示：增生明显活跃，红系增生，尤以幼红细胞为甚。巨核细胞增多，形态较大。骨髓外铁和铁粒细胞消失。诊断为真性红细胞增多症。即予羟基脲、干扰素、环磷酰胺及静脉放血等治疗月余。但病情始终未缓解，故转请中医治疗。观其形体消瘦，精神萎靡，面色灰暗，全身皮肤呈棕红色，多处有紫红色瘀点、瘀斑，口唇紫黑，自觉五心烦热（体温 38.2℃），耳如蝉鸣，四肢麻木，头晕头痛，入夜尤甚，自汗盗汗，常湿衣衫，口渴喜饮，尤喜冷饮，胸腹隐痛，小便短赤，大便干结。舌质紫暗、苔薄黄，脉弦细。此为毒邪胶结，瘀血内阻为患，治以破血散结，扶正培本。处方：生水蛭 12g（装入胶囊后用药汁吞服），红花 9g，桃仁 12g，穿山甲 9g，大黄 6g，当归 15g，血竭 6g，三棱 12g，莪术 12g，黄芪 20g，党参 12g，黄精 12g，地龙 9g，丹参 15g，冰片 9g，甘草 6g。服药 14 剂，身热减轻，唯四肢入夜灼热，头痛头晕明显好转，神疲乏力改善，自汗止，但仍有盗汗，汗量减少，二便调，但感腹胀纳差。效不更方，



于前方加入焦麦芽 12g，焦谷芽 12g，焦六曲 9g，焦山楂 12g，炒白术 9g。继服 20 剂后，面色转为红润，食纳增加，皮肤瘀点、瘀斑颜色变浅或消失，盗汗亦止，头晕头痛仅于用脑或运动后有之，程度亦大为减轻。复查血常规：血红蛋白 180g/L，红细胞 $6.6 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $4.3 \times 10^9/L$ ，血小板 $140 \times 10^9/L$ ，血细胞比容 50%。于前方中去大黄、焦麦芽、焦谷芽、焦六曲、焦山楂，守方继用 30 剂，皮肤瘀点、瘀斑消失，头晕头痛轻微，其余诸症若失。检查血常规：血红蛋白 150g/L，红细胞 $5.8 \times 10^{12}/L$ ，白细胞 $4.4 \times 10^9/L$ ，血小板 $150 \times 10^9/L$ ，血细胞比容 42%，骨髓象基本正常。嘱其注意摄生，饮食清淡，勿过劳累，并服参苓白术丸以善其后，随访 2 年未复发。

水蛭为噬血之物，专入血分，善于搜剔瘀血。寄居阴湿之处，故性寒凉，功在凉血破瘀，消积散结。《神农本草经》曰：“味咸平，主逐恶血、瘀血内闭，破血癥聚无子，利水道。”。用于真红细胞增多症正为合拍。

水蛭之用量用法亦极为讲究，用之得当，可收事半功倍之效。可见只要辨证准确，临证可放胆用之，不必瞻前顾后。张氏临床一般用量在 9~15g，甚至 20g。张氏初用水蛭必经焙炙，即使药证相符亦疗效欠佳。始不解其义，至阅《医学衷中参西录》之“水蛭解”，方明其堂奥。张氏认为：水蛭最宜生用，甚忌火炙。水蛭原得水之精气而生，炙后则伤水之精气，破血消癥之力减弱。现代药理学研究表明：水蛭含水蛭素、抗血栓素、组胺样物质、肝素。水蛭素能阻碍血液凝固，扩张血管，促进血液循环，降低血小板聚集率，改善血液流变学。鲜品中含水蛭素较多，炙后水蛭素多分解破坏，因此炙水蛭之效远不如生用。

总之，真红细胞增多症是以毒、瘀为主要病理特点的难治性疾病，而水蛭具有多种功效，只要临证机圆法活、知常达变，就能获效。

第七章 化痰止咳平喘药

重用半夏经验

半夏最早载于《神农本草经》，其性温，味辛；归肺、胃、脾经；其基本功效有燥湿化痰，降逆止呕，消痞散结，外用消肿止痛。多用于痰饮证、哮喘证、咳嗽、眩晕证、呕吐证、心下痞、结胸、梅核气、瘰疬、痰核、痈疽肿毒、毒蛇咬伤及失眠等。临床常用量 3~10g。

王国三重用半夏治癫痫

河北名老中医王国三根据古今所论，认为半夏擅治寒痰、湿痰、呕吐、痞满、结胸、梅核气、瘰疬、瘰疬等症。故在临床上发古人之未发，认为癫痫一病，大多有痰阻脑窍所致，根据半夏温化寒痰的功效，对癫痫的治疗，运用大剂量的生半夏，一般用量在 30g 以上。配伍白附子、生南星等，可收佳效。

如治李某，女，32 岁，因垂体瘤术后而继发癫痫，已长达 2 年之久，每月发作数次，每次均为大发作。曾服用卡马西平等西药，症状有所缓解，但停药即发。邀王老诊治。刻下：头晕而沉，头痛而胀，脘痞，周身疲惫，舌质黯，苔白厚腻，脉弦滑。王氏认为，此乃痰阻清窍，拟温化寒痰、通络开窍之法。处方：生半夏 30g，陈皮 10g，茯苓 15g，白附子 15g，生南星 15g（先煎 30 分钟），龙齿 40g（先煎 30 分钟），炙甘草 6g。上方加减连服 60 余剂而愈。随访 1 年未再复发。

江尔逊重用半夏治失眠

四川经方大家江尔逊善于重用半夏治疗失眠。如治一男性失眠患者，46 岁。4 年前因事拂逆，郁怒难伸，渐致失眠。4 年来常服中成药，如归脾丸、养血安神片、朱砂安神丸、柏子养心丸等，临睡前加服西药安定。近半年来失眠加重，每晚必服安定 5mg 方能浅睡三四小时，且多梦纷纭，怵惕易惊。又因宿患慢性胃炎、慢性胆囊炎，常用三九胃泰、胃苏冲剂、消炎利胆片等，似效非效，甚是烦恼。刻诊：面容瘦削，略显晦暗，胃脘满闷而不痛，暖气频频，口干苦，纳差、大便



偏干，舌质红，苔黄粗厚，脉弦沉。

患者长期饱受失眠之苦，唯求安睡，无复他求。然则宿病胆热犯胃，胃失和降，宿病不除，卧安从来？今先行清胆和胃，用黄连温胆汤合小陷胸汤、半夏泻心汤化裁，使胆宁胃和则易安卧矣。处方：法半夏 15g，茯苓 30g，竹茹 20g，炒枳实 15g，黄连 5g，黄芩 10g，干姜 5g，瓜蒌仁 15g，太子参 10g，蒲公英 30g，4 剂，安定照服。

二诊：胃脘满闷消失，暖气、口干苦、怵惕易惊等减轻，大便通畅，睡眠略有改善。患者喜，乃续服本方，而停服安定。但当晚便通宵失眠，不得已复用安定如前。服至 12 剂，纳开，口苦除，唯仍不敢停服安定，停服则入睡极难，心烦不安。察其舌质仍红，苔黄薄少津，脉弦沉而细。知其胆热胃逆之证已愈，而露出肝郁血虚之底板。乃改投舒郁养血的酸枣仁汤加味：酸枣仁 30g，茯苓 30g，知母 12g，川芎 10g，炙甘草 10g，丹参 30g，百合 30g，3 剂，安定减半服。

三诊：睡眠仍无明显改善，上方加法半夏 40g，夏枯草 30g，高粱米 50g。服用 3 剂后，入睡较快，且能安睡四五小时；停服安定，继服至 15 剂后，入睡如常人，能安睡五六小时矣。嘱将上方制成蜜丸常服。半年后追访，睡眠大致正常。

从上例后，江氏治失眠顽症，恒在辨证方的基础上加法半夏 30~60g，高粱米 50~100g，夏枯草 15~30g，颇能提高疗效。

众所周知，半夏分生半夏和制半夏两类。生半夏有毒，若用至 40g，应注明先煮半小时以破坏其有毒的成分。今则连法半夏即制半夏 40g 亦拒付之，盲令初涉医林者遭遇满头雾水。

江氏总结半夏应用经验：①制半夏无毒；生半夏有毒，久煮可消除其毒性。②制半夏可用大剂量，不必先煮；生半夏宜先煮半小时以去其毒性，若重用 30~60g，以先煮 1 小时为宜。③若顾虑到半夏炮制不规范而可能残存毒性，则在使用大剂量（30g 以上）时不妨先煮半小时，以防万一。④半夏使用机会多，取效的关键是用量：若燥湿化痰，6~10g 足矣；降逆止呕，15~20g 不为多；镇静安神，必用 30~60g。

马明和重用半夏治失眠

马氏认为法半夏一般治疗失眠多用 30~60g 方效，法半夏先用净蜂蜜炙后加入他药同煎 30 分钟，取汁 300ml，徐徐咽下，其疗效卓著。治疗失眠，不用大量半夏不易取效。马氏有很多病例都是先用常用量不理想，再加大法半夏用量而获显效的。所以只要认证准确，亦可径用大量，略加炮制。不会有副作用，而且能缩短疗程。现代药理研究证实，法半夏对中枢神经有良好的镇静和安眠作用。法



半夏用蜜炙后，可去其毒性，保留其功效。

如治韩某，女，45岁，工人。因其丈夫检查出重病，以致烦躁不安，彻夜不能入寐1月余。来诊时，自述服西药镇静安眠药、中药汤剂等都无明显效果，仍不能入寐。神志恍惚、心悸、心烦，食欲不振，舌质淡红、苔滑腻微黄，脉弦滑。综观舌、脉、症，属气郁痰结，胃气不和所致。拟法半夏40g，百合15g，合欢花15g，茯苓15g，石菖蒲12g，3剂，水煎服。服后夜能入睡4~5小时，又原方续服2剂，睡眠正常，他症悉除。随访2个月，未复发。

赵强重用半夏治痰

赵氏认为，半夏味辛苦，性偏温，有毒。其功用为燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结。半夏生用，辛散之力强，临床常用生半夏为主治疗一些有形痰结或瘀结，如肿瘤、囊肿、炎性包块之类，收效甚卓。临床治疗疑难杂病时，有时用姜半夏、法半夏无效时，改用生半夏却收显效。可见其虽有毒性，但能发挥药效。生半夏用于散结，药量宜大，辨证时要认准痰瘀结滞之象，与生地黄同用，一燥一润，一温一凉，有相得益彰之妙。半夏生食确有毒性，但伍药入水煎，或单味水煎，时间在1小时以上，分次服用，则其毒性大减，即使用量较大（30g），也未发现中毒现象。

黄和重用半夏治多寐

黄氏认为半夏通阳化浊、开郁行滞、宣窍醒脑之功常被人忽视。临证重用半夏治阳郁、痰结、湿滞、浊蔽、热壅、气郁、血瘀等所致多寐，疗效颇佳。

黄氏临床实践体会，治疗多寐，小剂量半夏疗效不明显，30g以上方显其化浊开郁、通窍醒脑之功，而60g以上时镇静宁神作用增强，故剂量为30~60g效佳。因半夏性燥有毒，临床多不敢重用，其实大可不必过于担忧。《中药学》虽明言半夏有毒，但又指出有毒成分能被白矾所消除，故符合炮制规范的制半夏再经煎煮后几无毒性。《内经》所载之半夏秫米汤，半夏剂量达到5合（今约65g），可谓开半夏重用之先河。古今善用而重用半夏者，首推张仲景，如大半夏汤中半夏用量2升（今约260g）。现代如颜德馨、王士福、陈连起、胡学刚、沈丕安、牛元起诸贤皆为当今名医，均善以重剂半夏治疗顽症痼疾，大剂常用30~120g，即使生半夏，亦常用至60g。黄氏临证半夏常重用至30~150g，即使5~6岁小儿亦有用至30~45g者，并未见毒性反应。何况方剂之低毒高效者，非仅单味药物之作用，而尤得于臣佐助制之善也，加之煎服法得当，自能避其短而奋其功。

如治李某，女，43岁。身重体乏，头昏沉，困倦嗜卧，醒后缺乏清醒感，仍欲思睡，平素畏寒食少，胃脘不适，时欲恶呕，间断双下肢轻微凹陷性浮肿，病



已2年余。舌胖舌边见齿痕，舌苔薄白而腻、舌中略兼黄苔，脉滑而无力。胃镜诊断为浅表性胃炎，化验血常规示轻度贫血。辨证为脾胃虚弱，痰湿壅滞。治宜健运脾胃，通补阳气，化痰除湿，宣窍醒脑。方用健运脾胃醒脑汤加减。半夏60g，白术60g，党参60g，干姜30g，麻黄6g，陈皮30g，羌活15g，茯苓100g，黄连3g。每日1剂，水煎分2次服，每次服150ml。服药3剂后症减，精神已振。继服7剂后嗜寐消失。前方略为加减，继服7剂巩固疗效。

吴宁重用半夏治老年便秘

吴氏认为，多数老年性便秘病人长期服用泻热通便之剂，久之伤脾损胃，致脾失健运，胃失通降，水湿不布，肠燥失润，便结不通。临床特点是病人腹无所苦，或偶有腹胀纳差，大便3~5日甚或10余日不解，口臭，纳食不香，小便频数等。相当于《伤寒论》所说的“脾约证”。而半夏味辛，性温。“辛以润之”“温以通之”，且有燥湿化痰之功效，合麻子仁丸有相辅相成之作用，唯其用量需大，60g是起始用量，根据病情可加大至120~150g。较单纯应用麻子仁丸效果更好，尤其是远期疗效。

如治王某，女，74岁。2010年7月9日初诊。便秘不通4~5年，初服芦荟胶囊、番泻叶、润肠丸可通一时，旋即如故。某医曾给“大承气汤”，日泻水样便10余次，形体困乏，口干咽燥，之后依然。刻下：形体较胖，口淡无味，口臭熏人，纳食不香，腹无所苦，舌质淡、苔厚腻，脉沉伏。辨证：脾约证。治法：润肠滋燥，缓通大便。处方：麻子仁45g，白芍45g，大黄30g，枳实30g，厚朴30g，杏仁15g，生半夏90g。以水1600ml，煎至600ml，每服200ml，日3次。服完1剂，大便通畅，日1~2次。其便不稀、不燥。续服5剂，其疾告愈。其后出现大便不通，即用上方，效若桴鼓。

朱树宽重用半夏治三叉神经痛

山东名医朱树宽认为，三叉神经痛当属痰厥头痛，其病机为痰凝火郁络阻，治疗恒以半夏为主药，灵活化裁，取得良效。

如治傅某，男，76岁。1989年3月5日初诊。患者于1个月前无明显诱因出现右侧面部灼热疼痛，如鸡啄、似刀割，牵及齿龈和前额，每于洗脸、刷牙、甚至说话而诱发或加剧。某医院诊为三叉神经痛。予卡马西平治疗，效不显，改用穴位封闭，开始有效，后无效，且愈益加重，疼痛剧烈。日发作10余次。每次持续约几十秒至1分钟，伴烦躁难眠，纳谷不香，求治于中医。余见患者舌体淡胖、苔白滑而腻，脉弦滑有力，诊为痰凝火郁络阻。不通则痛。处方：姜半夏30g，生石膏30g，细辛6g，僵蚕10g，全蝎6g，白附子10g，川芎10g，川牛膝10g，



生姜 30g 为引，水煎温服，日 1 剂，早晚分服。服药 2 剂，疼痛大减，每日仅轻度发作 1~2 次，上方姜半夏改为 60g。继服 2 剂。疼痛消失。遂嘱常服礞石滚痰丸合止痉散，以资巩固。随访 5 年，未再复发。

又治张某，女，53 岁。1995 年 11 月 11 日初诊。患者左侧三叉神经痛已 18 年，长期服用卡马西平。3 年前在当地医院行三叉神经上颌支及下颌支切断术，疼痛得以缓解。术后 1 年，疼痛又复发如初，呈阵发性剧烈痉挛作痛，每天发作 10 余次，每次持续约 1 分钟，伴烦躁不眠。前医诊为瘀血阻络，先予通窍活血汤，不效；再予散偏汤，仍不效。余见患者舌苔白腻，脉沉细而弦，诊为痰瘀阻络、风火上扰。处方：半夏 30g，川芎 30g，僵蚕 10g，蝉蜕 15g，姜黄 10g，大黄 10g，全蝎 6g，蜈蚣 2 条（冲服），生姜 10 片为引，水煎温服。上方服 5 剂，疼痛缓解，日发作减为 2~3 次。上方半夏改为 60g。继服 5 剂，疼痛基本消失。遂嘱服礞石滚痰丸配四虫片以资巩固。随访年余，未见复发。

朱氏回忆在 1989 年收治三叉神经痛患者傅某时，对半夏这味教科书上注有毒性的药物，尚多畏惧感。故初用半夏，只取姜半夏，且还用生姜 30g 为引，在用量上也是先从 30g 开始，逐渐加至 60g。后因疗效非凡，方敢放胆投用。考半夏，善交通阴阳治失眠，《内经》有半夏秫米汤；吴鞠通深谙半夏之妙用，曾重用半夏二两（60g）治失眠。西医称三叉神经痛系神经细胞异常放电所为，故用药多取镇静、镇痛之苯妥英钠、卡马西平等。治疗三叉神经痛用半夏，亦取镇静、镇痛之功矣。唯应注意。半夏用量至为关键，其小量（6g）可降逆和胃，中量（15g）可化痰开结，大量（60g）可镇静止痛。治疗三叉神经痛，非用大量方取佳效，临床应用 10 余年，未发现不良反应。

重用天南星经验

天南星最早载于《神农本草经》。其性温，味苦、辛，有毒；归肺、肝、脾经；其基本功效有燥湿化痰，祛风解痉，外用散结消肿。多用于湿痰、寒痰证、风痰眩晕、中风、癫痫，破伤风、痈疽肿痛、蛇虫咬伤、疼痛症等。临床常用量为 3~10g。

李现林重用天南星治关节疼痛

河南名医李现林教授善用、重用制天南星治骨关节疼痛。李氏借鉴著名老中



医王士福教授治痹之秘在于重剂的经验，重用制天南星治疗多种骨关节疼痛，取得良好的效果，临床主要用于以下几种疾病。

用于治疗类风湿关节炎：类风湿关节炎是一种常见病、疑难病，在其急性发作期多表现为关节肿胀疼痛、积液、关节活动受限、皮温增高等急性滑膜炎的表现，常可导致关节破坏而留下残疾。李氏采用加减木防己汤加制天南星治疗类风湿关节炎，多获良效。处方：防己 25g，薏苡仁、生石膏各 30g，木通、黄柏各 10g，制天南星 60g，桂枝 6g，独活 15g。水煎服，每天 1 剂，3 周为 1 疗程。

用于治疗腰背筋膜炎：腰背筋膜炎多见于中年女性，表现为夜间腰背部酸困疼痛，辗转反侧难于入寐，早晨起床活动后症状缓解，舌黯红，脉弦细。李氏据证辨为寒湿痹阻，气血不通。治当祛寒燥湿，活血通络。方用小活络丹加减重用制天南星，药用制川乌、制草乌、乳香、地龙、没药各 10g，当归 15g，丹参 30g，制天南星 60g。水煎服，每天 1 剂。一般患者半月内症状即可解除。

用于治疗腰椎间盘突出症：腰椎间盘突出症是一种常见病、多发病。劳累、扭伤、受寒、负重等为其诱发因素。临床以腰痛伴放射性下肢疼痛麻木为其特征，下肢发凉，行走不利，舌多黯红，脉弦细。证属肝肾不足，气血瘀阻。治以温补肝肾，通络止痛。药用独活、续断各 20g，杜仲、川牛膝、制川乌、制草乌各 10g，当归、白芍各 15g，桑寄生 30g，制天南星 60g。水煎服，每天 1 剂，每获奇效。

用于治疗骨性关节炎：骨性关节炎多发于中老年人，女性高于男性，发病部位以膝关节最多，病变部位疼痛肿胀，活动受限，X 线片可见关节间隙狭窄、增生等退行性改变。证属肝肾不足，气血不通。治当补肝肾，壮筋骨，活血止痛。药用熟地黄、川牛膝各 10g，骨碎补、当归、淫羊藿各 15g，续断 20g，桑寄生 30g，制天南星 60g。水煎服，每天 1 剂，常获良效。

李氏认为，天南星是一种善治多种疑难疾病的奇特良药，由于其苦、辛温，有毒，具辛烈开泄之性，遂使众多医家慎用或弃用。然而胡建华认为川天南星、生天南星直接口含对口腔黏膜确有一定的刺激作用，但一经煎煮，则无任何不良反应。白矾炮制后（制天南星）也可去其毒性。《本草纲目》云：“南星得防风则不麻，得牛胆则不燥，得火炮则不毒。”近年来有许多学者对此均有论述，如刘嘉湘教授治疗癌肿每剂生天南星内服用量达 30~60g，经万余人使用，均无不良反应。徐伯平通过临床观察发现天南星用于治疗肿瘤，其疗效与剂量、持续时间有关，每剂用量宜 >60g，若经久煎（持续煎沸超过 2 小时），并在餐后服，每剂生天南星用量不超过 100g 服用是安全的。天南星经白矾炮制后（制天南星）可去其毒性，再入汤剂煎煮后则毒性殆尽。因此，制天南星煎汤内服，虽大剂量使用也



是安全的。

现代许多名医善用天南星。如张士颢老中医擅长用天南星治疗疑难杂症，认为天南星入汤剂可荡涤经络之血瘀痰阻，从而起到通痹止痛之效。王士福老中医常用 60g 以上的大剂量制天南星治疗湿痰流注关节之痹证，每每收效显著。王老云：“观诸伤科书治骨折诸方，多有重用南星者，深思其理，始悟古人以南星专止骨之痛。”李氏临证体验，在辨证用药的基础上，配合使用大剂量天南星，具有明显的镇痛作用，对各类骨关节疼痛者，多收捷效而无不良反应。

重用竹沥经验

竹沥最早载于《名医别录》。其性寒，味甘；归心、肺、肝经；其基本功效有清热豁痰，定惊利窍。多用于痰热咳喘、中风痰迷、惊痫癫狂等。临床常用量 30～50g。

江尔逊重用竹沥治痰热

四川名老中医江尔逊善用竹沥治疗痰热疾病，《血证论》所载豁痰丸原方，竹沥仅 3 钱，约合今之 9g，而江氏临证多重用 300ml，是否非用这么多不可？

竹沥一味，非重用不可！这是江氏的独家经验，也是他在患病自疗中的亲身体会。江氏 40 年前，向有痰饮宿疾，初则咳嗽、胁痛、寒热如疟，服香附旋覆花汤而愈。不久，又受外感复发，外证不彰，唯咳嗽痰多，胸部牵掣作痛，用六安煎不效，改用香附旋覆花汤亦不效。又数次更医，皆不中的。病益剧，呼吸、转侧均牵掣胸部作痛，仰卧于床，稍动气喘痰鸣，痰浊稠黏，有如饴糖成筋丝状，咳至口边而不出，须用手捞之，7 日之间，饮食不进，口干欲饮，入水则呛，势近垂危。他的老师陈鼎三先生诊之，辨为痰热蕴肺，乃嘱人急砍竹子，多备竹沥，仍煎豁痰丸，兑入竹沥 3 碗（约 500ml）。下午 3 时服头煎，黄昏服二煎。至半夜，感觉痰浊已减少，气喘胸痛亦减轻，竟可翻身；又服三煎，次晨诸症大减。其痰浊既未吐出，亦未泻下，于不知不觉中逐渐消失，且知饥索食。守方再服 1 剂，便可扶床走动，2 日后即可出门。改用气阴两补方药调理半月，身体康复如初。从此以后，江氏用本方抢救痰热壅肺伤津危症时，便推己及人而重用竹沥，屡用不爽。

竹沥何以有此卓效呢？《本草衍义》说：“竹沥行痰，通达上下百骸毛窍诸处，



如痰在巅顶可降，痰在皮里膜外可行；又如癫痫狂乱，风热发痉者可定；痰厥失音，人事昏迷者可省，为痰家之圣剂也。”

实践证明，竹沥重用之，其清热豁痰与润燥生津两擅其长，无出其右者，据江氏体验，每剂最少不能少于 60ml。又豁痰丸原方用的是荆竹沥。江氏临证时就地取材，曾用过淡竹沥、苦竹沥、茨竹沥等，疗效均不可靠，而以苦竹沥为优。最后再强调一次：豁痰丸取得卓效的关键是重用竹沥。

重用皂角刺经验

皂角刺最早载于《神农本草经》。其性温，味辛；归肺、大肠经；其基本功效有消肿排脓，祛风杀虫。多用于痈疽疮毒初起或脓成不溃之证以及皮癣、麻风等。临床常用量为 3~10g。

李幼安重用皂角刺治痈肿

湖北名医李幼安临床上将皂角刺用治于痈肿、历节风等疾收到良效，其用量较大，视病者之体质和病情之轻重而定，最大可达 120g，量少则杯水车薪，无不见效者，药录病例三则下。

1. 乳腺炎 丰某，女，28 岁。产后 9 天，双侧乳房肿痛，伴胃寒发热，精神疲惫，纳差，便秘，尿短赤。经局部穿刺检查而确诊为“急性乳腺炎”，注射青链霉素 7 天及服中药 2 剂罔效，遂来我处就诊。诊见左侧乳房有肿大，右侧乳房皮肤焮红，触痛明显，脉弦大，舌边尖略红，苔黄微腻。体温 38.8℃，白细胞计数 $15 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞 80%，淋巴细胞 19%，嗜酸性粒细胞 1%。综观脉症，证属气滞夹热毒所致，治宜理气消瘀解毒。处方：皂角刺 90g，鹿角片 15g，赤芍 10g，丝瓜络 12g，橘荔枝各（打）15g。水煎服。服上药 3 剂后，肿块缩小而能活动，热退痛减，精神及食纳好转，二便正常，脉和缓，苔薄黄，舌质红。续进 3 剂而诸症消失痊愈。

李氏几十年来以皂角刺为主（大剂量）治疗早期脓未成之乳腺炎近千例，均获满意效果。

2. 痈肿 李某，男，30 岁，工人。患者右侧髂窝处包块如鸡蛋大 10 余天，动辄疼痛，行走困难，经中西药治疗未见明显效果，后由友人介绍求诊于余。诊见脉弦数，舌红苔薄黄，诊断为“腹股沟肿块”，此乃热壅血瘀，治宜清热破瘀消



肿，方用皂角刺 90g，穿山甲 6g，水煎服，连服 5 剂肿块消失，行走如常而痊愈。

彭某，男，40 岁。患者右侧腿部肿硬作痛半年余，痛时腰不能直立，行动不便，经多方面检查，诊断为“静脉炎”，服用中医药而罔效，后由常听李氏谈及皂角刺作用的友人告诉患者，用皂角刺 120g 煎水代茶频饮，每日 1 剂，连服 20 余天，腿痛消失而痊愈，甚为佩服。

皂角刺辛温而开关利窍，又能攻毒导滞，破瘀消肿，其直达病所，溃痈散毒之力尤著。凡治外证，溃散之力频强，内治之证，消除之功尤显。临床上可用治于小儿重舌、小便淋闭、肠风下血、肠风下痢、妇人乳痈、腹内生疮、历节风及肌肉痈肿者等，若以米醋熬皂角刺涂疮癣尤有奇效。

重用葶苈子经验

葶苈子最早载于《神农本草经》，其性大寒，味苦、辛；归肺、膀胱经；其基本功效有泻肺平喘，利水消肿。多用于痰涎壅盛、喘息不得平卧、小便不利、水肿、悬饮、胸腹积水等。临床常用量为 5~10g；研末服，3~6g。

朱星江重用葶苈子治哮喘

上海名老中医朱星江认为哮喘的治疗需辨别虚实，有邪为实，无邪为虚，实喘在肺，重在祛邪，虚喘在肾，重在扶正。根据中医学理论，结合临床经验，治疗的根本法则概括为三句话，即泻肺气（平气化痰）、保元气（健脾利湿）、纳肾气（温补肾阳）。其基本方为：葶苈子 30~60g，大枣 30~60g，生白术 30~60g，炙马兜铃 9g，肾气丸 12g（包），生甘草 9g。方中葶苈子、大枣为葶苈大枣泻肺汤为方中主药，有泻痰行水、下气平喘作用。葶苈子辛、苦、大寒，泻肺平喘用于肺经邪实之喘咳痰多，且有利水消肿作用，其对于因哮喘年久而影响心脏功能者尤为适用。大枣缓中补脾，以防泻痰伤正。葶苈子常用量为 3~9g，但只要配合得当，辨证正确，用量可以适当加大，一般不会出现副作用，尤其是对于个别顽固性哮喘可用到 60g。此时可能有些病人出现腹泻，极个别病人出现呕吐。如有呕吐，剂量应适当减少。如腹泻，一般剂量不减，再加煨诃子 9g。一般病人用量在 30g 左右时，达到明显的泻肺平喘作用。方中生白术健脾补中，善能燥湿，配大枣加强其健脾补中之力，有培土生金之意，用量同葶苈子。马兜铃具有清肺降气、化痰止咳作用，是本方一味重要配伍药物。肾气丸能温补肾阳，以纳肾气。



甘草调和诸药且有祛痰、镇咳作用。本方药虽八味，配伍得当，重点突出，照顾到肺、脾、肾三脏，扶正祛邪，用在哮喘发作期，攻补兼施。

根据辨证论治原则，病虽同属哮喘，但有寒热及其各种不同的兼症之分。如属寒喘加麻黄 9g，白果 10~30 枚；如属热喘，加麻黄 9g，石膏 30g；如舌质红，阴虚加南沙参 15g，阿胶 45~9g 冲服；如咳嗽重者加炙百部 9g，炙款冬花 9g，炙紫菀 9g；如咳痰不爽者，加礞石滚痰丸 9g（包煎或 3g 吞服）；如出现腹泻者同用煨诃子 4.5~9g。其他随症加减，如有肺心病者忌麻黄。

对于哮喘缓解期，仍要按上述基本方加减，加重温补肾阳药，每周服 2~3 剂，以巩固疗效，或药量相应减轻，葶苈子、大枣、生白术均减为 15~18g。

如治姚某，女，32 岁。1973 年 12 月 2 日初诊。11 岁起患哮喘，时常发作，每年冬季发作厉害。今气急，咳嗽，痰多白稠，咳痰不畅，面部稍有浮肿，苔薄腻，舌质淡红，脉细带滑，治以泻肺健脾、化痰益肾法。目前在服用氨茶碱、肾上腺素。处方：葶苈子 30g，大枣 30g，生白术 30g，炙马兜铃 9g，肾气丸 9g（包），生甘草 9g，诃子 9g，补骨脂 9g，炙百部 9g，炙麻黄 4.5g，礞石滚痰丸 3g，分 2 次吞。

二诊：上方服 23 剂，喘平，痰量减少，且易咳出，精神佳，夜寝已安，氨茶碱、肾上腺素已停服，脉细濡，苔薄。处方：葶苈子 30g，大枣 30g，生白术 30g，炙马兜铃 9g，肾气丸 9g（包），生甘草 9g，诃子 9g，补骨脂 9g，炙麻黄 4.5g，海藻带（各）15g，炙远志 3g，礞石滚痰丸 9g，每日 3g 分 2 次吞。

患者愈后回沈阳，按上述基本方药在沈阳连服两个多月，在气温零下 30℃ 左右哮喘未发。1974 年 5 月 6 日返回上海，途中疲劳过度，出现气急乏力，苔薄脉细，用调补脾肾药如补中益气汤、附桂八味丸等。处方：党参 9g，黄芪 9g，当归 9g，白术 9g，茯苓 9g，甘草 9g，砂仁粉 4.5g（吞），阿胶 6g（烊冲服），葶苈子 30g，大枣 30g，附桂八味丸 9g。共服 20 剂而愈。

余国俊重用葶苈子治肺胀

四川名老中医余国俊先生治疗肺胀擅用葶苈子。《金匱要略》论肺胀，即以咳嗽胸满为主症的肺气胀满，类似现代医学的“肺气肿合并感染”，查《金匱要略》越婢加半夏汤、小青龙加石膏汤均为肺胀实证，故皆通过祛逐内外之合邪以泻肺除胀。然临床虚证并不少见，虚者以“胸闷气短”为主症，可伴有语声低微，自汗、浮肿、心悸、舌质淡、脉弱等症。其病机为肺肾气虚，肺气虚则肃降乏力，肾气虚则摄纳无权，致令清气难入，浊气难出，逆于胸中而成肺胀，类似现代医学的“肺气肿缓解期”，宜补肺益肾，可用参蛤散合右归丸加减，若上实下虚者，



可用苏子降气汤。余氏临床治疗肺胀，无论虚证、实证，均在当用方药中加葶苈子一味，重用致 30g 以上，有提高泻肺除胀之效。查古籍均言葶苈子猛峻，虚证不宜用之，即使实证用之，亦不过 9g 上下。但笔者重用此药，有时一剂竟达 60g 以上，每每取效，从未债事。近年来药理研究证实，葶苈子有较好的强心作用，值得引起重视。

李文瑞重用葶苈子治胸水

名老中医李文瑞认为葶苈子具有泻肺排热痰、消心胸之水之功效，部分与强心的现代药理作用基本相合。重剂用于心胸之水、痰热壅盛等病证，方可获效。常在葶苈大枣泻肺汤、小陷胸汤、千金苇茎汤、麻杏石甘汤等方中重用。临床主要用于肺炎、感冒所致之痰多色黄，以及心包积液、胸腔积液等。服药期间未见耗气、减慢心率等不良反应。李氏一般用量 3~10g，重用 15~25g，最大用至 30g。如治一女性 24 岁患者。咳嗽 8 月余，偶作喘。初诊时症见咳嗽痰多，色黄质黏，咳出不爽，胸闷憋气，纳食尚可，小便色黄，大便偏干。舌淡红，苔黄微腻，脉弦滑。证属痰热壅肺，宣肃失司。遂投予葶苈大枣泻肺汤合小陷胸汤。重用葶苈子 30g，并加紫菀 25g，服 5 剂后，咳嗽有缓，痰排出甚多。原方再进 5 剂，痰量减少。遵原方加减，继服 2 周，病告痊愈。未再复发。

陈汝兴重用葶苈子治心衰

陈氏善用葶苈子治疗心力衰竭。心力衰竭往往表现为水钠潴留水肿，陈师根据《素问》“平治于权衡，去菀陈莖，开鬼门，洁净府”的理论，主张治心力衰竭宜佐开鬼门、洁净府、去菀陈莖治水三法。开鬼门原指宣肺发汗，陈氏灵活变通，在心力衰竭的治疗上，理解为调整肺的布散宣肃，以通调水道，其常用紫苏子、桔梗、胡颓叶，尤为喜用葶苈子以泻肺利水，且量大，常用 30g 之多。现代药理研究表明，葶苈子对衰竭的心脏可增加其输出量，降低静脉压均需较大剂量才能起强心苷样作用。洁净府，意在行水利尿，其作用在肾，常和五加皮、泽泻、大腹皮等利水消肿。去菀陈莖，作用于脉，旨在散瘀通络，活血化瘀，常用川芎、丹参，尤擅用益母草，此药不仅活血化瘀，且具利水之功，用之于临床，确有较好的强心利水消肿之功效。

第八章 安神平肝潜阳、 息风止痉开窍药

重用酸枣仁经验

酸枣仁最早载于《神农本草经》，其性平，味甘；归肝、心、胆经；其基本功效有养心益肝，安神，敛汗。多用于心悸失眠、自汗、盗汗等，临床常用量为 9～15g。

刘惠民重用酸枣仁治失眠

山东著名中医学家刘惠民教授善于重用酸枣仁治疗失眠，纵观刘氏以前古今医者单剂用量极少有超过 15g 以上者，晚近更有人提出，本药如 1 次用量超过 50 粒，即有发生昏睡、丧失知觉，使人中毒的危险。刘氏根据《名医别录》酸枣仁能“补中，益肝气，坚筋骨，助阴气，能令人肥健”的记载，并结合其自身多年来用药的实践经验，认为酸枣仁不仅是治疗失眠不寐之要药，且具有滋补强壮作用，久服能养心健脑，安五脏，强精神，并认为“酸枣仁用至 50 粒即有中毒”的说法不足为凭，刘氏治疗神经衰弱，酸枣仁几乎为必用之品，其用量除根据体质强弱、病情轻重而酌定外，一般成人一次剂量多在 30g 以上，甚有多达 75～90g 者，用量五六倍于他人，从而完全突破古今本草方书对本药用量之记载。

如治房某，男，37 岁，1957 年 4 月 6 日初诊。1953 开始，经常心悸，头晕，头痛，头胀，失眠，多梦，胸闷，气短，烦躁易怒，有时面浮肢肿，食纳尚可。面色黯红，眼睑及下肢轻度浮肿，舌苔白厚，脉虚弱。辨证为心肾不足，脾失健运。治法：滋肾养心，益气健脾。处方：炒酸枣仁 45g，山药 18g，柏子仁 12g，朱茯神 12g，石菖蒲 6g，天冬 9g，远志 45g，天麻 9g，淡豆豉 12g，栀子皮 6g，茯苓皮 12g，知母 12g，砂仁 9g，橘络 9g，白术 9g，水煎两遍，分 2 次温服。人参 15g，琥珀 0.9g，共为细粉，分 2 次冲服。



5月23日来函：按上方服药20余剂，效果颇佳，精神很好，体力增强，心悸减轻，睡眠好转，仍多梦，劳累后面仍浮肿。原方加山茱萸12g，菟丝子18g，以增强补肾之功，继服。

又如治葛某，男，39岁，1958年6月27日初诊。1951年起，经常失眠，多梦，头痛，眩晕，眼花，脑胀，耳鸣，心慌，烦躁，易怒，记忆力减退，伴有脱发、阳痿等症，食欲一般，饭后上腹部闷胀，有时胃脘隐痛，大便稍干，2日1次。面黄，体瘦，舌苔薄黄，脉虚弱。辨证：肾气不足，心肾阴虚，痰热内盛。治法：补肾养心，益阴生津，清热化痰。处方：酸枣仁（生熟各半）37g，枸杞子12g，柏子仁9g，夜交藤9g，生菟丝子25g，天冬12g，合欢皮9g，生珍珠母31g，天竺黄6g，淫羊藿9g，生龙齿15g，豆豉12g，橘络12g，石斛12g，生白术9g，白豆蔻9g，肉苁蓉9g，山栀子6g，水煎两遍，分2次温服。西洋参15g，琥珀06g，共研细粉，分2次冲服。7月9日二诊：服药8剂，睡眠好转，每天能睡8小时以上，头晕、头胀、头痛等症均减轻，食纳好转，胃脘已无不适，大便已正常，仍多梦，舌苔脉象同前。嘱原方继服。7月16日三诊：又服上方6剂，诸症基本痊愈。

刘氏实践证明，只要配伍得宜，大多可应手取效，且无不良反应。根据刘氏的经验，在神经衰弱的治疗中如能根据病情和体质酌情应用重剂酸枣仁，实乃取得良好效果的关键，反之如墨守成规，迷于用多中毒之说，则常因病重药轻，杯水车薪，乃至延误病情。在酸枣仁的用法上，刘氏常喜欢生熟并用，乃宗《本草纲目》“熟用疗胆虚不得眠，生用疗胆热好眠”的论述，认为酸枣仁生熟之差，在作用上有兴奋或抑制的不同作用之故。

重用夜交藤经验

夜交藤最早载于《何首乌别录》一书。其性平，味甘；归心、肝经。其基本功效为养血安神，祛风通络，止痒。多用于心神不宁、失眠多梦、血虚身痛、风湿痹痛、皮肤痒疹等。临床常用量为9~15g。

朱良春重用夜交藤治失眠

国医大师朱良春教授认为：在诸多安神药中，以夜交藤催眠作用最佳。盖阳入阴则寐，夜交藤入心肝二经血分，功擅引阳入阴故也。此品善于养血，故用于



血虚所致的失眠，最为适宜。因其性平和，其他各种原因所致的失眠，亦可作为佐使药用之。唯其用量宜大，少则不效。朱氏处方一般恒用 30g，重症失眠则用至 60g，每每应手。

如治章某，男，48 岁，教师。患失眠 2 年余，屡服人参归脾丸、安神健脑液不应，每晚需依赖服安定片，始能维持 2~3 小时睡眠。心烦不安，胁胀口苦，面红，舌边尖红，脉细数。缘由情志失畅，肝郁化火，劫灼阴血，血不荣心，故彻夜不寐。治宜养心肝之阴，清浮越之热。方用：细生地、桑椹子各 15g，玄参 10g，知母 10g，川黄连 6g，白芍 12g，茯神 12g，酸枣仁 12g，麦冬 12g，生甘草 3g，夜交藤 30g。7 剂。药后能在不用安定的情况下睡 3 小时。药既奏效，毋庸更张。原方夜交藤加至 60g，续服 12 剂。三诊时患者欣喜来告，每晚已可熟睡五六小时，嘱用上方 10 剂，蜜丸，每丸重 10g，日 1 丸，夜 2 丸，以巩固疗效。

另外，夜交藤又有活血、通经、止痒之功。《本草从新》谓其“行经络，通血脉”，《本草纲目》谓其主治“风疮疥癣作痒，煎汤洗浴”。临床上常以之治疗老人身痒，盖高年阴血多虚，血虚生风故痒，夜交藤有养血活血之功，洵为当选之佳品。内服常配生地黄、红花、徐长卿、忍冬藤、牡丹皮等。沐浴时用夜交藤 200g 煎汤擦身，其效尤佳。

陈慈煦重用夜交藤治失眠

已故贵阳中医学院名老中医陈慈煦教授善用夜交藤治疗失眠。陈氏认为夜交藤镇静安神，本为藤类药物，兼可以通络。其味淡质轻，需重用 30g 以上才可以建功。对胃痛呕酸兼失眠病人，酸枣仁味酸不宜用，用夜交藤配合欢皮可宁心安神解郁。对于失眠又兼关节炎者重用夜交藤最为合拍。合欢皮安神宁心，兼可解郁，为一物二用之品。费伯雄《医醇膳义》有“合欢解郁汤”，以合欢皮开郁为主，因情志不遂、思虑过度而引起的失眠用之最佳。

冯先波重用夜交藤治失眠

贵阳市名医冯先波先生亦善用夜交藤治疗失眠，常在辨证论治处方中加用夜交藤、龙齿、珍珠母、合欢皮四药。夜交藤养心安神，《饮片新参》谓：“养肝肾、止虚汗、安神催眠”，唯剂量宜大方有效，冯氏常重用 30g；合欢皮取其解郁安神，现代患者失眠多因工作压力大、思虑过度所致，合欢皮可使心肝安和、情志喜悦而收安神之效；龙齿、珍珠母为重镇安神之品。冯氏认为此四药虚实皆可应用，对于虚证，在补虚为主的基础上少佐重镇安神之品，收标本兼治；实证则重用此四味，临床可收速效。



重用龙骨经验

龙骨最早载于《神农本草经》。其性平，味甘、涩；归心、肝、肾经；其基本功效有镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩。多用于心神不宁，心悸失眠、惊痫癫狂、肝阳眩晕、湿疮痒疹，疮疡久溃不敛等，临床常用量为 15~30g。

尹岭重用龙骨治经验

尹氏临证擅长使用重剂量龙骨、牡蛎治疗，多获奇效，现介绍如下。

1. 孤独症案 刘某，男，17 岁。2009 年 2 月 9 日初诊。自幼性格孤僻，不善与人交流，随年龄增长，逐渐出现自伤行为。阵发性有喉间抽动和跳跃动作，有强迫症状，喜爱背诵火车时刻表，有反复刻板动作。双腕皮肤有蚕茧大隆起瘢痕，询问患者系自咬所致。曾服用苯巴比妥、苯妥英钠、丙戊酸钠、卡马西平、礞石滚痰丸等药物均无明显疗效。体格发育正常，心理发育幼稚，面色正常，舌红苔白，舌体肥大，牙龈增生，脉浮弦。乃阳不入阴，魂魄飞扬。治重镇摄纳，燮和阴阳。予大量龙骨、牡蛎等药。药用：龙骨 50g，牡蛎 50g，柴胡 12g，桂枝 15g，升麻 12g，党参 6g，生地黄 20g，炙黄芪 20g，炙甘草 10g，白术 15g，当归 12g，陈皮 20g。每日 1 剂，早晚分服。守方 1 个月，患者服药后，喉间抽动和跳跃动作发作次数和时间明显减少，能主动和父母交流，自残行为消失。嘱患者每天三顿饭后服用鲜竹沥 10ml，以涤痰开窍。随访半年，情况稳定。

按语：本患者正值青少年，心肝火旺，心火亢盛，心神不宁，加之火盛炼津，炼液为痰，乃阳不入阴、魂魄飞扬之病。用大剂量龙骨、牡蛎重镇摄纳，燮和阴阳，清代医家邹澍曾述龙骨、牡蛎挽空灵之阴阳，与桂枝、柴胡、承气汤无不可会合成剂，而摄阳以归土，据阴以召阳，再助用涤痰开窍的竹沥，长期服用以达良效。

2. 顽固性失眠案 张某，女，55 岁。2009 年 12 月 5 日初诊。夜晚入睡困难。每夜仅睡 2~3 个小时。凌晨需来回走动以减轻难以言说的全身不适。恙已 1 年。CT、MRI 均无异常发现。北京友谊医院诊断为不安腿综合征。曾服用泰必利等药均无良效。诊见：神清语利，略有惫态，无自主运动。舌红苔白，脉细数。始用百合地黄汤效果欠佳。此乃虚多邪少，神不守舍。治当补虚，安神定志。予以



大量龙骨牡蛎与百合地黄汤加减。处方：龙骨 50g，牡蛎 50g，百合、生地黄各 30g，天花粉、石斛、糯稻根各 15g，知母 12g，浮小麦 30g，甘草 6g。水煎服，每日 1 剂，早晚分服。用药后自觉全身舒服，每夜睡眠时间延长，即使不入睡躺在床上也能耐受。守方半年，睡眠正常。停药后症状无复发。

按语：患者年过半百，阴精亏虚，因形体失阴濡养，浮阳躁越，单用百合地黄汤效有不逮，故在用百合地黄汤滋养阴液的同时，给予龙骨、牡蛎摄阳以归土，据阴以召阳。

3. 多动症验案 叶某，男，7 岁。2010 年 3 月 10 日初诊。患儿出生足月顺产，平素未得过特殊疾病。于 3 岁左右时，好动少静，容易急躁，性情执拗，爱破坏家具，计算力差，反应迟钝，略口吃，语言表达尚可，上课爱做小动作，不能和同学较好相处。既往脑电图和磁共振检查排除癫痫和大脑器质性病变。诊见：时坐立不宁，表情不耐烦。舌红苔白，脉象弦滑。据证分析，当系肝旺脾弱，阴液内伤，神守不宁，浮阳外越。治宜调肝理脾，开窍益智，宁神制动。方用甘麦大枣汤合大量龙骨牡蛎为治。药用：龙骨 50g，牡蛎 50g，桂枝 15g，陈皮 12g，生甘草 9g，浮小麦 9g，大枣 2 枚。每日 1 剂，早晚分服。用药 7 剂后，患者日常生活中小动作明显减少，不再挑衅小朋友，行为自控力较前加强。嘱其守方 3 个月以图远效。

按语：龙骨引火归土，可借以化气生精；牡蛎召阳归阴，可借以平阳秘阴。二者联用，可用于不同原因导致的惊狂、烦惊、烦躁。龙牡煎后无异味，性味平和，与滋补心脾真阴的甘麦大枣汤合用，宜于儿童长期服用，以奏药效。

4. 幻视听案 林某，女，43 岁。2010 年 3 月 12 日初诊。患者为家中长女，未婚，因父早亡，养成极度要强个性。10 年前与其兄合伙做生意发生矛盾，彼此关系极不和睦。近期出现幻视、幻听 3 个月，病情呈加重趋势，但否认自己有病。诊见：神清语利，与人沟通正常，略显疲惫，面白无华，舌淡红、苔白边有齿痕，脉滑缓。病机乃心脾不足，化痰生瘀，内风欲作。方用豁痰化瘀、燮和阴阳之法。药用：龙骨 50g，牡蛎 50g，浙贝母 12g，丹参 9g，香附 9g，三七（冲服）3g。每日 1 剂，早晚分服。10 剂后患者幻听、幻视消失。嘱其守方 20 剂巩固疗效。

按语：张锡纯认为龙骨善化瘀血，牡蛎善消坚结，二药并用，能使血之未离经者永安其宅，血之已离经者尽化其滞，对痰瘀互结引起的神志疾病，正合病机。



重用赭石经验

赭石最早载于《神农本草经》一书。其性寒，味苦；归肝、心、胃经。其基本功效为平肝潜阳，重镇降逆，凉血止血。多用于肝阳上亢、头晕目眩、中风、妊娠恶阻、气逆喘证等。临床常用量为 10~30g。

邹孟城重用赭石治脑震荡

名老中医邹孟城善用赭石治疗脑震荡。脑震荡与脑挫伤之治疗，素无特效疗法，中医多主平肝化痰、潜阳息风。邹氏以前以钩藤、石决明、姜半夏、茯神、天麻、龙骨、牡蛎、磁石、竹茹、白蒺藜等治疗数例，鲜获速效。后读曹惕寅先生之《诊暇录稿》，得以单味赭石重投缓服，以治脑震荡之法，用于临床，其效应若桴鼓。先后四五例，投剂辄应。

如治陶某，男，48岁。1979年10月5日上午，与邻居因事争执，被木棍击伤头颅、腰背及眼部，当即晕仆，急送某区中心医院急诊。在该院留观12日，诊断为“脑挫伤”。出院时腰背及眼外伤渐愈。血压由入院时220/130mmHg下降为130/90mmHg。其时主症为头晕泛恶剧烈。于出院当日邀余往诊。自诉：击伤伊始，即晕不可支，旬余以来，虽针药迭进，而症无少减，只能静卧，不能稍动躯体，稍稍动作，即觉天旋地转而眩晕欲仆，随即泛恶频频，但不呕吐。一日三餐及饮水服药均由家属喂饲。余诊得脉象弦滑，舌质、舌苔无异常。速予：赭石100g，加水两大碗，煎至一大碗，待温后，以汤匙缓缓喂饮，约4小时饮尽。当日下午开始服药，至傍晚，甫尽药汁之半，已可自行翻身。于是续服前药而尽其剂，及夜半独自下床登厕矣。然步履蹒跚，时欲以手扶物。翌日又服1剂，即恢复正常。直至1989年以他病逝世，生前未见任何脑震荡后遗症。

此案眩晕甚而无呕吐，《诊暇录稿》之案，则为呕吐剧烈，神识不清。该书原刊于1927年，以后未见再版，渐成凤毛麟角矣。今照录原文，以资读者印证：

“粤东范君之女，年五龄。自楼窗跌仆下坠，狂妄躁语。与饮吐，得食食吐。不能辨识父母，目不交睫。或云肝阳挟痰，或谓温邪痰滞。历五日夜，医药罔效。后经其友绍余往诊，切其脉错乱无定。外既不伤于风寒，内亦无病于痰滞，筋骨肌肉，亦无重伤，实以身躯颠倒重震，浊气反上，清气下陷，姑宗镇胃降浊法治之。独味煅代赭石五两，煎汤三大碗，每隔十分钟用小匙饮五六匙。饮未及



半，神识大清，呕吐亦止，啜粥一盂，安卧而瘥。”

夫赭石一物，《医学衷中参西录》谓“其质重坠，又善镇逆气，降痰涎，止呕吐，通燥结，用之得当，能建奇效。”观此两案，可知其于脑震荡、脑挫伤症之眩晕、呕吐卓具殊效，无疑是治疗脑震荡、脑挫伤之首选特效中药。此症之病机，曹氏谓为“浊气在上，清气在下”，而治疗大法取“镇胃降浊”，与通常所用之平肝潜阳、化痰息风之法不同，迥出意表，可谓匠心独运，实为脑震荡、脑挫伤病机之研究开一门径。

张平重用代赭石治呕吐

赭石用量一般为 10g~30g，40g~120g 即为大剂量。张锡纯曾在《医学衷中参西录》中记载，应用大剂量赭石治疗因胃气不降而致的吐衄、呕吐等症，疗效甚佳。张氏受其启发，通过反复实践观察，体会到重剂赭石在治疗呕吐一症中，功效显著。

如治赵某，男，37 岁，工人。2000 年 6 月 7 日就诊。患者 3 天前因饮食不洁，出现胃脘部疼痛，呕吐不止。经用解痉、止痛、消炎等西药治疗，胃痛止，仍频繁呕吐，食不下，遂来中医就诊。刻诊：急躁易怒，胃脘胀满，呕吐酸腐浊物，噯气，口不渴，大便 2 日未行，小便黄赤。舌质红，苔黄腻，脉弦实。辅助检查：胃肠钡剂示胃炎（胃内存有潴留液）。中医辨证：饮食停滞兼肝气犯胃。治以降胃化滞，疏肝理气。处方：赭石 45g，木香 15g，槟榔 15g，芒硝 10g（冲服），灵芝 12g，延胡索 10g，川厚朴 12g，神曲 15g，山楂 15g，云苓 20g。连服 4 剂，呕吐、胃痛止，大便已下，唯觉腹胀、纳差，再拟以疏肝养胃剂以善其后，诸症消失。随访半年，无复发。

又如治范某，女，32 岁，工人。于 2002 年 4 月 5 日就诊。患者有十二指肠球部溃疡病史 2 年，近因工作劳累，出现胃脘不适，伴呕吐大量清水痰涎，进食则吐，前来我科就诊。刻诊，面色萎黄，四肢困重，畏寒肢冷，胃脘隐痛，吐清水，喜热饮，纳差，大便溏薄，小便自调。舌质淡，苔白腻，脉沉细。中医辨证：脾胃虚寒，湿阻中焦。治以温中健脾，降胃止呕。处方：赭石 45g，党参 30g，附子（先煎）10g，干姜 6g，陈皮 12g，半夏 9g，茯苓 12g，苍白术各 15g，薏苡仁 12g。服上方 3 剂后，呕吐止，遂去赭石，继以原方为基础，随证加减，连服 20 剂，诸症悉除。复查胃肠钡餐透示：十二指肠球部溃疡已愈合。随访 1 年未复发。

引起呕吐的原因很多，其病机为胃失和降、胃气上逆所致。治疗在于使逆气得降，呕吐得止。张锡纯：“赭石，善镇逆气，降痰涎，止呕吐，通燥结。”又谓“降胃之药，实以赭石为最效”。张氏临床观察，重用赭石治疗呕吐一症，只要辨



证正确，配伍得当，用之获良效。值得注意的是，但因其性味苦寒，对于脾胃虚寒型呕吐，须以附子、干姜、吴茱萸等伍之，且中病即止，不可久用。而对于气虚者，佐拟人参、党参等品适量，效果更佳。

重用蜈蚣经验

蜈蚣最早载于《神农本草经》。其性温，味辛，有毒；归肝经；其基本功效有息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。多用于痉挛抽搐、疮疡肿毒、瘰疬结核、风湿顽痹、顽固性头痛等。临床常用量煎服 3~5g；研末冲服，每次 0.6~1g。

周济安重用蜈蚣治破伤风

著名老中医周济安先生多年经验认为，蜈蚣为治疗破伤风的要药，任何情况都可选用。用于破伤风有镇痉息风、解毒等作用，故适用于本病之牙关紧闭、抽搐挛急性阶段，且须大剂量使用，方能取效，周氏常用 20 余条，未见不良反应，否则疗效较差。自古以来，蜈蚣就被列为有毒之虫，而对其用量加以限制，一般只用 1~2 条，以防中毒，但研究发现，原来蜈蚣的毒性存在于头部颚齿中。这种毒在活体蜈蚣内有较强的毒性，用在自卫和捕食时麻痹猎物。但蜈蚣死后，它颚齿中的毒素会被迅速氧化，变性为无毒的成分。因为蜈蚣毒是一种蛋白质，在一定的空气、温度、湿度下易变性而失去活性。特别是药用蜈蚣，均是先将蜈蚣处死，加热干燥，这个加工过程已使蜈蚣毒完全被破坏，因此重用时会不会中毒。过去，临床使用本品，往往要去头足、尾足，以减少其毒性，现在看来，完全没有必要。试验表明，成年人每次服用蜈蚣数量最多可达 25 条，长期服用无不良反应。周氏体会，破伤风来势急，病情重，传变快，非大剂量运用解毒药是难以奏效的，诚如张景岳所说：“若安危在举动之间，即用药虽善，若无胆量勇敢，而药不及病，亦犹杯水车薪。”故凡辨证准确而病重者，必须大胆施以重剂，方能力起沉疴。此外，配合针刺治疗，对退热解痉有很好疗效，值得重视。

如治刘某，男，42 岁，农民。1963 年 4 月 27 日初诊。患者 18 日与社员抬水缸，不慎绳断打伤右脚掌外侧小趾处，伤口如一汤圆大，当时流血约 50ml，经公社医院外科常规处理。于 24 日开始恶寒，身痛，背强，牙紧，急去该院服药打针（药名不详）。延至 27 日诸症加重，牙关紧闭，汤药难进，时见抽搐，又经诊治



但病情急剧恶化，抽搐加急，故此以“破伤风”急诊入院。检查：急性病苦笑面容，牙关紧闭，舌苔不可窥及，饮食难进，项背强直，角弓反张，周身筋肉挛急，2~5分钟抽搐1次，汗出如洗，衣被尽湿，体温39.8℃，小便黄赤，大便4天未解，脉象洪数。此为阳明热盛、风阳妄动之候。治宜清热泻火，息风镇痉，方用白虎汤加减：石膏60g，知母12g，甘草10g，大黄12g，全蝎10g，蜈蚣20条，蝉蜕10g，鸡矢白10g（焙干，研末吞服）。

4月29日复诊：患者口噤稍松，抽搐次数减少，身热、汗出亦减，但大便仍未解。继以上方加重大黄至18g，嘱服2剂。

5月2日三诊：大便已解，泻下臭秽浊物多次，口噤基本解除，尚能咀嚼，躯干强直减轻。惟身热未清，体温38℃，舌质红绛，脉虚弦而数，此为热伤气阴、余毒未尽之候。拟竹叶石膏汤加减：淡竹叶12g，石膏30g，太子参15g，麦冬18g，金银花15g，连翘12g，天花粉15g，鸡矢白10g（研末吞服），2剂。

5月5日四诊：诸症悉平，行动自如。饮食睡眠正常，因略有低热，仍按原方嘱再进2剂。共住院10天痊愈出院。

又如治罗某，女，28岁，农民。1963年6月15日初诊。因产后7天突然喉痛，吞咽困难，未曾服药。次日开始痉挛抽搐，经当地医院诊治，服中西药物多剂，了无寸效，更见项背强直，四肢僵硬，牙关紧闭，肌肉抽搐，高热汗出，经急诊室确诊为“破伤风”而入院。通过西医抢救，注射大量破伤风抗毒素，以及镇静药物等，诸症如故，次日约见会诊。检查：急性病苦笑面容，牙关紧闭，进食困难，头项强直，腹肌板状硬，每隔10分钟左右全身阵挛1次，发热口渴，喉间痰声漉漉，舌尖有咬伤，舌质红，苔薄黄，脉洪大浮数。此乃毒热壅盛、风痰内动之候。治宜清热解毒，息风镇痉，方用玉真散加减：防风12g，天南星10g，天麻12g，蝉蜕12g，全蝎10g，蜈蚣20条，僵蚕15g，金银花18g，连翘15g，甘草10g，鸡矢白10g（焙干，研细吞服）。并针百会、颊车、合谷、太冲，均用泻法，留针15分钟。

6月17日复诊：上方服后，病情基本稳定，但仍抽搐，神志欠清，继以前方1剂，送服紫雪丹3支。针刺少商、地仓、合谷、丰隆，针法同前。

6月18日三诊：牙关紧闭解除，神志转清，抽搐次数减少，惟口渴心烦，咳嗽痰多，此为痰热壅肺、清肃失常之候，嘱勿惊扰。停针刺，照原方去防风、南星，加黄连6g，贝母10g，服法同前。

6月20日四诊：诸症悉平，喉间已无痰声。为巩固疗效，嘱再进上方5剂。于6月25日痊愈出院。



刘复兴重用蜈蚣治皮肤病

云南名老中医刘复兴教授认为蜈蚣“凡疮疡诸毒皆能消之”，因蜈蚣有消炎解毒之效，对疮疡痈毒、肿瘤、久治不愈之皮肤病，刘氏都善用之，小至3月幼童，大至9旬老人，用之未见不良反应，故刘氏提出“皮疾起沉痾，必用蜈蚣”。刘氏用蜈蚣粉配乌梅外敷腐肉、腐肉、皮赘，疗效切实。此外，在治疗感染性皮肤病，如毛囊炎、体癣、疣、带状疱疹等时，刘氏常在内服或外洗方中重加蜈蚣2~3条，取其杀虫生肌之效，老师曾用蜈蚣脚碾粉外用治伤或溃疡，确有祛腐生肌之效。

刘伟胜重用蜈蚣治恶性肿瘤

广东名老中医刘伟胜教授善用蜈蚣治疗恶性肿瘤。刘氏认为，中医历来认为气滞血瘀是恶性肿瘤发生的一个主要病机，气机不畅，则津、液、血运行代谢障碍，积而成块以生肿瘤。因而凡肿瘤患者见血瘀证均可用理气活血法。蜈蚣能息风止痉，祛风通络，解毒散结；全蝎能消肿散结，息风止痉，镇静止痛。刘氏根据恶性肿瘤的病机，辨证使用蜈蚣、全蝎。因寒致瘀，与温阳祛寒药同用，寒得温则散；气滞血瘀，应理气活血，加强活血化瘀药对血液循环系统的作用；气虚血瘀，则配合补气益气药，有助于正气的恢复和瘀血的祛除，减少活血化瘀药伤正之弊；血瘀与痰凝互结，则宜配合祛痰散结药，以增强消散肿块的作用。一般在辨证方中加入蜈蚣2~3条。

刘氏认为，由于肿瘤病人正气多已受损，其治疗不耐一味猛烈攻伐，使用全蝎、蜈蚣之品时，应衰其大半而止矣。根据患者的体质状况和耐攻承受能力，把握用量、用法及用药时间，方能收到预期的效果。同时，全蝎、蜈蚣之品较少单独全程用于肿瘤的治疗，多在扶正培本的基础上佐予，或在肿瘤发展的某一阶段慎用而用之。

况时祥重用蜈蚣治脑出血

贵州名医况时祥教授善用蜈蚣治疗脑出血。况氏认为，蜈蚣息风通络，又擅化瘀，用于脑出血急性期，有促进血肿消散、通畅血管的良好作用，用于后遗症期，又能活血通络，促进偏瘫等症的恢复。一般急性期宜重用，后遗症期剂量宜小。况氏临证时，急性期常以蜈蚣6条，配水蛭15~30g，地龙20g；后遗症期以蜈蚣2~3条，水蛭、地龙、僵蚕各6~9g，白花蛇、壁虎各5g作为常规用药配入辨证方药中，以此治疗10余例脑出血患者，均获满意效果。

李士懋重用蜈蚣经验

河北名医李士懋临证以全蜈蚣入药，不去头足，不炒不炙，以大者、生者为



佳。其用量常在 10~40 条。

如治王某，女，47 岁，2006 年 7 月 4 日初诊。有高血压家族史，其他无不适。舌淡稍暗、苔白，脉沉涩滞。辨证属血虚生风。治宜益气养血息风。方用黄芪四物汤加减：黄芪 40g，当归 15g，赤芍、白芍各 15g，川芎 8g，熟地黄 15g，僵蚕 12g，蝉蜕 7g，蜈蚣 10g，全蝎 12g，葛根 12g，升麻 6g，党参 15g，水煎服，每日 1 剂，分 2 次温服。7 月 11 日复诊：脉沉滞，舌淡暗，有齿痕，苔少，头胀消失，血压 130/85mmHg，复方利血平减为每日 1 片。上方去党参、升麻，改蝉蜕 12g，黄芪 60g，蜈蚣 15g，加地龙 18g，并嘱停西药。7 月 25 日：又服上药 14 剂，脉沉弦滞，较前略起；舌淡有齿痕、苔薄白，无不适，血压 130/80mmHg。调方：黄芪 90g，当归 15g，赤芍 15g，白芍 15g，川芎 8g，僵蚕 12g，蝉蜕 10g，蜈蚣 20 条，全蝎 12g，升麻 6g，葛根 30g，地龙 15g，怀牛膝 12g。继服 20 剂停药。至 2006 年 10 月 30 日回访，血压 130/80mmHg，无其他不适。

此患者脉弦涩滞为阴血不足，经脉失柔，涩滞不畅，故当补气养血息风。用黄芪四物汤以补气养血；伍以蜈蚣、僵蚕、蝉蜕、全蝎、地龙等虫类药物以平肝息风，未见毒副作用，血压平稳。

又如治吕某，男，45 岁，2005 年 4 月 12 日初诊。主诉：头晕，寐差，夜只能睡 1~2 小时，烦躁，不欲饮食，舌质暗红、苔薄黄，脉沉弦数而拘紧，血压 160/100mmHg，未服降压药。辨证：肝热生风。治以清热平肝息风。方药：水牛角 30g（先煎），僵蚕 15g，蝉蜕 4g，全蝎 10g，蜈蚣 30g，怀牛膝 15g，牡丹皮 12g，生地黄 15g，赤芍 12g，白芍 15g，钩藤 15g（后下），石决明 30g（先煎），生龙骨、生牡蛎各 30g（先煎），鸡内金 15g，焦三仙各 15g，川楝子 9g。水煎服，每日 1 剂，分 2 次温服。4 月 19 日复诊，药后头晕明显减轻，饮食增加，睡眠好转，夜能睡 3~4 个小时，舌暗红、苔薄腻，脉弦数细，已不拘紧。血压 150/90mmHg。依上方改蜈蚣 10 条研细粉，分 2 次冲服，汤药中加夜交藤、夏枯草各 30g，服法同前。又连续服药 20 余剂，头晕消失，睡眠及饮食正常，血压 130/85mmHg。

脉沉弦数而拘紧，为肝经郁热，筋脉失柔所致；肝经郁热，热盛生风，上扰清窍则头晕；郁热内扰，神失潜藏则烦躁、失眠；肝旺脾虚运化失常则不欲饮食。故用水牛角、牡丹皮、生地黄、赤芍清肝泻火，凉血解毒；全蝎、蜈蚣、僵蚕、蝉蜕平肝息风，怀牛膝滋补肝肾；白芍柔肝敛阴；石决明、生龙骨、生牡蛎、钩藤清热平肝，镇静安神；川楝子疏肝行气；鸡内金、焦三仙健胃消食助运化以养



后天。诸药合用而奏清热平肝息风之功。复诊其脉弦数细，已不拘紧，症状减轻，故以蜈蚣 10 条研粉吞服，使之充分发挥药效，并加夜交藤强养心安神之力；夏枯草增其清肝泻火之功。显示了蜈蚣重剂的息风之力。

重用全蝎经验

全蝎最早载于《蜀本草》一书。其性平，味辛；归肝经。其基本功效为息风镇痉，攻毒散结，通络止痛。多用于痉挛抽搐、疮疡肿毒、瘰疬结核、风湿顽痹、顽固性头痛等。临床常用量煎服 3~6g；研末冲服，每次 0.6~1g。

王常绮重用全蝎治风湿痹痛

王氏善用全蝎配蜈蚣治疗风湿痹痛。全蝎味辛性平，蜈蚣辛温燥烈，走窜性猛。二药行表达里，窜筋透骨，逐湿祛风，无所不至，能搜剔隧道之邪，起到解痉止痛，可称之为活络祛风止痛之要药。临床可用于各类型之痹证，然以寒凝之痹证效佳，可配伍乌头汤，对痹痛能较快地起到散寒、通络止痛之效。全蝎和蜈蚣虽均有毒性，但王老在多年临床应用中未发现一例中毒现象，其用量全蝎 9~15g，小儿酌减；蜈蚣 3~6 条，均研末冲服，其效更佳。

周世明重用蜈蚣治难治性疼痛

周氏常重用全蝎 10g、蜈蚣 3 条治疗难治性疼痛。周氏认为，疼痛不单是局部原因，还与全身脏腑经络的病理变化密切相关。例如顽固性偏头痛，多因肝风夹痰火，循经上炎而致。癌性疼痛多因气血亏虚，寒热错杂，瘀阻气滞而致肿毒疼痛。骨质增生疼痛多由骨质增生，继发关节肿胀，积液渗出，刺激椎动脉，直接压迫血管使之狭窄，致动脉供血不足。中医学认为，该病乃因经络空虚，风寒湿邪乘虚侵袭，致经络痹阻，气血凝滞，血脉不通，而致颈项强痛，腰部胀痛。所以医治疼痛必须根据脏腑经络理论，利用脏腑经络相连、功能相应、病理变化相关等特点，以中医辨证施治。全蝎、蜈蚣具有息风止痉、解毒散结、通络止痛之功效，可激发经气，疏通经络，促进气血运行，使药力直达病所，缓解疼痛，再针对病因病机，配合其他行气活血、清热除痰、解毒散结等药物，故能取得满意的疗效。



重用蟾蜍经验

蟾蜍最早载于《药性论》。其性温，味辛，有毒；归心经；其基本功效有解毒，止痛，开窍醒神。多用于痈疽疔疮、瘰癧、咽喉肿痛、痧胀腹痛、神昏吐泻等。临床常用量为蟾酥内服 0.015~0.03g，蟾皮研末入丸、散，每次 0.3~0.9g。

李幼安重用蟾蜍治顽疾

湖北名医李幼安善用蟾蜍治疗顽疾。李氏认为，蟾蜍的药用价值是值得称道的。据《中药大辞典》记载：蟾蜍有“破癥结、行水湿、化毒、杀虫、定痛”等功用。现代临床报道，其可以治疗恶性肿瘤及肝硬化腹水等病症。药用有蟾头、蟾皮、蟾舌、蟾酥、干蟾、蟾蜍胆等品种。李氏临证试之，确有良效。

用于治疗肝癌：取活蟾蜍 1 只，稍大者较好，麻油 500ml，煎枯去渣，以此油炒菜食用，每月可服麻油 1500ml 左右。笔者曾遇 5 例肝癌患者早期配合治疗，均有不同程度的缓解作用。其中一例已存活 10 年，一例已存活 3 年，均健在。虽然这些病例都同时用过解毒抗癌的中草药，但觉未服此油者疗效较差。

用于治疗肾病综合征：取活蟾蜍 1 只，稍小者较好，杀死，去内脏，用馒头包裹蒸熟后去蟾蜍，将馒头 1 日服完，分 2~3 次均可，如无反应，间隔旬日可以再服 1 次。笔者最初耳闻患者服用此方有效，继而视察两例，其中一例连续服用 2 次，病情缓解，3 年未发。一例初服中药调补脾肾、清利湿热之品半年尚无显效，后加用此法 2 次而缓解，至今历时 8 年，未见病情反复，此例服第 1 只蟾蜍馒头时无任何反应，服第 2 只时有恶心呕吐现象，3 日后即恢复正常。

用于治疗臌胀（肝硬化腹水）：取干蟾 15g（烤酥），制香附 5g，大枣肉 10g。前二味研为极细末，枣肉蒸熟捣烂，加米糊为小丸，如绿豆大，米粉与药物量为 1:3。每日服 1 次，每次 2~6g。如有头晕、恶心、呕吐、腹痛、腹泻时，则即时停药，此为先祖遗方，以后沿用尚觉有效。

以上拾零，反映蟾蜍的药用价值还是比较大的，使用方法的多样化也是可取的。本药为有毒之品，但根据药性及病情适当选择应用，还是可取的。

第九章 补虚、收涩、 攻毒杀虫止痒药

重用黄芪经验

黄芪始见于汉墓马王堆出土的帛书《五十二病方》，在《神农本草经》中列为上品。其性微温，味甘；归肺、脾经；其基本功效有补脾升阳，益肺固表，利尿消肿，托毒生肌。多用于脾气虚证、中气下陷、固表止汗、水肿、托毒生肌、气虚便秘等。临床常用量为 9~30g。

邓铁涛应用黄芪的经验

国医大师、著名中医学家邓铁涛教授善用黄芪，且在不同的疾病中灵活变动剂量，每每获得佳效。

1. 陷者举之 重用黄芪以升陷，其适应证为脏器下垂（如胃下垂、子宫下垂、脱肛、肾下垂等）、重症肌无力、肌肉萎软、呼吸困难、眩晕等属气虚下陷者。

胃黏膜下垂者可用四君子汤加黄芪 30g，再配枳壳 3g 以反佐，一升一降，升多降少，所以要用枳壳反佐，因胃属腑主受纳，胃气以降为顺，虽然黏膜下垂需升，但胃气需降，故重用黄芪补气升提以治黏膜下垂，而反佐枳壳以顺应胃气以下降，以促进胃黏膜之复原。治脱肛，内蒙古《中草药新医疗法资料选编》载方：用黄芪 120g，防风 9g。此方实出王清任治脱肛之黄芪防风汤。王氏方：黄芪四两，防风一钱。李东垣认为：防风能制黄芪，黄芪得防风其功愈大，乃相畏而相使也。可见王清任之黄芪防风汤实源出于东垣，防风之分量不宜多用。此法治脱肛的确有效。

重症肌无力，治以强肌健力饮，此方为自拟经验方，亦重用黄芪为主药。重症肌无力证候较复杂，除眼睑下垂外，可有复视，吞咽困难，构音不清，四肢无力，重者呼吸困难，大气下陷，危及生命。邓氏认为该病的最大特点是肌肉无力，



因脾主肌肉，故此是脾胃气虚之证，并由虚至损，且与五脏相关。治疗上紧抓脾胃虚损这一病理中心环节，重用黄芪以补气升陷，同时针对兼夹之证调理五脏，重补脾胃，以运四旁，促病痊愈。

2. “升”者平之 此处一言“升”，血压升高也。高血压一病，肝阳上亢者为多，临床上多使用平肝潜阳、降逆息风之品，但亦有不效者。邓氏治疗气虚痰浊型之高血压者，则重用黄芪合温胆汤以治之。据《中药研究文献摘要》所载日本寺田文次郎等报告：“与其他六种可以注射的降血压制剂比较，证明黄芪的作用强大。虽然有的药剂可使血压有持续性下降的作用，但此种药剂大量使用后，可使动物衰弱。”这一结论，从药理研究角度支持了重用黄芪可以降压。

此外，邓氏认为，治疗高血压若从帮助改善血流供求关系，帮助血压升高所要去实现的调节反应，因势利导，促其成功，则不需要再有高血压反应的持续激起。这一论点正道出了治气虚型高血压重用黄芪，就在于调节脏腑阴阳之平衡，改变“重要器官血流供求矛盾的严重脱节”的局面，促使“血压升高的血管反应”缓解而达到降压之效果。这就是重用黄芪以降压之机制所在。

怎样解释黄芪降压与升陷之理？邓氏的体会是：黄芪轻用则升压，重用则降压。为什么药理研究只得一个降压的结果？因为动物实验都是大剂量用药进行研究的，所以得出降压的结果。邓氏治疗低血压症，喜用补中益气汤，方中黄芪的分量不超过 15g。治疗气虚痰浊型高血压，邓氏喜用黄芪合温胆汤，黄芪分量必用 30g 以上。

诚然，补中益气汤除了黄芪之外还有柴胡与升麻，可使升提之力倍增。在重用黄芪降血压时亦可加潜阳镇坠之品，效果当然更好，但不加镇坠药亦有降压作用，这是可以肯定的。曾会诊一中风患者，偏瘫失语而血压偏高，辨证为气虚血瘀之证，处方以补阳还五汤，黄芪照方用四两，该院西医生对黄芪四两有顾虑，拟加西药降压，晓之以理，照方服药后血压不升反降，乃信服。

虽说黄芪重用可以降压，有证有据，但黄芪仍然是益气升阳之药，这一点不可不加以注意。如果辨证为肝阳上亢或有内热之高血压亦想用几两黄芪以降压，则犯“实实之戒”了！慎之，慎之。由此可见，药理学之研究目前尚未能为邓氏们解答全部之问题，仍须辨证论治。

3. 攻可补之 邓氏曾治一气阴两虚之胎死腹中之患者，初用平胃散加芒硝，并配合针灸，后用脱花煎，皆因药证不符而未效，再经仔细辨证，借用王清任治产难之加味开骨散，重用黄芪 120g，外加针灸，1 剂而死胎产下。开骨散是以宋代龟甲汤加川芎而成，明代又名加味芎归汤，此方重用当归、川芎以行血，龟甲



潜降，血余炭引经而止血，本方不用攻下药和破血药，故明代以后多用以治难产。清代王清任认为，本方治产难有效有不效，缘于只着重于养血活血忽视补气行气，故主张在开骨散的基础上，重用黄芪以补气行气，使本方更臻完善。此例何以用加味开骨散取效？缘患者妊娠8个月，胎动消失7天，诊其舌淡嫩，剥苔，脉大而数，重按无力，更兼问诊知其妊娠反应较甚，呕吐剧烈，食纳艰难，致使伤津耗气，病虽实而母体虚，本不任攻下，故用平胃散加味和脱花煎无效。此例说明重用黄芪可下死胎。这是寓攻于补之法也。

4. 瘫者行之 对于偏瘫、截瘫等属于气虚有痹者，补阳还五汤是一张特别著名的效方。它出自王清任的《医林改错》。张锡纯虽然批评了王氏对于治疗半身不遂过于强调阳气不足之说，认为痿证有虚也有实。补阳还五汤用之要得当。但张氏不能不说：“补阳还五汤其方实甚妥善也。”邓氏曾用此方治疗各种脑血管意外后遗症属气虚血瘀之偏瘫者，都有不同程度的疗效，有恢复五成的，也有恢复八九成的。曾治一例严重截瘫之女性青年，就诊时已卧床数月，两腿消瘦，自膝下皮包骨头，需人搀扶起坐，坐亦不能持久，邓氏乃用补阳还五汤加减治之，黄芪初用120g，最大量时用至200g，服药8月余，并经艰苦锻炼，已能扶拐杖缓慢行进，1年后参加工作，2年后能去掉手杖跛行，后结婚生一子。

邓氏体会使用补阳还五汤需要注意两点：一者辨证须是气虚血瘀之证；二者黄芪必须重用至120g，不宜少于60g方效，其他药量也可略为增加，但决不能轻重倒置。

5. 表虚固之 李东垣认为，黄芪能补三焦又能实卫气。卫气者，温分肉而充皮肤，肥腠理而司开阖者也。“实卫”就是“固表”。自汗一证，玉屏风散为疗效确切的名方。邓氏体会此方不但治自汗，一些盗汗属气虚者亦适用。为了方便，常用汤剂，其分量为：黄芪12g，防风3g，白术15g。防风用量少于黄芪，白术的量是黄芪与防风的量之和。治自汗盗汗兼阴虚者，邓氏喜用玉屏风散加生龙骨、生牡蛎各30g，或加浮小麦、糯稻根各30g，若汗出特多者加麻黄根10g。

治疮疡烂肉，黄芪也是一味重要药物，曾会诊一患者，腋下肿瘤摘除之后，伤口久不愈合，不断渗液，一天要换多次纱布。用补益气血之剂重用黄芪30g后渗液减少，不到半月而伤口愈合，此黄芪内托之功也。

6. 证须审之 邓氏虽喜用黄芪，但黄芪到底是药，不是粮，用之对证则效，用之不当则害人。曾治一肺结核病人，于养阴除痰药中加入黄芪9g，1剂额部发热，2剂全面发热，3剂颈面均热，撤去黄芪热自消失。又治一中风患者，药后头皮发痒，体温增高，误以为外感，改用辛凉解表之剂，1剂退热，再用黄芪90g，



又再发热，右上肢活动反而退步，乃知辨证不当。细想患者脉虽虚大，但舌苔厚腻而舌质不胖亦无齿印，此证痰瘀比较，痰湿重于血瘀，改用祛痰为主，稍加祛瘀之药，以五爪龙代黄芪，证遂好转。对于使用黄芪的指征，邓氏认为舌见淡胖有齿印，脉虚大或寸部弱，再参察有否其他气虚之证候，便可考虑使用。至于用量之多寡，则要时时留意证候之变化，切戒墨守成规，刻舟求剑。

傅萍重用黄芪治肝硬化腹水

傅氏临床重用黄芪治疗肝硬化腹水，收到良好疗效。傅氏认为肝硬化腹水病程多较长，肝郁则必克脾土，脾虚运化失职则水湿内聚。因此，无论在肝硬化早期或晚期，皆可在辨证的基础上加用黄芪。早期健脾，以防传变。即《金匱要略》所谓：“见肝之病，知肝传脾，当先实脾。”晚期则健脾为其主要治法，黄芪乃必用之药。其健脾益气可固其本，又具利水之功，可治其标，即具表里皆治之功，其见效快、疗效好的特点也就更显而易见了。

有言黄芪大补，能助火伤阳，有壅邪内闭之虞。但从临床来看，在对肝硬化腹水的治疗中，只要配合得当，就不会产生任何副作用。临床上傅氏常常重用黄芪 30~150g，无任何副作用。傅氏的体会是，只要配合得当，黄芪扶正不留邪，补气无壅闭，利水不伤阴。但对于湿热蕴结较重的臌胀患者，用黄芪时需慎重。

黄芪虽有着上面所述的重要作用，但仍需通过适当的配伍以使其独特的疗效更好地发挥。而随着配伍的不同，黄芪会体现出不同的作用，如配止血药，则用其益气摄血的作用；配通阳之桂枝，则用其温通的作用；配宣肺之麻黄，则用其退其表之水的作用；配伍地龙，则用其通血脉的作用等。

如治魏某，男，34岁，农民，1998年3月10日初诊。患乙肝多年，5年前查B超发现肝硬化，无腹水。1个月前因劳累感乏力，但无腹胀，就诊于某传染病院，查B超示肝硬化中等量腹水，予保肝、利尿药治疗。2周来症状急速加剧，腹胀明显，逐渐出现眼睑、颜面及四肢高度浮肿。诊见：面色苍白，精神萎靡，少气懒言，全身浮肿，腹胀大如鼓，肝区闷痛，畏寒，小便清，每日尿量约1000ml，大便稀溏，日解1~2次，苔白厚，脉沉滑。B超示：大量腹水存在。诊为臌胀，辨为脾气亏虚，水湿内停。治以益气健脾、通阳利水之法。药用：黄芪60g，党参15g，白术10g，茯苓皮30g，大腹皮10g，槟榔10g，厚朴10g，枳实10g，车前子15g，泽泻30g，猪苓15g，桂枝10g，麻黄6g，滑石10g，赤芍15g。服上方药后即停服西药，3剂后每日尿量增至1800ml左右，腹胀、浮肿有所减轻，后在此方基础上随症加减，黄芪多用50~90g，服30剂药后身肿消。3个月后复查



B 超腹水消失，后坚持服中药治疗，至今身体状况尚好。

又如治闵某，女性，42岁，农民，于1999年8月19日就诊。患者有慢性乙肝病史10余年，腹水3个月余，曾在当地医院中西成药治疗无效。某医院经检查诊为肝硬化并肝静脉阻塞性腹水，劝其服中药治疗，故来就诊。诊见腹胀大硬满，腹壁胀痛，腰以下浮肿，右胁痛，纳少，尿量<1000ml，色黄赤，大便溏，日解1次。因连日奔波，感下午发热，体温38.7℃，鼻塞，衄血少许，舌红，苔无，脉沉滑。诊为臌胀，辨为脾气亏虚，水湿内聚，日久阴虚，复感外邪。停用西药，治以益气健脾，养阴清热，利水。药用：黄芪90g，茵陈15g，醋柴胡10g，秦艽10g，炙鳖甲10g，地骨皮12g，牡丹皮15g，赤白芍各15g，泽兰15g，香附10g，豆蔻6g，车前子10g，猪苓10g，生薏苡仁15g，地龙10g，白茅根30g。服上方3剂后热退，14剂药后腰背及下肢浮肿消退，腹虽胀大，但腹壁胀痛症状消失，每日尿量约2000ml，后黄芪加至120g，其他药物随症加减，2个月后腹水消失。坚持服中药年余，腹水至今未复发。

重用白术经验

白术最早载于《神农本草经》一书。其性温，味甘、苦；归脾、胃经。其基本功效为健脾益气，燥湿利尿，止汗，安胎。多用于脾气虚证、气虚自汗、脾虚胎动不安、通便等。临床常用量为6~12g。

吕同杰重用白术通便

名老中医吕同杰在临床中，遵张仲景便硬加白术之训，用白术30~60g，加生地黄、当归等养血润燥之品，治疗脾失健运、胃肠功能失调的大便硬结患者，每多取效，进一步证实了白术不但可以用于脾虚泄泻病人，而且也适用于大便硬结的病人。这种作用一般称之为“双相”作用。大量临床和实验证实，不但白术如此，很多中药都有“双相”作用。白术所以能止泻又能通便，其主要原因是通过白术的健脾作用，使肠胃的运化、升降传导功能得到了调节和恢复。

魏龙骧重用白术通便

北京已故名老中医魏龙骧先生治便秘，概以生白术为主力，少则30~60g，重则120~150g，便干结者加生地黄以滋之，时或少佐升麻，乃升清降浊之意。至遇便难下而不干结，更或稀软者，其苔多呈黑灰而质滑，脉亦多细弱，则属阴

结脾约，又当增加肉桂、附子、厚朴、干姜等温化之味，不必通便而便自爽。

1977年6月，有北京电车公司某厂之一工人于某来诊。自称患便秘六七年矣，中西医迄未停诊，竟无寸效。7年来，汤药近千剂左右，滋阴如麦冬、沙参、玉竹、石斛、知母有之；润下如大麻仁、郁李仁、柏子仁、桃仁以及大黄、芒硝、番泻叶有之；补剂如党参、黄芪、太子参、怀山药、肉苁蓉、狗脊、巴戟天等药备尝之矣；丸药若牛黄解毒、牛黄上清、更衣丸、槐角丸、麻仁滋脾丸；其他如开塞露、甘油栓等，直似家常便饭，且常年蜜不离口。然与便秘已结不解之缘，言下不胜其苦，颇为失望。魏氏诊之，心烦易汗，眠食日减，脉细，舌苔薄滑，余无他象，皆由便秘过久，脾胃功能失调所致。当投生白术90g，生地黄60g，升麻3g。患者虽未形诸言表，但眉宇间已形半疑半信之态，以为仅仅三味又无一味通下，默然持方而去，实则并未服药。终以便不自下，姑且试之，幸其万一。不期，4小时后，一阵肠鸣，矢气频转，大便豁然而下，为数年之所未有如此之快者。正所谓一剂知，二剂已。嗣后，又继服20余剂，六七年之便秘，竟占勿药。患者喜出望外，称谢而去。

高龄患便秘者实为不少，一老人罹风疾偏枯，步履艰难，起坐不利，更兼便秘，何以堪此。尝指腹而叹曰：“大便不通，如之奈何！愿医者善为我图之。”查其舌质偏淡，苔灰黑而腻，脉见细弦。此乃命门火衰，脾失运转，阴结之象也。疏方生白术60g为主，酌加肉桂3g，佐以厚朴6g，大便遂能自通，灰苔亦退，减轻不少痛苦。类似病人，亦多有效，勿庸一一例举。

陈红涛重用白术治化疗后便秘

陈氏自拟一方：生白术30~60g，肉苁蓉10g，当归10g，枳壳10g，厚朴10g，莱菔子10g，牛膝10g，升麻5g，治疗化疗后便秘。用生白术治此症，必须用大剂量方能奏效，最轻者亦需30g，重者可用120g。临床应用若无兼症，单用白术一味（用生者更好）亦可见功，患者服后1天就开始出现肠鸣矢气，2天即有正常大便排出。若兼气虚明显者，可酌加黄芪、太子参、党参；若兼腹胀甚者，可酌加木香，槟榔；若兼血虚者，可酌加熟地黄；若兼肾阳虚者，可酌加巴戟天；血瘀甚者，加桃仁；脾阳虚重者，加干姜10g。另外，嘱患者每日定点大便，饮食规律，少食辛辣肥甘厚腻之品。

如治范某，女，56岁，结肠癌术后化疗后4年，患者于化疗后即出现长期便秘症状，长期服用麻仁软胶囊及芦荟胶囊后方能排便。近1个月来服上药后腹泻，不服上药4~5天不便，故来诊。症见：乏力，纳差，腹胀，便秘，4~5日一行，腹不胀，矢气少，舌体胖大，舌质紫暗，苔厚腻，脉左沉，右涩，根据症状及舌



脉，诊为便秘，脾虚痰湿阻滞。拟方：生白术 60g，肉苁蓉 10g，当归 10g，枳壳 10g，厚朴 10g，莱菔子 10g，牛膝 10g，升麻 5g，生黄芪 15g，太子参 15g。7 剂，服第 1 剂后病人矢气多，第 2 天即排大便，便质发黑，后每日都正常排便，饮食也渐增。后服上方 3 周，大便日 1 次，未再出现便秘。

顾丕荣重用白术治肝硬化腹水

著名中医学家顾丕荣善重用白术治疗肝硬化腹水。顾氏认为：肝硬化腹水治疗中最宜重用白术，轻则 20~30g，重则 50~60g。白术不仅具有益气健脾燥湿之功，更兼利小便、退水肿、化血结的作用。白术擅利水散血之长，却无刚燥劫阴之弊。水臌属脾虚者宜用，属肝肾虚者亦可用之。大剂投用，以补药之体，奏攻药之用，培中伐邪，两恰其宜。顾老使用白术讲究炮制，以便发挥一药多用的作用。生则刚燥化湿，炒用健脾利水，炙可滋润生津。如苔腻者湿盛用生白术，舌淡苔薄边有齿痕者脾虚用土炒白术，舌红苔少或剥者阴虚宜用蜜炙白术。用量宜大，配地骷髅即《绛囊撮要方》之水臌方，临证屡试不爽。

现代药理研究证明，白术具有较好的升高白蛋白，纠正白蛋白/球蛋白比例倒置的功能，并具有明显而持久的利尿作用，且能促进电解质，特别是钠的排泄，又有抗血凝作用，因而肝硬化腹水的形成机制与白术的药理作用不谋而合，故为要药。

李华重用白术治眩晕

李氏多年来每每以白术为主治疗各种眩晕证，如以《中医诊疗要览》之联珠饮（即苓桂术甘合四物汤）治疗排尿性晕厥、低血压，以之加葛根、川芎、鹿衔草等治疗椎基底供血不全之眩晕，加半夏、泽泻等治疗内耳性眩晕等证，收效均甚为满意。

李氏体会：①应用白术治眩晕，不必拘于痰饮与火的临床见证，除肝阳上亢及舌红无苔，或舌苔黄燥外，其余诸型眩晕均可选用。②应用白术治眩晕用量宜大，成年人不宜少于 25g，内耳眩晕可用至 50g。③白术质润气香，一经炒炙，香损质枯，大失其性。近人研究证实，炙白术其挥发油损失约 15%以上。而挥发油很可能即是白术治疗眩晕的主要成分，所以白术治疗眩晕最好用生品。

颜德馨重用白术的经验

国医大师颜德馨认为，白术益气健脾，收敛止血，颇有殊功。曾治大咯血气脱，有形之血不能速生，无形之气所当急固，旋以白术 100g，米汤疾火煎服一大碗，药后 2 小时血止神清，肢和脉起，竟未复发。亦以之治肺结核大咯血，居经不行，每晨晚各以米汁调服白术粉一匙，1 个月后血止经行，体渐康复，血家当



以胃药收功，土厚火敛，信而有征也。此外，重用白术还有通便功效，人知白术止泻，殊不知白术既能燥湿实脾，复能缓脾生津，津润则便畅，凡老年人便秘，以白术 30g 煎汤服之，可治肠液枯燥，使大便通畅。盖脾为太阴之脏，藏精气而不泻，多脂多液，脾主运化，为胃行其津液，重在生化，故凡脾土本虚，胃强脾弱，耗伤脾阴，或老年腑燥，产后体虚，皆使脾气不得敷布，失其转输之能而使脾阴亏损，症见消渴便秘，治当补益脾阴，然滋阴之剂回补其阴液，不能助其生化，惟有白术一味，以资其化源才是治法，《慎斋遗书》云：“专补脾阴之不足，用参苓白术散”，诚良言哉。

沈英森重用白术治帕金森病

广东省名老中医沈英森教授善重用白术、草决明配伍，辨证施治帕金森病患者，疗效显著。如治罗某，女，80岁，2010年7月30日初诊。患者2年前被西医确诊为帕金森病，一直口服西药治疗，如阿司匹林肠溶片、卡左双多巴控释片（息宁）、吡贝地尔缓释片等。虽然症状暂时有所缓解，但整体状况却非常糟糕，病人生活质量很差，病情日益加重。查病人双腿僵直无力，四肢震颤，不能站立，言语欠清晰，短气，头晕，腹胀不适，排便艰难无力，舌红苔白，脉弦细。中医诊断为颤证，辨证属肝肾阴阳两虚，筋脉失养。治宜育阴潜阳，补益肝肾。处方：鳖甲 15g（先煎），龟甲 15g（先煎），肉苁蓉 15g，防风 10g，白术 40g，草决明 40g，黄芪 45g，党参 30g，杜仲 15g，厚朴 10g，桑寄生 15g，天麻 10g，制首乌 15g，火麻仁 20g。服药 7 剂，腹胀减，大便有所改善。守方加肉苁蓉至 30g，继服 14 剂。复诊自述感觉良好，大便通畅。遂坚持中药治疗，沈教授在辨证论治的基础上始终加入白术、草决明这两味药且大剂量用之，至今已过半载，现在患者已经能够站立，诸症明显好转，精神状态良好，生活质量有了很大的提高。

王自立重用白术治消化系统疾病

甘肃名医王自立灵活运用大剂量白术治疗各种病症，均取得了良好效果，且在治疗的过程中未发现有明显的不良作用。

1. 脾虚便秘 王某，女，65岁。平素大便困难，需 5~6 日一行，便质干结，严重时数 10 日一行，粪便干硬如羊屎。自觉乏力明显，食后腹胀，舌淡胖苔白，脉沉。辨为脾虚便秘。方药如下：党参 30g，白术 30g，肉苁蓉 30g，当归 15g，枳壳 45g，厚朴 15g，槟榔 15g，砂仁 10g，麦芽 30g，郁李仁 30g。3 剂，水煎分服，每天 2 次。3 剂后患者复诊，自诉大便干结较前已明显好转，2 日一行，唯便时仍觉乏力，上方白术重用至 60g，继服 7 剂，大便已正常。随访半年无异常。



方中重用白术，同时配伍党参益气健脾润肠，厚朴、枳壳、砂仁行气导滞，理气宽中。现代药理研究认为白术有促进肠胃分泌的作用，可使肠胃分泌旺盛，蠕动增速。临证时须掌握患者多具有脾虚不运、气机失畅的特点。且注意方中应加入理气药物。王氏在临床中治疗本类病症白术最大量用至 80g，枳壳用量最大用至 60g，但须注意根据病人体质不同，当用量各异。

2. 肝硬化腹水 王某，男，65 岁，因乏力、胁肋部疼痛至医院，B 超检查诊断为肝硬化失代偿期，大量腹水，门静脉增宽至 17cm，脾大伴脾功能亢进。既往有乙肝病史 15 年，未作特殊治疗。常自觉胁肋部隐痛，乏力，口干，腹胀，食后尤甚，双目干涩，查舌淡红少苔，脉弦。诊断为臌胀，证属肝肾阴虚。处方如下：党参 45g，黄芪 60g，白术 60g，仙鹤草 30g，北沙参 30g，玉竹 15g，黄精 15g，五味子 15g，山茱萸 30g，薏苡仁 30g，麦芽 15g，山楂 15g，女贞子 30g，茯苓 20g，陈皮 10g，枳壳 10g，白豆蔻 10g。水煎分服，每天 2 次。

方中重用了白术健脾益气，燥湿利水；佐以党参、茯苓、山药等以健脾实脾，取其“见肝之病当先实脾”之意；五味子、女贞子养阴。现代药理研究认为白术可增加白蛋白，纠正白蛋白与球蛋白比例失调，促进钠的排出。有研究认为白术有恢复毒物致肝损害的作用，同时又具有明显的利尿作用，亦有研究认为白术和党参有显著的开大腹膜孔的功能，可使腹膜孔开放数目增加，分布密度增高。腹水的转归与腹膜孔的吸收功能有关，由于白术和党参能较强地调控腹膜孔，因而有消腹水作用。王氏治疗肝硬化白术量最大用到 120g，且观察到白术用量 > 60g 的病例白蛋白恢复正常的时间要短于 < 60g 的病例。

3. 功能性消化不良 刘某，女，45 岁。素体虚弱，常自觉胸脘不舒，痞塞胀闷，稍稍多食即胀闷更甚，多次行胃镜检查均无明显异常。查舌淡胖，苔薄，脉弱。辨证为脾虚。处方如下：党参 15g，白术 45g，佛手 15g，枳壳 30g，砂仁 10g，石菖蒲 15g，香附 10g，麦芽 15g，茯苓 10g，仙鹤草 30g。水煎分服，每天 2 次。

方中重用白术合党参、茯苓健脾和胃；枳壳、佛手行气助运；石菖蒲、麦芽醒脾，补而不滞。白术用量依据脾虚程度及便秘程度给药，一般常用 15~30g，中度可用至 30~60g。有研究表明白术对胃肠功能具有双向调节作用，其作用与剂量呈量效关系，小剂量白术煎剂对胃肠道有轻度抑制效应，大剂量煎剂能加强肠胃蠕动，促进胃肠推进作用。



重用甘草经验

甘草最早载于《神农本草经》。其性平，味甘；归心、肺、脾、胃经；其基本功效有补脾益气，祛痰止咳，缓急止痛，清热解毒，调和诸药。多用于心气不足、脉结代、心动悸、脾气虚证、热毒疮疡、咽喉肿痛及药物、食物中毒等。临床常用量为 1.5~9g。

李文瑞重用甘草治咽喉肿痛

名老中医李文瑞临床应用甘草一般用量 3~10g，重用 15~25g，最大用至 45g。李氏认为甘草之清热利咽、解毒消肿的功效与抗炎、解毒等现代药理作用相合。重剂用于咽喉肿痛，疗效颇佳，常在桔梗甘草汤中重用。临床主要用于咽炎、喉炎、扁桃体炎等。服药期间，未出现浮肿、腹胀、钾低等副作用。如治一女性 29 岁患者。患急性咽炎 5 天。症见咽痛音哑，咽部不爽，目赤干涩，纳食尚可，小便色黄，大便通调，舌微红，苔黄少津，脉滑数。证属热壅咽部，灼伤津液。遂予桔梗 10g，生甘草 30g，玉蝴蝶 10g，蝉蜕 5g，肥玉竹 10g，服 5 剂后症状减轻，再进 5 剂病愈。之后随访未见复发。

冯先波重用甘草代替激素

贵阳市名老中医冯先波认为，甘草的类皮质激素作用属于温养肾阳者，用于各种疾病之依靠使用激素者，无论是暂用或常用，重用甘草于对证方药中，颇能代激素而获安。尤其哮喘患者，已长期服用大量激素不能或离者，将方药中之甘草用量予以加大，60~90g，服后症状即能减轻，若服后出现浮肿，只需加入泽泻 18g 即可消除。

李伯重用甘草治心律失常

李氏临床常常运用炙甘草汤治疗心律失常，效果确实不错，但用之不当会产生一定的不良反应，最主要的不良反应是引起浮肿和血压升高。这种不良反应的产生与炙甘草的用量有直接关系。临床经验证明，其治疗心律失常的疗效也与炙甘草的用量有关，一般用 15~30g，有时可用到 30~60g。李氏在临床中发现，上述用量服 2 周以上就可能出现浮肿或血压升高，有的人可能出现的时间更晚一点。炙甘草的不良反应早已引起了人们的重视。现代药理研究证明，其造成浮肿和血压升高的原因与水钠潴留有关。李氏在临床应用中，曾有 3 例病人出现了上



述不良反应，经配合应用车前草、钩藤后，不良反应逐步消失，后来一直是炙甘草与车前草、钩藤同用，未出现过上述不良反应。车前草、钩藤每剂一般各用 30g。

炙甘草不良反应的出现与个人的体质有关。有的人炙甘草每日服 40g，连服月余也无任何不良反应出现；另有人每日仅服 15g，1 周就出现头痛、血压升高。故临床超量应用炙甘草治病时，要时刻警惕其不良反应，最好能合理配伍，防患于未然。

重用熟地黄经验

熟地黄最早载于《本草拾遗》。其性微温，味甘；归肝、肾经；其基本功效有补血养阴，填精益髓。多用于血虚诸证、肝肾阴虚诸证、虚喘等。临床常用量为 10~30g。

张成铭重用熟地黄治喘证

江苏名老中医张成铭多年实践体会认为，熟地黄味厚质重，阴中有阳，是治疗虚喘、虚实夹杂之喘的一味良药。摄纳之品虽众，无有过于此者，只要巧为配伍，有事半功倍之效。张氏认为，熟地黄所治者为虚喘，其特点是气短不足以吸，动则喘甚。只要见此等证候，不论其舌脉如何，有痰无痰，均可用之，不必有所顾虑。以熟地黄补肾纳气，用量必大，一般 30~45g，多则 60g，量少无功，惟其量大才能效专力宏。

张氏认为，临床上需注重配伍。慢性咳喘患者有虚多实少、虚实并重及偏寒偏热、寒热夹杂之不同，临床上当仔细辨别，分别施治。若咳喘发作间期，以虚为主者，治以补肾固本，药用熟地黄、山茱萸、山药、党参、麦冬、茯苓、五味子、胡桃肉之味，兼阳虚内寒者加鹿角胶（或鹿角霜）、淫羊藿、杜仲、菟丝子，阴虚内热者去党参，加胡桃肉、知母、生地黄，或以麦味地黄汤加阿胶、牛膝。咳喘频作，发无已时，证属阳虚兼痰者，治取阳和汤，阴虚夹痰者治取金水六君煎。对感受外邪而急性发作，咳喘气急，痰多色黄，或白黏多沫，舌红口干者，宜用清上固下法，药取熟地黄、山药、云茯苓、麦冬、五味子、虎杖、重楼、鱼腥草、竹沥水、胆南星。腑气不通者加大黄，气虚欲脱者伍人参。若夹有瘀血，又可选用丹参、桃仁以活血化瘀。总之，根据虚实寒热轻重不同，随证治之，而纳气补肾不变，此亦是扶正以祛邪之谓。临床曾遇到过慢性支气管炎、肺气肿合



并急性感染的病例，单用抗生素、中药清肺化痰效果不显，病情缠绵，而改用纳气补肾兼以祛邪化痰方后，感染得以控制，病情迅速改善，其中熟地黄之功不可没也。

王金荣重用熟地黄治癃闭

王氏善用熟地黄治疗阴虚癃闭。王氏认为，阴虚癃闭，多见于癃闭日久，阴精灼伤，或阴亏之质，继患癃闭。其见证，或为虚实夹杂，或纯虚无邪，而纯虚者病情重，治疗亦难。王氏经过认真研究，确立重用熟地黄为主，少佐白芍以为引导，每可收立竿见影之效。如治娄某，女，75岁。1992年5月20日诊。患者1个月前卒患中风，昏迷、偏瘫，大便失禁。经抢救后，神志恢复，仍言语不利，左侧肢体瘫痪。近1周来，又加小溲量少不利，渐至点滴全无。导尿不慎，又引发尿路感染。西药治疗无功，转邀中医救治。查其形体瘦小，言语謇涩，左下肢稍能抬动，上肢拘挛，功能丧失。伴神萎气短，心悸不安，口燥咽干，欲饮而不敢饮，食欲不振，大便干燥如羊屎，小溲不通。舌质光红无苔，以手扪之干燥，脉沉细无力，时现微数。断为阴虚癃闭重证。处方：熟地黄120g，台党参24g，白芍18g，甘草9g。水煎服。1剂即知，2剂溲通，续服2剂，小便复常。后转方调治偏瘫等证。

刘方柏重用熟地黄治重症臌胀

四川名老中医刘方柏善于重用熟地黄治疗肝腹水疾患。刘氏认为重证臌胀不同于单臌胀，其病情已由侧重于肝脾转为侧重于肾，这是“五脏所伤，穷必及肾”的结果。此时患者肾气大伤，真阴涸竭，以常法治之或如杯水车薪，无济于事，或仅取快一时，旋即更甚。当此之时，惟当采用补下启中法峻补其下，使肾之气化功能得以恢复，肾之将竭之阴得以充填，方能关门利，二便通，水浊得泄，胀满除。此法是刘氏从南通名老中医陈自明那里学来的，而陈老又是遥承于张景岳，并于20多年前在《中医杂志》介绍了此法。当时刘氏即感本法见解独到，用药奇特，遂于临床试用，果然疗效惊人。运用中考虑到水气之密不可分和患者都有大便不通的情况，又将先师江尔逊治气水相因为患时辄用均效的二金汤和魏龙骧的白术通便方合入，疗效更增。多年来，刘氏治疗多例住在医院等待死亡的重症臌胀者，用后俱见肿胀迅速消除，令不少西医同行惊讶。

刘氏于临床使用中发现，无论补真阳还是补真阴，关键的一药是熟地黄。在陈自明先生的补下启中原方中熟地黄用至120g，陈老特别强调：“屡屡用之，并无中满泥膈之弊，为什么呢？”陈老认为，张景岳引王冰的话已作了明确的回答：“少服则资壅，多服则宣通。”因此，刘氏每以熟地黄120~150g为主药，以前列



之补下启中汤为主方，视阴阳亏损之偏重而加用他药，每用必效。从而认识到陈老重用的熟地黄真乃填补肾精力宏、充泽真阴效专之神品，可谓特效方中之特效药也。

如治一男性患者，77岁。2006年2月23日就诊。半年前诊为肝癌，近1个月来腹胀加重，渐至腹大如鼓，入某院住院数日，臌胀日剧，至胀极而欲寻死，自动出院，转诊于刘氏。由两人搀架缓步来诊。面色黧黑，形瘦骨立，腹大如瓮，腹壁青筋鼓露，呕吐，气短难续，二便艰涩，下肢肿胀，呻吟不已。脉迟细，舌苔白。CT：肝癌、大量腹水。X线上消化道造影：食管下段静脉曲张。B超：肝实质占位，大量腹水。免疫检验：甲胎蛋白 250.73μg/L。自半年前发现腹胀和反胃，经有关检查确诊为肝癌后，即用中西医双重治疗，从未间断。腹胀进行性加重1个月来，由门诊而转为住院医治，然病情不仅未能遏制，反日甚一日，方转诊于余，以求一试。本例极度臌胀，表现出元阳欲亡、真阴欲绝、生命垂危之象。当此之时，攻之则危亡立见，消之则无济于事，惟峻补其下兼佐调气疏浚以疏启其中，或可挽大厦于将倾。诊为臌胀。肾阳亏损，真阴涸竭，气化无权，中焦气壅。处以补下启中汤合二金汤加味：熟地黄 120g，枸杞子 30g，山茱萸 20g，炮附子 20g，肉桂 10g，仙茅 12g，龟甲 20g，厚朴 30g，海金沙 30g，鸡内金 12g，土鳖虫 10g，蝼蛄 10g，红参 10g，猪苓 10g，生白术 40g，鳖甲 20g。水煎，每日1剂。

3月1日二诊：上方服完1剂，大便稀黑、腥臭，日排五六次，服第2剂起大便减至日二三次，色已不黑，腹胀明显消退，按之较软，呕仅于进食时小作，精神转好，不再呻吟，家人喜出望外。续前方5剂。

3月6日三诊：自服中药以来，患者自行停用一切西药。现呕吐止，进食则胀，大便日二次，已不稀，口干，脉较前有力，舌质稍干。真阳已见回复，治宜酌增化气行水。前方去附子、肉桂、仙茅，加桂枝 10g，猪苓 10g，茯苓皮 30g，泽泻 30g，大腹皮 30g。4剂。

6月12日四诊：患者坚持服上方，每日或隔日1剂，腹胀已大消。B超探查：少量腹水。纳食接近正常，精神转好，能外出游耍。

8月23日五诊：B超探查：腹水全部消失。血检：红细胞、血红蛋白、总蛋白均较前明显上升。腹胀及肢肿全消，突出感到疲乏、倦怠。宜续行补下以固本，添用补脾以益气，调整处方如下：熟地黄 100g，龟甲 15g，鳖甲 15g，肉苁蓉 20g，土鳖虫 10g，海金沙 30g，鸡内金 12g，红参 10g，茯苓 12g，炒白术 12g，炒白扁豆 30g，陈皮 10g，山药 30g，砂仁 10g，薏苡仁 30g。



后记：患者持续服上方，二三日1剂，中途小有新疾，如呃逆、腹泻等，均以临时对症治疗方一二剂而愈。直至2007年11月下旬因较多饮用啤酒后大吐血，于当地医院抢救无效死亡。自接受本法治疗以来，一直以相对好的生活质量存活了近2年，而腹水至死未见再发。

重用白芍经验

白芍最早载于《神农本草经》，其性微寒，味甘、苦、酸；归心、肝、脾经；其基本功效有养血敛阴，柔肝止痛，平抑肝阳。多用于肝血亏虚及血虚月经不调、肝脾不和之胸胁脘腹疼痛或四肢挛急疼痛、肝阳上亢之头痛、眩晕、利尿等。临床常用量为5~15g。

张琪重用白芍治痛证

国医大师张琪教授善用重剂芍药甘草汤方，除治脚挛急外亦治腹痛。因肝主筋藏血，肝血充盈则筋得养，肝血虚或为热耗则失营而挛急。由此可知，无论腓肠肌或腹直肌挛急，其病变皆责之于肝，肝体阴用阳，阳亢阴亏，故易发生此症。芍药甘草汤益阴养血而柔肝，肝血充盈则筋舒而挛急自除。

张氏治一王姓媼，61岁，体质消瘦，近几日两大腿筋抽掣，初较轻微而未介意，突于昨夜就寝之际，两大腿筋剧烈抽搐拘挛，左腿大筋杠起僵直似一条棍棒，抽掣疼痛难以忍受。当即延医针刺并艾灸足三里稍见缓解，然终不能控制其发作，一夜之间不断发作。延诊视。观其人素禀阴亏血燥，木火体质，参合病情，乃属血燥阴亏、筋脉失荣所致。急拟：白芍50g，甘草25g，知母15g，公藤30g。煎服1剂后，两腿大筋有欲抽之感，但始终未能发作，尤其在傍晚两腿有一阵轻松舒适之感。继服上方3剂而愈。

又治一李姓妇女，47岁。胃脘痛胀，食不下，久治无效。经X线钡剂检查及胃镜检查，诊断为肥厚性胃炎，来门诊求治。诊其脉弦滑有力，舌尖红少津，此肝气犯胃之证。查其以前所服之药皆棱、莪、青皮、香附之类伐肝破气之品，不仅治之无效，反而使病痛加剧。岂知乃肝气横逆、凌脾犯胃所致，宜柔肝和脾胃方能收效。处方：白芍50g，甘草20g，柴胡15g，枳实10g，牡丹皮15g，川楝子20g。服3剂痛止，继续调治而愈。

张氏曾见一脾大性肝硬化病人，某医曾以鳖甲、三棱、莪术、青皮、土鳖虫、

桃仁等开破之剂施治，服药后两胁剧痛。某医以为药力不达，病家亦深信不疑，连续用药竟致不起。肝病患者服削坚开破之剂僨事者并非罕见。张氏治疗此病常用四逆汤，以芍药为主柔肝敛阴疗效颇佳。脾大可用鳖甲消坚，但须与人参、当归等补气养血药合用，消补兼施方能取效。《金匱要略》鳖甲煎丸、大黄蠱虫丸皆以消坚化积为主，但前者用人参、阿胶、芍药以益气育阴；后者用干地黄、芍药、甘草以育阴养血，二者皆寓扶正除邪之义，并非一味消坚化积，此不可不知。

芍药甘草汤，药性缓和，须用大量方效。张氏常用芍药 30~50g。然芍药毕竟属酸寒之品，如虚寒腹痛则非所宜。《伤寒论》第 280 条：“太阴为病，脉弱，其人续自便利，设当行大黄、芍药者，宜减之，以其人胃气弱，易动故也。”张氏于临床用芍药每达 50g，有肝气犯胃之胃脘痛常应手取效。但如属脾寒者则易引起泄泻，仲景之“设当行大黄芍药者宜减之”之语，亟应引起我们重视。由此可见，于某个方剂药物，宜潜心揣摩研讨。既要知其利的一面，又应知其害的一面，临床应用方能得心应手，而不致僨事。

吴立文重用白芍利小便

吴氏认为充分发挥白芍治疗作用，正确辨证用药是前提，但要取得好的疗效，合适的用量也是至关重要的，对于某些病症，重用白芍常是取效的关键。

1. 止痛 芍药甘草汤有缓和脚挛急、缓急止痛功效，吴氏尝以之治疗小脚转筋，用白芍 30~60g，甘草 10g，木瓜 15~20g，水煎服，可取得迅速缓解之效。芍药甘草汤还可用于多种痛症的治疗，如胃脘痛、腹痛、头痛，以及痹证所致疼痛等。重用白芍对缓解疼痛常能取得好的效果。如治坐骨神经痛患者，经辨证属血瘀者，以活血效灵丹合芍药甘草汤施治；偏寒者，可用《普济本事方》麝香圆加减合芍药甘草汤施治。如治边某，男。右侧腰髋部疼痛，连及右下肢，且畏寒怕凉，舌质偏紫，脉弦。西医诊为坐骨神经痛，中医辨证属寒痹。处方：黑大豆 30g，制附子 15g，全蝎 3g，川牛膝 15g，地龙 12g，香附 10g，木瓜 10g，白芍 30g，炙甘草 10g。用上方 7 剂后疼痛缓解，继以上方加鸡血藤、红花、蜈蚣等药调理善后。

2. 止血 白芍酸收敛肝，有较好的止血作用，如《傅青主女科》所制开郁止血汤治妇人郁结血崩，即重用醋炒白芍 30g。清·罗止园《止园医话》中特别指出了白芍对肺病咯血的治疗作用，认为白芍为“止血神品”，效验确实，甚为推崇。临床上一遇吐血或咯血，即以白芍为主药投之。但他强调白芍的用量须在一两（即今之 30g）以上。《岳美中医话集》中载有以旋覆代赭汤加芍药一两半、肉桂三分，治疗胃出血，吐血量大以“升斗”计之的患者，仅服 1 剂，血即渐止，还认为对



妇女血崩，辨证属脾不统血者，可在归脾汤中用芍药一二两，往往可以收到较好的止血效果。这些经验之谈，于临床颇有裨益。如治一女性患者，28岁，工人，3个月来，每月行经20天左右，量多，以致面色萎黄，头晕眼花，疲乏无力，察其舌淡，苔薄白，脉微细，即以补中益气汤加味施治：生黄芪30g，党参15g，白术15g，当归身12g，陈皮6g，升麻10g，柴胡10g，炙甘草6g，炒白芍30g，煅海螵蛸15g，茜草根10g，于经前服用7剂。服药当月，经来7日即止，下月待月经始来即继续服药。至经止停药，连服3个周期，行经也基本恢复正常。白芍以其酸收敛肝之用而有止血之功，应在辨证论治的基础上加用本药为妥，但用量须重，这一点是应该加以重视的。

3. 利水 《伤寒论》中的真武汤，是一首温肾利水的名方，该方伍用了芍药，有人认为芍药在方中起护阴作用，有人则指出用芍药乃取其利水作用。张锡纯《医学衷中参西录》则明确指出白芍为阴虚有热、小便不利者之要药。观前医用白芍利水有两个特点：一是用量大，二是要生用。书中载验案二则：一妇人患阴虚小便不利，水肿甚剧，大便旬日不通，投八正散不效，改用生白芍180g，配阿胶，1剂即二便通利，水肿消退。另载治一六旬老人，患水肿，二便皆不通利，用生白芍90g，配橘红、柴胡，亦起到二便通利作用。因炒用则加强收敛及补养作用，欲其利水，当以生用为宜。吴氏曾治一老年患者，男，55岁，农民。因腹痛服用阿托品后，出现小便点滴不通，西医诊为前列腺肥大，当即予以导尿，过2日仍不能自行排尿，乃邀中医治疗。患者自感少腹不适，口干，余无明显不适，察舌质偏红，舌苔薄黄，脉弦稍细，辨为阴虚内热，阴虚则气无以化，气无力而致癃闭。拟用滋阴、清热、利水之法，以导赤散加川牛膝治之：生地黄20g，木通10g，竹叶10g，生甘草梢6g，川牛膝30g。服2剂，未见效果，因思张锡纯重用生白芍善利小便之说，遂于上方加生白芍60g，服2剂，未行导尿，小便通利。后以上方治一李姓患者，男，60岁，亦为小便点滴难出，用药治后也起到二便俱出之效。愈知重用生白芍确有通利之用，其不仅可利小便，且可通润大便，亦证张氏之说，确属经验之谈。

张锁庆重用白芍治便秘

张氏多年来喜重用白芍止痛，治疗多种疼痛性病证。在重用白芍止痛的同时，发现有腹泻的不良反应。减为常用量以下，其止痛效果相对也减弱，而腹泻的不良反应也随之消失。观察发现，重用白芍止痛效果不但加强，虽腹泻，但无痛苦，并有便畅痛减之感，从而张氏临证将白芍试用于便秘病证，结果其通便功效十分显著。自拟三生通便汤（生白芍50g，生白术30g，生甘草10g）治疗多种便秘。

实热者加生大黄 10g；血虚者加生何首乌 15g，当归 15g；阳虚者加肉苁蓉 15g；因津亏者加麦冬 15g，沙参 15g；因肺气失降者加杏仁 10g，紫菀 15g；因脾运失健者加生莱菔子 15g，生枳壳 10g；因肝郁气滞者加生麦芽 30g 等。若某些病证导致大小便皆不通，用生白芍 50g、生大黄 15g 水煎内服，有较好的利尿通便功能。

芍药通便之功，以白芍生用为著，赤芍也可酌情而用，但其功次于生白芍。用芍药通便量宜大，若用量小于常规用量，只有他功而无通便之效。芍药通便可单味也可加入复方中应用，若于辨证选方中再加入白芍，其通便作用更为可靠。古人曾有“肝主小便，肾主大便”和“肾司二便”之说。可见肝肾功能正常，是保证小便通、大便畅的根本。芍药入肝能补能调，使肝之疏泄有常，肾之开阖有度，因此说芍药是一味利尿通便的良药。

于清军重用白芍治便秘

于氏以白芍配甘草水煎服治疗习惯性便秘，药用生白芍 40g，生甘草 15g。水煎服，每日 1 剂，一般 3 剂显效，7 剂 1 个疗程，每获良效。

中医学认为，凡习惯性便秘者，均为大肠与脾胃、肝肾有关。脾虚血少，失于濡润，或中气不足，排送无力，故传导失司，胃热内盛，大肠燥屎内结，大便艰行；肝主疏泄，若肝气郁结，通降失常，粪便内停，肾主二便，肾阳虚则阴寒内凝，则传送不利；阴精不足，失于润滑，排出困难。而白芍在《本草备要》中有“补血、泻肝、益脾、敛肝阴之功”的记载，有通顺血脉、缓中、利大小肠、消痈肿之效；甘草在《别录》中有“生用凉而泻火，除胃积热，胃肠气滞，补脾胃不足而泻火”。故二药合用，具有温补清泻、养阴益血的独特之功。适用于任何年龄、性别，其效甚佳，值得临床推广应用。

夏翔重用白芍止血

白芍有止血之功，《傅青主女科》所载加减当归补血汤，用白芍一两，伍用桑叶、白术、黄芪等，治老年妇女血崩不止。现临床用以治疗功能性子宫出血、崩漏不止等出血证，常有殊效，有言“此方止血，关键在白芍、桑叶用量要大”。傅氏自拟方“平肝开郁止血汤”，用治“郁结血崩”，方中白芍用量亦达 30g。

另有临床报道，遇血证恒于应证方药中加入白芍 30~60g，每收良效。分举一女子咯血案和一男子便血案，辨证论治准确，用白芍初时量小而收效甚微，后仍守原方而将白芍加量用至 50g，则此二者皆收速效而血止。近代名医岳美中言：“临床上凡吐血、衄血皆可用之。妇女血崩辨证属脾不统血者，可在归脾汤中加白芍一二两，往往可收到止血效果。”亦有报道重用白芍治疗多例支气管扩张咯血获良效。李春花医师在用白芍配伍他药治疗妇科疾病方面有着丰富的临床经验，



用白芍配伍蒲黄，治疗妇女瘀血阻滞之痛经、崩中漏下等；配苈麻根，用治胎漏、胎动不安等疾；与赤芍相伍，用治月经先期、月经量多及崩中漏下等；与川芎合用，认为妇科诸疾均可用之。

夏氏在临床体会到，白芍是一种应用范围极广、临床效果极佳的药物。各个脏腑、各个系统的许多病症都能用白芍收效。不单单用于止血，如以呼吸系统来说，对哮喘患者应用小青龙汤或其他肃肺降气平喘的方药时，重点配合白芍则可增强其平喘的功效。这是因为白芍通过柔肝，加强肝木的疏泄作用，以肃肺降气而奏平喘的功效。同样，对虚喘的患者在应用补气益肺方药的同时，配以养血柔肝的白芍，也能提高其疗效。对消化系统疾病，应用白芍的范围就更广。对溃疡病来说，小建中汤是良方，如欲使其疗效更为显著，一定要重用白芍，甚至可用至 60g 或 90g。对食管、胃、肠痉挛以及过敏性结肠炎患者可用白芍配合白术、香附、木香等而获良效。以心血管疾病来说，对冠心病、心肌炎等患者，可用白芍配合丹参、党参、麦冬等药物，以加强补心活血、养血补气的功效（药理学证实白芍具有降压作用）。以运动系统的疾病来说，如治腓肠肌痉挛或其他肌肉痉挛，可重用芍药甘草汤，若再配合地龙、全蝎等虫类祛风药则更为有效（药理学证实白芍具有镇痛、抗惊厥等作用）。再如对偏头痛、痛经、手术后疼痛等病证，都可应用白芍进行治疗。如果在处方中按常用量（9~15g）应用白芍效果不显著，可重用至 60g 或 90g，则疗效更佳，且无不良反应。

李洪洲重用白芍治腰椎增生症

李氏在辨证论治基础上重用白芍组方治疗腰椎增生症，疗效显著。方以白芍 30~90g，木瓜、炙甘草各 15g，鸡血藤、威灵仙、杜仲各 20g。寒凝经络者加熟附子 20g，肉桂 10g；血虚加丹参 20g；肾阴不足加墨旱莲 20g，女贞子 15g；肾阳虚者加桑寄生、狗脊各 20g；气虚加黄芪 30g；风湿阻络加地龙 15g。每天 1 剂，水煎，分 3 次口服。

如治李某，男，57 岁，2005 年 10 月 21 日初诊。患者腰痛 8 年余，腰部僵硬如板状，走路多时痛甚，弯腰及下蹲困难，活动受限，左侧下肢麻木，病情反复发作。摄腰椎 X 线片示：第 4~5 腰椎椎体前后缘呈唇样增生改变。证属肝肾阴虚，督脉拘急，治宜培补肝肾，益督荣筋。予以理疗及针灸治疗效不佳，拟中药治疗。处方：白芍 50g，木瓜、女贞子、炙甘草各 15g，鸡血藤、威灵仙、杜仲、墨旱莲各 20g。每天 1 剂，水煎，分 3 次口服。服 10 剂，症状减轻。守方去木瓜加黄芪 30g，续服 10 剂，症状明显减轻，活动改善。继续服用 30 余剂，症状消失。随访 2 年未复发。



方中以白芍为主药，具有滋阴潜阳、柔肝止痛、强肾健骨之功效。经李氏长期临床观察，重用白芍治疗腰椎增生等骨性退行性病变，均获良效。

张岐山重用白芍治阳强

张氏曾治殷某，45岁，1998年9月16日初诊。患者半个月来每至夜半后因阴茎勃起、胀痛而醒。自服止痛药，可使疼痛减轻，但仍不能入眠，直至天明，起床活动后症状逐渐消失，伴腰膝酸痛，心烦易怒，口干喜饮，舌质红，苔薄黄少津，脉细略数。曾多方治疗无效。辨证属阴虚火旺，予知柏地黄汤加味：熟地黄20g，山药15g，牡丹皮10g，泽泻10g，茯苓10g，山茱萸15g，知母12g，黄柏12g，生龙牡各30g，6剂，每日1剂，水煎分2次服。6天后复诊，腰膝酸痛及心烦易怒症状减轻，但阳强之患无明显改变。遂于上方中加用白芍100g，炒枣仁30g，再6剂，水煎服。药后诉阳强之症基本消失。继续用6剂而愈。追访至今无复发，患者性功能正常。

张氏认为本例患者据辨证显系肾水亏虚，水不生木，阴不敛阳。正值半夜子时，阳初生之际，肝火妄动使然。故以知柏地黄汤补肾阴，降肝火，重加白芍补肝血，柔肝体，敛肝气。正合《本草正义》之谓：“芍药，收摄……肝气之恣横，安靖甲乙之横逆。”又《本草纲目》谓芍药：“除血痹，破坚积，散恶血，逐贼血，去水气。”故张氏在治疗本病时重用白芍，临床实践说明其效果较佳。

李文瑞重用白芍治慢性胰腺炎

名老中医李文瑞临床应用白芍一般用量5~10g，重用15~30g，最大用至50g。李氏认为重用白芍具有柔肝缓急而不耗气、平肝泻热而不伤阴之功效，与解痉、镇痛、解热等现代药理作用相合。常在芍药甘草汤、乌梅丸、四君子汤、桃红四物汤、柴胡疏肝散等方中重用。临床主要用于慢性胰腺炎、胆道蛔虫症、肝血管瘤、更年期综合征等。如治一女性73岁患者，患慢性胰腺炎3年，症见口苦恶心，进食稍多则腹痛，二便如常，肢软乏力。舌胖质淡红，苔薄白，脉细弦。证属脾虚肝郁，疏泄失司。投予四君子汤加白芍30g，香附、郁金各10g，服5剂后疼痛明显减轻，纳食增加，乏力有缓。遵原方加减。再进10剂后，诸症缓解。

重用乌梅经验

乌梅最早载于《神农本草经》。其性平，味酸、涩；归肝、脾、肺、大肠经；



其基本功效有敛肺止咳，涩肠止泻，安蛔止痛，生津止渴。多用于肺虚久咳、久泻、久痢、蛔厥腹痛、呕吐等。临床常用量为 3~10g。

桂珂重用乌梅治肠炎

桂氏临床发现，乌梅丸加减治疗慢性非特异性结肠炎有一定疗效，其中乌梅用量宜重，一般不低于 30g。

如治王某，女，38 岁，教师。便溏伴下腹隐痛 3 年余，经多方治疗无效前来就诊。患者形体较瘦，神疲乏力，日解大便 3~6 次，均不成形，腹部隐痛，以两侧为甚，入夜或遇冷时加重，纳差，夜寐不安。经结肠镜检查诊断为慢性非特异性结肠炎。观其体征：面色少华，舌淡边有齿印、苔少，脉细弦，腹软，无明显压痛，肝脾未触及。患者苦于大便不成形，如厕次数多，工作、生活均受影响。中医诊断为泄泻。本例证属脾肾两虚，治拟健脾补肾，涩肠止泄。考虑到乌梅丸寒热并用，用乌梅丸加减治疗。处方：乌梅 30g，黄连 3g，黄柏 9g，细辛 3g，花椒 6g，干姜 6g，桂枝 6g，党参 10g，当归 10g，附子 6g，白术 20g，枸杞子 10g，白花蛇舌草 30g，7 剂，每日 1 剂，分 3 次煎服。服药期间禁食生冷刺激之物。二诊时，患者告知便溏次数减少，日解大便 1~3 次，有时成形，腹部隐痛的症状缓解，信心倍增，继续按原方治疗。服药 2 个月后，大便完全成形，每日 1 次，无腹部隐痛的症状出现，患者形体日渐丰腴。嘱患者服香砂六君子丸巩固疗效，1 年后患者告知痊愈，后未再复发。

重用桑螵蛸经验

桑螵蛸最早载于《神农本草经》，其性平，味甘、咸；归肝、肾经；其基本功效有固精缩尿，补肾助阳。多用于遗精滑精、遗尿尿频、白浊、阳痿等。临床常用量为 6~10g。

王国三重用桑螵蛸治肠炎

河北名老中医王国三遵古而不泥古，根据桑螵蛸其固涩之功，临床上配芡实，一般用量在 30g 以上，治疗慢性结肠炎久泻不止者，常收良效。

如治王某，男，59 岁，1998 年 8 月 9 日初诊。患者主因大便稀薄反复发作 10 年，加重 1 个月而来就诊。患者 10 年前因受寒突发腹痛腹泻，每日泻下 10 余次稀水样便，伴有腹痛，曾用抗生素治疗症状缓解。后每因受寒则复发，如此反

复发作数十年。近1个月来，由于饮食不洁，上症又作，来求中医诊治。刻下：大便稀薄，每日3~5次，伴肛门下坠，无脓血便，腹痛时作，周身乏力，纳呆食少，面色萎黄，舌质淡，苔白，脉细沉。王老认为，此乃中气不足之泄泻，用补中益气汤加桑螵蛸30g，芡实30g。加减调治6个月，10年顽疾而愈。随访至今未再复发。

重用金樱子经验

金樱子最早载于《雷公炮炙论》。其性平，味酸、涩；归肾、膀胱、大肠经；其基本功效有固精缩尿止带，涩肠止泻。多用于遗精滑精、遗尿尿频、带下、久泻、久痢等。临床常用量为6~12g。

李文瑞重用金樱子治尿崩症

名老中医李文瑞临床应用金樱子一般用量5~20g，重用25~45g，最大用至60g。李氏认为金樱子具有固精缩尿之功效，重剂应用则收涩作用显著。常加入缩泉丸、桂枝加龙骨牡蛎汤、锁阳固精丸等方中重用。临床主要用于尿崩症、遗尿、遗精等。如治一女性65岁患者，患尿崩症半年，症见口干欲饮，尿频不痛，腰膝酸软。少腹冷胀，大便调，舌淡红，苔薄白，脉细弦。证属肾气不足，气化无权。遂予缩泉丸加金樱子45g等。服10剂后，诸症大减，遵原方10倍量，研为极细末。每服3~5g，日2~3次。服用月余，病告痊愈。之后随访，未见复发。

重用海螵蛸经验

海螵蛸最早载于《神农本草经》。其性微温，味咸、涩；归肝、肾经；其基本功效有固精止带，收敛止血，制酸止痛，收湿敛疮。多用于遗精、带下、崩漏、吐血、便血及外伤出血、胃痛吐酸、湿疮、湿疹、溃疡不敛等。临床常用量为6~12g。

邱德锦重用海螵蛸经验

著名中医学家邱德锦善用海螵蛸治呃逆证。邱氏谓，海螵蛸味咸涩，性微温，

主要用于收敛止血，止带固精，制酸止痛，燥湿生肌。遍查历代本草，未有言其能降逆者。唯《素问》血枯证中有“胸胁支满者，防于食”之句，治以四乌贼骨一芦菇（即茜草）方。叶天士《本草经解》中有海螵蛸气微温，禀天春和之木气，入足厥阴肝经之说，似与疏肝降逆之效有关，然终系附会。邱氏意咸能润下，润下即可降逆除痞，如大承气汤之治痞满燥实是也。夫呃逆者，不论其为胃寒、胃火、脾肾阳虚、胃阴不足等不同病因，均为胃气上逆之证。海螵蛸能润下，治呃逆理当有验。扩而充之，治一切气逆之症，亦必有效也。旋覆代赭汤之所以能降逆化痰者，因方中旋覆花一味，辛苦咸微温，润下之故，故有诸花皆升，唯旋覆独降之说。

如治吉某，男，69岁，于1988年元月5日就诊。患胆石症伴总胆管梗阻，于3天前手术治疗，手术经过良好，唯术后呃逆，昼夜不止，牵拉刀口疼痛难忍。曾用中西各法，未能制止。邱氏投以海螵蛸60g，浓煎300ml，分2次服。下午4时服药后，呃逆次数减少，晚9时再服1次，一夜未呃，自此全愈。

如治郭某，女，51岁，于1988年3月17日就诊。患梅核气2年，屡治不愈。近日又增胸满胁痛，便秘。邱氏投以海螵蛸60g，佩兰叶30g，煎成450ml，每次用药汁150ml，送服十香止痛丸1粒，1日3次服药。服药3日止，8日已愈。

海螵蛸咸以入肾，有收敛之功用，能治吐血、鼻衄，足见具降逆之效。邱氏用于手术后呃逆和梅核气各1例收效，前证多虚，后证多实，表明海螵蛸治呃似乎起到补与泻的双相作用，有待验证。

重用硫黄经验

硫黄最早载于《神农本草经》。其性温，味酸；归肾、大肠经；其基本功效有外用解毒杀虫疗疮，内服补火助阳通便。多用于疥癣、湿疹、阴疽疮疡、阳痿、虚喘冷哮、虚寒便秘等。临床常用量为1.5~3g。

王琦重用硫黄经验

北京名老中医王琦胆大心细，善用虎狼之药硫黄而令人称叹叫绝。2009年7月20日，王氏接诊一畏寒女性，81岁。该患畏寒30余年，时值盛夏，却感同三九，终日着衬衣、毛衣、羽绒服等薄厚衣七层，虽时感上身汗出，需摇扇解汗，仍畏寒肢凉，如置冰中。平素不耐凉风及空调，不能食水果等生冷，夜



间须着棉衣棉袜入睡。尝服金匱肾气丸、右归胶囊等补肾阳之药未效。查其舌黯红、苔白灰腻，脉沉。王氏予桂枝 10g，白芍 10g，炙甘草 6g，制附片 15g（先煎 1 小时），生姜 10g，红枣 10g，黄芪 20g，白术 15g，防风 10g，麦芽 15g，神曲 10g，生硫黄 2g（用豆腐煮后吞服），水煎服，每日 2 次，嘱忌油腻食物。如此叠予桂枝加附子汤合玉屏风散加硫黄，温阳固表。患者持续服药 2 个月后，阳气渐复，畏寒大减，着衣减至只穿薄厚毛衣两层，能耐受凉风及空调，可食西瓜、苹果、桃等水果，汗出亦大减。此方效若桴鼓，很大程度上取决于所投硫黄每天 2g。

硫黄为有毒之药，服之不当可中毒。当今临床医师因惧怕硫黄之毒，鲜有用于口服者。先生审证准确，谨守病机，因证议药，对症制方，予硫黄口服，尤重煎服方法：嘱患者将硫黄夹在两片豆腐中，用线裹紧，放入水中煮 1 小时，待豆腐变绿，再服其中的硫黄，食后再进食半个馒头。如此口服硫黄近 2 个月，共约 120g，未见患者有不良反应。故硫黄虽有毒性，但只要正确炮制，配伍得当，可获倍效。由此可见，用药如用兵，语谓“兵者凶也”，强寇入境，大敌当前，岂可因其凶而废之，医者用药亦因此理。硫黄是壮阳之精品，若配合附子、肉桂治疗肾阳极度虚衰更是为上乘之剂，疗效颇佳。

硫黄内服中毒量为 10~20g。引起硫黄中毒原因有二：一是硫黄中含有砷、碲等有毒元素；二是硫在肠道中生成的硫化氢是一种剧烈的神经毒物，并可抑制某些酶的活性。传统以硫黄与豆腐共煮，试验表明，硫黄生品比经豆腐炮制后的砷含量高 8~15 倍。在肠内容物中，脂肪性物质较多时，易产生大量硫化氢，故硫黄内服时应忌油腻食物。

由此得知，临证中如遇有肾阳衰微，投桂附类不效者，要敢于给服硫黄，可望获满意疗效。

张志秋重用硫黄经验

著名老中医张志秋治疗命门火衰之泄泻善用硫黄。张氏认为，此种泄泻之病机在于久泻伤阳，温运失职，脏虚腑寒。阳虚则气滞，气滞则寒凝，迫使上升之气机转为下降，泄泻自作。四神丸虽可温肾暖脾，轻骑利刃，直达病所，但对沉寒病冷、阳虚久泄之重症，则尚嫌力量不足，拟加生硫黄一味，峻补命火，温脾补肾。黄宫绣《本草求真》论硫黄“久患寒泻，脾胃虚寒，命欲重尽者，须用此主之。”张锡纯亦大力推崇硫黄治久泻。张氏每用生硫黄末为丸，先服少量，每日 0.6~0.9g，开水送下，逐渐加量至 3g。硫黄熟用力薄，少服无效，多服有燥渴之弊，生用则量少而效高又无他弊，但必须是正品（以纯净、透明，



无杂质者为佳)方可使用。沉寒痛冷,影响气血运行,肠道传送无力,能使人便秘;命门火衰,导致寒邪内停,肠道运化失常,亦可使人泄泻。故半硫丸可治老年人虚冷便秘,生硫黄也可治阳虚久泻,全在根据病症应用。

重用狼毒经验

狼毒最早载于《神农本草经》。其性平,味苦、辛;归肺、肝、脾经;其基本功效有蚀疮杀虫,破积散结,逐水祛瘀。多用于疥癣、湿疹、结核、水肿臃胀、虫积、冷积腹痛等。临床常用量为 0.9~2.4g。

邹孟城重用狼毒治肺癆

著名中医学大家邹孟城善用狼毒蛋治疗肺癆。狼毒蛋治肺癆方,首先于 20 世纪 70 年代《新中医》杂志报道。作者位于东北,故一次制作 1 月量(红壳蛋 20 余枚)。上海地处长江流域,气温较高,因而稍稍变通其方法。每次以狼毒 10g,加水适量,烧煮,1 小时后加入洗净之红壳鸡蛋 8 枚,煮之蛋熟即离火,让蛋浸没于狼毒液中,过 2 小时后取蛋食第 1 枚,随即存入冰箱保藏,以后每日取食 1 枚,食时可用微波炉加热,或放碗中隔水蒸热。如在夏季天气炎热,宜于每日制作,当日服食。其法每日以狼毒 3g,放于底窄之小锅内,加水煮后浸泡 4 小时食用,每日 1 枚。邹氏曾以此法治一刘姓女子,系食堂炊事员,年近 40 岁。因乏力、低热骨蒸,至区结防所检查,诊断为右上肺浸润型结核,嘱其须耐心服药数年,以观后效。授以狼毒蛋方,服法如上。服用数日后低热骨蒸即消失,由是信心坚定,每日坚持服 1 枚,经治 4 个月,X 线片复查则结核病灶全部钙化。愈后至今已 10 余年,向来康健无病,肺癆亦未复发。

又:狼毒为有毒之品,邹氏曾以一片煮水饮服,旋即咽喉疼痛,咽后壁滤泡丛生,经多日始消。医书有以狼毒加水烧煮,上置蒸笼,内放大枣,蒸 2 小时后取枣晒干食用,每日 10~15 枚,其法似较每日煮蛋为简便。邹氏曾试作而亲尝之,然食后即见明显泛恶及眩晕,虽经数小时可自行解除,但总是药物毒性作用,难免有损于患者之病体。而狼毒蛋则绝无不良反应,邹氏亦曾尝试多次,蛋壳煮破者食之亦无妨。且曾饮服少量与蛋同煮之狼毒液汁,亦未见任何不良反应。是否蛋白质对狼毒具有解毒功能,有待研究。鸡蛋以红壳者为优,红壳蛋壳厚而致密,滤毒功能当较白壳者更佳也。



文琢之重用狼毒治肾囊风

著名中医外科专家文琢之认为，狼毒味辛、性平，有大毒，闻其名则畏其峻猛，不敢试用。文氏治肾囊风顽固者，常喜用生者配入洗药中，曾用至 15g 未见中毒。近代认为是镇痛解毒药，古人用作内服有破积、降气、杀虫、镇咳之功，对胸中积癖痛证有效，但量未超过 3g。从未见有杀人事实。现代配伍川乌等外用，药插入阴道中可以堕胎，临床报道有效。但文老曾亲见用狼毒 5cm 作外用堕胎药，引起中毒死亡者，因此用狼毒者必慎之。

参 考 文 献

- [1] 张琪. 张琪临床经验辑要. 北京: 中国医药科技出版社, 1998.
- [2] 沈年洪. 慢性咳嗽重用麻黄. 中医药临床杂志, 2007, 19 (2): 197.
- [3] 孟德玉, 杨晓艳. 实喘还须重用麻黄. 中国中医急症, 2008, 17 (7): 1010.
- [4] 任鸿义. 临床重用石膏退热的体会. 中国民间疗法, 2010, 18 (5): 60.
- [5] 中医研究院广安门医院. 医话医论荟要. 北京: 人民卫生出版社, 1982.
- [6] 李静. 名医师承讲记——临床家是怎样炼成的. 北京: 中国中医药出版社, 2007.
- [7] 李新发, 刘华. 重用苍术、麻黄治疗湿热阳痿. 齐齐哈尔医学院学报, 1997, 18 (1): 58.
- [8] 叶进. 叶景华医技精选. 上海: 上海中医药大学出版社, 1997.
- [9] 关思友. 关思友医案医话选——中医临床思维例释. 郑州: 郑州大学出版社, 2002.
- [10] 王森, 等. 刘星元医案医论. 北京: 学苑出版社, 2006.
- [11] 刘玉洁, 等. 王国三临证经验集. 北京: 人民卫生出版社, 2009.
- [12] 余国俊. 中医师承实录. 北京: 中国中医药出版社, 2006.
- [13] 吴佩衡. 吴佩衡医案. 昆明: 云南人民出版社, 1979.
- [14] 罗少锋, 蔡学熙, 林敏. 重用细辛治疗心血管病. 心血管康复医学杂志, 1999, 8 (3): 12.
- [15] 姜敏. 王琦老师用硫黄温阳一则. 世界中西医结合杂志, 2010, 5(9): 800-801.
- [16] 李国荣. 重用苍术治疗婴儿泄泻. 中医杂志, 1995, 7 (17): 20.
- [17] 张学文. 疑难病症治. 2版. 北京: 人民卫生出版社, 2005.
- [18] 来春茂. 来春茂医话. 昆明: 云南人民出版社, 1984.
- [19] 顾文忠. 重用苍术治疗顽固性湿证举隅. 实用中医药杂志, 2001, 17 (9): 43.
- [20] 邓铁涛. 中国百年百名中医临床家·邓铁涛. 北京: 中国中医药出版社, 2001.



- [21] 王金荣. 重用熟地治癃闭. 浙江中医杂志, 1999, 7 (11): 495.
- [22] 王鹏宇. 内蒙古名老中医临床经验选粹. 北京: 中医古籍出版社, 1991.
- [23] 李可. 李可老中医急危重症疑难病经验专辑. 太原: 山西科学技术出版社, 2006.
- [24] 孙一民. 临证医案医方. 郑州: 河南科学技术出版社, 1981.
- [25] 杨进等. 中国百年百名中医临床家孟澍江. 北京: 中国中医药出版社, 2001.
- [26] 李现林. 重用制南星治骨关节疼痛. 新中医, 2006, 38 (3): 71.
- [27] 李慧, 杨淑杰. 重用泽泻治疗泄泻验案二则. 新疆中医药, 2002, 20 (5): 79.
- [28] 陈树森. 陈树森医疗经验集萃. 北京: 人民军医出版社, 1989.
- [29] 朱晓鸣. 临证秘验录. 北京: 中医古籍出版社, 1999.
- [30] 何绍奇. 读书析疑与临证得失. 北京: 人民卫生出版社, 1999.
- [31] 刘惠民. 刘惠民医案. 济南: 山东科学技术出版社, 1979.
- [32] 朱良春. 中国百年百名中医临床家朱良春. 北京: 中国中医药出版社, 2001.
- [33] 张瑞. 重用黄连防治阵发性室上性心动过速体会. 河南中医药学刊, 2001, 16 (4): 31.
- [34] 余国俊. 我的中医之路——一位当代名医的治学与师承经历. 北京: 中国中医药出版社, 2007.
- [35] 彭慕斌, 等. 彭景星医论医案. 北京: 中国医药科技出版社, 2004.
- [36] 刘方柏. 刘方柏重急奇顽证治实. 北京: 人民军医出版社, 2010.
- [37] 上海市卫生局. 上海老中医经验选编. 上海: 上海科学技术出版社, 1980.
- [38] 夏小军. 夏小军医学文集. 兰州: 甘肃科学技术出版社, 2007.
- [39] 李丹初. 湖北名老中医经验选. 武汉: 湖北名老中医咨询服务中心, 1985.
- [40] 周天寒. 周济安先生重用蜈蚣治疗破伤风的经验. 陕西中医函授, 1992, 1 (4): 17.
- [41] 杨小清. 重用豨莶草美容消斑. 中医杂志, 2001, 42 (5): 265.
- [42] 袁家玘, 等. 医林拔萃. 贵阳: 贵州人民出版社, 1985.
- [43] 陶红玲, 周海平. 运用痛泻要方重用陈皮. 浙江中医杂志, 2010, 45 (4): 236.
- [44] 黄和, 杨慧敏. 重用半夏治疗多寐临床体会. 实用中医药杂志, 2010, 2 (8): 120.
- [45] 杨世兴, 等. 陕西省名老中医经验荟萃 (第6辑). 西安: 陕西科学技术出



版社, 2005.

- [46] 章真如. 章真如临床经验辑要. 北京: 中国医药科技出版社, 2004.
- [47] 吴宁. 重用半夏治验 3 则. 江苏中医药, 2011, 43 (12): 50.
- [48] 杜书学. 重用大黄车前子治黄疸. 河北中医杂志, 1989, 11 (4): 23.
- [49] 余跃平. 重用天花粉治疗异位妊娠体会. 中国中医药信息杂志, 2012, 19 (1): 84.
- [50] 辽宁省卫生局. 沈阳市老中医经验选编 (第一集). 内部刊物, 1987.
- [51] 张云鹏. 中国百年百名中医临床家·姜春华. 北京: 中国中医药出版社, 2002.
- [52] 高光震, 等. 吉林省名老中医经验选编. 长春: 吉林科学技术出版社, 1985.
- [53] 刘弼臣. 刘弼臣临床经验辑要. 北京: 中国医药科技出版社, 2002.
- [54] 邹孟城. 三十年临证经验集. 上海: 上海科学技术出版社, 2000.
- [55] 张天嵩. 重用川芎治疗重度偏头痛 1 例. 上海中医药杂志, 2008, 42 (7): 23.
- [56] 何任. 中国百年百名中医临床家·何任. 北京: 中国中医药出版社, 2001.
- [57] 王因仲. 重用川芎治疗顽固性头痛. 社区中医药, 2009, 9 (1): 12.
- [58] 张天嵩. 重用川芎治疗重度偏头痛 1 例. 上海中医药杂志, 2008, 42 (7): 23.
- [59] 沈大友, 石秀全, 沈显峰. 重用玄参治疗急性血栓性静脉炎之体会. 光明中医, 2010, 25 (12): 2294.
- [60] 白伟. 重用玄参治疗慢性干燥性鼻炎疗效. 医学理论与实践, 2011, 24 (19): 2344.
- [61] 李洪洲. 重用白芍治疗腰椎增生症. 新中医, 2008, 40 (10): 26.
- [62] 吴立文. 重用白芍几点体会. 甘肃中医学院学报, 1992, 11 (12): 9.
- [63] 张岐山. 重用白芍治阳强. 中国民间疗法, 2011, 9 (7): 25.
- [64] 黄素英, 等. 中国百年百名中医临床家蔡小荪. 北京: 中国中医药出版社, 2002.
- [65] 孟景春. 孟景春临床经验集. 北京: 湖南科学技术出版社, 2007.
- [66] 陈金鹏. 李士懋重用蜈蚣平肝息风经验介绍. 中医杂志, 2008, 49 (1): 15.
- [67] 颜德馨. 颜德馨临床经验辑要. 北京: 中国医药科技出版社, 2002.
- [68] 李俊龙. 中国百年百名中医临床家·魏龙骧. 北京: 中国中医药出版社, 2001.
- [69] 陈红涛. 重用生白术治疗化疗后引发便秘的体会. 光明中医, 2010, 25 (10): 1918.

- [70] 苏进光. 重用苦参治疗室性早搏. 中国中医急症, 2008, 17 (9): 1313.
- [71] 张董晓. 重用薏苡仁治疗乳头溢液. 北京中医药, 2010, 29 (11): 847.
- [72] 周辉. 重用龙骨牡蛎治疗疑难杂证验案 4 则. 江苏中医药, 2010, 42 (9): 43.
- [73] 骆忠元. 已故四川省级名中医何克炽老师重用青蒿治疗疟疾经验. 中国中医药杂志, 2006, 4 (2): 52.
- [74] 田霞. 重用白薇治疗男性更年期综合征. 医学创新研究, 2007, 4 (6): 80.
- [75] 张新丽. 临床重用白术举隅. 甘肃中医, 2009, 22 (7): 32.
- [76] 刘俊. 冯先波精细入微辨证讲记. 北京: 中国中医药出版社, 2012.
- [77] 李秋贵. 李文瑞教授重用单味药的临床经验. 辽宁中医杂志, 1994, 21 (10): 446-448.
- [78] 陈天资. 浅谈重用生大黄. 中国中医药信息杂志, 1998, 5 (2): 42.
- [79] 靳锋. 浅议重用枳壳治疗胃下垂. 中国中医药信息杂志, 2001, 8 (10): 69-70.
- [80] 郑书全. 重用茜草治疗荨麻疹体会. 实用中医药杂志, 2008, 24 (1): 67.
- [81] 罗舜达. 柴胡疏肝汤重用陈皮治疗乳腺增生病. 中国社区医师, 2008, 10 (1): 125-126.
- [82] 李忠悦. 重用葛根治疗热痹. 吉林中医药, 2004, 24 (2): 40-41.
- [83] 黄文东. 著名中医学家的学术经验. 长沙: 湖南科学技术出版社, 1981.
- [84] 任继学. 任继学重用土茯苓消尿蛋白. 浙江中医药杂志, 2006, 41 (1): 9.
- [85] 熊棠庆, 晏锦春. 顽固水肿重用苍术. 中医杂志, 1997, 38 (2): 71.
- [86] 李霞, 徐娟. 汪建勋老师重用泽泻化痰祛瘀平眩晕. 陕西中医, 2011, 1 (32): 98.
- [87] 靳锋. 王自立主任医师治顽痹重用细辛经验撷英. 甘肃中医, 2003, 10 (16): 15.
- [88] 马明和. 重用半夏治疗失眠. 中医杂志, 2001, 42 (2): 73.
- [89] 骆洪道. 重用败酱草治疗鼻窦炎. 中医杂志, 2003, 44 (1): 13.
- [90] 孙玉齐. 鸡血藤治疗便秘. 中医杂志, 2003, 44 (9): 648.
- [91] 赵云芝. 重用鸡血藤治疗不宁腿综合征. 中医杂志, 2003, 44 (10): 731.
- [92] 黄时浩. 白花蛇舌草治疗慢性非特异性溃疡性结肠炎. 中医杂志, 2007, 48 (6): 535.
- [93] 郭辉雄. 仙鹤草治疗盗汗. 中医杂志, 2006, 47 (5): 337.
- [94] 魏莉. 防风重剂治耳鸣. 中医杂志, 2006, 47 (6): 419.

- [95] 王希臣. 大剂量败酱草治疗女性生殖系统炎症. 中医杂志, 2003, 44 (1): 13.
- [96] 李艳. 重用仙鹤草治疗化疗引起的骨髓抑制. 中医杂志, 2006, 47 (5): 336.
- [97] 孙文亮. 重用槐花治疗血栓性静脉炎. 中医杂志, 2007, 48 (11): 1105.
- [98] 马帮义. 仙鹤草治疗细菌性痢疾. 中医杂志, 2006, 47 (5): 336.
- [99] 李晓三. 重用牛蒡子治疗周围性面神经麻痹. 中医杂志, 1997, 38 (11): 645.
- [100] 宫润珍. 白花蛇舌草是治疗盆腔炎的佳品. 中医杂志, 2008, 49 (8): 724.
- [101] 杨德义. 大剂量川芎为主辨证治疗偏头痛 137 例. 上海中医药杂志, 2011, 45 (12): 38.
- [102] 熊新年. 败酱草治疗前列腺增生症. 中医杂志, 2003, 44 (1): 12.
- [103] 朱树宽. 半夏善治三叉神经痛. 中医杂志, 2001, 42 (2): 73.
- [104] 李春贵. 重用升麻解药毒. 中医杂志, 2007, 47 (3): 177.
- [105] 尚学瑞, 赵世运. 重用生石膏为主治疗急性热病. 中医研究, 2003, 16 (4): 55.
- [106] 时慧君. 重用土茯苓治疗痛风性关节炎. 中医杂志, 2002, 43 (1): 12.
- [107] 李庭喜, 尚学瑞. 重用土茯苓治验举隅. 中医研究, 2004, 17 (2): 62.
- [108] 苏林. 重用防风治疗胃下垂. 中医杂志, 2003, 44 (7): 491.
- [109] 桂珂. 重用乌梅治疗慢性非特异性结肠炎. 中医杂志, 2002, 43 (7): 492.
- [110] 王荣港. 土茯苓善治牙龈肿痛. 中医杂志, 2002, 43 (1): 12.
- [111] 张淑华. 重用鸡血藤治疗经行身痛. 中医杂志, 2003, 44 (9): 648.
- [112] 张平, 郭明华. 重用赭石治疗呕吐的应用体会. 中华当代医学, 2004, 27 (7): 66.
- [113] 张霆. 重用水蛭治疗真性红细胞增多症一得. 北京中医杂志, 2002, 21 (6): 355.
- [114] 傅萍. 重用黄芪治疗肝硬化腹水体. 实用中西医结合临床, 2003, 3 (6): 37.
- [115] 杨丁友. 大剂量鸡血藤治疗重症肌无力. 中医杂志, 2003, 44 (9): 647.
- [116] 郑伟. 重用益母草治疗功能失调性子宫出血. 中医杂志, 2003, 44 (11): 811.

编辑推荐中医图书

名老中医学术经验传承丛书		
名医诊法经验	小 16 开	32.00 元
名老中医用药心得（第 2 版）（第 1 辑）	小 16 开	29.80 元
名老中医用药心得（第 2 版）（第 2 辑）	小 16 开	29.80 元
名老中医用药心得（第 2 版）（第 3 辑）	小 16 开	29.80 元
名医效验药对（杂病卷）	小 16 开	30.00 元
名医效验药对（内科卷）	小 16 开	49.80 元
名医论十大名中药	小 16 开	32.00 元
名医用大黄	小 16 开	35.00 元
名医用细辛	小 16 开	27.00 元
名老中医屡试屡效方	小 16 开	32.80 元
名老中医屡试屡效方 2	小 16 开	39.00 元
名医用名方	小 16 开	35.00 元
名医用名方 2	小 16 开	29.80 元
名医经典医案导读	小 16 开	32.80 元
名医针灸特色疗法	小 16 开	35.00 元
名家教你读医案（第 1 辑）	小 16 开	29.00 元
名家教你读医案（第 2 辑）	小 16 开	39.00 元
名家教你读医案（第 3 辑）	小 16 开	35.00 元
名家教你读医案（第 4 辑）	小 16 开	39.80 元
名家教你读医案（第 5 辑）	小 16 开	39.80 元
名家教你读医案（第 6 辑）	小 16 开	48.00 元
国医大师学术经验研读录（第 1 辑）	小 16 开	26.00 元
国医大师学术经验研读录（第 2 辑）	小 16 开	26.00 元
国医大师学术经验研读录（第 3 辑）	小 16 开	27.00 元
关节炎名医选方用药	小 16 开	35.00 元
心血管病名医选方用药	小 16 开	39.80 元
糖尿病名医选方用药	小 16 开	28.80 元
中医妇科用药经验	小 16 开	33.00 元
常用中药的拓展应用（第 1 辑）	大 32 开	39.00 元
常用中药的拓展应用（第 2 辑）	大 32 开	29.80 元
内科常见病效验方药	大 32 开	45.00 元
中医单验方百家经验	小 16 开	19.80 元
中医不传之秘在于量——寻找中药重剂取效的秘诀	小 16 开	24.00 元
经方论剑录·经方医学论坛临床经验交流精华	小 16 开	29.80 元
名家论脉：中医脉诊理论与实践	小 16 开	29.00 元
现代名老中医珍本丛刊·名家经验荟萃		
王修善临证笔记	大 32 开	22.00 元
萧通吾脉诀及脉案	大 32 开	18.00 元

顾兆农治验详析	大 32 开	18.00 元
刘梓衡临床经验回忆录	大 32 开	18.80 元
靳文清 50 年临证得失录	大 32 开	19.80 元
汤承祖 60 年行医经验谈	大 32 开	35.00 元
张了然医案医话选	大 32 开	15.80 元
高式国针灸穴名解	大 32 开	19.80 元
李可临证要旨 1	大 32 开	29.80 元
谦斋辨证论治学：当代名医秦伯未辨证论治精华	大 32 开	28.80 元
何世英儿科医案	大 32 开	26.00 元
李凤翔七十年行医三字诀	大 32 开	27.00 元
李凤翔疑难病治验录	大 32 开	25.00 元
三湘医萃：医话	大 32 开	19.00 元
三湘医萃：医论	大 32 开	35.00 元
三湘医萃：医案	大 32 开	29.00 元
李可临证要旨 1	大 32 开	29.80 元
李可医案处方集	大 32 开	32.00 元
李可医论专辑	大 32 开	32.00 元
孟景春选评疑难医案	大 32 开	22.00 元
孟景春用药一得集	大 32 开	22.00 元
黄煌经方医案	小 16 开	29.80 元
朱仲德临床经验集	大 32 开	12.00 元
李士懋·田淑霄：脉学心悟·濒湖脉学解索	小 16 开	22.00 元
左振素临证经验辑要	小 16 开	29.00 元
增订幼科类萃	小 16 开	45.00 元
董氏穴位割治截根疗法（配盘）	大 32 开	29.00 元
家传秘方效验录	大 32 开	29.80 元
临证用药心悟	大 32 开	35.00 元
30 年临证实验录	小 16 开	29.80 元
中医名言启示录	小 16 开	25.00 元
中医理法方药心悟	小 16 开	35.00 元
田纪钧手法妙术：软组织损伤手法治疗术（配盘）	小 16 开	45.00 元
田纪钧手法妙术：错骨缝与筋出槽治疗术（配盘）	小 16 开	48.00 元
田纪钧手法妙术：亚健康调理术（配盘）	小 16 开	28.00 元
《诸病源候论》导引还原法（配盘）	大 32 开	49.80 元
脊柱九大诊疗区挂图	对开	39.00 元
中医微创入路解剖彩色图谱（“三个一百”原创获奖图书）	大 16 开	168.00 元
中医文化、中医入门		
一个传统中医的成长历程	大 32 开	19.00 元
任之堂跟诊日记 1	小 16 开	29.80 元
任之堂跟诊日记 2	小 16 开	29.80 元
任之堂跟诊日记 3	小 16 开	38.80 元

任之堂中药讲记	小 16 开	29.80 元
不传之秘——中医师是怎样炼成的	小 16 开	29.80 元
零起点学中医——带你体验中医的 12 堂课	小 16 开	25.00 元
学点中医：一本你终于可以读懂的中医书	小 16 开	27.00 元
趣味方剂口诀	36 开	19.00 元
老中医经方歌诀译释	36 开	16.00 元
易学易记中药手册	36 开	23.00 元
易学易记中医诊断手册（第 2 版）	36 开	22.00 元
系统辨证脉学培训教程	小 16 开	23.00 元
林沛湘教你学中医诊断	小 16 开	35.00 元
中医小方杂谈	大 32 开	19.00 元
名方 60 首讲记（第 2 版）	小 16 开	32.80 元
中药应用讲记	小 16 开	68.00 元
师传望诊歌诀	大 32 开	18.00 元
皮肤病临证效验方	小 16 开	29.80 元
中医师秘藏的小验方	小 16 开	19.80 元
中药通俗演义	小 16 开	27.80 元
读医案学中医——中医是怎么看病的	小 16 开	22.00 元
步入中医之门系列		
步入中医之门 1：道少斋中医讲稿（第 2 版）	小 16 开	29.80 元
步入中医之门 2：被淡忘的经络辨证	小 16 开	30.00 元
步入中医之门 3：分部经络辨证理论与实践	小 16 开	32.00 元
步入中医之门 4：“火神派”热潮之冷思考	小 16 开	27.00 元
步入中医之门 5：疑难重症辨证论治 24 讲	小 16 开	27.00 元
中医经典研读		
黄元御医籍精品：四圣心源	大 32 开	17.00 元
破解中医治病密码：临证辨象	小 16 开	29.80 元
黄元御医籍精品：黄元御读伤寒	大 32 开	29.00 元
圣余医案白话选讲	小 16 开	25.00 元
李克绍读伤寒	小 16 开	30.80 元
李广钧内经 10 讲	小 16 开	39.80 元
《伤寒论》师承课堂实录（第 2 版）	小 16 开	39.00 元
《伤寒论类编补遗》师承课堂实录	小 16 开	68.00 元
《金匱要略增补》师承课堂实录	小 16 开	68.00 元
一通百通讲伤寒：老中医串讲伤寒实录 1	小 16 开	65.00 元
一通百通讲金匱：老中医串讲伤寒实录 2	小 16 开	65.00 元
伤寒证症精解：老中医串讲伤寒实录 3	小 16 开	65.00 元
仲景脉学精讲：老中医串讲伤寒实录 4	小 16 开	35.00 元
伤寒心悟	小 16 开	25.00 元
伤寒论表解	小 16 开	29.00 元

我社邮购部联系电话：010-51927300-8705，8129

联系人：王 兰

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名= 中医不传之秘在于量：寻找中药重剂取效的秘诀
作者= 陈云志，刘俊主编
页数= 1 6 8
出版社= 北京：人民军医出版社 ， 2 0 1 3 . 1 2
出版日期= 2 0 1 3 . 1 2
S S 号= 1 3 5 0 0 8 6 9